



Nuansa
Fajar
Cemerlang



optimal

Asuhan Kebidanan Nifas & Menyusui

Andri Tri Kusumaningrum, S.SiT.,Bd.,M.Kes
Yayah Rokayah, SKM. M. Kes
Ni Wayan Manik Parwati, S.Si.T.,M.Keb
Fatmawati, SST., M.Keb
Psiari Kusuma Wardani, S.ST, M.Kes
Tutik Iswanti, SST., M.Keb
Heni Nurakilah, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.
Rizka Fatmawati, S.SiT., M.Kes
Henny Sulistyawati, SST.,M.Kes
Ismiati, S.ST., M.Keb
Annesya Atma Battya, S. Sos., S.Tr.Keb.,M.Tr.Keb
Dewi Ayu Ningsih, S.ST, M.Keb, CTM-BT
Dwie Yunita Baska,SST, M.Keb
Irma Nurma Linda, S. Keb., Bd., M. Keb.
Dwi Rahmawati, SST.,M.Keb
Rini Mustikasari Kurnia Pratama, S.Si.T., M.Keb



ASUHAN KEBIDANAN NIFAS DAN MENYUSUI

Andri Tri Kusumaningrum, S.SiT.,Bd.,M.Kes

Yayah Rokayah, SKM. M. Kes

Ni Wayan Manik Parwati, S.SiT.,M.Keb

Fatmawati, SST., M.Keb

Psiari Kusuma Wardani, S.ST, M.Kes

Tutik Iswanti, SST., M.Keb

Heni Nurakilah, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.

Rizka Fatmawati, S.SiT., M.Kes

Henny Sulistyawati, SST.,M.Kes

Ismiati, S.ST., M.Keb

Annesya Atma Battya, S. Sos., S.Tr.Keb.,M.Tr.Keb

Dewi Ayu Ningsih, S.ST, M.Keb, CTM-BT

Dwie Yunita Baska,SST, M.Keb

Irma Nurma Linda, S. Keb., Bd., M. Keb.

Dwi Rahmawati, SST.,M.Keb

Rini Mustikasari Kurnia Pratama, S.SiT., M.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

ASUHAN KEBIDANAN NIFAS DAN MENYUSUI

Penulis:

Andri Tri Kusumaningrum, S.SiT.,Bd.,M.Kes
Yayah Rokayah, SKM. M. Kes
Ni Wayan Manik Parwati, S.Si.T.,M.Keb
Fatmawati, SST., M.Keb
Psiari Kusuma Wardani, S.ST, M.Kes
Tutik Iswanti, SST., M.Keb
Heni Nurakilah, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.
Rizka Fatmawati, S.SiT., M.Kes
Henny Sulistyawati, SST.,M.Kes
Ismiati, S.ST., M.Keb
Annesya Atma Batty, S. Sos., S.Tr.Keb.,M.Tr.Keb
Dewi Ayu Ningsih, S.ST, M.Keb, CTM-BT
Dwie Yunita Baska,SST, M.Keb
Irma Nurma Linda, S. Keb., Bd., M. Keb.
Dwi Rahmawati, SST.,M.Keb
Rini Mustikasari Kurnia Pratama, S.Si.T., M.Keb

Desain Cover:

Aldian Shobari

Tata Letak:

Siti Hartina Fatimah

Achmad Faisal

ISBN:

978-623-88564-9-7

Cetakan Pertama:

April, 2023

Hak Cipta 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website: www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Karunia dan Rahmat-Nya, sehingga Buku Asuhan Kebidanan dengan judul “Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui” dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Buku Asuhan Kebidanan ini tidak terlepas adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mengharpkan adanya saran dan kritik yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik di masa mendatang. Semoga Buku Asuhan Kebidanan ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Jakarta, Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PEMERIKSAAN DAN PERUBAHAN FISIK SAAT KUNJUNGAN NIFAS	1
BAB 2 PERSIAPAN MENYUSUI DAN TEKNIK MENYUSUI.....	25
BAB 3 ADAPTASI PSIKOLOGI MASA NIFAS	37
BAB 4 PROSES LAKTASI DAN MENYUSUI	51
BAB 5 KONSEP DASAR MASA NIFAS	65
BAB 6 KONSELING PADA MASA NIFAS	75
BAB 7 RESPON ORANG TUA TERHADAP BAYI BARU LAHIR (BBL)	83
BAB 8 DETEKSI DINI KEGAWATDARURATAN MASA NIFAS	91
BAB 9 KUNJUNGAN MASA NIFAS.....	105
BAB 10 MASALAH MENYUSUI PADA BAYI	125
BAB 11 KEBUTUHAN DASAR MASA NIFAS	135
BAB 12 <i>SUPPORT SYSTEM</i> DALAM PROSES MENYUSUI	145
BAB 13 ANATOMI FISILOGI LAKTASI.....	155
BAB 14 SYSTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PASCA NIFAS DAN MENYUSUI	167
BAB 15 GANGGUAN PSIKOLOGIS PADA POSPARTUM DAN SCREENING MENGUNAKAN EDINBURGH POSTNATAL DEPRESSION SCALE (EPDS)	189
BAB 16 <i>PARENTING SELF-EFFICACY</i> PADA IBU NIFAS	209
PROFIL PENULIS	221

BAB 1

PEMERIKSAAN DAN PERUBAHAN FISIK

SAAT KUNJUNGAN NIFAS

Andri Tri Kusumaningrum, S.SiT.,Bd.,M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

PEMERIKSAAN DAN PERUBAHAN FISIK SAAT KUNJUNGAN NIFAS

Andri Tri Kusumaningrum, S.SiT.,Bd.,M.Kes

A. Pendahuluan

Periode pasca persalinan merupakan masa enam sampai delapan minggu mulai setelah kelahiran bayi sampai organ reproduksi kembali seperti sebelum kehamilan. Masa ini yang disebut dengan puerperium. Perubahan yang terjadi secara fisiologis terjadi jelas, dan dianggap normal. Faktor, yang mempengaruhi meliputi tingkat kenyamanan, perawatan, kesehatan bayi baru lahir, tingkat energi, serta motivasi semangat yang diberikan tenaga kesehatan profesional akan membantu respons awal ibu terhadap bayinya. Seorang bidan harus memahami dan memanfaatkan pengetahuannya tentang anatomi dan fisiologi ibu masa pemulihan, untuk memberikan perawatan yang efektif pada ibu, bayi dan keluarganya. Kunjungan nifas dilakukan untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir, untuk mendeteksi, mencegah dan menangani masalah yang terjadi selama masa nifas.

Jika wanita mendapatkan asuhan yang berkualitas sejak dari masa hamil sampai dengan persalinannya, maka komplikasi masa nifas jarang terjadi. Jika pasien sering melakukan kunjungan bidan melalui pemeriksaan antenatal maka bidan mempunyai kesempatan lebih banyak untuk melakukan screening terhadap kemungkinan masalah atau komplikasi yang terjadi pada saat persalinan dan nifas.

B. Pengertian

Pemeriksaan atau pengkajian fisik adalah salah satu upaya mengetahui tanda, gejala atau gangguan kesehatan yang dialami ibu nifas dengan mengumpulkan data-data obyektif dilakukan dengan cara pemeriksaan kepada pasien.

C. Tujuan Pemeriksaan Fisik Masa Nifas

Pemeriksaan fisik pasca persalinan sangat penting dilakukan pada semua ibu pasca persalinan untuk memastikan kesehatan umum, kesehatan sistem reproduksi ibu serta penapisan dini masalah kesehatan pascapartum. Hal ini dapat menurunkan risiko kesakitan dan kematian pada ibu. Mortalitas ibu setelah melahirkan sering terjadi dalam satu bulan setelah persalinan, dan hampir setengahnya terjadi dalam 24 jam pertama.

- Menjaga kesehatan ibu dan bayinya fisik maupun psikologi.
- Melakukan penapisan yang komprehensif, deteksi dini masalah, menangani atau melakukan rujukan bila terjadi masalah kegawatadaruratan pada ibu dan bayinya.
- Memberikan health education tentang perawatan personal hygiene, nutrisi nifas dan menyusui, KB pascasalin, proses laktasi, pemberian imunisasi dasar dan perawatan bayi sehat.
- Menjelaskan dan memberikan perawatan asuhan keluarga berencana

D. Kapan dan Tujuan Pemeriksaan Nifas Dilakukan

Pedoman klinis pengkajian fisik pascapartum adalah sebagai pemeriksaan yang wajib dilakukan pada semua ibu masa nifas. Pemeriksaan ini dilakukan minimal sebanyak 4 kali, dimana pemeriksaan atau kunjungan kesatu dilakukan pada 24 jam pertama setelah persalinan. Pemeriksaan dan perawatan postpartum merupakan suatu proses yang berlanjut, dan tidak hanya melakukan satu kali kunjungan pemeriksaan saja.

➤ Kunjungan Nifas (KF-1) : 6 - 8 jam pascapartum

- 1) Pencegahan perdarahan postpartum akibat atonia uteri
- 2) Deteksi dini dan perawatan penyebab lain perdarahan
- 3) Memberi Pendidikan Kesehatan pada ibu dan atau anggota keluarga tentang cara pencegahan perdarahan setelah persalinan akibat atonia uteri
- 4) Pelaksanaan pemberian ASI dini
- 5) Menjalin bonding attachment antara ibu dan bayi baru lahir
- 6) Mencegah hipotermi agar bayi tetap hangat dan sehat

➤ Kunjungan Nifas (KF-2) : 6 hari setelah persalinan

1. Menilai involusi uterus berjalan normal : memastikan uterus dapat berkontraksi baik teraba keras, fundus teraba di bawah umbilikus, memastikan tidak ada perdarahan abnormal dan tidak ada bau.
2. Pengkajian adanya tanda infeksi, peningkatan suhu atau perdarahan abnormal
3. Pastikan ibu mendapatkan nutrisi seimbang, cairan dan istirahat.
4. Pastikan ibu menyusui dengan baik dan tak memperlihatkan tanda penyulit

➤ Kunjungan Nifas (KF 3) : 2 minggu setelah persalinan

Sama seperti kunjungan 6 hari setelah persalinan

➤ Kunjungan Nifas (KF 4) : 6 minggu setelah persalinan

1. Tanyakan kepada ibu tentang penyulit-penyulit yang dialami
2. Melakukan konseling untuk penggunaan KB secara dini

E. Teknik Pemeriksaan Fisik Ibu Nifas

Teknik dalam pengkajian fisik ibu pascapersalinan ada 4 yang digunakan yaitu meliputi; inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi.

F. Persiapan Alat

1. Persiapan Ruang

Ruangan disiapkan dengan baik dan nyaman, dengan diberi penyekat untuk menjaga privasi pasien dan mengatur pencahayaan yang tepat dan suhu ruangan.

2. Persiapan Pasien

Sebelum pemeriksaan dilakukan, persetujuan medis atau *informed consent* dilakukan terlebih dahulu. Posisi pasien berbaring terlentang nyaman dan pada pemeriksaan bagian pelvis, pasien dalam posisi litotomi.

3. Persiapan Alat

Nama Alat	Fungsi
a. Baki 1 buah 	Penyangga peralatan dan bahan yang dibutuhkan ketika pemeriksaan fisik pada ibu nifas.
b. Tensimeter 	Untuk mendengarkan denyut nadi guna mengukur tekanan darah pada pasien atau klien
c. Stetoskop 	Selain untuk mendengarkan detak jantung tetapi juga untuk mendengarkan organ lain yang berada dalam tubuh.
d. Termometer 	Untuk mengukur suhu (temperatur) tubuh

e. Penlight 	Membantu memberikan cahaya agar pemeriksaan lebih jelas seperti pemeriksaan dalam telinga pasien, untuk pemeriksaan pupil pada mata pasien, untuk pemeriksaan mulut pasien dan pemeriksaan hidung bagian dalam.
f. Kapas dan Air DTT 	Membersihkan bagian yang terluka
g. Handscoon 	
h. Pinset Anatomis 	Digunakan untuk menjepit kasa sewaktu merawat luka, menjepit jaringan yang lunak dan tipis.
i. Bengkok 	Wadah atau penampung kasa/kapas setelah tidakan
j. Larutan Klorin 0,5 % 	Untuk disinfeksi serta membunuh kuman, bakteri dan virus pada alat yang akan di sterilkan.
k. Perlak dan Pengalas 	Digunakan untuk alas atau pelapis pasien yang dapat menahan dan menyerap cairan dengan cepat

l. Kom Kecil Tertutup 	Wadah untuk kasa steril, betadine, sputum atau dahak
m. Jam Tangan Berdetik 	Memeriksa dan mencatat tanda vital pasien, pemberian obat dan bagan lab.
n. Air Sabun 	Untuk membersihkan tangan dari kotoran serta kuman – kuman sebelum melakukan pemeriksaan fisik dan juga setelah melakukan pemeriksaan fisik
o. Tempat Sampah 	Untuk menampung sampah medis maupun non medis

G. Pemeriksaan Fisik Pascapartum

1. Tanda-Tanda Vital

Jika sebelum persalinan kondisi ibu normal, maka perubahan tanda vital terlihat, peningkatan tekanan darah systole dan diastole terjadi dan berlangsung selama 4 hari setelah persalinan. Pada bulan ke 6 setelah persalinan fungsi organ pernafasan akan kembali seperti wanita tidak hamil. Saat rahim kosong, diafragma akan turun, aksis jantung kembali normal dan impulsasi titik maksimum (Point Of Maximum Impulsasi (PMI)) dan EKG

Kembali normal. Perubahan fisiologis pada masa nifas (tanda-tanda vital) meliputi, tekanan darah, suhu badan, pernapasan dan nadi.

a. Suhu badan

Suhu merupakan pernyataan tentang perbandingan (derajat) panas suatu zat. Dikatakan sebagai ukuran panas/dinginnya suatu benda. Suhu tubuh ibu inpartu tidak lebih dari 37,2 derajat Celcius. Setelah persalinan, suhu tubuh dapat naik kurang lebih 0,5 derajat celcius dari keadaan normal. Kenaikan suhu tubuh ini diakibatkan dari tenaga yang keras sewaktu melahirkan, kehilangan dan dehidrasi saat persalinan maupun kelelahan. Pada hari ke-4 setelah persalinan, suhu tubuh akan naik lagi. Hal ini disebabkan ada pembentukan ASI, kemungkinan payudara membengkak, maupun kemungkinan infeksi pada endometrium, mastitis, traktus genetalis ataupun sistem lain. Apabila kenaikan suhu di atas 38 derajat celcius, waspada terhadap infeksi post partum. Pada hari ke-3 suhu tubuh akan naik lagi karena ada pembentukan ASI, buah dada mengalami pembesaran atau bengkak, berwarna kemerahan karena banyaknya ASI. Bila suhu tidak turun kemungkinan adanya mastitis, infeksi pada endometrium, tractus urogenitalis atau sistem lain. Kondisi patologis jika didapatkan demam lebih dari 38⁰C pada dua hari berturut-turut pada 10 hari yang pertama setelah persalinan, kecuali hari ke-1 dan suhu harus diambil paling tidak 4x dalam sehari. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan suhu tubuh adalah termometer. Pemeriksaan suhu dapat menggunakan termometer air raksa dan digital. Macam mengukur suhu tubuh:

- Oral. Termometer diletakkan secara sublingual selama tiga sampai lima menit.
- Axilla. Termometer diletakkan ditengah aksila selama 5-10 menit dengan menggunakan termometer raksa. Hasil suhu aksila lebih rendah 0.6° C (1°F) dari pada oral
- Rectal. Hasil suhu rektal 0.4°C (0.7°F) lebih tinggi dibanding suhu oral.

b. Nadi

Denyut nadi normal pada orang dewasa 60-80 kali permenit. Setelah melahirkan biasanya denyut nadi teraba lebih cepat. Umumnya terjadi bradikardi pada 6-8 jam pertama setelah persalinan akibat konsekuensi peningkatan cardiac out put & stroke volume. Akan kembali seperti kondisi sebelum hamil 3 bulan setelah persalinan. Frekuensi nadi antara 50-70x permenit masih dianggap

normal. Nadi yang cepat atau lebih dari normal mungkin indikasi hipovolemia sekunder dari perdarahan. Pemeriksaan denyut nadi dapat dilakukan pada:

- Arteri Radialis. Palpasi sepanjang tulang radialis, lebih mudah teraba di atas pergelangan tangan pada sisi ibu jari. Relatif mudah dan sering dipakai secara rutin.
- Arteri Brachialis. Terletak di dalam otot biceps dari lengan atau medial di lipatan siku. Digunakan untuk mengukur tekanan udara.
- Arteri Karotis. Terletak di leher di bawah lobus telinga, di mana terdapat arteri karotid berjalan di antara trakea dan otot sternokleidomastoideus.



Gambar 1.16 Pemeriksaan Nadi

c. Tekanan darah

Tekanan darah terjadi akibat tekanan pada pembuluh arteri ketika darah dipompa ke seluruh tubuh. Tekanan darah normal, sistolik antara 90-120 mmHg dan diastolik 60-80 mmHg. Setelah persalinan masa nifas normal, umumnya tekanan darah tidak berubah. Terjadi perubahan penurunan tekanan darah menjadi lebih rendah diakibatkan perdarahan postpartum. Tekanan darah tinggi postpartum menunjukkan adanya pre-eklamsia post partum.

Kondisi hipotensi ortostatik dapat terjadi pada 48 jam pertama dengan gejala perasaan pusing atau pening setelah berdiri sebagai akibat gangguan daerah persyarafan yang mungkin terjadi setelah persalinan. Selain itu bisa karena hypovolemia akibat adanya perdarahan. Penggunaan oksitosin yang berlebihan saat persalinan dan pasca persalinan dapat meningkatkan tekanan darah, maka perlu dilakukan evaluasi rutin. Pada kasus hipertensi dan mengalami sakit kepala dapat diberikan analgetic dan harus cukup istirahat. Namun jarang terjadi.

Pemeriksaan tekanan darah diukur nilai sistolik dan diastolik menggunakan alat sphygmomanometer dan stetoskop untuk mendengar denyut nadi.



Gambar 1.17 Pemeriksaan tekanan darah berbaring dan duduk

d. Pernafasan

Rata-rata frekuensi pernafasan normal orang dewasa antara 16-24 kali per menit. Pernafasan pada ibu pascasalin pada umumnya pernafasan lambat atau normal. Hal ini disebabkan karena ibu masih dalam fase pemulihan atau dalam keadaan istirahat. Pernafasan akan berhubungan dengan suhu dan denyut nadi. Bila suhu dan nadi tidak normal, maka pernafasan akan mengikutinya, kecuali jika ada masalah khusus pada saluran nafas. Pada kasus tidak normal peningkatan subarachnoid (spinal block) dapat terjadi hipotensi dan hipoventilasi. Bila pernafasan setelah persalinan lebih cepat, kemungkinan adanya tanda syok.



Gambar 1.18 Pemeriksaan Pernafasan

2. Muka

- a. Periksa adanya pembekakan pada wajah
- b. Periksa adanya cloasma

Odema umumnya terjadi pada trimester akhir kehamilan dan dapat berlanjut sampai postpartum. Tekanan akibat pembesaran uterus selama kehamilan akan menyebabkan pembengkakan. Saat persalinan, proses mengejan, cairan dan darah di tubuh akan berada dalam puncaknya. Hal ini menyebabkan pembengkakan di jari, tangan, kaki dan juga wajah.

Tanda pembengkakan di wajah dan ekstermitas pada ibu postpartum :

- Ukuran perut terjadi peningkatan (ascites)
- Napas pendek atau sulit bernapas (pulmonary edema)
- Penurunan ekskresi urine, walaupun takaran minum air normal.
- Pakaian atau aksesoris yang dipakai terasa lebih sempit

- Pada keadaan parah, tanda edema dapat berupa kesulitan bernapas, napas pendek ketika berbaring, batuk serta akral teraba dingin

Penatalaksanaan Pembengkakan Pada Wajah Dan Ekstremitas Pada Ibu Nifas

Cara meringankannya :

- Berbaring posisi miring ke kiri dengan kaki sedikit ditinggikan
- Jangan berdiri terlalu lama
- Jika perlu sering melatih kaki untuk ditekuk ketika duduk atau berdiri
- Kaki diangkat ketika duduk atau beristirahat
- Deteksi adanya varises, kemerahan betis, pergelangan kaki odema
- Menghindari penggunaan kaos kaki ketat
- Lakukan senam secara teratur

3. Mata

- a. Periksa konjungtiva warna merah muda/pucat
- b. Periksa sklera putih/kuning

Keadaan konjungtiva normalnya berwarna merah muda dan sklera warna putih. Konjungtiva pada ibu nifas dengan anemia terlihat pucat, bisa didapatkan pada ibu nifas yang dengan riwayat perdarahan postpartum, defisiensi zat besi.

4. Payudara

Pemeriksaan payudara pascasalin dilakukan secara inspeksi dan palpasi. Karena pengaruh hormone laktogen (prolaktin) terhadap kelenjar payudara terjadi perubahan payudara yaitu pada masa laktasi, memicu keluarnya kolostrum (cairan berwarna kuning mengandung protein dan mineral) diproduksi mulai akhir masa kehamilan sampai hari ke 3-5 postpartum.

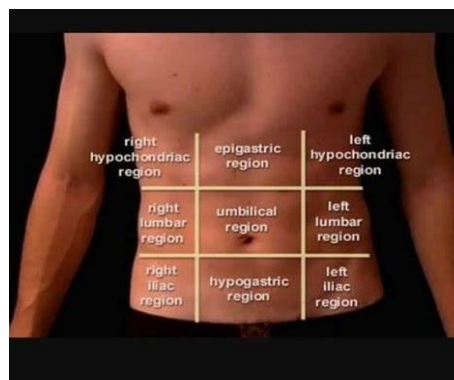
Dua hari pertama setelah persalinan, keadaan payudara sama dengan keadaan dalam kehamilan. Payudara belum mengandung susu, tetapi kolostrum yang dapat diperiksa dengan dipijat pada areola mammae. Hormon progesteron dan estrogen produksi dari plasenta, akan merangsang pertumbuhan kelenjar susu. Pengaruh hormone prolactin terjadi hari ketiga, pembuluh darah payudara menjadi bengkak terisi darah, pada perabaan terasa hangat, bengkak dan rasa sakit. Selama 5 hari pertama, colostrum disekresi oleh payudara diperas dari putting susu. Colostrums mengandung tinggi protein, sebagian besar globulin dan banyak mineral, mengandung sedikit gula dan lemak. Jika proses menyusui kurang efektif atau tidak menyusui maka terjadi nyeri payudara akibat pembesaran (*engorgement*), milk leakage dapat memuncak pada hari ke 3 sampai 5 setelah melahirkan.

Keadaan engorgement karena pengeluaran ASI tidak efektif, dapat menyebabkan terjadinya kongesti darah, ASI, dan limfe. Kondisi sumbatan saluran ASI ini menyebabkan payudara terasa panas, nyeri, keras dan mengkilap. Pada pemeriksaan akan ditemukan benjolan terasa nyeri dan kemerahan pada kulit di atasnya biasanya tanpa demam. Deteksi tanda mastitis ditandai payudara kemerahan, nyeri dan keras disertai demam sampai menggigil dan nadi cepat. Jika terjadi massa fluktuatif serta demam yang bertahan hingga 48-72 jam tidak menurun selama 48-72 jam setelah penanganan mastitis, perlu curiga terjadinya abses payudara. Puting diperiksa, apakah terdapat iritasi, fisura dan crack karena dapat mengganggu proses menyusui dan menjadi media masuknya pathogen.

- a. Penyebab saluran payudara tersumbat:
 - Ibu jari yang menekan terlalu kuat saat menyusui.
 - Penggunaan bra terlalu ketat.
 - Pengeluaran ASI tidak efektif sehingga, sehingga terkumpul terbentuklah sumbatan.
- b. Gejala yang ditimbulkan antara lain :
 - Gejala terlihat jelas dan lunak pada perabaan, pada ibu yang kurus
 - Payudara yang mengalami sumbatan terasa nyeri dan bengkak terlokalisir.
- c. Penanganan sumbatan saluran susu ini dengan melakukan perawatan payudara.

5. Abdomen

Abdomen terdiri dari beberapa sistem yang dimiliki tubuh, diantaranya Sistem Reproduksi, Sistem Pencernaan, Sistem Endokrin, serta Sistem Perkemihan. Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa harus memahami struktur anatomi abdomen yang meliputi bagian batas-batas perut.



Gambar 1.19 Regio abdomen

Perubahan fisik abdomen pada masa nifas meliputi; uterus (Penurunan TFU, uterus kontraksi, deteksi sub involusi uterus, luka post section caesaria), kandung kemih, rektus abdominalis.

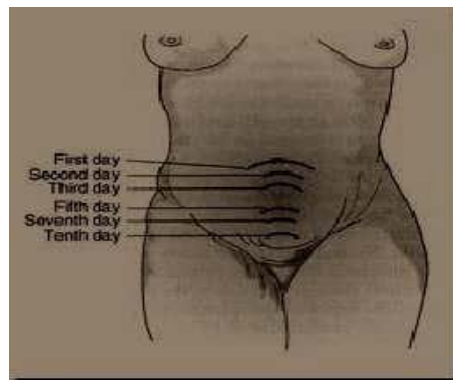
a. Uterus

Uterus merupakan organ yang tebal, berbentuk buah peer, berotot dan terletak didalam pelvis diantara rectum dan kandung kemih. Otot uterus yang disebut miometrium.

- **Penurunan TFU dan uterus kontraksi**

Tonus otot uterus dilakukan pemeriksaan setelah melahirkan, untuk memastikan uterus berkontraksi dengan baik. Pemeriksaan dilakukan dengan palpasi atau pemeriksaan bimanual tonus uterus untuk memastikan bahwa uterus terus berkontraksi dengan kuat. Ukuran uterus lebih besar daripada normal dan teraba lunak disertai perdarahan dari ostium serviks dapat ditemukan pada kasus atonia uterus.

Involusi uterus dapat diperiksa dengan mengukur penurunan tinggi fundus uterus, yang diukur dari simfisis pubis dengan menggunakan mideline. Sebelumnya, uterus diarahkan kebagian tengah abdomen. Postpartum 24 jam pertama, tinggi fundus uterus kurang lebih 13,5 cm di atas simfisis pubis. Setiap 24 jam didapatkan penurunan tinggi kurang lebih 1,25 cm, sehingga saat akhir minggu kedua atau 14 hari uterus telah berada dalam pelvis. Proses involusi kemudian terjadi secara perlahan sampai 6 minggu postpartum, hingga akhirnya ukuran uterus menyerupai ukuran normal.



Gambar 1.20 Penurunan TFU

Berat uterus, saat hamil perut sebelas kali lebih berat uterus sebelum hamil, mengecil menjadi kira-kira 500 g satu minggu setelah persalinan dan 350 g, dua minggu setelah

melahirkan uterus berada di dalam panggul sejati lagi. Akhir minggu keenam, beratnya 60 g dan akhir minggu kedelapan, uterus memiliki berat 30 g, yaitu sebesar uterus normal.

Tabel 1.2 Penurunan TFU

Involusi Uteri	Tinggi Fundus Uteri	Berat Uterus	Diameter Uterus
Plasenta Lahir	Setinggi Pusat	1000 Gram	12,5 cm
7 Hari	Pertengahan pusat	500 Gram	7,5 cm
14 Hari	Tidak Teraba	350 Gram	5 cm
6 Minggu	Normal	60 Gram	2,5 cm

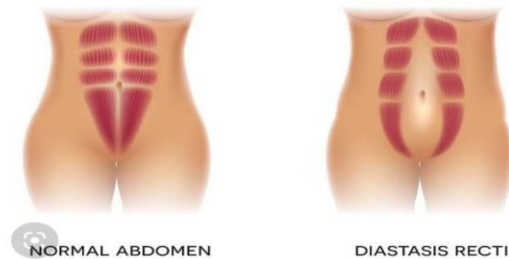
Selama kehamilan uterus terus tumbuh secara massif akibat peningkatan hormone estrogen dan progesteron. Pertumbuhan uterus saat kehamilan terjadi hipertrofi, hiperplasia, peningkatan jumlah sel-sel otot, dan pembesaran sel yang sudah ada. Sedangkan pada masa pasca persalinan terjadi penurunan kadar hormon yang menyebabkan terjadinya autolisis, merusak secara langsung jaringan hipertiroid yang berlebihan. Sel tambahan yang terbentuk pada masa kehamilan masih menetap sehingga ukuran uterus sedikit lebih besar setelah persalinan.

- **Rectus Abdominalis**

Otot rectus abdominal merupakan otot abdomen yang lebar dan panjang. Dilakukan palpasi perut untuk merasakan apakah ada pemisahan antara kedua sisi otot perut saat menundukkan kepala dan dilakukan pemeriksaan USG. Pemeriksaan fisik: palpasi untuk menentukan adanya peregangan pada perut.

Sistem muskuloskeletal kembali secara bertahap seperti keadaan sebelum hamil membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 bulan setelah melahirkan. Kembalinya tonus otot abdomen dan otot dasar panggul pulih Kembali secara bersamaan. Pemulihan masa nifas dapat berlangsung secara normal atau lebih cepat dengan melakukan latihan fisik ringan, seperti senam nifas. Otot rectus abdominis akan teregang lebih dari 2,5 cm pada garis tengah umbilikus, kondisi ini disebut dengan Diastasis Recti Abdominis (DRA),

karena pada kondisi tersebut Linea alba terjadi peregangan mekanis pada dinding abdomen yang terjadi distensi uterus berlebihan, hal ini juga dikarenakan adanya pengaruh hormon ibu saat kehamilan.



Gambar 1.21 Diastasis Recti Abdominis

- **Pemeriksaan Sub Involusi Uteri**

Subinvolusi merupakan proses gagalnya uterus kembali kekeadaan seperti sebelum hamil yang tidak sempurna. Etiologi yang sering ditemukan yaitu infeksi. Tujuan pemeriksaan :

- Mengobservasi untuk mengkaji apakah ada tanda infeksi dan luka jahitan
- Memeriksa penurunan fundus uteri dan posisi uterus serta konsistensinya.
- Pemeriksaan penunjang : USG , Radiologi.

- **Luka Pasca Operasi SC**

Luka pasca operasi adalah luka post operasi luka yang sengaja dibuat insisi dengan prosedur pembedahan atau operatif. Insisi diperiksa dan lakukan perawatan setiap hari, jahitan kulit (klip) diangkat pada hari ke empat setelah pembedahan.



Gambar 1.22 Bekas Luka Operasi SC

Pemeriksaan mendeteksi adanya infeksi pada luka:

- Rubor, kemerahan. Oleh karena aliran darah yang menuju jaringan yang terinfeksi mengisi pembuluh darah kecil sehingga melebarkan pembuluh darah

kecil, menimbulkan warna yang lebih cerah yang disebut hyperemia atau kongesti.

- Tumor, berarti pembengkakan atau pembesaran, bila terjadi proses infeksi pada bagian tubuh yang terinfeksi maka akan terjadi pembengkakan lebih besar dari ukuran sebelumnya, karena banyaknya aliran darah yang menuju ke daerah infeksi. Jaringan akan sedikit mengalami pembesaran karena aliran darah lebih banyak dari sebelumnya. Oleh karena itu pada bagian yang agak bengkak, maka disitu yang banyak mengandung banyak darah.
- Dolor, rasa nyeri atau sakit pada daerah yang ada luka, respon yang pasti terjadi jika ada luka. Selain itu nyeri terjadi jika terjadi kerusakan atau adanya masalah pada jaringan tubuh, sebagai alarm jika terjadi masalah pada tubuh akan memberi peringatan berupa nyeri.
- Kalor, panas terjadi karena mekanisme tubuh meningkatkan aliran darah ke bagian infeksi sebagai upaya perbaikan secepat mungkin dan melawan kuman penyebab infeksi. Proses tersebut menyebabkan peningkatan suhu pada area infeksi.
- Fungsio laesae, perubahan fungsi jaringan yang terinfeksi, tidak bisa diberfungsi sebagaimana mestinya.

b. Kandung Kemih

Fungsi ginjal pada masa kehamilan mengalami peningkatan akibat perubahan hormonal selama kehamilan. Sedangkan pada masa postpartum terjadi penurunan kadar hormon steroid menyebabkan ginjal mengalami penurunan fungsi. Pada ibu menyusui, urine dapat mengandung laktosa dan merupakan hal yang normal. akibat dari proses persalinan karena bayi melewati jalan lahir dapat menyebabkan dinding kandung kemih mengalami edema dan hiperemia. Munculnya rasa nyeri panggul akibat dorongan saat melahirkan.

Memantau frekwensi berkemih, polyuria, rasa sakit seperti terbakar saat berkemih, inkontinensia, prostatitis. Pemeriksaan fisik: palpasi supra simphysis untuk mengeluarkan urine. Buangan urine harus dicatat dalam waktu 6 jam.

c. Kolon

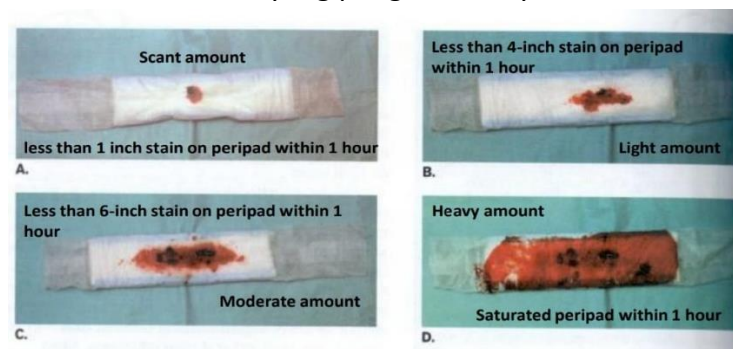
Sistem pencernaan mengalami penurunan motilitas usus yang menjadi penyebab terjadinya konstipasi pada ibu setelah persalinan, faktor lain dari konsumsi suplemen besi maupun pola eliminasi yang kurang baik, psikologis yang cemas adanya jahitan atau rasa tidak nyaman pada perineum. Dampak proses meneran akibat konstipasi menyebabkan ibu berisiko mengalami hemoroid. Pada perabaan teraba keras seperti batu adalah feses yang mengeras yang disebut skibala.

6. Pemeriksaan Genetalia Eksterna

a. Perdarahan (Lochea)

Lochea, yaitu pengeluaran cairan dari rahim setelah persalinan selama masa nifas. Pengeluaran lochea dibagi berdasarkan jumlah dan warnanya sebagai berikut :

- Lochea rubra : Keluar pada hari 1 sampai hari ke 3 setelah persalinan. Cairan yang keluar warna merah segar karena berisi darah segar, endometrium, jaringan sisa plasenta, lemak bayi, lanugo (rambut bayi) dan mekonium.
- Lochea sanguilenta: berwarna merah kecoklatan mengandung lendir, keluar pada hari ke 4-7 masa nifas.
- Lochea serosa : Lochea ini berwarna kuning kecoklatan karena mengandung serum, leukosit, dan robekan laserasi plasenta. Muncul pada hari ke 7 sampai hari ke 14 post partum.
- Lochea alba : lochea ini berwarna keputihan, mengandung leukosit, sel desidua, sel epitel, selaput lendir servik dan serabut jaringan mati. Lochea alba keluar selama lebih dari 14 hari atau 2 sampai 6 minggu postpartum.
- Lochea purulenta, lochea ini muncul jika terjadi infeksi keluar cairan seperti nanah berbau busuk.
- Lochiostasis : lochea yang pengeluarannya tidak lancar



Gambar 1.23 Lochea pada pembalut

Karakteristik bau lochia tidak sama dengan sekret menstrual. Pada lochia serosa, baunya yang paling kuat dan harus dibedakan juga dengan bau lochea yang menandakan infeksi. Pengeluaran lochea dalam jumlah banyak pada awal jam postpartum yang selanjutnya akan berkurang sejumlah besar sebagai lochia rubra, sejumlah kecil sebagai lochia serosa, dan sejumlah lebih sedikit lagi lochia alba. Pada ibu postpartum posisi berbaring umumnya jumlah lochia lebih sedikit dibanding dengan berdiri. Hal ini terjadi akibat pembuangan bersatu di vagina bagian atas manakala wanita dalam berbaring dan kemudian akan mengalir keluar manakala posisi berdiri. Rata-rata jumlah total pengeluaran lochia kira-kira 8-9 oz atau sekitar 240-270 ml.

Memantau perdarahan dari vagina harus dipantau dengan teliti. Perlu diperhatikan warna, bau, jumlah, dan durasi. Jumlah lochia yang sedikit atau tidak ada mungkin disebabkan oleh infeksi atau lochiometra, sedangkan jumlah yang banyak mungkin disebabkan oleh infeksi atau terlambatnya proses involusi. Apabila lochia tetap berwarna merah lebih dari 2 minggu setelah persalinan ada kemungkinan tertinggalnya sisa plasenta atau karena proses involusi yang kurang sempurna (subinvolusi) yang sering disebabkan retroflexio uteri atau terdapat sisa-sisa konsepsi atau retensio plasenta dalam uterus.

b. Perineum

Perineum menjadi kendur segera setelah melahirkan, karena sebelumnya teregang oleh tekanan kepala bayi yang bergerak maju. Pada postnatal hari ke-5, perineum sudah mendapatkan kembali sebagian besar tonusnya sekalipun tetap lebih kendur daripada keadaan sebelum melahirkan. Akan tetapi latihan pengencangan otot perineum akan mengembalikan tonus otot dan memungkinkan wanita secara perlahan. Perubahan pada perineum pasca melahirkan terjadi pada saat perineum mengalami robekan. Robekan jalan lahir dapat terjadi secara spontan ataupun dilakukan episiotomi dengan indikasi tertentu. Pada pemeriksaan perlu diperhatikan adanya robekan pada daerah perineum. Berdasarkan derajatnya, ruptur perineum dapat diklasifikasikan menjadi empat derajat.

- Derajat satu : yaitu terjadi robekan superfisial pada bagian kulit
- Derajat dua : yaitu bila terjadi robekan pada bagian kulit hingga otot perineum

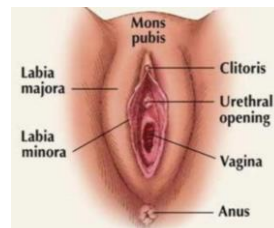
- Derajat tiga : bila robekan mulai dari otot perineum hingga melibatkan otot sfingter anal
- Derajat empat : bila terjadi robekan ekstensif otot sfingter anal hingga mencapai mukosa rektum

Proses penyembuhan luka episiotomi sama dengan luka operasi lain. Penyembuhan harus berlangsung dua sampai tiga minggu. Luka jalan lahir yang tidak terlalu luas akan sembuh secara perpriman (sembuh dengan sendirinya), kecuali luka jahitan terjadi infeksi akan menyebabkan sellulitis yang dapat menjalar hingga terjadi sepsis. Hal terpenting setelah penjahitan laserasi perineum adalah monitoring penyembuhan luka melalui pemeriksaan perineum pascapartum. Penilaian infeksi perineum dapat menggunakan system REEDA :

- *Redness*, dengan inpeksi tampak kemerahan pada daerah penjahitan
- *Edema*, adanya cairan dalam jumlah besar yang abnormal di ruang jaringan intrselular tubuh, menunjukkan jumlah yang nyata dalam jaringan subcutis, edema dapat terbatas yang disebabkan oleh osbtruksi vena atau saluran limfatik atau oleh peningkatan permeabilitas vascular.
- *Echymosis*, bercak perdarahan yang kecil, lebih besar dari petekie (bitnik merah keunguan atau bercak biru kecil yang rata dan bulat sempurna menonjol atau tidak beraturan) pada kulit perineum
- *Discharge*, Ekskresi atau pengeluaran dari daerah yang ada luka di perineum
- *Approximation*, proses menyatunya jaringan yang dijahit

c. Vagina

Vagina merupakan saluran yang menghubungkan rongga uterus dengan tubuh bagian luar (introitus vagina). Dinding depan dan belakang vagina berdekatan satu sama lain. Selama proses persalinan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar, terutama pada saat melahirkan bayi. Beberapa hari pertama sesudah persalinan, vagina tetap berada dalam keadaan kendur.

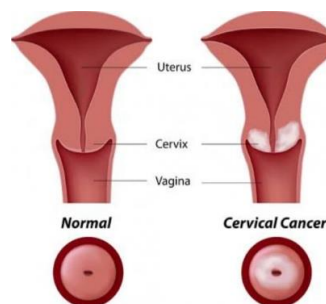


Gambar 1.24 Genetalia Eksterna

Setelah 3 minggu vagina kembali berangsur-angsur seperti keadaan tidak hamil dan rugae dalam vagina akan muncul kembali sementara labia menjadi lebih menonjol. Ukuran vagina akan selalu lebih besar dibandingkan keadaan sebelum persalinan pertama. Vagina yang semula sangat teregang akan kembali secara bertahap pada ukuran sebelum hamil selama 6-8 minggu setelah bayi lahir. Rugae akan kembali terlihat sekitar minggu keempat. Pada pemeriksaan vagina dan vulva perlu diperhatikan adanya hematoma yang dapat disertai nyeri dan perubahan tanda vital, mengindikasikan terjadinya perdarahan. Hematoma dengan ukuran lebih dari 3-4 cm, dapat memerlukan insisi dan evakuasi bekuan darah.

d. Serviks

Serviks merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit sehingga disebut juga sebagai leher rahim. Serviks menghubungkan uterus dengan saluran vagina dan sebagai jalan keluarnya janin dan uterus menuju saluran vagina pada saat persalinan. Segera setelah persalinan, bentuk serviks akan menganga seperti corong.



Gambar 1.25 Serviks

Hal ini disebabkan oleh korpus uteri yang berkontraksi sedangkan serviks tidak berkontraksi. Sehingga seolah olah pada perbatasan antara korpus dan serviks uteri terbentuk semacam cincin.

Warna serviks berubah menjadi merah kehitaman karena mengandung banyak pembuluh darah dengan konsistensi lunak. Kadang terdapat laserasi atau perlukaan kecil. Karena robekan kecil yang terjadi selama berdilatasi selama persalinan, maka serviks tidak akan pernah kembali lagi seperti keadaan sebelum hamil. Muara serviks yang berdilatasi sampai 10 cm sewaktu persalinan maka akan menutup secara bertahap. Setelah 2 jam persalinan serviks hanya dapat dilewati oleh 2-3 jari dan setelah 1 minggu persalinan hanya dapat dilewati oleh 1 jari, setelah 6 minggu persalinan serviks menutup. Pada 2-3 hari pertama, ostium serviks masih terbuka

sebesar 2-4 cm. Setelah satu minggu, ostium serviks umumnya menutup atau hanya dapat dimasukkan satu jari pemeriksa.

e. Pelvis

Ligamen-ligamen, diafragma pelvis, serta fascia yang meregang pada waktu persalinan, secara berangsur-angsur menjadi pulih kembali ke ukuran normal. Namun pada beberapa kasus terdapat keadaan dimana uterus menjadi menekuk ke belakang karena ligamentum rotundum menjadi kendur. Stabilisasi secara sempurna terjadi pada 6-8 minggu setelah persalinan. Untuk memulihkan kembali jaringan penunjang alat genitalia, serta otot dinding perut dan dasar panggul, disarankan untuk melakukan latihan atau senam nifas. Adanya nyeri tekan pada pelvis disertai peningkatan nyeri saat bergerak di tempat tidur atau berjalan. Pelvis yang meregang waktu persalinan, secara berangsur-angsur menjadi pulih kembali ke ukuran normal.

f. Ekstremitas

- Apakah terdapat pembengkakan/odema
- Apakah terdapat varises
- Apakah terdapat kemerahan dan nyeri pada ekstremitas
- Apakah terdapat vena yang teraba seperti tali pada ekstremitas
- Homan sign (+) positif/terdapat nyeri pada betis saat dorsofleksi kaki dengan lutut lurus

Tromboflebitis adalah peradangan pada pembuluh darah balik (vena) yang memicu terbentuknya gumpalan darah pada satu vena atau lebih. Tromboflebitis biasanya terjadi pada pembuluh darah lapisan permukaan yang terletak di area dengan aliran darah buruk. Ibu nifas dengan Riwayat penderita varikosis atau genetic rentan terjadi relaksasi dinding vena dan statis vena. Hormon progesterone dan tekanan oleh uterus pada vena selama kehamilan mengakibatkan stasis vena dan relaksasi dinding vena Kompresi vena selama posisi persalinan juga dapat mempengaruhi. Tanda gejala tromboflebitis :

- Demam tinggi dengan nadi cepat
- Nyeri pada tungkai bawah
- Edema paha, kaki
- Tanda homan positif
- Terjadi pada hari 10-20 hari masa nifas



Gambar 1.26 Tromboflebitis

Klasifikasi

- **Tromboflebitis superficial** yaitu tromboflebitis yang terjadi pada pembuluh darah vena yang lokasinya di dekat kulit yang mengenai vena-vena pada tungkai misalnya vena femoralis, vena poplitea dan vena safena.

Ditandai dengan :

- Sedikit meningkat suhu dan nadi
- Nyeri pada tungkai
- Panas lokal
- Kemerahan dan nyeri tekan



Gambar 1.27 Tromboflebitis Superficial

- **Tromboflebitis vena profunda / Trombosis vena dalam** (deep vein thrombosis/ DVT), yaitu tromboflebitis yang mengenai di otot bagian dalam sebagai akibat dari trombosis yang mengenai vena-vena dinding uterus, ligamentum latum, yaitu vena ovarika, vena uterin dan vena hipogastrika.

Ditandai gejala :

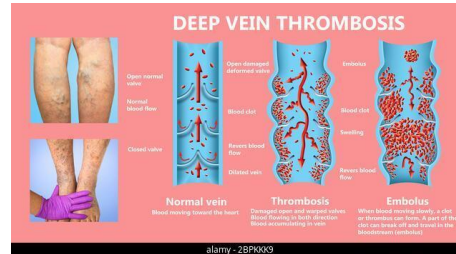
- Terjadi peningkatan suhu ringan
- Peningkatan ringan jumlah nadi
- Nyeri berat pada tungkai diperburuk dengan pergerakan mendadak atau saat berdiri secara tiba-tiba
- Edema pergelangan kaki, tungkai dan paha
- Tanda homan positif
- Nyeri saat palpasi penekanan betis
- Nyeri tekan sepanjang aliran pembuluh darah yang terkena dengan pembuluh darah dapat teraba

Pemeriksaan tanda homans dengan letakkan satu tangan di atas lutut ibu dengan memberikan tekanan ringan untuk menjaga kaki tetap lurus. Jika terdapat nyeri betis saat dorsofleksi, tanda ini positif.

Penanganan, meliputi :

- Bed Rest
- Latihan pergerakan tungkai yang terkena

- Kompres dengan hangat
- Penggunaan stoking elastic
- Pemberian analgesik jika dibutuhkan
- Lakukan rujukan ke dokter untuk kolaborasi terapi antibiotik dan antikoagulan.



Gambar 1.28 Tromboflebitis vena profunda

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Nurul, and Rafhani Rosyidah. "*Buku Ajar Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*." *Umsida Press* (2019): 1-209.
- Bickley, Lynn S. Pemeriksaan Fisik & Riwayat Kesehatan Bates : Buku saku / Lynn S.Bickley, Peter G. Szilagyi alih Bahasa, Esty Wahyuningsih; editor edisi Bahasa Indonesia, Monica Ester, Ramona P.Kapoh – Ed.5 – Jakarta : EGC, 2008
- Eka Puspita dan Kurnia Dwi. 2014. Asuhan Kebidanan Masa Nifas (Post Natal Care). Jakarta : CV Trans Info Media.
- Intranatal, Postnatal, Bayi Baru Lahir dan Kontrasepsi. Jakarta : Salemba Medika
- Johnson., Joyce Y. 2014. Keperawatan Maternal Edisi 1.Yogyakarta : Rapha Publishing.
- Kumalasari, intan 2015. Panduan Praktik Laboratorium dan Klinik Perawatan Antenatal,
- Mustika, Dian Nintyasari, Siti Nurjanah, and Yuliana Noor Setiawati Ulvie. "*Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas ASI EKSKLUSIF*." (2020).
- Ningsih, Dewi Andariya, Frisca Dewi Yunadi, and Misrina Retnowati. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Penerbit NEM, 2021.

BAB 2

PERSIAPAN MENYUSUI DAN TEKNIK MENYUSUI

Yayah Rokayah, SKM. M. Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. Pendahuluan

Persiapan menyusui pada masa kehamilan penting dilakukan, ibu yang menyiapkan lebih dini akan lebih siap menyusui bayinya. Dibeberapa puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya (rumah bersalin RS) ada kelas bimbingan persiapan menyusui (BPM). Program ini merupakan bagian dari pelayanan ibu hamil yang mendukung keberhasilan menyusui. Diharapkan semua tempat pelayanan kesehatan yang melayani ibu hamil dapat menyediakan program ini. Pelayanan meliputi:

1. Penyuluhan langsung melalui bantuan sarana audio-visual atau media pandang, dengar, seperti video tentang:
 - a. Keunggulan ASI dan kerugian susu buatan
 - b. Manfaat rawat gabung
 - c. Merawat bayi
 - d. Gizi hamil dan menyusui
 - e. KB (keluarga berencana)
2. Dukungan psikologis untuk ibu dalam menghadapi persalinan dengan tujuan agar ibu meyakini keampuannya dan keberhasilan menyusui.
3. Pemeriksaan payudara
4. Pemeriksaan Putting susu.

B. Persiapan Psikologis

Keberhasilan menyusui didukung oleh persiapan yang dilakukan sejak masa kehamilan. Persiapan ini sangat berarti karena keputusan atau sikap ibu yang positif terhadap pemberian ASI harus sudah terjasi saat kehamilan, atau bahkan jauh sebelumnya. sikap ibu dalam pemberian ASI disebabkan oleh berbagai factor, antara lain adat, kebiasaan, kepercayaan menyusui di daerah masing-masing. pengalaman menyusui pada anak sebelumnya, kebiasaan menyusui dalam keluarga atau dikalangan kerabat, pengetahuan ibu dan keluarganya tentang manfaat ASI. Dukungan dokter, bidan atau petugas kesehatan lainnya, teman atau kerabat sangat dibutuhkan terutama untuk ibu yang baru pertama kali hamil. Langkah-langkah persiapan ibu agar secara mental siap menyusui adalah:

1. Memberikan motivasi kepada ibu dengan meyakinkan bahwa setiap ibu mampu untuk memberikan ASI kepada bayinya, dan menjelaskan bahwa persalinan dan menyusui itu suatu hal fisiologis.
2. Meyakinkan ibu akan keuntungan dan kerugian dari ASI.

3. Membantu ibu untuk mengatasi keraguannya karena pernah bermasalah pada saat menyusui.
4. Mengikutsertakan suami dan keluarga lain yang berperan dalam keluarga untuk mendukung pemberian ASI
5. Memberikan kesempatan kepada ibu untuk bertanya setiap ia membutuhkannya. Dokter, bidan atau petugas kesehatan lainnya harus memberikan perhatian.

C. Pemeriksaan Payudara

Dalam masa kehamilan payudara perlu diperiksa sebagai persiapan menyusui. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada payudara secara dini. Jika ditemukan ada kelainan pada payudara dapat dikoreksi agar ketika menyusui bisa berjalan lancar. Pemeriksaan dilakukan secara Inspeksi dan palpasi.

1. Inspeksi

a. Payudara

- Ukuran dan bentuk: perlu diperhatikan bila ada kelainan pada bentuk payudara seperti pergerakan massif, gerakan yang tidak simetris pada perubahan posisi.
- Kontur permukaan: permukaan yang tidak rata, adanya retraksi atau luka pada kulit payudara harus diperhatikan kearah tumor atau keganasan dibawahnya. Saluran limfe yang tersumbat dapat menyebabkan kulit bengkak, dan membuat gambaran seperti kulit jeruk.
- Warna kulit: pada umumnya warna kulit payudara sama dengan warna kulit perut atau punggung, yang perlu diperhatikan adalah adanya warna kemerahan tanda radang, penyakit kulit atau keganasan.

b. Areola

- Ukuran dan bentuk : pada umumnya meluas pada saat waktu pubertas dan selama kehamilan dan bentuknya simetris. Bila batas areola tidak rata perlu diperhatikan lebih khusus.
- Permukaan : dapat licin atau berkerut. Bila ada sisik putih perlu dipikirkan adanya penyakit kulit karena kebersihan diri yang kurang.
- Warna : pada saat kehamilan terjadi pigmentasi menyebabkan warna kulit pada areola terlihat lebih gelap

c. Putting susu

- Ukuran dan bentuk : ukuran putting susu sangat bervariasi setiap orang dan tidak mempunyai arti khusus. Bentuk putting susu bermacam-macam, pada bentuk putting susu yang terbenam perlu

dipikirkan retraksi adanya keganasan, namun tidak semua putting susu terbenam karena akibat keganasan.

- Permukaan : pada umumnya tidak beraturan . adanya luka dan sisik merupakan suatu kelainan.
- Warna : warna sama dengan areola karena mempunyai pigmen yang sama atau lebih.

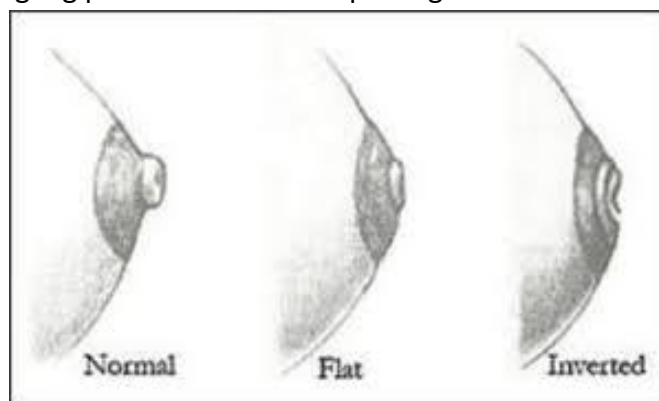
2. Palpasi

- a. Konsistensi : dari waktu ke waktu berbeda karena pengaruh hormon
- b. Massa: setiap massa harus digambarkan secara jelas letak dan ciri-ciri massa yang teraba harus dievaluasi dengan baik.
- c. Putting susu : pemeriksaan putting susu merupakan hal penting dalam mempersiapkan ibu pada waktu menyusui

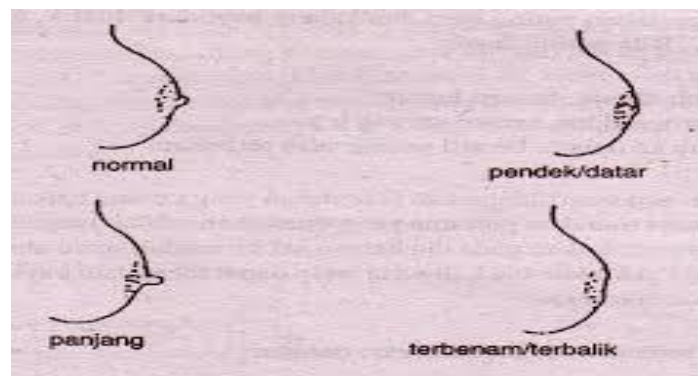
D. Pemeriksaan Putting Susu

Untuk menunjang keberhasilan menyusui maka pada saat kehamilan putting susu ibu perlu diperiksa kelenturannya dengan cara :

1. Sebelum dipegang periksa dulu bentuk putting susu.



Gambar 2.1



Gambar 2.2

2. Cubit areola di sisi putting susu dengan ibu jari dan telunjuk.
3. Dengan perlahan putting susu dan areola ditarik, untuk membentuk “dot”.

E. Teknik Menyusui

Seorang ibu dengan bayi pertamanya mungkin akan mengalami kesulitan ketika menyusui, yang sebetulnya tidak tahu cara-cara yang sebenarnya sangat sederhana. Cara meletakkan bayi pada payudara ketika menyusui berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui. Walaupun seorang bayi sudah dapat menghisap tetapi dapat mengakibatkan putting terasa nyeri. Selain itu mungkin ada masalah lain, terutama pada minggu pertama setelah melahirkan. Saat ini ibu secara emosional lebih peka (sensitif). Sebenarnya kepekaan tersebut sangat membantu dalam proses pembentukan ikatan bathin antara ibu dan bayi, ibu menunjukkan rasa cintanya, kasih sayangnya kepada anak. Di sisi lain ibu baru menjalani proses pemulihan dan mungkin menjadikannya tepat tersinggung. Dalam hal ini ibu sangat membutuhkan pendamping yang dapat membimbingnya untuk bisa merawat bayi, termasuk menyusui. Disarankan agar ibu didampingi oleh orang yang dapat membantunya, terutama orang-orang sangat berpengaruh besar dalam kehidupannya atau yang disegani, seperti suami dan keluarga, kerabat atau kelompok orang-orang pendukung ASI dan dokter/bidan serta petugas kesehatan lainnya, yang siap memberikan dukungan terhadap keinginan ibu untuk bisa menyusui.

Dokter, bidan atau tenaga kesehatan lainnya yang berkecimpung dalam bidang laktasi seharusnya mengetahui bahwa menyusui itu merupakan suatu proses alamiah. Namun untuk mencapai keberhasilan menyusui diperlukan pengetahuan mengenai teknik-teknik menyusui yang benar sehingga pada saatnya dapat disampaikan kepada ibu yang memerlukan bimbingan setelah persalinan.

F. Posisi dan Perlekatan Menyusui

Ada berbagai macam posisi menyusui. Cara menyusui yang biasa pada umumnya dilakukan adalah dengan posisi duduk, berdiri, berbaring. Ada posisi menyusui khusus berkaitan dengan situasi tertentu yang terjadi pada ibu nifas seperti pada ibu dengan pasca operasi sesaria. Bayi diletakan disamping kepala ibu dengan kaki diatas. Posisi menyusui untuk bayi kembar dilakukan dengan cara seperti memegang bola, kedua bayi disusui dengan waktu yang bersamaan dipayudara kiri dan kanan. Pada ASI yang memancar (penuh) , posisi menyusui bayi ditengkurapkan diatas dada ibu, tangan ibu sedikit menahan kepala bayi, dengan posisi ini maka bayi tidak akan tersedak.



Gambar 2.3 Macam- macam posisi menyusui

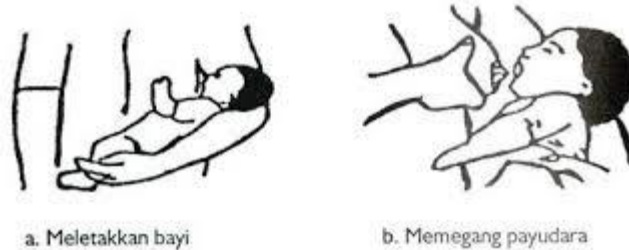


Gambar 2.4 Cara meletakkan bayi dan memegang payudara

G. Langkah-Langkah Menyusui Yang Benar

1. Sebelum menyusui, ASI dikeluarkan sedikit kemudian dioleskan pada putting susu dan areola sekitarnya. Cara ini mempunyai manfaat sebagai desinfektan dan menjaga kelembaban putting susu.
2. Bayi diletakan menghadap perut ibu/payudara
 - a. Ibu duduk atau berbaring santai. Bila duduk lebih baik menggunakan kursi yang rendah agar kaki ibu tidak menggantung dan punggung ibu bersandar pada sandaran kursi.
 - b. Bayi dipegang dengan satu tangan, kepala bayi terletak dilengkung siku ibu dan bokong bayi terletak pada lengan. Kepala bayi tidak boleh tertengadah dan bokong bayi ditahan dengan telapak tangan ibu.
 - c. Satu tangan bayi diletakan dibelakang badan ibu, dan yang satu lagi didepan.
 - d. Perut bayi nempel pada badan ibu, kepala bayi menghadap ke payudara
 - e. Telingga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus.

- f. Ibu menatap bayi dengan kasih sayang.
- 3. Payudara dipegang dengan ibu jari diatas dan jari yang lain menopang dibawah, jangan menekan puting susu atau areolanya saja.



Gambar 2.5 Cara meletakkan bayi dan memegang payudara

- 4. Bayi diberi rangsangan untuk membuka mulut(*rooting reflex*)dengan cara:
 - a. Menyentuh pipi dengan puting susu atau,
 - b. Menyentuh sisi mulut bayi



Gambar 2.6 Merangsang bayi membuka mulut

- 5. Setelah bayi membuka mulut, dengan cepat kepala bayi diletakan ke payudara ibu dengan puting serta areola dimasukan ke mulut bayi;
 - a. Usahakan sebagian besar areola dapat masuk kedalam mulut bayi, sehingga puting susu berada dibawah langit-langit dan lidah bayi akan menekan ASI keluar dari penampungan ASI.
 - b. Setelah bayi mulai menghisap, payudara tidak perlu dipegang atau disangga lagi.

H. Cara Pengamatan Teknik Menyusui yang Benar

Menyusui dengan teknik yang tidak benar dapat mengakibatkan puting susu menjadi lecet, ASI tidak keluar optimal sehingga mempengaruhi produksi ASI selanjutnya atau bayi enggan menyusui. Untuk mengetahui bayi telah menyusui dengan teknik yang benar, perhatikan:

- a. Bayi tampak tenang.
- b. Badan bayi menempel pada perut ibu

- c. Mulut bayi terbuka lebar
- d. Dagunya menempel pada payudara ibu
- e. Sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi, areola bagian bawah lebih banyak yang masuk
- f. Bayi nampak mengisap kuat dengan irama perlahan
- g. Putting susu ibu tidak terasa nyeri
- h. Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus
- i. Kepala bayi menengadahkan
- j. Melepas isapan bayi
- k. Menyusui berikutnya dari payudara yang belum terkosongkan
- l. Setelah selesai menyusui, ASI dikeluarkan sedikit kemudian dioleskan pada puting susu dan areola sekitarnya biarkan kering dengan sendirinya.



Gambar 2.7 Teknik menyusui yang benar

- m. Menyendawakan bayi
pada akhir menyusui untuk mencegah terjadinya gumoh hendaknya bayi dipeluk tegak pada bahu atau dipangkuan ibu, sambil ditepuk-tepuk perlahan punggungnya untuk mengeluarkan udara yang ditelan oleh bayi selama ia menyusui. Tindakan ini perlu dilakukan beberapa kali selama bayi menyusui, bahkan juga 5-10 menit setelah bayi selesai menyusui. Tindakan ini perlu dilakukan dalam bulan-bulan pertama.

Setelah dibuat sendawa bayi hendaklah diletakkan lagi di tempat tidur dalam posisi miring pada sisi kanan, untuk mengurangi kemungkinan “gumoh” posisi ini juga dapat membantu kelancaran perjalanan air susu dari lambung ke dalam usus bayi.

Tujuan menyendawakan bayi adalah mengeluarkan udara dari lambung supaya bayi tidak muntah (gumoh) setelah menyusui. Cara menyendawakan bayi:

- Bayi digendong tegak dengan bersandar pada bahu ibu, kemudian bahu bayi ditepuk-tepuk atau,

- Bayi tengkurap dipangkuan ibu, kemudian punggung bayi ditepuk secara perlahan



Gambar 2.8 Cara menyendawakan bayi

I. Lama dan Frekuensi Menyusui

Sebaiknya bayi disuse tanpa dijadwal (on demand), karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya. Ibu harus menyusui bayinya bila bayi menangis bukan karena sebab lain (kencing, kepanasan, kedinginan atau sekedar ingin dipeluk) atau ibu sudah perlu menyusui bayinya. Bayi yang sehat dapat mengosongkan satu payudara sekitar 5-7 menit dan ASI dalam lambung bayi akan kosong dalam waktu 2 jam. Pada awalnya bayi akan menyusu dengan jadwal yang tak teratur, dan akan mempunyai pola tertentu setelah 1-2 minggu kedepan.

Menyusui yang dijadwal akan berakibat kurang baik, karena isapan bayi akan berpengaruh pada rangsangan produksi ASI selanjutnya. Dengan menyusui tanpa dijadwal sesuai kebutuhan bayi, akan mencegah timbulnya masalah menyusui. Ibu yang bekerja diluar rumah dilanjutkan agar lebih sering menyusui pada malam hari akan memacu produksi ASI. Untuk menjaga keseimbangan besarnya kedua payudara maka sebaiknya setiap kali menyusui harus dengan kedua payudara. Ibu harus berusaha menyusui sampai payudara terasa kosong, agar produksi ASI

menjadi lebih baik. Setiap kali menyusui, dimulai dari payudara yang terakhir disusukan. Selama menyusui sebaiknya ibu menggunakan BH yang dapat menyangga payudara, tetapi tidak terlalu ketat.

J. Pengeluaran ASI

Apabila ASI berlebihan sampai keluar memancar, maka sebelum menyusui sebaiknya ASI dikeluarkan terlebih dahulu untuk menghindari bayi tersedak atau bayi enggan menyusui. Pengeluaran ASI juga berguna untuk para ibu yang bekerja yang akan meninggalkan ASI buat bayinya dirumah. ASI yang merembes karena payudara yang penuh, pada bayi yang mempunyai masalah mengisap (misalnya pada bayi yang BBLR), menghilangkan bendungan atau memacu produksi ASI saat ibu sakit dan tidak dapat langsung menyusui bayinya. Pengeluaran ASI dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Pengeluaran dengan tangan

Cara ini lazim digunakan karena tidak banyak membutuhkan sarana dan lebih mudah langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Ibu diminta mencuci tangan sampai bersih.
- Ibu/ keluarga menyiapkan cangkir bertutup yang telah dicuci dengan air mendidih.
- Ibu melakukan pemijatan atau masase payudara dengan kedua telapak tangan dari pangkal payudara ke arah areola. Minta ibu mengulang pemijatan ini pada sekeliling payudara secara merata.
- Ibu menekan daerah areola ke arah dada dengan ibu jari disekitar areola bagian atas dan jari telunjuk pada sisi areola yang lain.
- Pijat areola dengan ibu jari dan telunjuk, jangan memijat/menekan putting karena dapat menyebabkan rasa nyeri/lecet.
- Minta ibu untuk tekan-peras-tekan-peras-tekan-peras. Pada mulanya ASI tak keluar, jangan berhenti tekan-peras dilanjutkan setelah beberapa kali maka ASI akan keluar.
- Minta ibu agar mengulangi gerakan ini pada sekeliling areola dari semua sisi sehingga yakin bahwa ASI telah diperas dari semua segmen payudara.

2. Pengeluaran dengan pompa

Bila payudara bengkak/terbendung (engorgement) dan putting susu terasa nyeri, maka akan lebih baik bila ASI dikeluarkan dengan pompa payudara. Pompa baik digunakan bila ASI benar-benar penuh, tetapi pada payudara yang lunak akan lebih susah. Ada 2 macam pompa yang dapat digunakan yaitu tangan dan listrik.

Cara pengeluaran ASI dengan pompa payudara tangan:

- Tekan bola karet untuk mengeluarkan udara.
- Letakan ujung lebar tabung pada payudara dengan puting susu tepat ditengah, dan tabung benar-benar melekat pada kulit.
- lepas bola karet, sehingga puting dan areola tertarik kedalam.
- Tekan dan lepas beberapa kali, sehingga ASI akan keluar dan terkumpul pada lekukan penampung pada sisi tabung.
- Cucilah alat dengan bersih, menggunakan air mendidih, setelah selesai dipakai atau akan dipakai. Bola karet sukar dibersihkan oleh karenanya bila memungkinkan lebih baik pengeluaran ASI dengan tangan.

K. Penyimpanan ASI

ASI dikeluarkan dapat disimpan untuk beberapa saat, ada perbedaan lamanya disimpan dikaitkan dengan tempat penyimpanan nya.

- Didalam udara terbuka/ bebas : 6-8 jam
- Di lemari es (4oC) : 24 jam
- Di lemari pendingin/ beku (-18oc) : 6 bulan

ASI yang telah didinginkan tidak boleh direbus bila akan dipakai, karena kualitasnya akan menurun yaitu unsur kekebalannya. ASI tersebut cukup diiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar, agar tidak terlalu dingin, atau dapat pula direndam didalam wadah yang telah berisi air panas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini Yeti (2010), *Asuhan Kebidanan Masa Nifas* Yogyakarta. Pustaka Rihana.
- Ambarwati (2008), *Asuhan Masa Nifas*. Yogyakarta Mitra Cendika.
- Bahyatun (2009), *Asuhan Kebidanan Nifas Normal*. Jakarta ECG
- Dr.Taufan N, dkk (2014), *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Dan Nifas*. Yogyakarta Nuha-Medika.
- N Azizah (2021), *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas Dan Menyusui*. Umsida Press, 1-209. <https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-78-2>
- Siti Hamidah (2022), *Monograf Manajemen Laktasi dan Stimulasi menuju Tumbuh Kembang Anak Optimal*. Jawa Tengah EUREKA MEDIA AKSARA .

BAB 3

ADAPTASI PSIKOLOGI MASA NIFAS

Ni Wayan Manik Parwati, S.Si.T.,M.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. Adaptasi Psikologi Ibu Masa Nifas

Adaptasi psikologis masa nifas adalah suatu proses adaptasi dari ibu post partum. Proses perubahan psikologis ibu nifas adalah suatu perubahan sikap yang terjadi pada saat post partum atau setelah ibu melahirkan bayi. Proses pengambilan sikap oleh ibu nifas yang berhubungan dengan dirinya dan bayi. Adanya perubahan fisik dan psikologis ibu nifas membuat ibu nifas harus menyesuaikan dengan adanya perubahan tersebut. Penyesuaian atau adaptasi ini diperlukan sekali oleh ibu nifas supaya ibu nifas mampu bertanggung jawab dan menjalankan peran seorang ibu.

Menurut teori Reva Rubin setelah proses kelahiran bayi, tanggung jawab keluarga bertambah terutama ibu dengan peran barunya. Adanya dorongan, perhatian dan dukungan positif terhadap ibu dalam proses penyesuaian masa nifas dan perannya sebagai ibu akan melalui tahapan sebagai berikut:

1. *Taking in*

Pada tahap ini ibu nifas fokus pada diri sendiri dan biasanya berlangsung satu sampai dua hari setelah melahirkan. Ibu mudah tersinggung, kelelahan sehingga butuh istirahat yang cukup untuk mencegah terjadinya anemia. Pada fase ini perlu komunikasi yang baik serta pemulihan nutrisi ibu. Ada kalanya ibu tidak menginginkan kontak dengan bayinya, tetapi bukan berarti ibu tidak memperhatikan bayinya. Pada fase ini ibu perlu mendapatkan informasi tentang bayinya bukan cara merawat bayinya.

2. *Taking hold*

Dalam fase ini ibu mulai belajar untuk melakukan perawatan terhadap bayi dan dirinya. Keluarga akan memberikan dukungan dan komunikasi yang baik agar ibu merasa mampu melewati fase ini. Periode ini biasanya berlangsung pada hari ketiga sampai hari kesepuluh.

3. *Letting go*

Tahapan ini ibu sudah menerima secara sadar mengenai tanggung jawab dan peran barunya sebagai ibu. Ibu telah menyesuaikan diri dan mampu melakukan perawatan pada bayinya secara mandiri. Ibu menjalani ikatan batin dengan bayinya sejak awal (*bonding*).

Menurut Whibley (2006) perubahan emosi ibu *postpartum* secara umum antara lain adalah:

- 1 *Thrilled* dan *excited*, ibu merasakan bahwa persalinan merupakan peristiwa besar dalam hidup. Ibu heran dengan keberhasilan melahirkan seorang bayi dan selalu bercerita seputar peristiwa persalinan dan bayinya.
- 2 *Overwhelmed*, merupakan masa kritis bagi ibu dalam satu hari pertama dalam perannya sebagai ibu dalam mengerjakan tugas-tugas baru seperti merawat bayinya.
- 3 *Let down*, ibu mengalami perubahan emosi, ada perasaan kecewa terhadap perubahan fisik dan peran barunya.
- 4 *Weepy*, ibu mengalami *postpartum blues* karena perubahan yang tiba-tiba dalam kehidupannya, merasa cemas dan takut dengan ketidakmampuan merawat bayinya dan merasa bersalah. Perubahan emosi ini dapat membaik dalam beberapa hari setelah ibu dapat merawat diri dan bayinya serta mendapat dukungan keluarga.
- 5 *Feeling beat up*, merupakan masa kerja keras fisik dalam hidup dan akhirnya merasa kelelahan.

B. Gangguan Psikologis Ibu *Postpartum*

1. Jenis Gangguan Psikologis

Terdapat 3 jenis gangguan psikologis yang umum terjadi pada masa nifas, yaitu:

a. *Postpartum blues*

Fenomena ini terjadi akibat adanya perubahan *mood* pada ibu *postpartum* yang terjadi setiap waktu setelah ibu melahirkan tetapi seringkali terjadi pada hari ketiga atau keempat *postpartum* dan memuncak antara hari kelima dan ke-14 *postpartum*. Kondisi akan menghilang dalam beberapa hari. Hal ini masih dianggap normal terkait dengan perubahan dan adaptasi psikologis *postpartum*. Apabila ibu nifas mempunyai faktor predisposisi dan pemicu lainnya maka dapat berlanjut menjadi depresi *postpartum*.

b. Depresi *postpartum*

Depresi *postpartum* ditandai dengan perasaan sedih akibat berkurangnya kebebasan bagi ibu, perubahan tubuh, penurunan estetika, berkurangnya interaksi sosial dan kemandirian yang disertai gangguan tidur, menurunnya nafsu makan, cemas berlebih, kehilangan kontrol, perasaan tidak berdaya, kurang memperhatikan bentuk tubuhnya, pikiran yang menakutkan mengenai kondisi bayi, tidak menyukai bayi dan takut menyentuh bayinya. Gangguan psikologis ini dapat terjadi selama dua minggu berturut-turut dan menunjukkan perubahan dari keadaan sebelumnya.

c. *Postpartum* psikosis

Depresi postpartum yang tidak tertangani dengan baik berisiko menjadi psikosis, yang ditandai dengan gejala depresi berat dengan proses pikir (*delusion, hallucinations and inchorence of association*) yang dapat mengancam dan membahayakan keselamatan jiwa ibu dan bayinya. Kondisi ini sangat memerlukan pertolongan dari tenaga profesional yaitu psikiater dan pemberian obat (Sebastian, 2016)

Tabel 3.1. Gangguan Psikologis Masa Nifas

	Postpartum blues	Depresi postpartum	Psikosis
Prevalensi	60-80%	10-20%	3-5%
Gejala	<i>Labilitas mood</i> , mudah menangis, nafsu makan menurun, gangguan tidur, biasanya terjadi dalam 2 minggu atau kurang dari 2 minggu	Cemas, rasa kehilangan, sedih, kehilangan harapan (<i>hopelessness</i>), menyalahkan diri sendiri, gangguan percaya diri, kehilangan tenaga, lemah, gangguan nafsu makan (<i>appetite</i>), berat badan menurun, insomnia, rasa khawatir yang berlebihan, perasaan bersalah dan ada ide bunuh diri	Gejala sama dengan depresi postpartum ditambah halusinasi, delusi dan agitasi
Kejadian	1-10 hari pasca melahirkan	1-12 bulan pasca melahirkan	Pada umumnya terjadi pada bulan pertama pasca melahirkan
Etiologi	Perubahan hormonal dan perubahan/adanya stressor dalam hidup	Memiliki riwayat depresi, respon hormonal, Kurangnya dukungan sosial	memiliki riwayat penyakit mental, perubahan hormone, ada riwayat keluarga dengan penyakit bipolar
Penanganan	Support dan empati	Konseling	Psikoterapi dan terapi obat

Sumber: (Widjaja, 2014)

2. Prevalensi

Postpartum sindrom ditandai dengan episode episodik ketidaknyamanan, kelebihan emosi, gangguan terhadap memori, dan kesedihan. Kondisi ini mempengaruhi 50% - 80% ibu pasca melahirkan yang masih dalam perawatan di ruang nifas dalam beberapa hari pertama pasca melahirkan. Pada 85% ibu postpartum akan mengalami gangguan perasaan yang bersifat ringan dan sementara, namun pada beberapa ibu nifas dapat mengalami gejala yang berkepanjangan. Diperkirakan sekitar 10-15 % dari ibu nifas yang mengalami postpartum blues, apabila tidak di skrining dan tidak mendapatkan penanganan yang baik akan ada kecenderungan untuk berkembang menjadi depresi pascapersalinan (Gondo, 2017). Jean Esquirol untuk pertama kalinya pada tahun 1818 menunjukkan data tentang 92 kasus psikosis setelah melahirkan yang diambil dari studinya selama perang. Gangguan kejiwaan ini digambarkan sebagai suatu bentuk depresi yang tidak normal yang terjadi pada ibu pasca melahirkan. Gangguan ini diperkirakan secara spesifik berhubungan dengan perubahan fisiologis dan psikologis masa kehamilan dan kelahiran yang berlanjut ke perubahan hormonal masa nifas, perubahan spesifik pada aksis Hipotalamus-Pituitari-Adrenal.

3. Etiologi

Penyebab dari gangguan psikologis postpartum belum diketahui secara pasti, tapi diduga disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:

a. Faktor hormonal

Perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron mempengaruhi terjadinya fluktuasi hormonal pada tubuh. Kadar hormon kortisol atau hormon pemicu stres yang terdapat pada tubuh ibu mengalami peningkatan, sementara kadar hormon progesteron sangat rendah. Pada waktu yang sama, kadar hormon prolaktin dan hormon laktogen mengalami peningkatan, dimana hormon ini berperan dalam produksi ASI. Hal inilah yang akan menyebabkan kelelahan fisik serta memicu stres pada ibu.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulansari, Istiaji and Ririanty (2017) dikatakan bahwa *postpartum blues* dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu terjadinya fluktuasi hormonal, dimana hormone estrogen meningkat selama kehamilan dan akan menurun setelah melahirkan sehingga hal ini bisa memicu terjadinya stres, sedangkan hormone endorphin yang merupakan hormone kebahagiaan mengalami penurunan saat persalinan sehingga hal ini juga bisa memicu terjadinya stres. Selain

itu ketidakstabilan hormone tiroid pasca melahirkan menyebabkan menurunnya gairah ibu nifas.

b. Faktor demografik

Faktor demografik yang menyebabkan gangguan psikologis postpartum adalah faktor umur ibu postpartum yang terlalu tua atau terlalu muda, pengalaman kehamilan maupun persalinan, latar belakang ibu seperti status perkawinan, tingkat pendidikan, status kehamilan, sosial ekonomi dan riwayat kejiwaan ibu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2018) melaporkan bahwa terdapat hubungan antara usia ibu, pendidikan dan status obstetrik dengan kejadian *postpartum blues*. Dimana sebagian besar kejadian *postpartum blues* dialami oleh ibu dengan usia 20-35 tahun dan juga *postpartum blues* sebagian besar terjadi pada ibu yang pendidikan SMP. Tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir serta koping *stress* pada diri individu, sehingga secara tidak langsung hal ini mempengaruhi kejadian *postpartum blues*. Pengalaman saat hamil dan melahirkan juga mempengaruhi kejadian *postpartum blues*, dimana ibu yang baru pertama kali melahirkan mempunyai risiko lebih besar terjadinya *postpartum blues* dibandingkan dengan ibu yang sudah pernah melahirkan sebelumnya.

c. Faktor psikologis

Faktor psikologis ibu postpartum berhubungan erat dengan dukungan suami dan keluarga. Gangguan psikologis pada ibu nifas bisa disebabkan karena kurangnya dukungan suami dan keluarga kepada ibu yang baru melahirkan. Selain itu, kondisi bayi yang tidak sesuai dengan harapan ibu dapat juga menjadi pemicu terjadinya gangguan tersebut.

Hasil penelitian Tilana (2021) melaporkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan suami dengan kejadian *postpartum blues*, dimana dukungan suami sangat diperlukan untuk memberikan pengaruh positif pada ibu nifas, serta kerja sama yang baik antara ibu dan suami dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi ibu dalam merawat dirinya serta bayinya.

d. Faktor fisik

Rasa lelah akibat merawat bayi, memandikan, menyusui, mengganti popok dan lain sebagainya dapat menjadi pemicu ibu mengalami *postpartum blues*, apalagi jika suami dan keluarga tidak membantu ibu selama masa nifas, maka hal ini akan meningkatkan kemungkinan ibu mengalami gangguan psikologis postpartum.

Hasil penelitian Sepriani (2020) melaporkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan kejadian *postpartum blues*, dimana kelelahan fisik karena berkurangnya waktu untuk istirahat dan tidur akibat bertambahnya peran dan tanggung jawab dalam mengurus bayi memicu terjadinya *postpartum blues*.

e. Faktor sosial

Ibu yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan peran barunya sebagai seorang ibu serta adanya perubahan gaya hidup dan perasaan terkekang akibat kehadiran bayi dan merasa dijauhi oleh lingkungan, akan meningkatkan resiko ibu mengalami gangguan psikologis *postpartum*.

Penelitian Purwati and Noviyana (2020) melaporkan terdapat hubungan lingkungan sekitar dengan kejadian *postpartum blues*. Ibu nifas secara alamiah akan beradaptasi dengan perubahan yang dialaminya, jika adaptasi ini tidak mengalami kendala maka ibu kemungkinan kecil mengalami gangguan psikologis *postpartum*. Perubahan dan adaptasi ini memerlukan dukungan dari orang terdekat dan lingkungan sekitarnya, dimana semakin baik penyesuaian diri ibu nifas terhadap peran barunya sebagai ibu maka dapat mencegah dan menurunkan kejadian *postpartum blues*.

4. Tanda dan gejala *postpartum blues*

Menurut Sebastian (2016) adapun tanda dan gejala pada ibu yang mengalami *postpartum blues* yaitu:

- a. Reaksi depresi/ disforia/ sedih
- b. Sering menangis
- c. Cemas
- d. Mudah tersinggung
- e. Labilitas perasaan
- f. Gangguan nafsu makan dan gangguan tidur
- g. Cenderung menyalahkan diri sendiri
- h. Mudah sedih
- i. Cepat marah
- j. Kelelahan
- k. *Mood* mudah sekali berubah, menjadi gembira lebih mudah dan cepat juga menjadi sedih
- l. Perasaan bersalah
- m. Perasaan terjebak dan marah pada pasangannya dan bayinya
- n. Perasaan kurang menyayangi bayinya
- o. Perasaan kurang percaya diri

p. Pelupa

Menurut Yunitasari and Suryani (2020), gejala yang sering dijumpai pada ibu yang mengalami *postpartum blues* adalah 48% sedih, 41% cemas, 41% mudah tersinggung, 26% labilitas perasaan, 23% menangis, 21% gangguan nafsu makan dan 15% gangguan tidur.

5. Dampak Gangguan psikologis postpartum

Postpartum blues yang tidak mendapatkan penanganan dan perawatan dengan baik akan berlanjut menjadi depresi *postpartum* dan apabila setelah 6 minggu depresi tersebut tidak hilang dan bertambah parah, maka selanjutnya kondisi ini akan menjadi psikosis *postpartum*. Apabila *postpartum blues* berlanjut menjadi depresi *postpartum*, maka tingkat kesedihan ibu menjadi lebih intens, ibu sulit melakukan aktivitas sebagai seorang ibu dan gejala gangguan depresi tersebut bisa menimbulkan dampak yang merugikan pada ibu, bayinya serta anggota keluarganya. Ibu menjadi tidak mapu merawat bayinya dengan maksimal karena merasa tidak mampu dan tidak berdaya. Ibu menjadi menghindari tanggung jawab, lupa untuk memberikan nutrisi dan menyusui bayinya sehingga berisiko terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Simulasi untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayinya tidak bisa optimal, dimana bayi yang sedang dalam tahap perkembangan suka berkomunikasi, hal ini tidak bisa dilakukan. Contoh sederhana seperti senyuman, tatapan mata, tangisan, Gerakan badan atau tangan dan coletahan yang seharusnya direspon oleh ibu, namun karena gangguan psikologis hal tersebut tidak terjadi. Akibatnya bayi menjadi kecewa, sedih bahkan stress dengan respon ibunya. Kejadian seperti ini membuat perkembangan tidak optimal, sehingga membuat kepribadiannya kurang matang (Tilana, 2021; Verawati et al., 2020).

C. Skrining Postpartum Sindrom Dengan *Edinburgh Postpartum Depression Scale* (EPDS)

EPDS merupakan adalah salah satu instrumen skrining yang paling banyak digunakan untuk menilai gejala depresi dan kecemasan pada masa postpartum. EPDS menilai pengalaman emosional di masa lalu tujuh hari menggunakan sepuluh item skala Likert. Instrumen skrining diri ini awalnya dikembangkan di Inggris (UK) oleh Cox, Holden dan Sagovsky pada tahun 1987. Penggunaannya kini telah meluas jauh di luar Negara Inggris. Instrumen ini mencerminkan studi validasi asli dari Inggris, di mana sembilan dari sepuluh wanita yang didiagnosis oleh psikiater sebagai depresi setelah melahirkan adalah diidentifikasi dengan benar dalam perbandingan buta dengan skor sesuai EPDS. Sifat psikometrik dari EPDS adalah:

sensitivitas 86% spesifisitas 78% dan 73% nilai prediksi positif (Shrestha et al., 2016).

EPDS merupakan kuisioner yang terdiri atas 10 pernyataan dengan 4 pilihan jawaban dari masing-masing pernyataan untuk menyaring depresi postpartum di masyarakat. Setiap jawaban memiliki score yang dipilih oleh ibu nifas sesuai dengan perasaan yang dirasakan saat pemeriksaan dan 7 hari terakhir. Uji validasi telah dilakukan pada 84 ibu dengan menggunakan kriteria diagnostik penelitian untuk penyakit depresi diperoleh dari wawancara Psikiatri Standar Goldberg. Ditemukan bahwa EPDS memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang baik, dan juga sensitif terhadap perubahan tingkat keparahan depresi dari waktu ke waktu. Skala dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 5 menit dan sederhana (Cox et al., 1987). Adaptasi lintas budaya dan menilai reliabilitas dan validitas EPDS versi Indonesia dilakukan Hutaaruk tahun 2011. Validitas konstruk dinilai pada 359 sampel probabilitas ibu di Jakarta, dan reliabilitas dianalisis dengan uji reliabilitas tunggal. EPDS menunjukkan validitas konstruk yang memuaskan dalam kaitannya dengan HSCL-25 (Hopkins Symptom Checklist-25) dengan koefisien korelasi 0,51 ($p < 0,01$). Reliabilitas uji tunggal dapat diterima (Koefisien = 0,652). Hal ini menunjukkan bahwa EPDS merupakan instrumen yang valid dan reliabel untuk digunakan sebagai instrumen skrining depresi pascapersalinan di Indonesia (Hutaaruk, 2011).

EPDS akan berguna dalam pekerjaan rutin petugas kesehatan komunitas dan membantu mengidentifikasi depresi pascapersalinan pada ibu yang dianggap oleh petugas kesehatan mereka berisiko. EPDS ini mungkin juga berguna dalam studi pengobatan depresi postpartum ketika dilakukan pada ibu yang tinggal di masyarakat. Ibu yang mendapat skor di atas 13 kemungkinan besar menderita atau berisiko mengalami depresi dengan berbagai tingkat keparahan. Score EPDS tidak boleh mengesampingkan penilaian klinis. Dibutuhkan suatu penilaian klinis untuk memastikan diagnosis. Hasil penilaian EPDS menunjukkan bagaimana perasaan ibu selama minggu sebelumnya. Jika ditemukan kasus yang meragukan, maka penilaian EPDS dapat diulangi setelah 14 hari. Alat ini tidak mampu mendeteksi ibu dengan neurosis kecemasan, fobia, atau gangguan kepribadian lainnya (Kleiman, 2021). (Cox et al., 1987).

1. Keuntungan EPDS

- a. Berguna dalam pekerjaan rutin petugas kesehatan dan membantu mengidentifikasi depresi pascapersalinan pada ibu yang dianggap oleh petugas kesehatan mereka berisiko
- b. Mudah digunakan dan sederhana
- c. Membutuhkan waktu 5-10 menit untuk menjawab EPDS
- d. Mendeteksi dini adanya depresi postpartum
- e. Dapat diterima oleh pasien

- f. Tidak memerlukan biaya
2. Kekurangan EPDS:
- a. Tidak bisa mendiagnosis depresi pasca persalinan karena membutuhkan penilaian klinis
 - b. Tidak bisa mengetahui penyebab dari depresi pasca persalinan
3. Cara penilaian EPDS
- a. Pernyataan nomor 1, 2, dan 4 (tanpa*) diberikan skor 0, 1, 2, atau 3 dengan kotak paling atas mendapatkan nilai 0 dan kotak paling bawah mendapatkannilai 3
 - b. Pernyataan nomor 3,5 sampai dengan 10 (tanpa tanda *) dinilai terbalik, dengan kotak paling atas mendapatkan nilai 3 dan kotak paling bawah mendapatkan nilai 0
 - c. Item pernyataan nomor 10 menunjukkan keinginan bunuh diri.
 - d. Nilai 30 adalah skor tertinggi
 - e. Kemungkinan mengalami depresi apabila mendapatkan skor 10 atau lebih
 - f. Semakin tinggi skor maka semakin berat gangguan/risiko depresi yang dialami ibu nifas
(Cox, J.L., Holden, J.M., and Sagovsky, 2018; Gondo HK, 2017; Kleiman, 2021).
4. Cara pengisian EPDS (Cox et al., 1987; Kleiman, 2021).
- a. Para ibu diminta untuk memberikan respons yang paling mendekati apa yang dia rasakan dalam 7 hari terakhir.
 - b. Ibu nifas harus menjawab semua pernyataan.
 - c. Harus berhati-hati untuk menghindari kemungkinan ibu mendiskusikan jawabannya dengan orang lain
 - d. Ibu harus menyelesaikan kuis ini sendiri, kecuali jika ibu ada kesulitan dalam memahami bahasa atau tidak bisa membaca.

Edinburgh Postnatal Depression Scale¹ (EPDS)

Name: _____ Address: _____
Your Date of Birth: _____
Baby's Date of Birth: _____ Phone: _____

As you are pregnant or have recently had a baby, we would like to know how you are feeling. Please check the answer that comes closest to how you have felt **IN THE PAST 7 DAYS**, not just how you feel today.

Here is an example, already completed.

I have felt happy:

- ☐ Yes, all the time
☒ Yes, most of the time This would mean: "I have felt happy most of the time" during the past week.
☐ No, not very often Please complete the other questions in the same way.
☐ No, not at all

In the past 7 days:

- | | |
|---|---|
| <p>1. I have been able to laugh and see the funny side of things</p> <p>☐ As much as I always could
☐ Not quite so much now
☐ Definitely not so much now
☐ Not at all</p> <p>2. I have looked forward with enjoyment to things</p> <p>☐ As much as I ever did
☐ Rather less than I used to
☐ Definitely less than I used to
☐ Hardly at all</p> <p>*3. I have blamed myself unnecessarily when things went wrong</p> <p>☐ Yes, most of the time
☐ Yes, some of the time
☐ Not very often
☐ No, never</p> <p>4. I have been anxious or worried for no good reason</p> <p>☐ No, not at all
☐ Hardly ever
☐ Yes, sometimes
☐ Yes, very often</p> <p>*5. I have felt scared or panicky for no very good reason</p> <p>☐ Yes, quite a lot
☐ Yes, sometimes
☐ No, not much
☐ No, not at all</p> | <p>*6. Things have been getting on top of me</p> <p>☐ Yes, most of the time I haven't been able to cope at all
☐ Yes, sometimes I haven't been coping as well as usual
☐ No, most of the time I have coped quite well
☐ No, I have been coping as well as ever</p> <p>*7. I have been so unhappy that I have had difficulty sleeping</p> <p>☐ Yes, most of the time
☐ Yes, sometimes
☐ Not very often
☐ No, not at all</p> <p>*8. I have felt sad or miserable</p> <p>☐ Yes, most of the time
☐ Yes, quite often
☐ Not very often
☐ No, not at all</p> <p>*9. I have been so unhappy that I have been crying</p> <p>☐ Yes, most of the time
☐ Yes, quite often
☐ Only occasionally
☐ No, never</p> <p>*10. The thought of harming myself has occurred to me</p> <p>☐ Yes, quite often
☐ Sometimes
☐ Hardly ever
☐ Never</p> |
|---|---|

Administered/Reviewed by _____ Date _____

¹Source: Cox, J.L., Holden, J.M., and Sagovsky, R. 1987. Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. *British Journal of Psychiatry* 150:782-786.

²Source: K. L. Wisner, B. L. Parry, C. M. Piontek, Postpartum Depression *N Engl J Med* vol. 347, No 3, July 18, 2002, 194-199

Users may reproduce the scale without further permission providing they respect copyright by quoting the names of the authors, the title and the source of the paper in all reproduced copies.

Gambar 3.1. Form EPDS (Kleiman, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Cox, J.L., Holden, J.M., and Sagovsky, R. . (2018). Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. *Cambridge University Press*.
- Cox, J. L., Holden, J. M., & Sagovsky, R. (1987). Detection of Postnatal Depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression scale. *British Journal of Psychiatry*, 150(JUNE), 782–786. <https://doi.org/10.1192/bjp.150.6.782>
- Gondo HK. (2017). Skrining Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) Pada Postpartum Blues. *Bagian Obstetri & Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*.
- Hutauruk, I. (2011). Indonesian Version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale: Cross-Cultural Adaptation and Validation. *Jurnal Ilmiah Psikologi Gunadarma*, 5(2), 98480.
- Kleiman, K. (2021). F. Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). *Therapy and the Postpartum Woman*, 347(3), 302–303. <https://doi.org/10.4324/9780203893913-55>
- Lestari, Y. I. (2019). *Hubungan Antara Faktor Psikososial, Dukungan Suami dan Keluarga dengan Kejadian Postpartum Blues*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Purwati, P., & Noviyana, A. (2020). Faktor- Faktor yang Menyebabkan Kejadian Postpartum Blues. *Infokes: Jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan*, 10(2), 1–4. <https://doi.org/10.47701/infokes.v10i2.1021>
- Saraswati, D. E. (2018). Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Postpartum Blues. *Journal of Health Sciences*, 11(2), 130–139. <https://doi.org/10.1190/segam2013-0137.1>
- Sebastian, L. (2016). *Overcoming Postpastum Depression & Anxiety* (Third). Addicus Books.
- Shrestha, S. D., Pradhan, R., Tran, T. D., Gualano, R. C., & Fisher, J. R. W. (2016). Reliability and validity of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) for detecting perinatal common mental disorders (PCMDs) among women in low-and lower-middle-income countries: A systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 16(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-016-0859-2>
- Tilana, D. D. (2021). *Hubungan Dukungan Suami, Dukungan Keluarga dan Penyesuaian Diri terhadap Peran Baru sebagai Ibu dengan Kejadian Postpartum Blues di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas*. Universitas ANdalas Padang.
- Verawati, D. I., Rizky, D. S., & Wiyadi. (2020). Faktor yang berhubungan dengan kejadian postpartum blues di wilayah puskesmas remaja tahun 2020. *Jurnal Kesehatan*, 8, 99–100.

Widjaja, I. P. (2014). *SARI PUSTAKA POSTPARTUM BLUES*.

Wulansari, P. S., Istiaji, E., & Ririanty, M. (2017). Hubungan antara Pengetahuan Ibu Tentang Baby Blues, Proses Persalinan dan Paritas dengan Baby Blues di RSIA Srikandi IBI Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 13(1), 40–52. <https://doi.org/10.3176/chem.geol.1974.4.04>

Yunitasari, E., & Suryani, S. (2020). Post partum blues; Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(2), 303–307. <https://doi.org/10.30604/well.022.82000120>

BAB 4

PROSES LAKTASI DAN MENYUSUI

Fatmawati, SST., M.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. Deskripsi

Dalam topik ini akan dibahas tentang proses laktasi menyusui dimana ada beberapa materi yang akan diberikan yaitu Definisi laktasi, Fisiologi Payudara, Proses Laktogenesis, Perawatan Payudara dan Masalah Menyusui pada masa laktasi selama masa nifas dan menyusui.

B. Tujuan

Setelah mempelajari topik ini diharapkan dapat :

1. Memahami Definisi laktasi dengan benar dan tepat.
2. Memahami Fisiologi Payudara dengan benar dan tepat.
3. Memahami Proses Laktogenesis dengan benar dan tepat.
4. Melakukan Perawatan Payudara dengan benar dan tepat.
5. Memahami Masalah Menyusui pada masa laktasi dengan benar dan tepat.

C. Materi**1. Laktasi dan Menyusui****a. Definisi Laktasi**

Laktasi dapat diartikan dengan pembentukan dan pengeluaran air susu ibu (ASI), yang merupakan makanan pokok terbaik bagi bayi yang bersifat alamiah. Bagi setiap ibu yang melahirkan akan tersedia makanan bagi bayinya, dan bagi si anak akan merasa puas dalam pelukan ibunya, merasa aman, tenteram, hangat akan kasih sayang ibunya. Hal ini merupakan faktor yang penting bagi perkembangan anak selanjutnya (Edmonds, 2018).

Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI di produksi sampai proses bayi mengisap dan menelan ASI. Laktasi merupakan bagian integral dari siklus reproduksi mamalia termasuk manusia. Masa laktasi mempunyai tujuan meningkatkan pemberian ASI sampai anak umur 2 tahun secara baik dan benar serta anak mendapatkan kekebalan tubuh secara alami. Proses ini timbul setelah ari-ari atau plasenta lepas. Plasenta mengandung hormon menghambat prolaktin (hormon plasenta) yang menghambat pembentukan ASI. Setelah plasenta lepas, hormon plasenta tersebut tak ada lagi sehingga akan merangsang pengeluaran ASI. Idealnya, ASI keluar 2-3 hari setelah melahirkan. Namun, sebelumnya di payudara sudah terbentuk

kolestrum yang bagus sekali untuk bayi, karena mengandung zat kaya gizi dan antibodi pembunuh kuman. Ketika bayi mengisap payudara, hormon yang bernama oksitosin membuat ASI mengalir dari dalam alveoli, melalui saluran susu (duktus/ *milk canals*) menuju reservoir kantong susu yang berlokasi dibelakang areola, lalu kedalam mulut bayi (Meshram *et al.*, 2012).

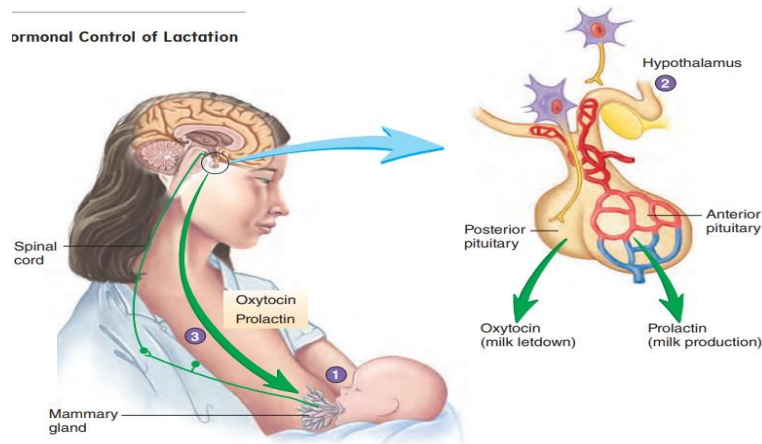
Produksi ASI juga sangat dipengaruhi oleh faktor kejiwaan. Ibu yang selalu dalam keadaan tertekan, sedih, kurang percaya diri dan berbagai ketegangan emosional akan menurunkan volume ASI bahkan tidak terjadi produksi ASI. Ibu yang sedang menyusui juga jangan terlalu banyak dibebani urusan pekerjaan rumah tangga, urusan kantor dan lainnya karena hal ini juga dapat mempengaruhi produksi ASI. Untuk memproduksi ASI yang baik harus dalam keadaan tenang (Sulaeman *et al.*, 2016).

b. Fisiologi Payudara

Laktasi/menyusui mempunyai 2 pengertian yaitu produksi dan pengeluaran ASI. Pengeluaran ASI merupakan suatu interaksi yang sangat kompleks antara rangsangan mekanik, saraf dan bermacam-macam hormon (Edmonds, 2018).

Pengaruh hormonal dimulai dari bulan ketiga kehamilan, tubuh wanita memproduksi hormon yang menstimulasi munculnya ASI dalam sistem payudara (Edmonds, 2018):

- Progesteron: memengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Tingkat progesteron dan estrogen menurun sesaat setelah melahirkan. Hal ini menstimulasi produksi prolaktin secara besar-besaran.
- Estrogen: menstimulasi sistem saluran ASI untuk membesar. Tingkat estrogen menurun saat melahirkan dan tetap rendah atau beberapa bulan selama menyusui.
- Prolaktin: berperan dalam membesarnya alveoli dalam kehamilan
- Oksitosin: mengencangkan otot halus dalam rahim pada saat melahirkan dan setelahnya, seperti halnya juga dalam orgasme. Setelah melahirkan, oksitosin juga mengencangkan otot halus disekitar alveoli untuk memeras ASI menuju saluran susu. Oksitosin berperan dalam proses turunnya (*let down reflex*).



Gambar 4.1 Proses Fisiologi Menyusui
Sumber: Lactation (brainkart.com)

Ada 2 refleks yang berperan sebagai pembentukan dan pengeluaran air susu yaitu (Rahayu dan Debby, 2020):

1) Refleks prolaktin

Menjelang akhir kehamilan terutama hormon prolaktin memegang peranan untuk membuat kolostrum, namun jumlah kolostrum terbatas karena aktivitas prolaktin dihambat oleh estrogen dan progesteron yang kadarnya memang tinggi. Setelah partus, lepasnya plasenta dan kurang berfungsinya korpus luteum menyebabkan estrogen dan progesterone sangat berkurang, ditambah lagi dengan adanya isapan bayi yang merangsang puting susu akan merangsang ujung-ujung saraf sensoris yang berfungsi sebagai reseptor mekanik. Rangsangan ini dilanjutkan ke hipotalamus melalui medulla spinalis dan mesensephalon.

Hipotalamus akan menekan pengeluaran faktor-faktor yang menghambat sekresi prolaktin dan sebaliknya merangsang pengeluaran faktor-faktor yang memacu sekresi prolaktin. Hormon ini merangsang sel-sel alveoli yang berfungsi untuk membuat air susu. Kadar prolaktin pada ibu yang menyusui akan menjadi normal 3 bulan setelah melahirkan sampai penyapihan anak dan pada saat tersebut tidak akan ada peningkatan prolaktin walaupun ada isapan bayi.

Pada ibu yang menyusui, prolaktin akan meningkat dalam keadaan-keadaan seperti:

- Anastesi
- Operasi
- Rangsangan puting susu
- Hubungan seksual

- Obat-obatan tranquliser hipotalamus seperti reserpin, klorpromasin, fenoteasi

Sedangkan keadaan-keadaan yang menghambat pengeluaran prolaktin adalah status dan nutrisi ibu kurang, stress atau depresi dan penggunaan obat-obatan.

2) *Let down reflex*

Bersamaan dengan pembentukan prolaktin oleh adenohipofise, rangsangan yang berasal dari isapan bayi ada yang dilanjutkan ke neuron hipofisis (hipofisis posterior) yang kemudian dikeluarkan oksitosin melalui aliran darah, hormon ini diangkut menuju uterus yang dapat menimbulkan kontraksi pada uterus sehingga terjadi involusio dari organ tersebut. Oksitosin yang sampai pada alveoli akan mempengaruhi sel mioepitelium. Kontraksi dari sel akan memeras air susu yang telah terbuat keluar dari alveoli masuk ke system duktulus yang untuk selanjutnya mengalir melalui duktus laktiferus masuk kemulut bayi.

Faktor-faktor yang meningkatkan *reflex let down* adalah:

- Melihat bayi
- Mendengarkan suara bayi
- Mencium bayi
- Memikirkan untuk menyusui bayi

Faktor-faktor yang menghambat *reflex let down* adalah keadaan bingung/pikiran kacau, takut, cemas. Bila ada stress dari ibu yang menyusui akan terjadi suatu *blockade* dari *reflex let down*. Ini disebabkan oleh karena adanya pelepasan dari adrenalin yang menyebabkan vasokonstriksi dari pembuluh darah alveoli, sehingga kadar oksitosin sedikit dan tidak bisa merangsang mioepitel pada ductus alveolus (Edmonds, 2018).

Akibat dari tidak sempurnanya *reflex let down* maka akan terjadi penumpukan air susu didalam alveoli yang secara klinis tampak payudara membesar. Payudara yang besar dapat berakibat abses, gagal untuk menyusui dan rasa sakit. Rasa sakit ini akan merupakan stress bagi ibunya. Bayi yang haus dan tidak puas ini akan berusaha untuk dapat air susu yang cukup dengan cara menambah kuat isapannya sehingga tidak jarang dapat menimbulkan luka-luka pada puting susu dan yang akan menyebabkan rasa sakit pada ibu. Dengan demikian akan menyebabkan kegagalan menyusui pada ibu (Edmonds, 2018).

c. Proses Laktogenesis

1) Laktogenesis I

Dimulai ketika memasuki trisemester 3 kehamilan (kira-kira 12 minggu sebelum kelahiran). Laktogenesis I ditandai dengan sekresi kolostrum dari kelenjar mammae. Secara anatomi dapat dilihat ukuran payudara bertambah yang salah satunya disebabkan karena alveoli mulai dipenuhi kolostrum. Namun, tingginya kadar hormon progesteron di dalam darah ibu menghambat produksi ASI hingga kelahiran (Bartell, 2020).

2) Laktogenesis II

Dimulai setelah plasenta dilahirkan (plasenta dilahirkan setelah bayi lahir). Kejadian terlepasnya plasenta secara langsung menyebabkan kadar progesteron, estrogen dan HPL turun dengan drastis, sementara kadar hormon prolaktin tetap tinggi. Prolaktin merupakan hormon utama di dalam laktasi (produksi ASI). Laktogenesis II ditandai dengan produksi ASI yang jumlahnya meningkat secara pasti, begitu juga dengan komposisi kolostrum yang secara bertahap berubah menjadi ASI mature (matang). Jumlah sodium, klorida dan protein akan berkurang secara bertahap sedangkan laktosa dan kandungan ASI matur lainnya mulai meningkat. Warna kolostrum yang kekuningan sedikit demi sedikit akan mulai berubah menjadi putih susu. Pada fase ini, dalam 2-3 hari (30-40 jam) setelah melahirkan, ibu akan mulai merasakan payudara yang terasa penuh karena ASI (Bartell, 2020).

Laktogenesis I dan II dikontrol sepenuhnya oleh hormon. Peristiwa ini disebut sebagai **neuro-endocrine** (*hormonally driven*). Jadi, proses laktogenesis I dan II akan tetap terjadi meskipun sang ibu tidak menyusui bayinya. Artinya, secara natural payudara akan memproduksi ASI meskipun belum ada permintaan dari bayi. Meskipun demikian, para pakar tetap menyarankan untuk mempersering menyusui di minggu awal kelahiran bayi karena disinyalir frekuensi menyusui yang sering di awal akan meningkatkan jumlah reseptor prolaktin di payudara. Reseptor prolaktin bertindak untuk mengenali hormon prolaktin, sehingga semakin banyak jumlah reseptor makan payudara akan semakin sensitif terhadap prolaktin (Bartell, 2020).

3) Laktogenesis III

Laktogenesis III atau disebut juga galaktopoiesis merupakan autocrine (kontrol lokal). Sistem hormon endokrin mengatur produksi ASI selama kehamilan dan beberapa hari

pertama setelah melahirkan. Ketika produksi ASI mulai stabil, sistem autokrin dimulai. Artinya, produksi ASI mulai menyesuaikan dengan kebutuhan bayi yang istilahnya dikenal dengan “*supply and demand*” (produksi sesuai dengan permintaan). Dalam hal ini, semakin sering ibu menyusui (memerah) maka produksi akan semakin cepat dan banyak. Payudara akan terus menerus memproduksi ASI selama ASI terus dikeluarkan. Namun, meskipun kontrol produksi ASI menjadi *autocrine*, hormon tetap berpengaruh hanya saja dalam porsi yang kecil. Pada fase ini, ASI yang diproduksi adalah ASI mature (matang) (Bartell, 2020).

d. Perawatan Payudara

Perawatan payudara adalah suatu metode untuk meningkatkan produksi ASI dan salah satu cara untuk melancarkan dalam proses menyusui dengan melakukan perawatan payudara secara teratur (Fatmawati *et al.*, 2019). Perawatan payudara yang dilakukan sebanyak 2 kali sehari sebelum mandi pada pagi dan sore hari selama 30 menit akan membantu kelancaran pengeluaran ASI (Yuliani, 2014). Perawatan payudara bertujuan untuk melancarkan sirkulasi darah dan mencegah tersumbatnya saluran produksi ASI sehingga dapat melancarkan pengeluaran ASI, memelihara kebersihan dan mengatasi puting susu datar yang terbenam (Asih, 2016). Gerakan pada perawatan payudara bermanfaat melancarkan refleks dan efektif meningkatkan volume ASI (Fatmawati *et al.*, 2019).

1) Manfaat Perawatan Payudara

Perawatan payudara merupakan metode non farmakologis yang memiliki banyak manfaat, antara lain (Ambarwati *et al.*, 2015):

- Meningkatkan pengeluaran ASI pada ibu nifas dan menyusui
- Mencegah dan meminimalisir terjadinya bendungan ASI dan mastitis
- Mencegah terjadinya puting lecet saat menyusui
- Menjaga kebersihan payudara terutama puting susu
- Membantu mengeluarkan puting susu ibu yang datar
- Meningkatkan kekencangan dan mempertahankan bentuk payudara
- Meningkatkan sirkulasi peredaran darah sekitar payudara
- Mempercepat pengosongan ASI pada payudara

2) Cara Perawatan Payudara (Yuliani, 2014)

- Perawatan payudara diawali dengan pengompres dan membersihkan payudara menggunakan air hangat.
- Tempelkan kapas yang sudah diberi minyak atau *baby oil* selama 5 menit, kemudian bersihkan puting susu.
- Apabila puting susu datar dilakukan pengurutan dengan teknik hoffman 5 sampai 10 kali pada puting susu agar puting menonjol dan melenturkan puting susu serta menjaga kebersihan sehingga memudahkan bayi untuk menghisap.
- Letakkan kedua tangan di antara payudara.
- Mengurut payudara dimulai dari arah atas, ke samping lalu ke bawah.
- Melakukan pemijatan payudara yang terdiri dari 3 gerakan:
 - Gerakan pertama kedua telapak tangan diletakkan di tengah di antara kedua payudara dengan ujung jari menghadap ke bawah, telapak tangan di tarik ke atas melingkari payudara dan menyangga payudara kemudian tangan dilepaskan dengan gerak cepat serta hati-hati ke arah depan selama 20-30 kali.
 - Gerakan yang kedua telapak tangan kiri menopang payudara kiri dan jari-jari, tangan kanan saling dirapatkan, sisi kelingking tangan kanan mengurut payudara kiri dari pangkal ke arah puting
 - Gerakan ketiga telapak tangan kiri menopang payudara kiri, jari-jari tangan kanan dikepalkan kemudian tulang-tulang kepalan tangan kanan mengurut payudara dari pangkal ke arah puting (20-30 kali).
- Membersihkan payudara dengan air hangat lalu air dingin, kemudian keringkan payudara dengan handuk bersih, dan gunakan bra yang bersih dan menyokong.

3) Teknik Menyusui

- Posisi menyusui yang umum dilakukan adalah posisi duduk, berdiri dan berbaring. Berikut merupakan posisi menyusui yang dapat dilakukan (Nurliana, 2014):
 - **Posisi Cradle**, merupakan posisi paling umum, dengan posisi ibu yang duduk tegak. Leher dan bahu

bayi disangga oleh lengan bawah ibu atau menekuk pada siku. Posisi ini perlu memerhatikan pergerakan kepala bayi pastikan kepala bayi dapat bergerak dan tidak terjepit.

- **Posisi Cross Cradle**, memiliki prinsip yang sama dengan posisi cradle. Hanya tangan yang digunakan untuk menyangga dibagian atas adalah lengan yang berseberangan.
- **Posisi Underarm/Football**, merupakan posisi yang cocok digunakan oleh ibu post SC. Posisi ini dilakukan dengan ibu menggendong bayi di samping, menyelipkan tubuh bayi ke bawah (mengapit bayi) dengan kaki bayi mengarah ke punggung ibu.
- **Posisi Lying Down**, direkomendasikan bagi ibu yang mengalami nyeri perineum, sehingga posisi ibu dapat miring. Posisi bayi menghadap payudara, tubuh ibu dan bayi sejajar dengan hidung yang menghadap ke putting.



Gambar 4.2 Posisi Menyusui

Sumber: eduglogster.com

- Cara menyusui yang benar (Buku KIA, 2020)
- Menyusui sesering mungkin/semua bayi (8-12 kali sehari atau lebih)
 - Bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui
 - Susui bayi sampai payudara terasa kosong, lalu pindahkan ke payudara sisi yang lain

- Apabila bayi sudah kenyang, tetapi payudara masih terasa penuh/kencang, maka payudara perlu diperah kemudian simpan ASI. Hal ini bertujuan untuk mencegah mastitis dan menjaga pasokan ASI.
- Posisi Menyusui (Buku KIA, 2020)
- Kepala dan badan bayi membentuk garis lurus
 - Wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting susu
 - Badan bayi dekat ke tubuh ibu
 - Ibu menggendong/mendekap badan bayi secara utuh
- Perlekatan Payudara
- Perlekatan yang tidak efektif pada payudara dapat menimbulkan luka atau puting lecet, pengeluaran ASI yang tidak efektif, resiko pembengkakan pada payudara hingga peradangan dan abses (Pollard, 2015). Sehingga diperlukan penerapan prinsip perlekatan yang baik seperti:
- Mulut bayi terbuka lebar dengan lidah di dasar mulut. Memasukkan payudara ke mulut bayi
 - Dagu bayi melekkukkan payudara ke dalam
 - Pipi bayi penuh
 - Terdengar suara menelan
 - Terlihat pengeluaran susu pada sudut mulut bayi
 - Areola terlihat lebih banyak di mulut bayi bagian atas dari pada bagian bawah (Buku KIA, 2020).



Gambar 4.3 Perlekatan Payudara saat Menyusui

Sumber: gizi.fk.ub.ac.id

- 4) Tanda Kecukupan ASI
- Bayi buang air kecil minimal 6x sehari
 - Warna urine umumnya kuning pucat
 - Bayi BAK berwarna kuning
 - Bayi terlihat puas, sewaktu-waktu merasa lapar dan bangun dengan tidur yang cukup

- Bayi menyusui 10x dalam 24 jam
- Payudara terasa lembut setiap kali habis menyusui (Nurliana, 2014)

e. Masalah Menyusui

1) Putting Susu Datar / Terbenam

Perlu dilakukan perawatan payudara dengan mencoba mengeluarkan ASI menggunakan tangan dan melakukan stimulasi untuk mengeluarkan putting yang terbenam. Stimulasi dapat dilakukan dengan pompa ASI / spuit 20cc untuk mengeluarkan putting susu yang terbenam (Nurliana, 2014).

2) Putting Susu Lecet

Pada keadaan putting susu lecet, seringkali diindikasikan untuk menghentikan menyusui karena putting terasa sakit. Adapun tatalaksana yang dilakukan bila putting susu lecet ialah:

- Memastikan perlakatan bayi saat menyusui
- Memastikan apakah bayi terkena oral thrush
- Menganjurkan ibu untuk terus menyusui jika keadaan luka tidak terlalu nyeri
- Mengoleskan ASI (hindmilk) pada area putting yang terluka
- Putting susu yang lecet dapat diistirahatkan sementara 1x24 jam, dengan pengeluaran ASI menggunakan tangan / pompa (Wahyuni, 2018)

3) Payudara Bengkak

Payudara bengkak memiliki manifestasi klinis berupa payudara terlihat bengkak, terasa nyeri, putting menonjol dan kencang, disertai kulit payudara mengkilap, dan apabila diperiksa tidak terdapat pengeluaran ASI. Hal ini terjadi akibat adanya peningkatan produksi ASI, namun tidak terdapat pengeluaran ASI yang memadai, perlekatan saat menyusui yang kurang baik, serta adanya keterlambatan waktu untuk menyusui. Untuk mencegah terjadinya bengkak payudara disarankan untuk:

- Menyusui dengan waktu yang teratur
- Memastikan perlekatan bayi sudah baik
- Meningkatkan durasi dan frekuensi menyusui (Wahyuni, 2018)

4) Mastitis

Mastitis adalah peradangan pada payudara dengan manifestasi payudara memerah, bengkak, dengan teraba masa padat (*luump*) didalam payudara, terkadang diikuti rasa nyeri dan panas disertai

peningkatan suhu tubuh ibu. Mastitis disebabkan oleh kurangnya pengeluaran ASI atau pengisapana ASI oleh bayi yang tidak efektif (Wahyuni, 2018). Beberapa tindakan yang dapat dilakukan sebagai tatalaksana mastitis ialah:

- Kompres hangat
- Pemberian pijat Oksitosin / stimulasi untuk memperlancar pengeluaran ASI
- Pemberian antibiotik dan pereda nyeri yang kolaborasi dengan dokter

D. Kesimpulan

Proses laktasi dan menyusui ini periode yng sangat penting, dimana dalam proses ini sudah dipersiapkan selama proses kehamilan mauun persalinan dimana ada beberpa hal yang dapat mengatasi masalah Selma proses menyusui sehingga dapat memberikan asuhan yang komprehensif kepada ibu dan lebih kompeten dalam pelaksanaan asuhan selama proses laktasi dan menyusui.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Eny Retna dan Wulandari, Diah. 2015. Asuhan Kebidanan Nifas. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Bartell, G.S., 2020. Lactogenesis II Onset Following Prolonged Delay in a Mother With a Nonfunctioning Macroadenoma Treated With Cabergoline: A Case Study in Persistence. *Clinical Lactation*.
- Buku Kesehatan Ibu dan Anak. 2020. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Edmonds, D.K., 2018. Puerperium and Lactation. *Dewhurst's textbook of Obstetrics and Gynaecology 9th ed. Wiley BlackWell*, pp.433-444.
- Fatmawati, L., Syaiful, Y. and Wulansari, N.A., 2019. PENGARUH PERAWATAN PAYUDARA TERHADAP PENGELUARAN ASI IBU POST PARTUM. *Journals of Ners Community*, 10(2), pp.169-184.
- Fatmawati, R. and Hidayah, N., 2019. Gambaran Pola Tidur Ibu Nifas. *Infokes: Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan*, 9(2), pp.44-47.
- Meshram, I.I., Laxmaiah, A., Venkaiah, K. and Brahman, G.N.V., 2012. Impact of feeding and breastfeeding practices on the nutritional status of infants in a district of Andhra Pradesh, India. *National Medical Journal of India*, 25(4), p.201.
- Nurliana, K., 2014. Asuhan Kebidanan Masa Nifas. *Malang. Salaksa Media*.
- Rahayu, S. and Debby Aniestia Milasari, N., 2020. EFFECT OF THE COMBINATION OF WOOLWICH AND EFFLURAGE MASSAGE ON BREAST MILK PRODUCTION AMONG NORMAL POSTPARTUM WOMEN. *Journal of Critical Reviews*, 7(4), pp.584-588.
- Sulaeman, E.S., Yunita, F.A., Yuneta, A.E.N., Ada, Y.R., Wijayanti, R., Setyawan, H., Rinawati, S. and Utari, C., 2016. The effect of oxytocin massage on the postpartum mother on breastmilk production in Surakarta Indonesia.
- Wahyuni, E.D., 2018. Asuhan kebidanan nifas dan menyusui. *Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan*.
- Yuliani, A., 2014. Pengaruh Perawatan Payudara Terhadap Pengeluaran Air Susu Ibu (Asi) Pada Ibu Postpartum Di Rumah Bersalin Wargi Lestari Kelurahan Utama.

BAB 5

KONSEP DASAR MASA NIFAS

Psiari Kusuma Wardani, S.ST, M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. Pengertian Masa Nifas

Masa nifas (*puerperium*) adalah masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali seperti semula sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 minggu atau ± 40 hari. Jadi puerperium adalah masa setelah melahirkan bayi dan biasa disebut juga dengan masa pulih kembali, dengan maksud keadaan pulihnya alat reproduksi seperti sebelum hamil. Dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, asuhan masa nifas adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan bidan pada masa nifas sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan.

Secara garis besar terdapat tiga proses penting dimasa nifas yang dapat dibandingkan dengan keadaan pada masa hamil ataupun sebelum hamil melalui tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Proses Penting di Masa Nifas

Proses	Sebelum/ Saat Hamil	Pasca Melahirkan / Masa Nifas
Involusi	Rahim adalah organ tubuh yang spesifik dan unik karena dapat mengecil serta membesar dengan menambah atau mengurangi jumlah selnya. Pada wanita yang tidak hamil, berat rahim sekitar 30 gram dengan ukuran kurang lebih sebesar telur ayam. Selama kehamilan, rahim makin lama akan makin membesar	Setelah plasenta lepas, otot rahim akan berkontraksi atau mengerut (<i>involusi</i>), sehingga pembuluh darah terjepit dan perdarahan berhenti. Berikut ukuran rahim pada masa involusi: 1. Setelah bayi lahir, umumnya berat rahim menjadi sekitar 1000 gram dan dapat diraba kira-kira setinggi 2 jari dibawah <i>umbilicus</i>. 2. Satu minggu setelah lahir beratnya 500 gram. 3. Dua minggu setelah lahir beratnya 300 gram dan tidak dapat diraba lagi. 4. Setelah 6 minggu beratnya sudah sekitar 40-60 gram. Pada saat ini dianggap bahwa masa nifas sudah selesai. 5. Pada masa tiga bulan setelah masa nifas rahim akan kembali ke posisi yang normal dengan berat 30 gram.

Kekentalan Darah Kembali Normal	Selama hamil, darah ibu relative encer. Hal tersebut dikarenakan cairan darah ibu banyak, sementara sel darahnya berkurang.	Setelah melahirkan, sistem sirkulasi darah ibu akan kembali seperti semula. Darah kembali mengental, dimana kadar perbandingan sel darah dan cairan darah kembali normal. Umumnya hal ini terjadi pada hari ke 3 sampai hari ke 15 pasca persalinan.
Proses Laktasi atau Menyusui	-	Proses ini timbul setelah plasenta lepas. Plasenta mengandung hormon penghambat prolaktin (hormone plasenta) yang menghambat pembentukan ASI. Setelah plasenta lepas, hormon plasenta itu tidak dihasilkan lagi, sehingga terjadi produksi ASI. ASI keluar 2-3 hari pasca melahirkan. Namun, hal yang luar biasa adalah sebelumnya di payudara sudah terbentuk kolostrum yang sangat baik untuk bayi karena mengandung zat kaya gizi dan antibodi pembunuh kuman

B. Tujuan dan Tahapan Masa Nifas

1. Tujuan Masa Nifas

Asuhan masa nifas diperlukan dalam periode ini karena merupakan masa kritis baik bagi ibu maupun bayinya. Dengan pemantauan melekat dan asuhan pada ibu dan bayi pada masa nifas dapat mencegah beberapa kematian. Adapun tujuan dari masa nifas menurut Elisabeth (2015) yaitu:

- Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis
- Melaksanakan skrining secara komprehensif, deteksi dini, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayi
- Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB, cara dan manfaat menyusui, pemberian imunisasi, serta perawatan bayi sehari-hari
- Memberikan pelayanan keluarga berencana
- Pendidikan tentang peningkatan pengembangan hubungan yang baik antara ibu dan anak
- Mempercepat involusi alat kandungan
- Melancarkan fungsi gastrointestinal atau perkemihan
- Melancarkan pengeluaran lochea
- Meningkatkan kelancaran peredaran darah sehingga mempercepat fungsi hati dan pengeluaran sisa metabolisme.

2. Tahapan Masa Nifas

Menurut Dewi tahun 2012, tahapan masa nifas dibagi menjadi tiga tahap yaitu :

a. Puerperium dini

Suatu masa kepulihan dimana ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan. Ibu yang melahirkan pervaginam tanpa komplikasi dalam 6 jam pertama setelah kala IV dianjurkan untuk mobilisasi segera

b. Puerperium intermedial

Suatu masa kepulihan menyeluruh dari organ-organ reproduksi selama kurang lebih enam sampai delapan minggu.

c. Remote puerperium

Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan sempurna terutama ibu apabila ibu selama hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasi. Rentang waktu remote puerperium berbeda untuk setiap ibu, tergantung dari berat ringannya komplikasi yang dialami selama hamil atau persalinan.

Adapun tahapan masa nifas menurut Reva Rubin yaitu :

a. Periode taking in (1-2 hari setelah melahirkan)

- Ibu masih pasif dan tergantung dengan orang lain
- Perhatian ibu tertuju pada kekhawatiran perubahan tubuhnya
- Ibu akan mengulangi pengalaman-pengalaman waktu melahirkan
- Memerlukan ketenangan dalam tidur untuk mengembalikan keadaan tubuh ke kondisi normal
- Nafsu makan ibu biasanya bertambah sehingga membutuhkan peningkatan nutrisi.
- Kurangnya nafsu makan menandakan proses pengembalian kondisi tubuh tidak berlangsung normal

b. Periode Taking On/Taking Hold (2-4 hari setelah melahirkan)

- Ibu memperhatikan kemampuan menjadi orang tua dan meningkatkan tanggung jawab akan bayinya
- Ibu memfokuskan perhatian pada pengontrolan fungsi tubuh, BAK, BAB dan daya tahan tubuh
- Ibu berusaha untuk menguasai keterampilan merawat bayi seperti menggendong, menyusui, memandikan dan mengganti popok
- Ibu cenderung terbuka menerima nasehat bidan dan kritikan pribadi

- Kemungkinan ibu mengalami depresi postpartum karena merasa tidak mampu membesarkan bayinya
- c. Periode Letting Go (hari ke 10 akhir masa nifas)
- Terjadi setelah ibu pulang ke rumah dan dipengaruhi oleh dukungan serta perhatian keluarga
 - Ibu sudah mengambil tanggung jawab dalam merawat bayi dan memahami kebutuhan bayi sehingga akan mengurangi hak ibu dalam kebebasan dan hubungan sosial
 - Depresi postpartum sering terjadi pada masa ini.

Pengeluaran lochea menurut Sutanto tahun 2018 yaitu :

- a. Lochea rubra hari ke 1-3, berwarna merah, terdiri dari darah segar, jaringan sisa-sisa plasenta, dinding Rahim, lemak bayi, lanugo dan sisa meconium.
- b. Lochea sanguinolenta hari ke 4-7, berwarna merah kecoklatan dan berlendir, terdiri dari sisa darah bercampur lendir.
- c. Lochea serosa hari ke 7-14 hari, berwarna kuning kecoklatan, lebih sedikit darah dan lebih banyak serum, juga terdiri dari leukosit dan robekan atau laserasi plasenta.
- d. Lochea alba hari ke 14 sampai selesai masa nifas, mengandung leukosit, sel desidua dan sel epitel, selaput lendir serviks, dan serabut jaringan yang mati.

C. Peran dan Tanggung Jawab Bidan Dalam Masa Nifas

Bidan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas dan menyusui. Adapun peran dan tanggung jawab bidan pada ibu dalam masa nifas dan menyusui menurut Reni tahun 2019 :

1. Peran sebagai Pelaksana

Sebagai pelaksana bidan memiliki 3 kategori tugas yaitu :

- a. Tugas Mandiri
 - 1) Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan
 - 2) Memberi asuhan kebidanan kepada klien dalam masa nifas dengan melibatkan klien / keluarga
- b. Tugas Kolaborasi
 - 1) Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga
 - 2) Memberi asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan resiko tinggi serta pertolongan pertama dalam keadaan

keawatdaruratan yang memerlukan Tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga

c. Tugas Ketergantungan

- 1) Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga
- 2) Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas yang disertai penyulit tertentu dan kegawatdaruratan dengan melibatkan klien dan keluarga

2. Peran sebagai Pengelola

Sebagai pengelola bidan memiliki 2 tugas yaitu :

- a. Mengembangkan pelayanan dasar Kesehatan, terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat atau klien
- b. Berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program Kesehatan dan sector lain di wilayah kerjanya melalui Peningkatan kemampuan dukun bayi, kader Kesehatan, serta tenaga Kesehatan lain yang berada dibawah bimbingan dalam wilayah kerjanya.

3. Peran sebagai Pendidik

Sebagai pendidik bidan mempunyai 2 tugas yaitu :

- a. Memberikan Pendidikan dan penyuluhan Kesehatan pada klien (individu, keluarga, kelompok serta masyarakat) tentang penanggulangan masalah Kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan Kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana. Asuhan yang diberikan bidan memberikan layanan konsultasi. Walaupun sudah dipersiapkan dengan baik serta ditambah pelayanan nifas yang sesuai, masih sering timbul masalah menyusui yang perlu ditanggulangi agar laktasi dapat dipertahankan.
- b. Melatih dan membimbing kader, peserta didik kebidanan dan keperawatan, serta membina dukun di wilayah atau tempat kerjanya

4. Peran sebagai Peneliti

- a. Melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidan Kesehatan baik secara mandiri maupun kelompok.

5. Peran Bidan yang Lain

Selain peran diatas, bidan juga dapat menunjukkan peran kepada ibu nifas dengan jalan :

- a. Bidan mengadakan evaluasi terhadap segala perkembangan selama postpartum secara periodik
- b. Bidan mengevaluasi respon orang tua terhadap bayi dan persiapan perawatannya

- c. Mengevaluasi segala perubahan perilaku Wanita dan respon psikologis terhadap kemampuan melahirkan
- d. Memberikan dukungan mental kepada ibu terhadap psikologis yang sedang dihadapi ibu nifas saat ini.

D. Kebijakan Program Nasional Masa Nifas

Kebijakan program nasional pada masa nifas yaitu paling sedikit 3 kali melakukan kunjungan pada masa nifas yang dilakukan untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir untuk mencegah, mendeteksi serta menangani masalah-masalah yang terjadi. Berikut adalah jadwal pelaksanaan Kunjungan Neonatus (KN) dan Kunjungan Nifas (KF)

Tabel 5.2
Jadwal Pelaksanaan Kunjungan Neonatus (KN) dan Kunjungan Nifas (KF)

Kunjungan Neonatus (KN)	Kunjungan Nifas (KF)
KN 1 (6-48 jam)	KF 1 (6-48 jam)
KN 2 (3 hari-7 hari)	KF 2 (4 hari-28 hari)
KN 3 (8 hari-28 hari)	KF 3 (29 hari-42 hari)

Tujuan kunjungan masa nifas secara garis besar yaitu sebagai berikut :

1. Menilai kondisi kesehatan ibu dan bayi
2. Melakukan pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan kesehatan ibu nifas dan bayi
3. Mendeteksi adanya komplikasi atau masalah yang terjadi pada masa nifas
4. Menangani komplikasi atau masalah yang timbul dan mengganggu kesehatan ibu nifas maupun bayinya

Tabel 5.3
Frekuensi Kunjungan Masa Nifas

Kunjungan	Waktu	Tujuan
1	6-8 jam setelah persalinan	a. Mencegah terjadinya perdarahan pada masa nifas b. Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan dan memberikan rujukan bila perdarahan berlanjut c. Memberikan konseling kepada ibu atau salah satu anggota keluarga mengenai bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri d. Pemberian ASI pada masa awal menjadi ibu e. Mengajarkan ibu untuk mempererat hubungan antara ibu dan bayi baru lahir f. Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi

2	6 hari setelah persalinan	a. Memastikan involusi uteri berjalan dengan normal : uterus berkontraksi, fundus dibawah <i>umbilicus</i>, tidak ada perdarahan abnormal, tidak ada bau b. Menilai adanya tanda-tanda demam infeksi atau perdarahan abnormal c. Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, minuman dan istirahat d. Memastikan ibu menyusui dengan dan memperhatikan tanda-tanda penyakit e. Memberikan konseling kepada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi sehari-hari
3	2 minggu setelah persalinan	a. Memastikan involusi uteri berjalan normal, uterus berkontraksi, fundus di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal, dan tidak ada bau b. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau kelainan pasca melahirkan c. Memastikan ibu mendapat cukup makanan, minuman dan istirahat d. Memastikan ibu menyusui dengan dan memperhatikan tanda-tanda penyakit e. Memberikan konseling kepada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari
4	6 minggu setelah persalinan	a. Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang dialami atau bayinya b. Memberikan konseling untuk KB secara dini

DAFTAR PUSTAKA

- Astutik, Reni Yuli, 2019. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui*. Jakarta : CV Trans Info Media
- Maritalia, Dewi. 2012. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Marmi. 2017. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas Puerperium Care*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sutanto, Andina Vita. 2018. *Asuhan Kebidanan Nifas & Menyusui*. Yogyakarta : Pustaka Baru
- Walyani, Elisabeth. 2015. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas & Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

BAB 6

KONSELING PADA MASA NIFAS

Tutik Iswanti, SST., M.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 6

KONSELING PADA MASA NIFAS

Tutik Iswanti, SST., M.Keb

A. Pengertian Konseling

Konseling adalah cara pendekatan dalam menyampaikan pendidikan kesehatan guna menolong individu dan membantu orang lain dalam mengambil keputusan melalui pemahaman terhadap klien seputar fakta-fakta, harapan, kebutuhan serta perasaan-perasaan klien (BKKBN, 2016) dalam (Nur Laela et al., 2022).

Konseling merupakan proses yang berjalan dan menyatu dengan semua aspek pelayanan kesehatan, dan pemberian informasi ini tidak hanya disampaikan dan diberikan pada satu kesempatan melainkan pada saat memberikan pelayanan. Bidan sebagai pemberi pelayanan harus meningkatkan kualitas pemberian konseling pada ibu nifas dan ini sangat penting dalam meningkatkan pemahaman ibu nifas (Maya Maftuha et al., 2022).

Konseling merupakan salah satu cara pemberian informasi kesehatan yang efektif dengan komunikasi Edukasi (KIE) dua arah yang dilakukan oleh seorang konselor tenaga kesehatan kepada pasien dan konselor juga dapat menerima atau mendengar keluhan atau pendapat dari pasien. Konseling saat ini juga dilakukan dengan menggunakan (memanfaatkan) berbagai jenis media untuk menyampaikan Informasi, dan salah satu yang sedang booming saat ini adalah pemanfaatan media internet (Asmirati et al., 2021).

Komunikasi informasi edukasi (KIE) adalah suatu cara pemberian informasi atau pesan terkait masalah tertentu oleh komunikator kepada komunikan melalui media tertentu. KIE dalam program Kesehatan ditunjukkan untuk mengatasi masalah kesehatan dengan meningkatkan kepedulian dan menghasilkan perubahan perilaku yang spesifik (Nadiya & Wati, 2021).

B. Pengertian Masa Nifas

Masa nifas adalah dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti semula atau pada keadaan sebelum hamil. Masa nifas dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari) (Nadiya & Wati, 2021).

Masa nifas adalah masa kritis bagi ibu dan bayinya karena banyak kematian ibu dan bayi terjadi pada masa nifas. Sesuai dengan kajian *United Nation Children's Fund* (UNICEF) menyatakan, sebagian besar kematian ibu dan bayi di Indonesia terjadi pada 2 hari pertama pasca persalinan (Pengetahuan et al., 2020).

Post Natal Care (PNC) dipromosikan oleh *World Healty Organization* (WHO) Secara khusus, dan merekomendasikan ibu dan bayi mendapatkan PNC awal dalam 24 jam pertama setelah persalinan dan minimal tiga kunjungan tambahan PNC dalam waktu 48-72 jam, dan 7-14 hari, dan 6 minggu setelah melahirkan. Pelayanan kesehatan yang diberikan untuk ibu nifas bertujuan untuk mendeteksi komplikasi pada masa nifas, penanganan dan rujukan terhadap kejadian tak diinginkan yang bisa terjadi, kesehatan secara umum, kebersihan personal, gizi yang dibutuhkan, melakukan perawatan bayi seperti perawatan tali pusat untuk mencegah terjadinya infeksi, memberikan ASI, KB dan melakukan imunisasi. Mutu pelayanan dasar yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat dilihat dari capaian SPM yang merupakan pencapaian target sebagai hasil kinerja pemerintah maka harus 100% setiap tahunnya (Suryanti et al., 2021).

C. Jenis Konseling pada Ibu Nifas

1. Konseling Perawatan mandiri post partum

Keberhasilan perawatan nifas ditentukan oleh kemampuan ibu dalam merawat dirinya terutama karena pengalaman melahirkan (paritas) dan penyampaian informasi kesehatan (media konseling) yang baik.

Perawatan yang dibutuhkan ibu selama masa nifas yaitu memantau dan mempertahankan kesehatannya dengan memberikan informasi kesehatan dan keterampilan yang tepat. Kebutuhan perawatan masa nifas antara lain pemenuhan kebutuhan nutrisi dan cairan, ambulasi, eliminasi, kebersihan diri, istirahat, seksual, senam nifas, perawatan payudara, teknik menyusui yang benar, perawatan luka dan pengawasan involusi uteri (Windarti & Dewi, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian ((Windarti & Dewi, 2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara paritas dengan perawatan mandiri. Perempuan primipara sebagian besar kurang mampu melakukan perawatan mandiri, sedangkan multiipara hampir seluruhnya memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan perawatan mandiri.

Hal itu menunjukkan bahwa pengalaman melahirkan merupakan faktor yang mendukung kemampuan seorang ibu post partum dalam melakukan perawatan masa nifas. Primipara belum berpengalaman merawat diri maupun bayinya, sehingga masih cenderung belajar dan berusaha lebih keras menyesuaikan kondisinya daripada multipara karena pada multipara telah memiliki pengalaman dan cenderung berusaha lebih baik dari pengalamannya dulu.

Ada pengaruh media konseling terhadap perawatan mandiri post partum. Media leaflet yang digunakan dalam pendidikan kesehatan sebagian besar ibu nifas kurang dalam melakukan perawatan mandiri, dengan media

konselor hampir seluruhnya ibu nifas sudah baik dalam melakukan perawatan mandiri.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan konseling langsung (adanya konselor) lebih bermakna dalam hal penyampaian informasi daripada menggunakan media leaflet. Media apapun pada dasarnya baik karena mempunyai kelebihan dan kekurangan masing – masing. Media konseling langsung akan lebih jelas dalam memahami setiap hal yang harus dilakukan selama merawat diri pada masa nifas. Jika ada materi yang kurang jelas dapat menanyakan secara langsung.

Dalam komunikasi antar manusia media yang paling dominan adalah pancaindra manusia seperti mata dan telinga. Pesan-pesan yang diterima pancaindra selanjutnya diproses dalam pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu sebelum dinyatakan dalam tindakan. Konseling memungkinkan individu mengambil keputusan berkaitan dengan hal penting bagi dirinya. Keputusan tersebut merupakan pilihan dari klien sendiri, tidak ditentukan oleh konselor. Klien belajar mengestimasi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi dalam pengorbanan pribadi, waktu, tenaga, uang, risiko, dan lain-lain.

Keberhasilan dalam penyampaian informasi sangat ditentukan oleh hubungan baik antara konselor dan klien. Konselor yang baik dalam menjalin rapport dengan klien akan lebih mampu mengantarkan konseling kepada kesuksesan. Kemampuan bidan dalam memberikan konseling pada ibu nifas sudah terbukti lebih baik.

2. Konseling Perawatan bayi

a. Tidur Bayi

Dalam sehari bayi dapat tidur sampai 20 jam, yang terpecah dalam periode-periode tidur 20 menit hingga 4 jam. Usahakan kamar bersuhu sejuk, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, dan mendapat cahaya serta ventilasi cukup. Posisi tidur yang dianjurkan adalah posisi terlentang karena dapat mencegah terjadinya sindrom kematian mendadak bayi atau *sudden infant death syndrome* (SIDS). Tempat tidur bayi sebaiknya menggunakan alas yang rata dan tidak terlalu lembut. Hindari menggunakan benda-benda yang dapat menutupi kepala bayi.

b. Cara merawat tali pusat

Setelah dipotong, tali pusat mungkin akan diolesi cairan antiseptik klorheksidin atau antiseptik lain. Setelah itu tali pusat dibiarkan terbuka dan kering dan tidak perlu dikompres dengan kasa yang mengandung cairan antiseptik. Saat ingin merawat tali pusat, cuci tangan terlebih dahulu, jangan oleskan apapun pada tali pusat, tidak perlu ditutup dengan kasa dan jangan ditutup dengan popok maupun gurita. Usahakan agar tali

pusat tidak basah, tidak terkena air seni maupun tinja bayi. Jika tali pusat kotor, segera cuci bersih dengan air yang bersih dan sabun lalu keringkan dengan kain bersih. Biarkan tali pusat terlepas sendiri. Jika terdapat tanda infeksi seperti kemerahan dan atau bengkak pada pusat ataupun kulit disekitarnya, berbau busuk dan terlihat nanah, segera kontrol ke tenaga kesehatan terdekat.

c. Memandikan bayi

Saat lahir, bayi belum perlu dimandikan. Bayi masih memiliki lapisan pelindung yang terlihat seperti lemak berwarna keputihan yang berfungsi untuk menjaga suhu bayi. Setelah 6 jam bayi dapat dilap dengan air hangat saja. Sebelum tali pusat lepas, bayi dapat dimandikan dengan kain lap atau spon. Setelah tali pusat lepas bayi dapat dimandikan dengan dimasukkan ke dalam air, hati-hati kepala terendam dalam air. Gunakan air hangat-hangat kuku, sabun dan sampo khusus bayi. Sebaiknya tidak memandikan bayi terlalu pagi maupun terlalu sore. Saat melakukan perawatan kulit bayi, prinsipnya menggunakan seminimal mungkin zat-zat yang berkontak dengan kulit, karena kulit bayi masih sangat sensitif.

d. Memilih pakaian bayi

Pilihlah pakaian dari bahan yang lembut, menyerap air dan tidak kaku. Bayi hanya perlu memakai atasan, popok atau celana, selimut dan topi jika bayi kedinginan. Tidak dianjurkan untuk membedong karena membatasi gerak bayi. Selain itu, tidak dianjurkan pula untuk terus menggunakan sarung tangan maupun kaos kaki karena terdapat indera peraba yang merupakan alat untuk belajar pada bayi. Jangan gunakan gurita karena bayi bernafas lebih banyak menggunakan otot-otot perut.

e. Pola buang air besar (BAB) dan buang air kecil bayi (BAK)

Bayi normal akan BAK dalam 24 jam pertama dan BAB paling telat dalam 48 jam pertama. Jika ini tidak terjadi, bayi perlu diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya bayi akan BAK 5-6 kali per hari dan BAB 3-4 kali per hari. Warna BAK yang baik adalah jernih tidak berwarna pekat, sedangkan warna BAB akan berubah dari warna hitam pekat, menjadi hijau dan akhirnya berwarna kekuningan pada sekitar usia 5 hari. Jika tidak terjadi perubahan warna BAB, harus dilakukan evaluasi kecukupan asupan ASI. Jika ibu menemukan darah pada kemaluan bayi perempuan saat awal-awal kelahiran, ibu tidak perlu khawatir, karena hal itu disebabkan bayi masih dipengaruhi hormon ibu. Keadaan tersebut masih dianggap normal.

f. Membersihkan popok dan kemaluan bayi

Bersihkan kemaluan dari bagian depan ke belakang dengan menggunakan kapas yang sudah dibasahi air bersih ataupun handuk basah. Jangan membersihkan popok dari bagian bawah anus ke kemaluan.

g. Mengenali isyarat lapar bayi

Bayi lapar akan menunjukkan tanda-tanda seperti memasukkan tangan ke dalam mulut, menggenggam tangan, mengeluarkan suarh seperti mengecap-ngecap. Jangan tunggu bayi menangis baru menyusunya. Berikan ASI sesuai kemauan bayi, jangan dijadwal. Normalnya bayi akan menetek selama 5-30 menit, jika diluar itu, evaluasi proses menyusui. Jika ibu terpisah dengan bayi, lakukan pemerahan ASI dan berikan ASI menggunakan sendok atau cangkir agar ketika ibu sudah bersama bayi lagi, bayi tetap dapat menetek dengan ibu.

h. Membersihkan mata, telinga dan hidung bayi

Mata dapat dibersihkan dengan kapas bersih yang dibasahi dengan air hangat, mulai dari arah hidung ke luar. Jika ditemukan tanda-tanda infeksi pada mata seperti bengkak, merah, mengeluarkan nanah segera bawa ke dokter. Kotoran telinga tidak perlu dibersihkan secara rutin dengan mengorek liang telinga karena akan keluar sendiri ketika sudah cukup besar dan lunak saat bayi menangis. Lubang hidung bayi juga tidak perlu dibersihkan secara khusus, cukup mengelapnya saat mandi.

3. Konseling Nutrisi ibu nifas

Nutrisi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan harus mendapatkan perhatian khusus, terutama pada ibu postpartum dimana masih ada luka perineum ataupun luka caesar dimana gizi diperlukan dalam proses penyembuhan luka tersebut. Hal utama yang diperhatikan dalam nutrisi bukan terkait banyaknya makanan yang dikonsumsi, akan tetapi zat gizi yang terkandung didalam makanannya (Nadiya & Wati, 2021).

Kebutuhan Gizi masa nifas akan meningkat 25%, untuk proses kesembuhan dan produksi ASI. Menu makanan seimbang yang harus dikonsumsi adalah cukup dan teratur, dan harus mengandung; 1).sumber tenaga (energi), 2). sumber pembangunan (protein), 3). Sumber dan pelindung (mineral, vitamin dan air). Ibu nifas memerlukan gizi untuk mempertahankan tubuh terhadap infeksi, mencegah konstipasi dan untuk memulai proses laktasi. Asupan kalori yang dibutuhkan per-hari 500 kalori dan dapat ditingkatkan sampai 2700 kalori. Asupan cairan per-hari ditingkatkan sampai 3000 ml dengan 12 asupan susu 1000 ml. Suplemen zat besi dapat diberikan kepada ibu nifas selama 4 minggu pertama setelah kelahiran.

4. Konseling KB

Masalah lain yang sering terjadi pada sebagian besar ibu yang akan menggunakan KB adalah kesulitan memilih jenis kontrasepsi apa yang akan digunakan. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi tentang keuntungan dan kelebihan jenis kontrasepsi. Tidak menggunakan kontrasepsi yang aman setelah melahirkan dikhawatirkan akan menyebabkan kehamilan tidak

diinginkan, jumlah anak yang banyak, jarak kehamilan yang terlalu dekat, dan menyebabkan psikis ibu terganggu hingga berisiko terjadi abortus (Maya Maftuha et al., 2022).

Indikator utama dalam kualitas pelayanan KB yaitu pemberian konseling yang berkualitas terhadap ibu sebagai calon akseptor KB yang menghasilkan *informed choice*, hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui konseling yang baik, lengkap dan dapat menggunakan media komunikasi serta pemberian informasi standar. Adapun informasi standar tersebut adalah informasi tentang kontra indikasi, risiko dan manfaat dari masing-masing alat/cara/metode kontrasepsi, informasi tentang cara menggunakan kontrasepsi dan efek samping yang mungkin timbul serta bagaimana cara mengatasi efek samping tersebut dan informasi tentang apa yang dapat klien harapkan dari pelayanan petugas KB (Nur Laela et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian (Maya Maftuha et al., 2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh konseling KB terhadap pengambilan keputusan alat kontrasepsi pada ibu nifas. Pemberian konseling dengan menggunakan lembar balik ABPK memberikan informasi dan dampak yang positif bagi ibu nifas tentang keuntungan penggunaan KB, sehingga ibu yang mendapatkan konseling yang baik dan jelas akan memilih untuk menggunakan KB dengan tujuan menjarangkan kehamilannya.

Pemberian konseling tentang KB berkaitan dengan adanya interaksi antar seseorang dengan pemberi pelayanan kesehatan khususnya bidan sebagai pemberi konseling. Kegiatan tersebut memungkinkan terjadinya proses pemindahan informasi dari bidan kepada calon akseptor KB. Dalam proses konseling, tenaga kesehatan menyalurkan informasi secara jelas tentang kontrasepsi seperti jenis, cara kerja, manfaat, kelebihan, dan kelemahan dari masing-masing alat kontrasepsi.

Komunikasi efektif dapat terjalin antar konselor dan penerima informasi, sehingga terjalin komunikasi dua arah secara bertahap dengan menyampaikan informasi sesuai dengan kebutuhan calon pengguna KB. Konseli akan merasakan nyaman dan lebih terbuka terhadap pertanyaan yang ingin disampaikan kepada konselor jika terdapat materi konseling yang kurang dipahami. Oleh karena itu, pemindahan informasi dapat berjalan baik karena terjalinnya rasa keterbukaan dan saling percaya, sehingga proses konseling dapat berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmirati, Marwidah, Mitra Asriani, & Irmawati. (2021). Counseling Leaflet Methods And Social Media To Change Knowledge Of Pregnant Women In The Third Trimester At Salassae Health Center. *Jurnal Life Birth*, 5(2), 53–60. <https://doi.org/10.37362/jlb.v5i2.597>
- Maya Maftuha, Desy Purnamasari, & Wahyu Fuji Hariani. (2022). Pengaruh Konseling Keluarga Berencana Terhadap Pengambilan Keputusan Alat Kontrasepsi Pada Ibu Nifas. *WOMB Midwifery Journal*, 1(1), 22–26. <https://doi.org/10.54832/wombmidj.v1i1.26>
- Nadiya, S., & Wati, R. (2021). Hubungan Pemberian Kie Dengan Pengetahuan Tentang Nutrisi Ibu Pada Masa Nifas Di Desa Geudong-Geudong. *Journal of Healthcare Tecnology and Medicine*, 7(2), 693–703.
- Nur Laela, Panyura, S. N., Resmawati, & Roni. (2022). Pengaruh Konseling Terhadap Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Pada Masa Nifas Di Sulawesi Selatan. *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 28–34. <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v1i1.873>
- Pengetahuan, T. P., Fazlaini, R., Rifayani, S., Akbar, I. B., & Hilmanto, D. (2020). Pengaruh Penerapan Modul Konseling Nifas Keterampilan Konseling Bidan Influence of Implementation of Nifas Counseling Modules on Knowledge , Attitudes and Skills Enhancement Midwife Counseling. *Medikes (Media Informasi Kesehatan)*, 7(1), 73–82.
- Suryanti, Y., Restianda, L., & Arzella, S. (2021). Penyuluhan Konseling Mitos Dan Fakta Masa Nifas. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 418–423. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i2.1856>
- Windarti, Y., & Dewi, U. M. (2018). Pengaruh Paritas Dan Media Konseling Masa Nifas Terhadap Kemampuan Perawatan Mandiri Ibu Post Partum Di Bpm Vivi Surabaya. *Journal of Health Sciences*, 11(1), 28–32. <https://doi.org/10.33086/jhs.v11i1.547>

BAB 7

RESPON ORANG TUA TERHADAP BAYI BARU LAHIR (BBL)

Heni Nurakilah, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

RESPON ORANG TUA TERHADAP BAYI BARU LAHIR (BBL)

Henri Nurakilah, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.

A. Respon Suami/Ayah dan Keluarga

Respon orang tua dan keluarga terhadap bayi baru lahir dapat berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal yaitu reaksi emosional dan pengalaman. Pengaruh lainnya adalah jumlah anak, keadaan ekonomi, dan lain-lain. (Azizah & Rosyidah, 2019)

Berikut beberapa respon positif dan negatif yang diberikan oleh suami dan keluarga: (Azizah & Rosyidah, 2019)

1. Respon Positif

Berikut beberapa respon positif suami/ayah dan keluarga terhadap bayi baru lahir: (Azizah & Rosyidah, 2019)

- a. Ayah dan keluarga menyambut kelahiran bayi dengan perasaan Bahagia;
- b. Ayah menjadi semangat dan rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan bayinya;
- c. Ayah dan keluarga ikut berperan serta dalam perawatan bayi;
- d. Timbulnya perasaan sayang terhadap ibu dan bayi.

2. Respon Negatif

Berikut beberapa respon negatif suami/ ayah dan keluarga terhadap bayi baru lahir: (Azizah & Rosyidah, 2019)

- a. Kelahiran bayi tidak diinginkan keluarga karena jenis kelamin yang tidak sesuai dengan harapan;
- b. Kehamilan akibat kegagalan ber-KB sehingga setelah bayi lahir tidak merasa bahagia;
- c. Ibu lebih memperhatikan bayi sehingga ayah merasa kurang diperhatikan;
- d. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi perasaan dan kekhawatiran;
- e. Kelahiran bayi yang abnormal dapat mengakibatkan perasaan minder.

3. Respon antara Ibu dan Bayi

Berikut beberapa respon antara ibu dan bayi: (Azizah & Rosyidah, 2019)

- a. *Toch* (sentuhan);
- b. *Eye to eye contac* (kontak mata);
- c. *Odor* (bau badan);
- d. *Body warm* (kehangatan tubuh);
- e. *Voice* (suara);
- f. *Entrainment* (gaya Bahasa);
- g. *Birhythmicity* (irama kehidupan).

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi respon orang tua terhadap bayi baru lahir: (Arnita, Tahlil, & Amalia, 2020)

a. Faktor Internal

Beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi respon orang tua terhadap bayi baru lahir yaitu: gen (keturunan), budaya, riwayat kehamilan sebelumnya.

b. Faktor Eksternal

Beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi respon orang tua terhadap bayi baru lahir yaitu: perhatian selama kehamilan, melahirkan dan setelah melahirkan, sikap dan perilaku pengunjung ketika setelah melahirkan.

5. Perilaku orang tua

Berikut beberapa perilaku yang mempengaruhi orang tua terhadap bayi baru lahir: (Setyowati, Krisnatuti, & Hastuti, 2017)

a. Perilaku Memfasilitasi

Contoh: melakukan kontak mata, memberikan perhatian, menggenggam anak sebagai individu yang unik, menunjukkan kebanggaan kepada anak, memahami perilaku anak dan memenuhi kebutuhannya.

b. Perilaku Penghambat

Contoh: menjauh dari anak, tidak mempedulikan kehadirannya, menghindari dan menolak untuk menyentuh anak, menunjukkan kekecewaan kepada anak dan tidak memenuhi kebutuhannya.

B. *Bounding Attachment*

1. Pengertian

Bounding adalah suatu ketertarikan mutual pertama antara individu. *Attachment* adalah suatu perasaan menyayangi atau loyalitas yang mengikat individu dengan individu lain. Jadi, *Bounding Attachment* merupakan sentuhan awal atau kontak kulit antara ibu dan bayi pada menit-menit pertama sampai beberapa jam setelah melahirkan bayi. (Azizah & Rosyidah, 2019)

2. Tahapan-tahapan

Berikut adalah beberapa tahapan *bounding attachment*: (Winani, Wanufika, Wibisono, & Katoda, 2020)

- a. Perkenalan (*acquaintance*), contoh: kontak mata, menyentuh, berbicara, dan mengeksplorasi untuk mengenal bayi;
- b. Ketertarikan (*bounding*), contoh: sikap pertama orang tua terhadap anak saat pertama kali bertemu;

- c. Perasaan kasih sayang (*attachment*), contoh: interaksi antara ibu dan bayi secara spesifik mulai dari setelah kala III persalinan sampai dengan melahirkan.

3. Elemen-elemen

Berikut adalah beberapa elemen *bounding attachment*: (Azizah & Rosyidah, 2019)

- a. Sentuhan

Sentuhan merupakan proses awal orang tua dalam mengenali bayi baru lahir. Orang tua mengawali eksplorasi terhadap tubuh bayi dengan cara menyentuh jari jemari bayi.

- b. Kontak Mata

Kontak mata antara orang tua terhadap bayi dilakukan sejak pertama lahir sehingga mengakibatkan kontak batin atau ikatan yang merasa lebih dekat satu sama lain.

- c. Suara

Suara tangisan bayi akan mampu mengambil sikap orang tua untuk menenangkan bayi dengan cara menggendong dan berbicara.

- d. Aroma

Orang tua dan bayi akan mengetahui aroma masing-masing khas tubuh. Bayi mampu membedakan mana aroma tubuh ibunya sendiri karena berkaitan dengan aroma air susu ibu (ASI).

- e. *Entrainment*

Elemen ini merupakan suatu respon bayi jika halnya sedang diajak berkomunikasi oleh orang tuanya. Contoh: bayi mampu menggerakkan kepalanya jika dipanggil nama oleh orang tuanya.

- f. Bioritme

Ibu dan bayi memiliki ritme alamiah sejak janin dalam kandungan sehingga setelah lahir bayi akan mampu membuat ritme personal (bioritme).

- g. Kontak dini

Kontak dini segera setelah bayi merupakan hal yang sangat penting dilakukan, contoh: melakukan IMD.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi *bounding attachment*: (Susilawati, Nilakesuma, & Risnawati, 2020)

- a. Kesehatan emosional orang tua;
- b. Dukungan sosial yang meliputi pasangan hidup, teman, keluarga, dan pelayanan Kesehatan;
- c. Tingkat keterampilan dalam berkomunikasi dan kompetensi asuhan;
- d. Kedekatan orang tua dengan bayi;
- e. Kecocokan orang tua dan bayi.

5. Dampak Positif

Berikut beberapa dampak positif dari *bounding attachment*: (Winarni, Winarni, & Ikhlasiah, 2018)

- a. Bayi merasa di cintai dan diperhatikan;
- b. Bayi akan merasa aman dengan mendapatkan pelukan seorang ibu;
- c. Menumbuhkan sikap sosial;
- d. Menciptakan dasar-dasar kepribadian yang positif bagi anak.

6. Hambatan

Berikut beberapa hambatan pada *bounding attachment*: (Susilawati, Nilakesuma, & Risnawati, 2020)

- a. Kurang dukungan dari orang terdekat;
- b. Ibu dengan risiko (memiliki penyakit tertentu);
- c. Bayi dengan risiko (memiliki penyakit tertentu);
- d. Kehadiran bayi yang tidak diinginkan.

C. *Sibling Rivalry*

1. Pengertian

Sibling rivalry merupakan suatu persaingan, kecemburuan, kemarahan, dan kebencian antara saudara kandung, yang sering kali muncul ketika anggota keluarga baru hadir baru lahir. (Azizah & Rosyidah, 2019)

2. Etiologi

Berikut beberapa etiologi dari *sibling rivalry*: (Marhamah & Fidesrinur, 2019)

- a. Anak merasa terancam hubungan dengan orang tuanya dikarenakan ada anggota keluarga baru;
- b. Anak merasa kasih sayang orang tua terbagi sehingga dapat mengakibatkan anak bersaing;
- c. Kecenderungan sikap orang tua terhadap salah satu anak sehingga mengakibatkan salah satu anak merasa kurang mendapatkan perhatian orang tua;
- d. Sikap orang tua dalam memuji kelebihan salah satu anak di depan anak yang lainnya;
- e. Perbedaan kemampuan masing-masing anak.

3. Faktor-faktor Penyebab

Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya *sibling rivalry*: (Wati, Siagian, Kurniasih, & Manurung, 2021) (Yektiningsih, Firdausi, & Yuliansari, 2022)

a. Usia anak;

Perbedaan usia antara saudara kandung dapat mempengaruhi cara mereka dalam bereaksi terhadap satu sama lainnya dan juga cara orang tua dalam memperlakukan anaknya.

b. Jenis kelamin;

Perasaan cemburu seorang anak akan cenderung lebih tinggi pada anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Selain itu, perasaan cemburu lebih sering terjadi pada pasangan adik-kakak dengan jenis kelamin yang sama dibandingkan dengan jenis kelamin yang berbeda.

c. Urutan anak dalam keluarga

Urutan anak dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap terjadinya *sibling rivalry*. Contoh anak sulung biasanya dianggap memiliki beban yang paling dikarenakan harus menjaga adinya dan menjadi panutan serta harus rentan mengalah dalam situasi tertentu.

d. Kepribadian anak

Kepribadian anak akan mempengaruhi reaksi anak akibat kehadiran adik atau anggota keluarga baru sehingga dapat mempengaruhi besarnya *sibling rivalry* yang terjadi pada anak.

e. Lingkungan

Kualitas lingkungan sosial di sekitar tempat tinggal anak memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian seorang anak.

f. Sikap orang tua

Sikap orang tua dalam membandingkan satu anak dengan anak yang lainnya dapat menimbulkan terjadinya *sibling rivalry* sehingga orang tua harus menghindari hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya *sibling rivalry*.

4. Dampak

Berikut beberapa dampak positif dari *sibling rivalry*: (Yektiningsih, Firdausi, & Yuliansari, 2022)

- a. Pertengkaran yang terus menerus dari kecil sampai dewasa;
- b. Persaingan dan saling membenci terhadap anak satu sama lain;
- c. Menumbuhkan asumsi pada anak untuk menjadi yang terbaik diantara anak yang lainnya.
- d. Mengakibatkan tali silaturahmi yang tidak baik terhadap satu sama lainnya.

Berikut beberapa dampak negatif dari *sibling rivalry*: (Yektiningsih, Firdausi, & Yuliansari, 2022)

- a. Mendorong anak untuk mengatasi perbedaan dengan mengembangkan beberapa keterampilan;
- b. Mengajarkan anak untuk berkompromi dan bernegosiasi;
- c. Mendorong anak untuk bertindak agresif;

5. Pencegahan

Berikut beberapa pencegahan supaya tidak terjadi *sibling rivalry*: (Marhamah & Fidesrinur, 2019)

- a. Orang tua tidak membandingkan satu anak dengan anak yang lainnya;

- b. Membiarkan anak untuk menjadi pribadi yang mandiri;
- c. Menyukai bakat dan keberhasilan anak;
- d. Membuat anak mampu bekerja sama satu sama lainnya;
- e. Memberikan perhatian setiap waktu;
- f. Bersikap adil;
- g. Meyakinkan setiap anak mendapatkan waktu yang cukup;
- h. Tidak memberikan tuduhan tertentu terhadap negatifnya sikap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnita, Y., Tahlil, T., & Amalia, R. (2020). Faktor-faktor yang Berkontribusi dengan interaksi Ibu-Bayi. *Idea Nursing Journal*, 18-28.
- Azizah, N., & Rosyidah, R. (2019). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Marhamah , A. A., & Fidesrinur. (2019). Gambaran Strategi Orang Tua dalam Penanganan Fenomena Sibling Rivalry pada Anak Usia Pra-Sekolah. *Jurnal AUDHI*, 30-36.
- Setyowati , Y. D., Krisnatuti, D., & Hastuti, D. (2017). Pengaruh Kesiapan Menjadi Orang Tua dan Pola Asuh Psikososial terhadap Perkembangan Sosial Anak. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 95-106.
- Susilawati, D., Nilakesuma, N., & Risnawati. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bounding Attachment Masa Nifas. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 628-637.
- Wati, L., Siagian, Y., Kurniasih, D., & Manurung, T. H. (2021). Faktor Dominan yang Mempengaruhi Sibling Rivalry pada Anak Usia Toddler. *Jurnal Keperawatan*, 1-10.
- Winani, L. M., Wanufika, I., Wibisono, & Katoda, Y. (2020). Bounding Attachment dan Tingkat Stress Ibu Pospartum. *Jurnal Kesehatan*, 1-10.
- Winarni, L. M., Winarni, E., & Ikhlasiah, M. (2018). Pengaruh Dukungan Suami dan Bounding Attachment dengan Kondisi Psikologi Ibu Pospartum di RSUD Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Bidan*, 1-11.
- Yektiningsih, E., Firdausi, N., & Yuliansari, P. (2022). Systematic Review Dampak Sibling Rivalry terhadap Permasalahan Emosional Pada Anak Preschool. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 6-15.

BAB 8

DETEKSI DINI KEGAWATDARURATAN

MASA NIFAS

Rizka Fatmawati, S.SiT., M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. Pendahuluan

Kehamilan, persalinan dan menyusui merupakan proses fisiologi yang perlu dipersiapkan oleh wanita dari pasangan subur agar dapat dilalui dengan aman. Selama masa kehamilan, ibu dan janin adalah unit fungsi yang tak terpisahkan. Setelah proses persalinan berlangsung, tubuh serta fungsinya akan kembali pada keadaan semula atau yang biasa disebut dengan proses involusi.

Proses masa nifas atau post partum adalah masa setelah persalinan selesai sampai 6 minggu atau 42 hari. Setelah masa nifas, organ reproduksi secara berlahan akan mengalami perubahan seperti sebelum hamil. Di Negara berkembang seperti di Indonesia masa nifa diperlukan pengawasan dan pengamatan yang serius karena merupakan masa kritis baik ibu maupun bayinya. Salah satu penyebab kematian yang terjadi adalah dalam masa masa nifas karena infeksi dan perdarahan pervaginam. Semua itu dapat terjadi, jika ibu post partum tidak mengetahui tanda bahaya selama masa nifas. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang masalah informasi yang diperoleh ibu nifas kurang. Untuk itu, diharapkan pemberi pelayanan kebidanan khususnya untuk pada ibu nifas dapat meningkatkan kompetensinya terkait dengan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan masalah yang mungkin terjadi.

Pada materi ini kita akan mempelajari tentang kegawatdaruratan masa nifas dari prinsip dasar sampai penatalaksanaan akan dijabarkan dalam beberapa kasus berikut ini :

1. Asuhan dengan perdarahan post partum sekunder
2. Asuhan dengan preeklamsia/ eklamsia post partum
3. Asuhan dengan sepsis puerpuralis
4. Asuhan dengan mastitis

B. Materi Kegawatdaruratan Pada Masa Nifas

1. Asuhan dengan perdarahan post partum sekunder
 - a. Pengertian

Perdarahan postpartum sekunder adalah perdarahan lebih dari 500 cc yang terjadi setelah 24 jam pertama setelah bayi lahir, biasanya antara hari ke 5 sampai 15 hari postpartum. Secara fisiologis, seorang ibu yang melahirkan akan mengeluarkan darah sampai 500 ml tanpa menyebabkan gangguan homeostatis. Jumlah perdarahan dapat diukur menggunakan bengkok besar (1 bengkok = $\pm$ 500 cc). Oleh sebab itu, secara konvensional

dikatakan bahwa perdarahan lebih dari 500 ml dikategorikan sebagai perdarahan postpartum dan perdarahan mencapai 1000 ml secara kasat mata harus segera ditangani secara serius (Nurhayati, 2019).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perdarahan postpartum merupakan perdarahan berlebihan yang terjadi setelah melahirkan sebanyak lebih dari 500 ml.

b. Penyebab perdarahan post partum sekunder

- 1) Atonia uteri
- 2) Robekan jalan lahir
- 3) Retensio plasenta
- 4) Gangguan pembekuan darah

c. Tanda dan gejala post partum sekunder

1) Atonia Uteri

Atonia uteri merupakan penyebab perdarahan postpartum yang paling umum. Atonia uteri adalah kondisi dimana rahim tidak dapat berkontraksi dengan baik. Tanda gejala atonia uteri adalah uterus tidak berkontraksi dengan baik atau lembek dan terjadi perdarahan segera setelah anak lahir. Penyulit dalam atonia uteri akan terjadi syok dan pembekuan darah pada serviks (pada posisi terlentang akan menghambat aliran darah).

2) Robekan jalan lahir

Robekan jalan lahir adalah robekan perineum yang terjadi pada saat bayi lahir baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat atau tindakan. Robekan ini umumnya terjadi pada garis tengah dan bisa menjadi luas apabila kepala janin lahir terlalu cepat. Robekan jalan lahir terjadi pada hampir semua ibu yang melahirkan anak pertama dan tidak jarang pada persalinan berikutnya.

Tanda gejalanya terjadi dalam robekan jalan lahir yaitu keluarnya darah segar setelah bayi lahir, uterus berkontraksi dan mengeras serta lahir plasenta lengkap. Biasanya ibu akan mengalami beberapa gejala seperti pucat, lemah serta badan menggigil.

3) Retensi Sisa Plasenta

Retensi plasenta adalah kondisi dimana plasenta tidak keluar 30 menit setelah bayi lahir dari jalan lahir. Keluhan lain biasanya demam, menggigil, nyeri berlangsung lama, perdarahan yang hebat, keluar cairan atau jaringan berbau tidak sedap dari vagina atau jalan lahir.

4) Gangguan pembekuan darah

Kata lain dari pembekuan darah adalah Hematoma yaitu gumpalan darah sebagai akibat cedera atau robeknya pembuluh darah wanita hamil aterm tanpa cedera mutlak pada lapisan jaringan luar.

Penyebabnya adalah akibat dari pertolongan persalinan, karena tusukan pembuluh darah selama anestesi lokal atau penjahitan dan dapat juga karena penjahitan luka episiotomi atau rupture perineum yang kurang sempurna.

Pembekuan darah ini mungkin dialami sesaat setelah melahirkan hingga enam minggu sesudahnya. Tanda gejala dapat dilihat dari uterus berkontraksi dan lembek, perdarahan, riwayat perdarahan lama. Tanda yang lain bisa dilihat dari sering duduk dalam waktu yang lama serta jarang melakukan aktifitas fisik, denyut jantung lebih cepat dari biasanya dan tidak teratur, sesak nafas, sakit dada serta pusing serta anemia.

d. Penatalaksanaan perdarahan post partum sekunder

Tindakan preventif dalam pencegahan post partum sekunder dengan cara melakukan resusitasi cairan untuk kemungkinan terjadi syok hipovolemik.

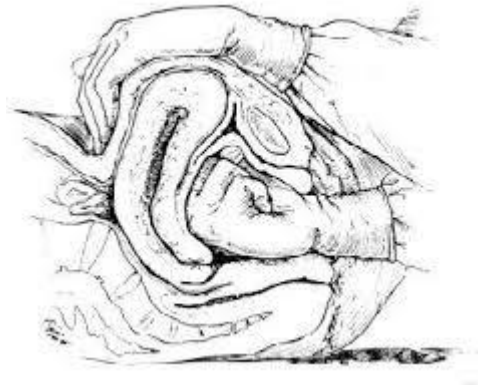
Tindakan Resusitasi Cairan
1. Kehilangan 1 L darah perlu penggantian 4-5 L kristaloid, karena sebagian besar cairan infus tidak tertahan di ruang intravaskuler, tetapi terjadi pergeseran ke ruang interstisial. Perdarahan post partum > 1.500 mL pada wanita yang saat hamilnya normal, cukup dengan infus kristaloid jika penyebab perdarahan dapat tertangani. 2. Bila dibutuhkan cairan kristaloid dalam jumlah banyak (>10 L), dapat dipertimbangkan penggunaan cairan Ringer Laktat. 3. Cairan yang mengandung Dekstrosa, seperti D 5% tidak memiliki peran pada penanganan perdarahan post partum. 4. Transfusi Darah diberikan bila perdarahan masih terus berlanjut melebihi 2.000 mL atau pasien menunjukkan tanda-tanda syok walaupun telah dilakukan resusitasi cepat. Tujuan transfusi memasukkan 2-4 unit PRC untuk menggantikan pembawa oksigen yang hilang dan untuk mengembalikan volume sirkulasi 5. PRC bersifat sangat kental yang dapat menurunkan jumlah tetesan infus, diatasi dengan menambahkan 100 mL NS pada masing-masing unit. Jangan menggunakan cairan Ringer Laktat untuk tujuan ini karena kalsium yang dikandungnya dapat menyebabkan penjendalan 6. Pengangkatan kaki dapat meningkatkan aliran darah balik vena sehingga dapat memberi waktu untuk menegakkan diagnosis dan menangani penyebab perdarahan. 7. Perlu pertimbangkan pemberian oksigen

Selain tindakan diatas untuk penanganan post partum sekunder dengan cara :

1) Atonia uteri

- a) Jika dijumpai keadaan syok, maka segera diberikan infus cairan kristaloid, transfusi darah, kontrol perdarahan dan pemberian O₂.
- b) Masase fundus uteri (maksimal 15 detik), jika uterus berkontraksi lakukan evaluasi rutin. Jika uterus berkontraksi tetapi perdarahan

- terus berlangsung, periksa apakah perineum, vagina dan serviks mengalami laserasi, jahit atau segera rujuk.
- c) Jika uterus tidak berkontraksi, bersihkan bekuan darah dan atau selaput ketuban dari vagina dan lubang serviks.
 - d) Pastikan bahwa kandung kemih ibu kosong. Jika penuh dan dapat dipalpasi lakukan kateterisasi kandung kemih dengan menggunakan tehnik aseptik.
 - e) Lakukan kompresi bimanual interna (KBI) selama 5 menit.



Gambar 8.1

- f) Anjurkan keluarga untuk membantu melakukan kompresi bimanual eksternal (KBE) jika uterus tidak segera berkontraksi setelah 5 menit.



Gambar 8.2

- g) Berikan 0,2 mg ergometrin IM atau misoprostol 600-1000 mcg per rektal. Jangan berikan ergometrin kepada ibu dengan hipertensi karena ergometrin dapat menaikkan tekanan darah.
- h) Gunakan jarum berdiameter besar (ukuran 16 atau 18), pasang infus dan berikan 500 cc larutan ringer laktat yang mengandung 20 unit oksitosin.
- i) Pakai sarung tangan steril atau disinfeksi tingkat tinggi dan ulangi KBI, karena KBI dengan ergometrin dan oksitosin akan membantu uterus berkontraksi.

- j) Jika uterus tidak berkontraksi dalam waktu 1 sampai 2 menit, segera rujuk ibu karena hal ini bukan atonia sederhana.
 - k) Sambil membawa ibu ke tempat rujukan, teruskan tindakan KBI dan infus cairan hingga ibu tiba di tempat rujukan.
- 2) Robekan jalan lahir
- a) Lakukan eksplorasi untuk mengidentifikasi lokasi laserasi dan sumber perdarahan
 - b) Lakukan irigasi pada tempat luka dan bubuhi larutan antiseptik
 - c) Jepit dengan ujung klem sumber perdarahan kemudian ikat dengan benang yang dapat diserap
 - d) Lakukan penjahitan luka mulai dari bagian yang paling distal dari operator
 - e) Khusus pada ruptura perineum komplit (hingga anus dan sebagian rektum), lakukan rujukan
 - f) Bila kontraksi uterus baik, plasenta lahir lengkap, tetapi terjadi perdarahan banyak maka segera lihat bagian lateral bawah kiri dan kanan dari portio terjadi robekan serviks jepitkan klem ovarium pada kedua sisi portio yang robek sehingga perdarahan dapat segera dihentikan. Segera lakukan rujukan.
- 3) Retensio plasenta
- a) Raba bagian dalam uterus untuk mencari sisa placenta , eksplorasi manual uterus menggunakan teknik yang serupa dengan teknik yang digunakan untuk mengeluarkan placenta yang tidak keluar
 - b) Keluarkan sisa placenta dengan eksplorasi digital (bila serviks terbuka) dan mengeluarkan bekuan darah atau jaringan. Jaringan yang melekat dengan kuat, mungkin merupakan plasenta akreta, usaha mengeluarkan berdampak perdarahan berat atau perforasi uterus, sehingga pasien harus segera dirujuk.
 - c) Berikan antibiotika karena perdarahan juga merupakan gejala metritis. Antibiotika yang dipilih adalah ampicilin dosis awal 1 g IV dilanjutkan 3 x 1 g oral dikombinasi dengan metronidazol 1 g supositoria dilanjutkan 3 x 500 mg oral
 - d) Lakukan rujukan bila serviks hanya dapat dilalui oleh instrumen, untuk evakuasi sisa plasenta dengan dilatasi dan kuretase
 - e) Sediakan pendonor bila kadar Hb < 8 g/dL berikan transfusi darah. Bila kadar Hb > 8 g/dL, berikan sulfas ferosus 600 mg/hari selama 10 hari

4) Gangguan pembekuan darah

Jika pembekuan darah berlanjut setelah mendapatkan penatalaksanaan maka lakukan uji pembekuan darah sederhana dengan cara :

- a) Ambil 2 ml darah vena kedalam tabung reaksi kaca yang bersih, kecil dan kering (kira-kira 10 mm X 75 mm)
- b) Pegang tabung tersebut dalam genggamannya Anda untuk menjaganya $\cong$ Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal $\cong$ 142 tetap hangat (kurang lebih + 37°C)
- c) Setelah 4 menit, ketuk tabung secara perlahan untuk melihat apakah pembekuan sudah terbentuk, kemudian ketuk setiap menit sampai darah membeku dan tabung dapat dibalik
- d) Kegagalan terbentuknya pembekuan setelah 7 menit atau adanya bekuan lunak yang dapat pecah dengan mudah menunjukkan adanya *koagulopathy*.
- e) Jika terjadi *koagulopathy* maka lakukan rujukan.

2. Asuhan dengan preeklampsia/ eklampsia post partum

Preeklampsia pasca persalinan (*postpartum pre-eclampsia*) atau tekanan darah tinggi setelah melahirkan ini bisa terjadi pada wanita memiliki tekanan darah tinggi dan kelebihan protein dalam urinenya setelah melahirkan. Menangani preeklampsia setelah melahirkan diperlukan penanganan medis segera karena dapat membahayakan ibu mengalami komplikasi serius setelah melahirkan. Keluhan terkait kondisi kegawat daruratan pada ibu post partum perlu dicurigai adanya preeklampsia berat atau preeklampsia pasca persalinan, dimana gejala yang dimunculkan berupa data subyektif serta obyektif.

a) Deteksi dini

Deteksi dini biasanya terdapat keluhan seperti nyeri kepala hebat, pandangan mata kabur, nyeri epigastrium pada ibu post partum.

b) Tanda gejala

Tabel 8.1 Tanda Gejala

PRE EKLAMPSIA BERAT	EKLAMPSIA
1. Tekanan diastolic $\geq$ 110 mmHg	1. Tekanan diastolic $\geq$ 90 mmHg
2. Protein urine $\geq$ +++	2. Protein urin $\geq$ ++
3. Kadang hiperrefleksia	3. Kadang disertai hiperrefleksia
4. Nyeri kepala hebat	4. Nyeri kepala hebat
5. Penglihatan kabur	5. Penglihatan kabur
6. Oliguria < 400 ml/24 jam, nyeri abdomen atas / epigastrik	6. Oliguria < 400 ml/24 jam
7. Edema paru	7. Nyeri abdomen atas / epigastrik
	8. Edema paru dan koma
	9. Ibu mengalami kejang

c) Penatalaksanaan

Penanganan secara umum tidak ada selain melakukan rujukan. Untuk penanganan khusus, yang dapat dilakukan adalah memberikan Magnesium Sulfat (MgSO₄). Magnesium sulfat (mgso₄) merupakan obat pilihan untuk mencegah dan mengatasi kejang pada preeklamsia berat dan eklamsia.

Tata cara pemberian MgSO₄ :

- 1) SEBELUM PEMBERIAN MgSO₄, periksa Frekuensi pernapasan minimal 16/menit, Reflek patella (+), Urin minimal 30 ml/jam dalam 4 jam terakhir, Beritahu pasien akan merasa agak panas sewaktu diberisuntikan MgSO₄
- 2) DOSIS AWAL Pemberian MgSO₄ 4 gr IV sebagai larutan 40% selama 5 menit, Segera dilanjutkan dengan pemberian 10 gr larutan MgSO₄ 50%, masing-2 5 gr di bokong kanan dan kiri secara IM dalam, ditambah 1 mg lignokain 2% pada semprit yang sama., Jika kejang berulang selama 15 menit, berikanMgSO₄ 2 gr (larutan 40%) IV selama 5 menit.
- 3) DOSIS PEMELIHARAAN MgSO₄ 1-2 gr /jam per infus, 15 tetes/menit atau 5 gr MgSO₄, Lanjutkan pemberianMgSO₄ sampai 24 pasca persalinan atau kejang berulang .
- 4) BERHENTILAH PEMBERIAN MgSO₄, jika Frekuensi pernapasan minimal < 16/menit, Reflek patella (-), Urin < 30 ml/jam dalam 4 jam terakhir SIAPKAN ANTIDOTUM, Jika terjadi henti nafas , lakukan ventilasi (masker dan balon, ventilator), beri kalsium glukonat 1 g (20 ml dalam larutan 10%) IV perlahan-lahan sampai pernafasan mulai lagi.

3. Asuhan dengan sepsis puerpuralis

a. Pengertian

Menurut WHO sepsis puerperalis adalah infeksi saluran genital yang dapat terjadi kapanpun mulai dari pecahnya ketuban atau saat persalinan sampai dengan hari ke-42 pascasalin. Hal ini ditandai dengan demam dengan suhu lebih dari 38°C yang terjadi selama 2 hari berturut-turut dalam masa nifas.

b. Tanda dan Gejala

Untuk menentukan apakah sepsis puerperalis terjadi, maka Anda dapat mendeteksinya melalui adanya dua atau lebih dan hal – hal berikut ini :

- 1) Nyeri abdominal pireksia (>38°C diukur 2x dengan interval 4 jam; >38,5°C dalam 1x pengukuran)
- 2) Hipotermia (<35,0°C)

- 3) Takipnea (>20 x pernapasan per menit)
- 4) Hipoksia (kejenuhan $O_2 < 90\%$)
- 5) Hipotensi (tekanan darah sistolik $< 90\text{mmHg}$)
- 6) Takikardia (laju denyut jantung >100 bpm; >90 bpm dalam puerperium)
- 7) Oliguria (luaran urin < 100 ml; <90 ml dalam puerperium)
- 8) Leukositosis (jumlah leukosit $>12,0 \times 10^9/L$ atau $>12.000/mm^3$)
- 9) Leukopenia (jumlah leukosit $< 2 \times 10^9/L$)
- 10) Gangguan kesadaran
- 11) Kegagalan merespon pengobatan
- 12) Peningkatan perdarahan masa nifas
- 13) Nyeri tekan uterus
- 14) Pada laserasi/luka episiotomi terasa nyeri, bengkak, mengeluarkan cairan nanah
- 15) Lochea yang berbau busuk
- 16) Terlambatnya involusi uterus (< 2 cm/hari).

Pada kasus sepsis puerperalis dapat menimbulkan kegawatdaruratan, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Infeksi terbatas pada kasus
 - a) Vulvitis
 - b) Vaginitis
 - c) Servisit
 - d) Endometritis
 - 2) Komplikasi yang bisa terjadi
 - a) Peritonitis
 - b) Salpingo-ooforitis dan parametritis
 - c) Septikemia
 - d) Abses
- c. Untuk mengetahui adanya kegawatdaruratan ibu nifas dengan sepsis puerperalis, Anda dapat melakukan pengkajian data subyektif dan obyektif, seperti dibawah ini :
- 1) Data Subyektif
 - a) Ibu menyampaikan baru melahirkan
 - b) Riwayat persalinan dengan tindakan (digunting, dengan alat dan plasenta dirogo)
 - c) Proses persalinan lama lebih 1 jam bayi tidak segera lahir
 - d) Saat hamil ibu dengan penyakit mis: batuk lama, dada berdebardebar, kencing manis dll

- 2) Data Obyektif
 - a) Partus lama utama ketuban pecah lama
 - b) Tindakan bedah vagina yang menyebabkan perlukaan pada jalan lahir
 - c) Tertinggalnya sisa plasenta, selaput ketuban dan bekuan darah
 - d) Demam tinggi sampai menggigil
 - e) Nadi kecil dan cepat
 - f) Nyeri tekan pada kedua sisi abdomen
- d. Pencegahan sepsis puerpuralis

Sesudah partus terdapat luka-luka di beberapa tempat pada jalan lahir. Pada hari pertama postpartum harus dijaga agar luka-luka ini tidak dimasuki kuman-kuman dari luar. Tiap penderita dengan tanda-tanda infeksi nifas jangan dirawat bersama dengan wanita-wanita dalam nifas sehat.
- e. Penatalaksanaan sepsis puerpuralis

Prioritas penatalaksanaan sepsis puerpuralis adalah :

 - 1) Menilai kondisi pasien
 - a) Keadaan umum
 - b) Tanda – tanda vital
 - 2) Resusitasi dan isolasi
 - a) Isolasi pasien yang diduga terinfeksi
 - b) Berikan pemasangan infus
 - 3) Mengambil specimen
 - a) Obati secara aktif jika diduga, tanpa menunggu kepastian diagnosis
 - b) Mulai dengan antibiotik seperti: benzil penisilin ditambah dengan gentamisin dan metronidazol, cairan 4 dan analgesik (seperti petidin 50-100 mg secara IM setiap 6 jam)
 - c) Jika tersedia, pasang selang nasogastrik (NGT) dan aspirasikan isi lambung
 - 4) Pengobatan
 - 5) Rujuk
 - a) Dirujuk Langsung ke RUMAH SAKIT
 - b) BAKSOKU (Bidan, Alat, Kendaraan, Surat, Obat, Keluarga, Uang)

Penatalaksanaan Sepsis Puerperalis dalam Kewenangan Bidan:

 - 1) Jika diduga sepsis periksa ibu dari kepala sampai kaki, cari sumber terjadinya sepsis.

- 2) Jika uterus nyeri, pengecilan uterus lambat, atau terdapat perdarahan pervaginam, rujuk ibu ke RS. Mulai memberikan infus RL
- 3) Jika kondisi gawat dan terdapat tanda septic syok, dan terjadi dehidrasi beri cairan IV dan antibiotik sesuai dengan ketentuan, lalu rujuk ibu ke RS
- 4) Jika hanya sepsis ringan beri antibiotik (co: Ampisilin 1 gr PE, diikuti 500 mg/oral setiap 6 jam, ditambah Metronidazol 500 mg setiap 8 jam selama 5hari)

5. Asuhan dengan mastitis

a. Pengertian

Mastitis adalah peradangan payudara pada satu segmen atau lebih yang dapat disertai infeksi ataupun tidak. Mastitis biasanya terjadi pada primipara (ibu pertama kali melahirkan), hal ini terjadi karena ibu belum memiliki kekebalan tubuh terhadap infeksi bakteri *Staphylococcus Aureus*.

b. Jenis – jenis mastitis

1) Mastitis infeksi

Gejala yang timbul dari mastiti infeksi biasanya ditandai adanya respon inflamasi dan rusaknya jaringan puting puting menjadi pecah-pecah sehingga dengan mudah bakteri untuk masuk

2) Mastitis non infeksi

Tanda dan gejala mastitis non infeksi payudara mengalami pembengkakan yang upnormal payudara yang mengeras, terasa sakit apabila disentuh dan terasa tegang dikarenakan kurangnya waktu menyusui untuk bayi

c. Tanda Gejala Mastitis

- 1) Demam dengan suhu lebih dari 38,5oC.
- 2) Menggigil
- 3) Nyeri atau ngilu seluruh tubuh
- 4) Payudara menjadi kemerahan, tegang, panas, bengkak, dan terasa sangat nyeri
- 5) Peningkatan kadar natrium dalam ASI yang membuat bayi menolak menyusu karena ASI terasa asin
- 6) Timbul garis-garis merah ke arah ketiak.

d. Penatalaksanaan Mastitis

1) Medis

- a) Diberikan antibiotic setelah 12 – 24 jam dengan dikonsultasikan oleh dokter agar mendapatkan antibiotic

yang sesuai dengan ibu menyusui. Terapi yang paling umum adalah Dikloksasilin.

- b) Diberikan analgesic untuk mengurangi rasa nyeri. Rasa nyeri menjadi penghambat hormon oksitosin yang berperan dalam proses pengeluaran ASI. Analgesik yang diberikan berupa ibuprofen dengan dosis 1,6gram per hari karena lebih efektif dalam menurunkan peradangan dibandingkan dengan paracetamol dan asetaminofen.

2) Non Medis

- a) Tindakan suportif untuk mencegah mastitis semakin buruk
- b) Pengosongan payudara
- c) Pengompresan payudara dengan menggunakan air hangat
- d) Mengubah posisi menyusui
- e) Memakai baju atau bra yang longgar dapat mengurangi penekanan berlebihan pada payudara
- f) Mengedukasi ibu dengan memberikan pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan mastitis

DAFTAR PUSTAKA

- American Pregnancy Association (2017). Retained Placenta.
- Didien ika, S., Suprpti.(2016). Modul Bahan ajar Asuhan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal. Pusdik SDM Kesehatan. Jakarta.
- Dr. Erna., Sugiarti.(2017). Buku ajar kegawatdaruratan maternitas pada ibu hamil, bersalin, nifas. Indomedia Pustaka. Yogyakarta
- Gallee, M. et al. (2021). Association Between First-Trimester Bleeding and Retained Placenta Requiring Dilatation and Curettage. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, 43(4), pp. 463–68.
- Nur D., Yuni K., Dwiwana E. (2018). Modul Praktik Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal. Jurusan Kebidanan PolkesYo. Yogyakarta.
- Perlman, N., & Carusi, D. (2019). Retained Placenta After Vaginal Delivery: Risk Factors and Management. *International Journal of Women's Health*, 11, pp. 527–34.

BAB 9

KUNJUNGAN MASA NIFAS

Henny Sulistyawati, SST.,M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. Konsep Dasar Kunjungan Masa Nifas**1. Pengertian Kunjungan ibu nifas**

Kunjungan nifas atau postnatal care adalah perawatan yang dilakukan dengan memberikan asuhan untuk mencegah, mendeteksi, mengidentifikasi, mengelola serta merujuk apabila terjadi komplikasi pada ibu nifas. Asuhan yang diberikan pada kunjungan nifas yaitu konseling tentang keluarga berencana, kesehatan psikologis ibu, serta gizi dan personal hygiene. (KEMENKES RI, 2021). Kunjungan ibu nifas adalah suatu program yang terjadwal untuk melakukan observasi, memberikan pendidikan, dan penatalaksanaan medis pada ibu nifas yang berlangsung selama 6-8 minggu setelah persalinan. (Ai Yeyeh Rukiyah, 2018a)

Kunjungan rumah postpartum dilaksanakan untuk tindakan pemeriksaan nifas lanjutan. Kunjungan rumah dilakukan untuk berkolaborasi dengan keluarga yang akan dijadwalkan berdasarkan kebutuhan. Dilakukan sebagai suatu tindakan untuk pemeriksaan postpartum lanjutan. Kunjungan rumah direncanakan untuk bekerjasama dengan keluarga dan dijadwalkan berdasarkan kebutuhan. Program pemerintah yang terdahulu, kunjungan nifas bisa dilakukan sejak 24 jam setelah pulang, dan jarang sekali menunda kunjungan nifas sampai hari ketiga ketika sudah pulang. Jadwal selanjutnya kunjungan nifas dilakukan pada minggu pertama jika dibutuhkan. Kunjungan nifas dilakukan paling sedikit empat kali untuk menilai status ibu dan status bayi, serta mencegah, mendeteksi dan menangani komplikasi yang menyertai. (Islami & Aisyaroh, 2012)

Pemeriksaan yang dilakukan pada kunjungan nifas meliputi pemeriksaan TTV (Tanda Tanda Vital), Kontraksi uterus, Tinggi Fundus Uteri, penilaian system perkemihan, kondisi perineum, system pencernaan, penyembuhan luka, serta pola istirahat dan nyeri punggung. (Kemenkes, 2020)

2. Tujuan Kunjungan Nifas

Berdasarkan program pemerintah Kunjungan nifas dilakukan paling sedikit 4 kali. Tujuan kunjungan nifas adalah sebagai berikut :

- a. Menilai kesehatan ibu dan bayi
- b. Melakukan pencegahan yang kemungkinan terjadi dengan gangguan kesehatan ibu nifas dan bayinya
- c. Mendeteksi terjadinya komplikasi/masalah yang terjadi pada masa nifas.

- d. Menangani komplikasi/masalah yang timbul dan mengganggu kesehatan ibu nifas maupun bayinya (EKA PUSPITA SARI, 2014)

3. Lokasi Kunjungan Nifas

Menurut (World Health Organization, 2015), Kunjungan nifas/postnatal care bisa dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, kunjungan nifas bisa dilakukan dengan menggunakan metode *home visit*. Pelaksanaan kunjungan nifas pada masa pandemic covid dengan metode kunjungan rumah (*home visit*) oleh tenaga kesehatan, dengan melakukan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 baik dari petugas, ibu dan keluarga atau metode pemantauan dengan menggunakan media online (Kemenkes, 2020)

4. Media Pendukung Kunjungan

Media yang digunakan untuk melakukan kunjungan nifas dengan media *telehealth*. Telehealth adalah media inovasi dalam perawatan kesehatan yang dibuat untuk memantau kesehatan yang kemungkinan tidak bisa datang untuk melakukan pemeriksaan dan konseling secara langsung. Media ini didesain untuk ibu hamil dan ibu nifas di masa pandemic covid-19 untuk meminimalisir tertularnya virus Covid-19 secara langsung. Selama kehamilan, persalinan dan masa nifas di perlukan dukungan atau motivasi yang dibutuhkan tidak hanya dari keluarga, masyarakat tetapi juga dari media layanan kesehatan, pemantauan dan dukungan ini bisa dilakukan dengan menggunakan *telehealth*. Telehealth bisa menggunakan call center khusus kesehatan ibu dan anak, Short Message Service (SMS), Whatsapp pengirim pesan, atau aplikasi telemedicine/telehealth. Telehealth berkontribusi pada peningkatan pengetahuan maternal terutama ketika terdapat batasan kunjungan kehamilan offline karena pandemic covid-19 (Anis, Wahyul; Amalia, 2021)

5. Jadwal Kunjungan Nifas

Menurut (Kemenkes, 2020) jadwal kunjungan pada masa nifas dibagi menjadi 4 :

- a. Kunjungan Nifas pertama / KF 1 (6 jam -2 hari postpartum)

Pada kunjungan pertama yang dilakukan adalah:

- 1) Pemantauan jumlah darah yang keluar
- 2) Pemeriksaan cairan yang keluar dari vagina
- 3) Pencegahan terjadinya perdarahan postpartum
- 4) Menilai kontraksi uterus, Tinggi Fundus Uteri serta kandung kemih
- 5) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah pendarahan masa nifas karena atonia uteri.
- 6) Mendeteksi penyebab perdarahan yang lain serta melakukan rujukan bila diperlukan

- 7) Pemeriksaan payudara dan Pemberian ASI Awal serta anjuran ASI Eksklusif sampai 6 bulan tanpa makanan pendamping apapun
 - 8) Pemberian kapsul Vitamin A
 - 9) Minum tablet tambah setiap hari
 - 10) Pelayanan KB pasca persalinan
 - 11) Memberikan pendidikan kesehatan tentang cara mempeerat ikatan batin (*bounding attachment*) antara ibu dan bayi
 - 12) Menjaga bayi agar tetap hangat dan mencegah hipotermi. (EKA PUSPITA SARI, 2014)
 - 13) Memberikan Konseling tanda bahaya nifas
 - 14) Memberikan Konseling tentang Personal Hygiene (
- b. Kunjungan Nifas kedua / KF 2 (3 – 7 hari postpartum)
- Pada kunjungan kedua asuhan yang dilakukan yaitu :
- 1) Memastikan involusi uteri berjalan dengan normal
 - 2) Memastikan Kontraksi uterus baik
 - 3) TFU pertengahan simpisis dan pusat
 - 4) Tidak ada perdarahan yang abnormal
 - 5) Menilai adanya tanda-tanda infeksi atau demam
 - 6) Memastikan ibu dapat beristirahat dengan baik
 - 7) Memastikan ibu mendapat aupan makanan dan cairan yang cukup
 - 8) Memastikan ibu Bisa menyusui bayinya dengan baik tanpa ada penyakit yang lain
 - 9) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi dalam sehari-hari. (EKA PUSPITA SARI, 2014)
- c. Kunjungan Nifas ketiga / KF 3 (8 – 28 hari minggu postpartum)
- Asuhan yang diberikan pada kunjungan ke tiga sama dengan asuhan yang diberikan pada kunjungan ke dua.
- d. Kunjungan Nifas keempat / KF 4 (29 – 42 hari postpartum)
- Asuhan yang diberikan pada kunjungan ke empat yaitu
- 1) Menanyakan pada ibu tentang hal-hal menyulitkan yang dialami oleh ibu atau bayinya.
 - 2) Memberikan konseling untuk KB secara dini. (EKA PUSPITA SARI, 2014)

6. Frekuensi Kunjungan Nifas

Selama masa nifas ibu dianjurkan untuk kunjungan nifas atau kontrol minimal 4 kali. Waktu yang disarankan untuk kunjungan nifas yaitu

- a. Kunjungan pertama pada 6 jam – 2 hari postpartum
- b. Kunjungan ke dua pada 3-7 hari postpartum

- c. Kunjungan ke tiga pada 8-28 hari postpartum
- d. Kunjungan ke empat pada 29-42 hari postpartum (Kemenkes, 2020).

7. Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Nifas

Di Indonesia cakupan kunjungan nifas lengkap masih rendah (Situmorang & Pujiyanto, 2021). Factor-faktor yang mempengaruhi kunjungan nifas :

a. Faktor Predisposisi

Factor predisposisi merupakan factor awal yang menjadi pedoman atau motivasi bagi perilaku. Factor predisposisi ini bisa dikatakan sebagai preferensi pribadi yang dibawa oleh seseorang atau sekelompok kedalam suatu pengalaman belajar. Preferensi ini bisa menjadi pendukung atau penghambat perilaku sehat, dan setiap kejadian factor ini akan selalu memiliki pengaruh. Factor predisposisi ini meliputi pengetahuan dan sikap terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, system nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, social, pekerjaan dan ekonomi.

1) Usia Ibu

Usia reproduksi diantara 20-35 tahun. Semakin dewasa usia ibu, maka pola pikir yang dimiliki ibu juga semakin matang. Oleh sebab itu, ibu yang memiliki usia dewasa maka akan lebih termotivasi dan lebih tanggap dengan keadaan dirinya untuk melakukan kunjungan nifas yang sudah di informasikan dari tenaga kesehatan waktu yang tepat untuk kontrol /kunjungan nifas agar tahu tentang pemeriksaan kesehatan dan mengantisipasi serta mendeteksi dini komplikasi pada masa nifas (Rosita, 2018)

2) Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan ibu tentang masa nifas merupakan salah satu faktor yang penting dalam kesuksesan proses menyusui. Hasil penelitian yang dilakukan Ibrahim (2012) menyebutkan bahwa ibu yang berpengetahuan baik 1,9 kali berpeluang untuk melakukan kunjungan nifas dibandingkan dengan ibu yang berpengetahuan kurang. Semakin tinggi tingkat pengetahuan, semakin ibu melakukan kunjungan nifas.

(Wolio, 2017)

3) Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan ibu maka semakin besar pengetahuan yang dimiliki ibu. Sehingga ketika pendidikan ibu semakin tinggi maka ibu memiliki wawasan yang luas dibandingkan ibu yang berpendidikan rendah. Oleh sebab itu, ibu yang berpendidikan tinggi memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang kesehatan dirinya pada masa nifas (Rosita, 2018).

Menurut (Wolio, 2017) Tingkat pendidikan dan akses ibu terhadap media masa juga mempengaruhi pengambilan keputusan, dimana semakin tinggi pendidikan semakin besar peluang untuk memberikan kolostrum kepada bayinya. Tingkat pendidikan formal yang tinggi memang dapat membentuk nilai-nilai progresif pada diri seseorang, terutama dalam menerima hal-hal baru, termasuk pentingnya pemberian kolostrum. Tingkat pendidikan inilah yang membantu seorang ibu untuk lebih mudah menangkap dan memahami suatu informasi, sehingga lebih mudah mengadopsi pengetahuan baru khususnya mengenai pentingnya kunjungan masa nifas. Dalam penelitian yang dilakukan (Nurpelita, 2017) menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan dan kurangnya informasi dapat berpengaruh terhadap kegagalan kunjungan masa nifas.

4) Sikap

Selain pengaruh pengetahuan, pendidikan dan motivasi ibu, faktor lain yang dapat berpengaruh adalah sikap ibu terhadap pemberian kolostrum. Menurut Notoatmodjo (2012), sikap merupakan reaksi ataurespon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau obyek. Manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Penelitian yang dilakukan oleh Permana (2016), menunjukan hasil bahwa faktor kognitif atau keyakinan adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku ibu dalam kunjungan nifas yaitu sebesar 75,63%. Sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Terwujudnya sikap agar menjadi tindakan nyata diperlukan faktor 25 dukungan dari pihak - pihak tertentu, seperti petugas kesehatan dan orang-orang terdekat ibu. Menurut Alport (dalam Notoatmodjo, 2012), sikap terdiri dari tiga komponen yaitu kepercayaan (keyakinan), kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek dan kecenderungan untuk

bertindak. Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh, dimana pengetahuan, berpikir, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting.

5) Paritas

Paritas adalah jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita. Ibu hamil dan suami yang telah memiliki anak sebelumnya cenderung memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan yang baru pertama kali memiliki anak (Asmijati, 2014). Penelitian yang dilakukan Asmijati (2014) dan Frinsevae (2015) menyebutkan bahwa paritas mempunyai hubungan yang signifikan dengan kunjungan nifas. Menurut Saifuddin (2012), paritas dapat dibedakan menjadi nullipara (wanita yang belum pernah melahirkan anak hidup), primipara (wanita yang telah melahirkan satu anak), multipara (wanita yang telah melahirkan anak kedua sampai keempat), grandemultipara (wanita yang telah melahirkan anak lebih dari empat).

Ibu yang baru melahirkan anak pertama maka keingintahuan lebih besar untuk melakukan kunjungan nifas karena dianggap hal baru. Berbeda dengan ibu yang memiliki paritas lebih dari satu, yang sebelumnya sudah pernah melakukan kunjungan nifas maka keingintahuannya akan menurun, karena dianggap sudah biasa dilakukan pada masa nifas (Rosita, 2018).

6) Metode Persalinan

Metode persalinan dengan *section caesaria*, *vakum*, *forceps*, dsb cenderung lebih antusias untuk melakukan kunjungan nifas lengkap dikarenakan metode persalinannya yang merupakan rentan terjadinya komplikasi pada masa nifas sehingga perlu dilakukan pemeriksaan secara intens yaitu dengan cara melakukan kunjungan nifas lengkap (Situmorang & Pujiyanto, 2021).

7) Tempat Persalinan

Ibu yang bersalin di fasilitas kesehatan biasanya sudah diberikan konseling tentang kunjungan nifas lengkap sehingga ibu mengerti dan paham tentang perawatan pada masa nifas (Hidayati & Sulistyoningtyas, 2017)

8) Pemeriksaan Kehamilan

Ibu yang selama hamil melakukan pemeriksaan kehamilan (*antenatal care*) lengkap cenderung akan melakukan kunjungan nifas lengkap. Hal ini dipengaruhi oleh pendidikan kesehatan ibu selama kehamilan yang sebelumnya sudah mendapatkan

pelayanan dan konseling kesehatan, sehingga akan berpengaruh positif pada pemeriksaan atau kunjungan nifas. (Ai Yeyeh Rukiyah, 2018b)

9) Regional Provinsi

Menurut (Situmorang & Pujiyanto, 2021), ibu nifas yang tinggal di daerah regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua cenderung akan melakukan kunjungan nifas lengkap dibandingkan dengan ibu nifas yang tinggal di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi. hal ini kemungkinan disebabkan oleh tingkat kesehatan yang masih rendah sehingga tingkat komplikasi lebih tinggi.

10) Kondisi kesehatan ibu dan bayi

Kondisi kesehatan ibu juga dapat mempengaruhi kunjungan nifas(Wolio, 2017)

11) Kepercayaan

Menurut Notoatmodjo (2012), kepercayaan adalah komponen kognitif dari faktor sosio-psikologis. Kepercayaan ini dibentuk oleh pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang percaya kepada sesuatu karena ia mempunyai pengetahuan tentang itu. Keyakinan sering diperoleh dari orang tua, kakek, atau nenek. Seseorang menerima kepercayaan itu berdasarkan keyakinan dan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu. Kepercayaan yang diyakini masyarakat dapat juga berupa kebiasaan yang ada dimasyarakat yang merupakan pelaziman dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini sering dikaitkan dengan adat dimasyarakat yang turun temurun karena kebiasaan pada umumnya sudah melekat pada diri seseorang termasuk kebiasaan yang kurang menguntungkan bagi kesehatan. Kepercayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan menganggap bahwa kolostrum merupakan air susu yang kotor yang pertama kali keluar.(Wolio, 2017)

b. Faktor Pendukung

1) Status Pekerjaan

Status pekerjaan juga mempengaruhi kunjungan nifas, baik pekerjaan suami maupun ibu. Mereka yang mempunyai status pekerjaan tinggi cenderung memiliki pendidikan tinggi. Factor kontribusi penting untuk pemanfaatan dan perawatan pasca melahirkan dipengaruhi oleh pendidikan (Pandey S, Shekhar K, Regev A, 2019)

2) Kepemilikan Jaminan Kesehatan

Keluarga yang memiliki jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menggunakannya untuk pemanfaatan dalam pelayanan fasilitas kesehatan karena jaminan kesehatan dapat menjamin masyarakat dalam memperoleh manfaat dalam pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. (Pandey S, Shekhar K, Regev A, 2019)

c. Faktor Kebutuhan

Riwayat Komplikasi Ibu yang mempunyai riwayat komplikasi kehamilan cenderung akan melakukan kunjungan nifas. Hal ini dikarenakan kesadaran ibu akan komplikasi atau tanda bahaya pada masa nifas, sehingga ibu akan lebih termotivasi memanfaatkan pelayanan kesehatan seperti kunjungan nifas untuk melakukan pencegahan dan perawatan pada masa nifas. (EKA PUSPITA SARI, 2014)

d. Faktor Pemungkin (*Enabling Factors*)

Faktor pemungkin merupakan faktor estenden yang memungkinkan suatu atau motivasi dapat terlaksana, termasuk 27 didalamnya keterampilan dan sumber daya pribadi di samping sumber daya masyarakat. Enabling Factor mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat untuk melakukan perilaku kesehatan. Faktor pemungkin ini juga menyangkut keterjangkauan sumber daya, biaya, jarak, ketersediaan transportasi, jam buka atau jam pelayanan, dan sebagainya. Dalam hal ini fasilitas klinik merupakan salah satu faktor pemungkin. (Wolio, 2017)

e. Faktor Penguat (*Reinforcing Factors*)

Faktor penguat adalah faktor yang menentukan apakah tindakan kesehatan, memperoleh dukungan atau tidak. Faktor penguat merupakan faktor penyerta (yang datang sesudah) perilaku dan berperan bagi menetap atau melenyapnya perilaku itu. Yang termasuk dalam faktor ini adalah penghargaan atau dukungan dari keluarga, teman, petugas kesehatan, tokoh masyarakat, dan pengambil keputusan.

- 1) Dukungan Keluarga Dukungan keluarga ini pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat fisik, emosional maupun psikologis yang diberikan kepada ibu yang baru saja melahirkan bayinya. 28
- 2) Dukungan Petugas Kesehatan Sebagai seseorang yang dipercaya ibu-ibu dalam mengatasi masalah bayi, petugas kesehatan hendaknya memberikan nasihat kepada seorang ibu pemulaan

menyusui agar dapat menumbuhkan kepercayaan diri ibu untuk menyusui bayinya sesegera mungkin. (Wolio, 2017)

8. Kunjungan Nifas di Masa Pandemi Covid-19

Menurut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia & United Nations International Children's Emergency Fund, 2020), untuk layanan ibu nifas pada masa nifas pandemic Covid-19, kunjungan nifas pertama (KF1) dianjurkan melakukan kunjungan nifas di fasilitas pelayanan kesehatan. Pada kunjungan nifas kedua (KF2), kunjungan nifas ke tiga (KF3), Kunjungan Nifas ke empat (KF4) disarankan untuk dilakukan dengan metode kunjungan rumah atau pemantauan media secara online. Pelayanan KB pada masa pandemi tetap berlangsung sesuai jadwal dengan membuat janji dengan tenaga kesehatan serta diutamakan untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Berdasarkan kebijakan program nasional pada masa nifas, kunjungan nifas dianjurkan dilakukan minimal sebanyak empat kali (EKA PUSPITA SARI, 2014).

Berdasarkan Petunjuk Layanan Kesehatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor: B-4 (05 April 2020), berikut petunjuk layanan kesehatan yang harus di terapkan. Protokol ini disiapkan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam memastikan kelanjutan pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir dapat tetap terlaksana sebagai upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi selama wabah pandemi Covid-19. Protokol ini disusun dengan mengacu pada referensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Organisasi Profesi, seperti: Pedoman Bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Ba yi Baru Lahir selama pandemi COVID0-19 (Kemenkes, 2020). Pedoman Pelayanan Kesehatan Balita pada Masa Tanggap Darurat Covid-19 (Kemenkes, 2020), Rekomendasi Penanganan Infeksi Virus Corona-19 pada Maternal (POGI, 2020), Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Covid19 di RT/RW/Desa (Kemenkes, 2020). Protokol ini diharapkan untuk digunakan sebagai acuan oleh pemerintah dan pelaksana layanan kesehatan ibu dan anak di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat, termasuk sektor swasta dan relawan. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, Bidan Praktik Mandiri) dan fasilitas kesehatan rujukan (RS Rujukan COVID RSIA) dalam memberikan layanan kesehatan, RS mampu PONEK, ibu dan anak dengan atau tanpa status terinfeksi COVID19. Kegiatan konsultasi dimaksimalkan dengan menggunakan teknologi informasi yang mudah diakses oleh ibu. Call center 119 ext 9 atau hotline yang disediakan khusus untuk layanan kesehatan ibu dan anak dan telemedicine perlu untuk disosialisasikan. Edukasi kepada Ibu hamil, Ibu bersalin, Ibu menyusui dan pengasuh agar patuh untuk menggunakan masker ketika berkunjung ke fasilitas kesehatan, dan jujur menyampaikan status kesehatannya jika ternyata sudah d idiagnosa

sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau terkonfirmasi COVID19.

a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

- 1) Puskesmas direkomendasikan untuk mengatur ulang fasilitas layanan KIA agar terpisah dengan Gedung Utama KIA tidak b Puskesmas sehingga Pasien bercampur dengan Pasien Umum.
- 2) Jika Puskesmas tidak mempunyai ruang KIA yang terpisah dari Gedung Puskesmas, maka dapat disiapkan fasilitas layanan darurat, misalnya, memanfaatkan sarana gedung pelatihan, penginapan, gedung olah raga, dll, dengan mengupayakan prasarana minimal terpenuhi (sumber air bersih, listrik, kamar mandi dll). Sedapat mungkin tidak menggunakan sekolah untuk memastikan anak dapat kembali bersekolah secepatnya.
- 3) Jika layanan KIA tidak mungkin dilaksanakan di Puskesmas, maka bisa disepakati Bidan Praktik Mandiri (BPM) dalam satu regional untuk dipergunakan secara kolektif oleh beberapa bidan di sekitarnya.
- 4) Menerapkan triase dan alur tatalaksana layanan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir. Memenuhi kebutuhan Rapid Test dan Alat Pelindung Diri (APD) Level 1 dan level 2

b. Tenaga Kesehatan

- 1) Tenaga kesehatan di RS, Puskesmas dan Praktik Mandiri, Bidan Desa dan kader kesehatan di dalam wilayah kerja memiliki pengetahuan tentang penularan COVID dan gejala kegawatdaruratan, serta pengetahuan tentang tanda bahaya ibu dan bayi baru lahir.
- 2) Tenaga kesehatan memahami algoritma tata laksana ibu hamil/ibu bersalin/bayi baru lahir dengan komplikasi atau kegawat daruratan serta alur pelayanan kesehatan ibu dan bayi dalam situasi pandemi COVID19.
- 3) Tenaga kesehatan memahami indikasi, pemakaian, melepaskan dan membuang Alat Pelindung Diri yang dipakai serta mematuhi penggunaannya dengan benar sesuai tugas di masing-masing area.
- 4) Tenaga Kesehatan mampu memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat agar mendukung Ibu hamil, Ibu bersalin, Ibu menyusui dan pengasuh memahami penggunaan masker dan etika batuk, menjaga kebersihan diri dan lingkungan di rumah dan ketika berkunjung ke fasyankes, dan menyampaikan status Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau terkonfirmasi positif COVID19.

- c. Layanan Paska Bersalin di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- 1) FKTP memberikan pelayanan KB (diutamakan metode kontrasepsi jangka panjang) segera setelah persalinan. Jika ibu tidak bersedia, maka dilakukan konseling KB serta nasihat untuk mendapatkan layanan KB paska bersalin.
 - 2) Bayi yang dilahirkan dari ibu yang bukan ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID19 pada 0-6 jam pertama, tetap mendapatkan perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, injeksi vitamin K1, pemberian salep/tetes mata antibiotik dan pemberian imunisasi hepatitis B dan Hblg (Hepatitis B immunoglobulin).
 - 3) Ibu dan keluarga mendapat nasihat dan edukasi tentang perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan tanda bahaya jika ada penyulit pada bayi baru lahir dan jika terjadi infeksi masa nifas.
 - 4) Tenaga kesehatan mengambil sampel skrining hipotiroid kongenital (SHK) pada bayi yang dilakukan setelah 24 jam persalinan, sebelum ibu dan bayi pulang dari fasilitas kesehatan.
 - 5) FKTP memberikan layanan kunjungan pasca bersalin pada ibu bukan PDP atau tidak terkonfirmasi COVID-19:
 - Pemeriksaan pada ibu nifas (sesuai SOP)
 - Asuhan neonatal (sesuai Pedoman)
 - Konseling menyusui (sesuai Pedoman)
 - Edukasi hidup bersih dan sehat, termasuk tanda bahaya pneumonia dan balita sakit
- d. Layanan Paska Bersalin di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)
- 1) FKRTL memberikan pelayanan KB (diutamakan metode kontrasepsi jangka panjang) segera setelah persalinan. Jika ibu tidak bersedia, maka dilakukan konseling KB serta nasihat untuk mendapatkan layanan KB paska bersalin.
 - 2) Bayi yang dilahirkan dari ibu yang bukan ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID19 pada 0-6 jam pertama, tetap mendapatkan: perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, injeksi vitamin K1, pemberian salep/tetes mata antibiotic, imunisasi Hepatitis B dan pemberian Hblg (Hepatitis B immunoglobulin)
 - 3) Bayi yang dilahirkan dari ibu ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID19:
 - Tidak dilakukan penundaan penjepitan tali pusat (delayed chord clamping)

- Bayi dikeringkan seperti biasa, dan segera dimandikan setelah kondisi stabil, tidak menunggu 24 jam.
 - Tidak dilakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- 4) Ibu dengan HBsAg reaktif dan terkonfirmasi COVID-19:
- a) Jika kondisi klinis bayi baik (bugar), maka imunisasi Hepatitis B tetap diberikan.
 - b) Jika kondisi klinis bayi tidak bugar atau tampak sakit, imunisasi Hepatitis B ditunda.
- 5) Bayi baru lahir dari ibu terkonfirmasi COVID-19 atau ibu dengan status PDP termasuk dalam kriteria Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan dirawat sesuai rekomendasi IDAI:
- a) Bayi Baru Lahir harus diperiksa COVID-19 (swab dan periksa darah) pada hari ke-1, ke-2 dan ke-14.
 - b) Bayi dirawat gabung jika ibu status ODP, tidak dirawat gabung jika status ibu PDP atau terkonfirmasi COVID-19
 - c) Jika ibu harus isolasi, maka dilakukan konseling untuk isolasi terpisah antar ibu dan bayinya selama 14 hari sesuai batas risiko transmisi. Pemisahan sementara bertujuan untuk mengurangi kontak antara ibu dan bayi.
 - d) Bila setelah mendapatkan konseling, ibu tetap berkeinginan untuk merawat bayi sendiri:
 - Persiapan harus dilakukan dengan memberikan informasi lengkap dan potensi risiko terhadap bayi.
 - Ibu dan bayi diisolasi dalam satu kamar dengan fasilitas ensuite selama dirawat di rumah sakit,
 - Bayi harus ditempatkan di inkubator tertutup di dalam ruangan.
 - Ibu disarankan untuk mengenakan APD yang sesuai dengan pedoman PPI dan diajarkan mengenai etika batuk dari ruangan
 - Bayi harus dikeluarkan sementara jika ada prosedur yang menghasilkan aerosol yang harus dilakukan di dalam ruangan
 - e) Tenaga kesehatan mengambil sampel skrining hipotiroid kongenital (SHK) pada bayi yang dilakukan setelah 24 jam persalinan, sebelum ibu dan bayi pulang dari fasilitas kesehatan. Tenaga Kesehatan menggunakan APD sesuai status bayi.

- f) Ibu dan keluarga mendapat nasihat dan edukasi tentang perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif, tanda bahaya jika ada penyulit pada bayi baru lahir serta anjuran membaca buku KIA dan nasihat untuk segera ke RS jika ada keluhan atau tanda bahaya.

e. Telemedicine

Dinas Kesehatan Kab/Kota diharapkan memfasilitasi penggunaan teknologi untuk menggantikan pelayanan rutin melalui tatap muka. Teknologi komunikasi yang dipergunakan dapat berupa call center khusus layanan KIA, SMS dan WA atau aplikasi telemedicine. Penggunaan teknologi dilakukan dengan memandang kesiapan daerah, penerimaan dan literasi masyarakat. Telemedicine ini dapat dimanfaatkan untuk :

- 1) Edukasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui
- 2) Penilaian mandiri adanya faktor risiko pada ibu hamil
- 3) Penilaian mandiri status kesehatan dan mengenali tanda bahaya adanya penyulit kehamilan, penyulit persalinan dan penyulit bayi baru lahir
- 4) Penilaian mandiri status COVID-19
- 5) Konsultasi kehamilan, persiapan persalinan, masa nifas dan perawatan bayi baru lahir untuk melengkapi kunjungan untuk ANC, kunjungan neonatal dan kunjungan nifas
- 6) Akses Ante Natal Care (ANC), Post Natal Care (PNC), layanan Keluarga Berencana (KB) dan membuat perjanjian untuk bertemu tenaga kesehatan
- 7) Peningat jadwal ANC, kunjungan neonatal dan nifas dan KB agar proses menyusui dapat berlanjut setelah ibu dan bayi disatukan.

f. Partisipasi Masyarakat

Peran Kader Kesehatan dan Kader Keluarga Berencana

- a) Kader (bersama Bidan Desa dan atau Puskesmas) memetakan jumlah ibu hamil, jumlah ibu hamil dengan faktor risiko, jumlah ibu hamil dengan dugaan COVID19, jumlah ibu hamil yang akan membutuhkan pelayanan paska persalinan, jumlah bayi baru lahir, jumlah balita dan jumlah bumil.
- b) Kader (bersama Bidan Desa dan atau Puskesmas) berkoordinasi dengan satuan tugas COVID19 tingkat desa/RW/RT juga mendata bumil yang baru “mudik” dari wilayah transmisi lokal/red zone sepe Jabodetabek, Jika ADA maka:
 - (1) Laporkan kepada Puskesmas untuk dilakukan skrining

- (2) Motivasi dan memberikan panduan ISOLASI MANDIRI di RUMAH selama 14 hari atau di Fasilitas Khusus untuk ISOLASI yang disediakan oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Swadaya Masyarakat atau di RS Darurat. Untuk daerah yang menetapkan status ODP untuk pendatang/pemudik, maka mengikuti anjuran untuk isolasi dan testing
 - (3) Edukasi untuk memantau status kesehatan secara mandiri. Jika memungkinkan bekali dengan termometer (beserta panduan cara menggunakannya) untuk mengukur suhu badan dua kali sehari, dan melaporkan kepada kader kesehatan/bidan desa dengan menggunakan pesan melalui SMS, WA atau cara lain yang tidak memerlukan kontak fisik/tatap muka.
 - (4) Bila semula tidak memiliki gejala dan tidak ada riwayat kontak erat dengan penderita COVID maka disarankan untuk segera berkonsultasi dengan bidan desa atau tenaga kesehatan puskesmas jika pada saat isolasi mandiri kemudian ada gejala infeksi COVID batuk, pilek, sesak).
 - (5) Bila diduga terinfeksi COVID--19 (ODP) atau PDP dengan gejala ringan, maka: (puskesmas/bidan desa melakukan pemeriksaan rapid test atau rujuk ke fasilitas layanan kesehatan/laboratorium yang telah ditunjuk untuk pengambilan apus selaput mukosa hidung dan tenggorok RTPCR, Bila keadaannya memburuk (demam tinggi atau kesulitan bernafas) atau ada gejala/tanda penyulit kehamilan atau ada tanda kegawatan janin (gerak janin berkurang), segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan puskesmas atau bidan desa untuk persiapan rujukan.
- c) Kader (bersama Bidan Desa atau Puskesmas) melakukan kampanye masif jaga jarak, jangan berkerumun, cuci tangan pakai sabun dan pakai masker. Bersama anggota masyarakat lainnya memastikan kepatuhan semua ibu hamil atas pesan tersebut. Kampanye dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi dan digital sehingga tidak melanggar prinsip physical distancing dan social distancing.
 - d) Kader (bersama Bidan Desa dan atau Puskesmas) mengumpulkan data dasar dan melaporkan secara berjenjang ke Puskesmas,

Dinkes Kab/Kota dan Provinsi. Update data dilakukan secara harian. Bila melakukan kunjungan, maka bidan desa dan kader wajib menggunakan masker serta tetap berpedoman pada prinsip hand hygiene dan physical distancing.

g. Edukasi

- 1) Jika terdapat tanda setanda kedaruratan ibu nifas dan bayi baru lahir, segera ke RS atau tenaga kesehatan terdekat atau hubungi call center 119 ext 9 atau hotline yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Melakukan pemeriksaan paska bersalin sebanyak 4 kali. Kunjungan pertama disarankan dilakukan di fasilitas layanan Kesehatan untuk pemeriksaan nifas dan neonatal. Pemeriksaan berikutnya melalui kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan atau memanfaatkan teknologi komunikasi:
KF 1: 6 (enam) jam sampai dengan 2 (hari) pasca persalinan
KF 2: 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari pasca persalinan; (
KF 3 8 (delapan) hari sampai dengan 28 (dua puluh pasca persalinan
KF 4: 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan 42 (empat puluh hari pasca persalinan.
- 3) Mendapatkan pelayanan KB sesuai jadwal yang diawali dengan perjanjian bertemu dengan petugas. Jika ibu menyusui dengan status terkonfirmasi positif COVID19 atau didiagnosa sebagai PDP, maka dokter harus melakukan komunikasi risiko:
 - a) Ibu diberikan konseling tentang menyusui dan manfaat bagi ibu dan bayi.
 - b) Ibu dijelaskan risiko utama yang dihadapi bayi menyusu adalah kontak dekat dengan ibu, yang cenderung terjadi penularan melalui percikan ludah (droplet).
 - c) Ibu dijelaskan bahwa nasihat klinis dapat berubah sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.
 - d) Untuk ibu yang ingin tetap menyusui, tindakan pencegahan harus diambil untuk membatasi penyebaran virus ke bayi:
 - Mencuci tangan sebelum menyentuh bayi dan payudara. Mengenakan masker selama menyusui.
 - Membersihkan pompa ASI segera setelah penggunaan.
 - Pertimbangkan untuk meminta bantuan seseorang dengan kondisi yang sehat untuk memberikan ASI.
 - Ibu harus didorong untuk memerah ASI (manual atau elektrik), sehingga bayi dapat menerima manfaat ASI dan untuk menjaga persediaan ASI.

9. Dampak Tidak melakukan Kunjungan Nifas

Komplikasi pada masa nifas yang tidak terdeteksi dengan segera salah satu penyebabnya adalah tidak melakukan Kunjungan masa Nifas (Achyar & Rofiqoh, 2016). Dampak tidak melakukan kunjungan nifas bisa terjadi komplikasi pada masa nifas atau komplikasi yang tidak terkontrol oleh tenaga kesehatan. Jika semakin jauh jarak antar ibu dengan tenaga kesehatan untuk tidak melakukan kunjungan nifas maka kemungkinan besar akan terjadi komplikasi yang tidak tertangani dengan baik sehingga bisa menyebabkan kematian pada ibu. Oleh karena itu, kunjungan nifas sangat penting dilakukan untuk memantau atau memberikan pengawasan secara komprehensif kepada ibu dan bayi selama masa pemulihan (Bidan & Dosen Kebidanan, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Ai Yeyeh Rukiyah, L. Y. (2018a). *Buku Saku: Asuhan Kebidanan Pada Ibu Masa Nifas: Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Trans Info Media (TIM).
- Ai Yeyeh Rukiyah, L. Y. (2018b). *Buku Saku: Asuhan Kebidanan Pada Ibu Masa Nifas: Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Trans Info Media (TIM).
- Anis, Wahyul; Amalia, R. B. (2021). The Effects of Telehealth During Pregnancy on Maternal Knowledge and Postpartum Mental Health in the Covid-19 Pandemic. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 15(4), 8.
- EKA PUSPITA SARI, K. D. R. (2014). *ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS (POSTNATAL CARE)*. CV TRANS INFO MEDIA.
- Hidayati, Y., & Sulistyoningtyas, S. (2017). Hubungan Usia dan Jenis Persalinan dengan Kejadian Postpartum Blues pada Ibu Post Partum di Wilayah Puskesmas Jetis II Kabupaten Bantul. *Universitas Aisyiyah Yogyakarta*.
- Islami, -, & Aisyaroh, N. (2012). Efektifitas Kunjungan Nifas Terhadap Pengurangan Ketidaknyamanan Fisik Yang Terjadi Pada Ibu Selama Masa Nifas. *Jurnal Kebidanan*, 1–13.
- Kemenkes. (2020). Pedoman Bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas Dan Bayi Baru Lahir. *Pedoman Bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas Dan Bayi Baru Lahir Selama Covid-19*, 8–9.
- KEMENKES RI. (2021). Profil Kesehatan Indonesia 2020. In *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*.
<https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia-Tahun-2020.pdf>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, & United Nations International Children's Emergency Fund. (2020). Laporan Kajian Cepat Kesehatan : Memastikan Keberlangsungan Layanan Kesehatan Esensial Anak dan Ibu di Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Kemenkes Dan Unicef*, 1–8.
<https://covid19.go.id/artikel/2020/07/24/laporan-kajian-cepat-kesehatan>
- Nurpelita. (2017). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas buatan II Siak*. 7941, 7941.
- Pandey S, Shekhar K, Regev A, S. A. (2019). Comprehensive Identification and Spatial Mapping of Habenular Neuronal Types Using Single-Cell RNA-Seq. *Pubmed Central*, 28(7). <https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.02.040>
- Rosita, M. (2018). Hubungan Antara Pendidikan, Usia Dan Paritas Ibu Nifas Dengan Kunjunganmasa Nifas Di Bidan Praktik Mandiri Suryati Palembang Tahun 2017. *Jurnal 'Aisyiyah Medika*, 1(1). <https://doi.org/10.36729/jam.v1i1.414>
- Situmorang, M. H., & Pujiyanto, P. (2021). Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Nifas Lengkap di Indonesia: Analisis Lanjut Data Riskesdas 2018.

JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat, 13(2), 78–86. <https://doi.org/10.52022/jikm.v13i2.179>

Wolio, I. A. (2017). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUNJUNGAN MASA NIFAS PADA IBU YANG MEMILIKI BAYI USIA 2-12 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS NAMBO KOTA KENDARI TAHUN 2017 SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Pendidikan Studi Diploma IV Kebidanan.*

World Health Organization. (2015). Postnatal Care for Mothers and Newborns: Highlights from the World Health Organization 2013 Guidelines. *Postnatal Care Guidelines*, March, 1–8. https://www.who.int/maternal_child_adolescent/publications/WHO-MCA-PNC-2014-Bri

BAB 10

MASALAH MENYUSUI PADA BAYI

Ismiati, S.ST., M.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 10

MASALAH MENYUSUI PADA BAYI

Ismiati, S.ST., M.Keb

Masalah umum setelah melahirkan ialah masalah menyusui. Umumnya persoalan yang paling sering ditemui ibu setelah melahirkan adalah ASI tidak keluar atau tidak lancar. ASI sangat penting buat bbl/ bayi baru lahir. Air Susu Ibu juga menjadi makanan yang paling baik bayi karena mengandung nutrisi dan baik buat sistem pencernaan dan sistem kekebalan tubuh, perkembangan fisik dan psikis, serta terjalin hubungan yang erat antara ibu dan bayi. Bayi baru lahir yang diberi ASI dapat terlindungi dari efek gangguan efektif dan gangguan fisiologis akibat ibu postpartum yang mengalami depresi. Pemberian ASI juga memberikan dampak positif bagi kesehatan ibu hamil, keluarga dan masyarakat melalui manfaat gizi, kekebalan, perkembangan, psikologi, sosial ekonomi dan lingkungan. Melindungi, mempromosikan dan mendukung ibu menyusui merupakan prioritas dari semua rencana kesehatan masyarakat nasional (Juanita, 2016)

Persoalan menyusui yang seringkali terjadi bisa ditimbulkan oleh bendungan ASI, puting yang tak menonjol, teknik menyusui yang tidak tepat, pembengkakan payudara, lecet, dan mastitis. Faktor keberhasilan ibu hamil untuk menyusui pada masa nifas ialah perawatan payudara selama kehamilan. Masalah menyusui merupakan masalah umum yang mungkin terjadi pada masa nifas awal. Hasil uji multivariat ditemukan bahwa ibu dengan masalah menyusui 39 kali lebih mungkin menderita depresi pascapersalinan dibandingkan ibu tanpa persoalan menyusui. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa menyusui berdampak pada psikologi ibu postpartum (Sukma, 2020).

Masalah menyusui tidak hanya terjadi pada ibu melainkan juga terjadi pada bayi. Kegagalan dalam proses menyusui, dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi, terbentuknya antibodi yang penting untuk perkembangan mikrobiota usus dan system kekebalan tubuh (Ariestanti, Y., & Widayati, T., 2018). Adapun masalah menyusui pada bayi yaitu:

1. Bayi Sering Tertidur Saat Menyusui

Persoalan pemberian ASI eksklusif yang pertama merupakan bayi seringkali tertidur saat menyusui. saat sedang menyusui bayi memejamkan mata artinya hal yang sangat wajar terjadi, terutama pada bayi yang baru berusia beberapa minggu atau hitungan bulan. Frekuensi tidur bayi memang cukup tinggi, tetapi Jika terlalu sering terjadi sampai bayi berusia 1 bulan atau lebih mampu menjadi masalah serius. Bayi kemungkinan akan kekurangan nutrisi yang membahayakan kondisi kesehatannya, seperti malnutrisi sampai penyakit jantung.

2. Bayi sering menangis atau rewel

Menangis ialah cara bayi berkomunikasi dengan dunia sekitarnya. Bayi yang tak jarang menangis tidak selalu karena kekurangan ASI, terdapat banyak penyebab yang bisa mengakibatkan bayi menangis yaitu Bayi menangis bisa karena bayi merasa tidak aman, ingin dipeluk serta ditemani ibu, bayi sakit sebagai akibatnya merasa tak nyaman serta bayi lapar atau haus, bayi mengompol. Bila lapar atau haus usahakan ibu segera menyusui, namun tetap memperhatikan posisi serta perlekatan yang benar agar bayi dapat menyusu dengan nyaman sampai kenyang. adapun tujuan tangisan bayi adalah buat menarik perhatian orang lain (terutama ibu) karena suatu hal termasuk rasa lapar, keinginan buat digendong, dan lain sebagainya.

Merasa ASI tak cukup yang ditandai menggunakan bayi rewel. adanya pemahaman bahwa bayi rewel dikarenakan lapar sebagai akibatnya membutuhkan makanan atau minuman tambahan, ibu beranggapan bahwa anugerah makanan kurang dari 6 bulan tergantung pada sistem pencernaan bayinya. dikarenakan bayi rewel walaupun telah disusui. sehingga ibu berpikir bayinya lapar lalu menetapkan buat menyampaikan makanan atau minuman selain ASI untuk memenuhi kebutuhan gizi anaknya serta ibu merasa produksi ASI berkurang waktu ibu kurang mengkonsumsi sayur-sayuran. apabila bayi rewel dan sistem pencernaannya tak bermasalah maka ibu memutuskan untuk menyampaikan makanan pendamping ASI. Sebagian besar ibu yang gagal memberikan ASI eksklusif menyatakan mendapatkan anjuran dari keluarga buat memberikan makanan atau minuman selain ASI serta mendukung keputusan ibu buat memberikan kuliner atau minuman selain ASI di saat usia < 6 bulan.

Hal ini terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan keluarga ibu tentang ASI eksklusif serta adanya pemahaman dari keluarga ibu baik ibu kandung, mertua, bibi ataupun suami Bila bayi rewel maka bayi tersebut merasa lapar sebagai akibatnya diperlukan makanan atau minuman tambahan selain ASI untuk memenuhi kebutuhan bayi. Selain itu ada beberapa ibu yang terpengaruh karena lingkungan ibu itu sendiri (Yulianah dkk, 2022).

Perhatikan sebab bayi menangis, jangan abaikan bayi menangis terlalu lama, puaskan menyusu. Keadaan menangis pada bayi tidak selalu ditimbulkan karena kekurangan ASI, banyak penyebab yang bisa membentuk bayi menangis. syarat yang dapat menyebabkan bayi menangis ialah

- Bayi merasa tidak nyaman karena BAK / BAB,
- Bayi merasa sakit
- Bayi kurang gizi
- kedinginan dan

- Bayi lapar atau haus, ketika lapar serta haus pastikan posisi dan perlekatan yang benar, sehingga bayi bisa menyusui sampai kenyang (Fadilah, 2015) Tindakan ibu: ibu tidak perlu cemas, sebab akan merusak proses laktasi, perbaiki posisi menyusui, periksa pakaian bayi: apakah basah, jangan abaikan bayi menangis terlalu lama .

3. Bayi bingung puting (*nipple confusion*)

Kondisi ini tidak akan terjadi jika ibu konsisten dan terjadwal menyusui bayinya. Bayi bingung putting ditimbulkan adanya pemberian ASI serta MP-ASI dini menggunakan botol dan bergantian menggunakan menyusui pada ibunya. Kadang ibu menyusui bayinya serta kadang juga bayi diberikan susu formula dengan memakai dot botol. Penggunaan dot botol mengakibatkan refleks hisap bayi berkurang. sebab dot ini akan membentuk bayi pasif dalam menghisap (Sulikah et al., 2022). Bayi yang menyusui ke ibunya diharapkan refleks isap yang aktif/kuat. indikasi bayi bingung putting merupakan waktu menyusui ke ibunya bayi akan menghisap di dot botol, menghisap payudara ibu sering berhenti terputus serta sebentar-sebentar, kadang akhirnya bayi menolak buat menyusui di ibu. Jangan mudah memberikan PASI, hadiah minuman serta makanan selain ASI sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan (bukan ASI eksklusif), menyebabkan gangguan pencernaan pada bayi yang bisa menyebabkan bayi sakit perut serta diare atau mencret. Bila bayi sakit, akan kurang mendapat asupan makanan yang bergizi (Kartika & Adriani, 2013). ibu yang memberikan ASI pada bayi, jangan sampai memberikan susu menggunakan dot botol, pergunakan sendok, cawan atau pipet, Bila terpaksa memberikan ASI yang diperas (Fadilah, 2015).

4. Bayi premature

Menyusui eksklusif adalah proses pemberian air susu ibu (ASI) kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan . Namun, sering ibu - ibu tidak berhasil menyusui atau menghentikan menyusui lebih dini karena ibu yang melahirkan bayi premature yang daya hisap dan menelan pada bayi prematur juga belum baik sehingga bayi mengalami kesulitan menyusui dan kondisi ini dapat membuat ibu stress. Kondisi kejiwaan ibu yang stress penuh tekanan akan menentukan produksi air susu, hormon oksitosin tidak akan bekerja dan ASI akan tetap tersimpan dalam payudara dan tidak mengalir yang membuat ibu tidak semangat memberikan ASI kepada bayinya sehingga ibu mulai berpikir untuk beralih menggunakan susu formula agar dapat memenuhi kebutuhan bayinya (Putri and Mufdlilah, 2022).

Prematuritas merupakan penyebab utama dari kematian neonatal 30% di dunia karena komplikasi kelahiran premature, diperkirakan satu juta anak meninggal setiap tahunnya. Masalah yang dapat terjadi akibat dari kelahiran prematur yaitu kesulitan bayi dalam beradaptasi dengan kehidupan diluar rahim, kurangnya refleks menelan dan ketidakefektifan hisapan bayi pada payudara yang

disebabkan karena belum matangnya sistem organ tubuh (Sulistiarini and Berliana, 2016).

Susui dengan sering, walau pendek-pendek, rangsang dengan sentuh langit-langit bayi dengan jari ibu yang bersih, jika tidak dapat menghisap berikan dengan pipa nasogastrik, tangan, dan sendok.

Uraian sesuai dengan umur bayi :

- a. Bayi umur kehamilan < 30 mgg : BBL < 1250 gr.
Biasanya diberi cairan infus selama 24-48 jam. Lalu diberikan ASI menggunakan pipa nasogastric
- b. Usia 30-32 mgg : BBL 1250 – 1500 gram.
Dapat menerima ASI dari sendok, 2 kali sehari, namun masih menerima makanan lewat pipa, namun lama kelamaan makanan pipa makin berkurang dan ASI ditingkatkan.
- c. Usia 32-34 mgg : BBL 1500-1800 gram.
Bayi mulai menyusui langsung dari payudara namun perlu sabar.
- d. Usia > 34 mgg: BBL > 1800 gram.
Mendapatkan semua kebutuhan dari payudara.

5. Bayi kuning

Menyusui tidak efektif merupakan suatu kondisi dimana ibu dan bayi mengalami ketidakpuasan atau kesulitan pada saat menyusui. Dampak dari menyusui tidak efektif bagi bayi akan mempengaruhi pertumbuhan bayi dan menyebabkan ikterus (Tika Setiani & Haryani, 2022). Pencegahan : segera menyusui setelah lahir, dan jangan dibatasi atau susui sesering mungkin. Berikan bayi kolustrum, karena kolostrum adalah cairan kental dapat pula encer yang berwarna kekuningan yang diberikan pertama pada bayi yang mengandung sel hidup menyerupai sel darah putih yang dapat membunuh kuman dan bakteri penyakit. Kolostrum di ekskresikan oleh kelenjar dari hari pertama sampai hari ke empat (Tauho, 2022) . kolustrum mengandung purgatif ringan, yang membantu bayi untuk mengeluarkan mekonium. Bilirubin dikeluarkan melalui feses, jadi kolustrum berfungsi mencegah dan menghilangkan bayi kuning.

6. Bayi kembar

Ibu optimis ASI nya cukup, susui menggunakan football position, susui di payudara dengan bergantian untuk variasi bayi, dan kemampuan menghisap mungkin tidak selaras. Menyusui bayi kembar membutuhkan lebih banyak kerja serta dedikasi daripada menyusui bayi tunggal. Melahirkan bayi kembar menuntut fisik serta mental bagi ibu, dibandingkan dengan kelahiran bayi tunggal, serta banyak hambatan buat menyusui, Maka dari itu perlunya dukungan dan pendidikan tentang menyusui bayi kembar berasal pelayanan kesehatan (Kim, 2017).

Dukungan bagi ibu yang menyusui tidak hanya dari tenaga kesehatan melainkan pula dukungan dari keluarga. Dukungan keluarga (suami) yang paling

utama mempengaruhi menyusui. Dukungan tenaga kesehatan contohnya memberikan motivasi dengan adanya KIE (komunikasi, informasi serta edukasi) yang baik, kenyamanan fisik dan psikologis memberikan perhatian pada ibu (Windari et al., 2017). Pengalaman dari ibu yang menyusui bayi kembar berbeda beda, sebagai akibatnya perlu di kaji permasalahan dari tiap ibu yang mempunyai bayi kembar. Sebagian besar, bayi kembar akan mendapatkan perawatan di rumah sakit, dan ini menyebabkan stres bagi ibu sehingga mengganggu kondisi fisik dan psikis ibu. Faktor kondisi ibu ini ialah salah satu faktor yang mensugesti keberhasilan menyusui bayi kembar (Barros et al., 2019).

Ibu yang melahirkan bayi kembar 90% lahir secara operasi caesar dan setengah lagi bayi prematur. perawat memberikan susu formula karena kekurangan ASI (Cinar et al., 2016; Mikami et al., 2017). Kurangnya rasa percaya diri, pengetahuan rendah dan pengalaman menjadi faktor yang sangat penting pada keberhasilan menyusui bayi kembar. dampak psikologis ibu yang menyusui bayi kembar yaitu ibu yang memiliki bayi kembar merupakan tantangan tersendiri dalam merawat bayi kembarnya. dimana ibu menangis ketika merawat anaknya serta merasa kelelahan, kurang istirahat, tak mampu mengurus diri ketika harus merawat serta menyusui bayi kembarnya, sehingga membuat emosi ibu menjadi tidak stabil (stres). Merawat bayi kembar membutuhkan waktu dan menghabiskan tenaga sehingga berpengaruh terhadap fisik serta emosional yang menyebabkan berkurangnya ASI dan menghentikan ASI (Cinar et al., 2016; Mikami et al., 2017).

Ibu yang memiliki bayi kembar pada umumnya mengalami stres daripada ibu yang memiliki bayi tunggal. Stres pada ibu bayi kembar berupa kesulitan dalam merawat, tidak mengetahui cara menyusui bayi kembar, dan merasa produksi ASI yang kurang. Padahal ibu yang menyusui bayi kembar, produksi ASI 2 kali lipat dari ibu yang menyusui bayi tunggal. Cara meningkatkan produksi air susu ibu yaitu dengan cara menyusui bayi kembar sesering mungkin dan ketika lahir melakukan inisiasi menyusui dini (IMD) skin to skin. Dukungan yang paling utama yaitu dukungan dari suami dan keluarga karena faktor pertama dalam memotivasi ibu untuk menyusui bayi kembarnya. Suami membantu dalam merawat bayi kembar dan selalu memotivasi ibu untuk menyusui bayi kembar. Dukungan dari tenaga kesehatan yaitu memberikan informasi tentang cara menyusui bayi kembar tetapi ada tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi karena menganjurkan dan memberi susu formula, padahal seharusnya ada *inform consent* sebelum melakukan tindakan. Ibu yang melahirkan bayi kembar sebagian besar melahirkan dengan operasi sesar dan sebagian ibu mengerti tentang pengetahuan menyusui bayi kembar tetapi ada juga yang tidak mengetahui cara menyusui bayi kembar (Tasripin & Fitriana, 2021).

7. Bayi Tersedak dan Cegukan

Produksi ASI setiap wanita dan kebutuhan bayi akan ASI berbeda-beda. Ada produksi ASI yang lebih banyak dari yang dibutuhkan, tapi ada juga yang lebih sedikit dari kebutuhan bayi. Produksi ASI berlebih terkadang membuat mulut bayi cepat penuh oleh susu, sedangkan daya telan dan pernapasan Si Kecil masih belum teratur. Hal inilah yang sering menyebabkan bayi tersedak atau cegukan.

Menurut jurnal yang diterbitkan Bioessay, menelan banyak udara jadi salah satu penyebab bayi cegukan terus-menerus. Cobalah untuk mengganti posisi menyusui setiap 2-3 menit secara bergantian pada dua sisi payudara untuk membantu mengatur aliran air susu saat proses menyusui.

8. Bayi Suka Menggigit Puting

Salah satu persoalan yang termasuk juga dalam masalah pemberian ASI eksklusif yang timbul adalah kebiasaan bayi yang senang menggigit. Ketika bayi menggigit, umumnya ibu akan melakukan gerakan secara langsung dengan cara menarik puting keluar dari mulut bayi. Tapi hal ini justru akan membuat bayi lebih kuat menggigit. Cobalah untuk mendorong payudara secara lembut ke arah mulut bayi hingga menutupi lubang hidungnya, ia akan berusaha membuka mulut dan menarik kepalanya untuk menghirup udara.

9. Bayi Muntah Setelah Minum ASI

Banyak bayi yang mengeluarkan cairan dari dalam mulut setelah minum susu, entah banyak atau sedikit. keluarnya muntahan tersebut hanya menandakan bahwa bayi sudah cukup kenyang dan ia bersendawa sambil mengeluarkan cairan yang kadang diartikan dengan muntahan. Untuk mengatasi hal ini, cukup menyediakan sapu tangan saat menyusui. Tetapi jika bayi muntah dan ekspresi wajahnya mirip orang yang kesakitan atau lemas setelah mengonsumsi ASI eksklusif, segera konsultasikan kesehatannya pada dokter.

10. Bayi sakit

Tidak ada alasan untuk menghentikan pemberian ASI. Untuk bayi tertentu seperti diare justru membutuhkan lebih banyak ASI untuk rehidrasi. Yakinkan ibu bahwa alam telah menyiapkan air susu bagi semua makhluk, sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu semua ibu sebenarnya sanggup menyusui bayi kembar.

11. Bayi sumbing

Bayi tidak akan mengalami kesulitan menyusui, cukup dengan berikan posisi yang sesuai, untuk sumbing *pallatum molle* (langit-langit lunak), dan *pallatum durum* (langit-langit keras) Manfaat menyusui bagi bayi sumbing: melatih kekuatan otot rahang dan lidah, memperbaiki perkembangan bicara, mengurangi resiko terjadinya otitis media. Untuk bayi dengan palatoskisis (celah pada langit-langit): Menyusui dengan posisi duduk, putting dan areola pegang saat menyusui,

ibu jari ibu digunakan sebagai penyumbat lubang, kalau mengalami labiopalatoskisis, berikan ASI dengan sendok, pipet, dot panjang.

12. Bayi dengan lidah pendek (Lingual Frenulum)

Keadaan ini jarang terjadi, dimana bayi mempunyai jaringan ikat penghubung lidah dan dasar mulut yang tebal dan kaku, sehingga membatasi gerak lidah, dan bayi tidak dapat menjulurkan lidah untuk menangkap puting.

Cara menyusui : Ibu membantu dengan menahan kedua bibir bayi segera setelah bayi dapat menangkap puting dan areola dengan benar.

13. Bayi yang memerlukan perawatan

Ibu ikut dirawat supaya pemberian ASI bisa dilanjutkan. Seandainya tidak memungkinkan, ibu dianjurkan untuk memerah ASI setiap 3 jam dan disimpan didalam lemari untuk kemudian sehari sekali diantar kerumah sakit. Perlu ditandai pada botol waktu ASI tersebut ditampung, sehingga dapat diberikan sesuai jam nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariestanti, Y., & Widayati, T. (2018). Peningkatan Pengetahuan Ibu Tentang ASI Eksklusif di Pondok Melati Bekasi. In *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS)* (Vol. 2, Issue 1, pp. 67–71)
- Barros da Silva, R., Barbieri-Figueiredo, M. do C. and Van Riper, M. (2019) 'Breastfeeding Experiences of Mothers of Children with Down Syndrome', *Comprehensive Child and Adolescent Nursing*. Taylor & Francis, 42(4), pp. 250–264. doi: 10.1080/24694193.2018.1496493.
- Cinar, N. et al. (2016a) 'Mothers' Attitudes Toward Feeding Twin Babies in the First Six Months of Life: A Sample From Sakarya, Turkey', *Iranian Journal of Pediatrics*, 26(5). doi: 10.5812/ijp.5413.
- Fadilah, N.A., 2015. PENGARUH HYPNO-BREASTFEEDING TERHADAP KELANCARAN PRODUKSI ASI PADA IBU POST PARTUM YANG MENYUSUI DI RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA SURABAYA (undergraduate). Universitas Muhammadiyah Gresik. <https://doi.org/10/Lembar%20Pengesahan.pdf>
- Haryono, S. S. (2014). *Manfaat ASI Eksklusif Untuk Buah Hati*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Juanita, F. (2016). Peningkatan Durasi Pemberian ASI Pada Ibu Post Partum Melalui Relaksasi Autogenic Training. 19(1), 24–32.
- Kartika & Adriani, 2013. POLA ASUH MAKAN PADA BALITA DENGAN STATUS GIZI KURANG DI JAWA TIMUR, JAWA TENGAH DAN KALIMANTAN TENGAH, TAHUN 2011. <https://core.ac.uk/download/pdf/225509337.pdf>
- Kim, B. Y. (2017) 'Factors that influence early breastfeeding of singletons and twins in Korea: A retrospective study', *International Breastfeeding Journal*. BioMed Central Ltd., 12(1). doi: 10.1186/s13006-016-0094-5.
- Mikami, F. C. F. et al. (2017) 'Effect of Prenatal Counseling on Breastfeeding Rates in Mothers of Twins', *JOGNN - Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing*. Elsevier B.V., 46(2), pp. 229–237. doi: 10.1016/j.jogn.2016.10.005.
- Putri, M.D.Y., Mufdlilah, M., 2022. PEMBERIAN ASI PADA BAYI DENGAN KELAHIRAN PREMATURE. *Journal of Midwifery and Reproduction* 5, 104–111. <https://doi.org/10.35747/jmr.v5i2.847>
- Sulikah, Peni, T., Dwi Wahyuningsih, B., 2022. HUBUNGAN PERSEPSI IBU MENYUSUI DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI DI KLINIK HJ. TARPANIE PRAMBON - SIDOARJO (Thesis). Perpustakaan Universitas Bina Sehat.

- Sulistiarini, D., Berliana, S.M., 2014. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kelahiran Prematur di Indonesia: Analisis Data Riskesdas 2013. *E-Journal Widya Kesehatan dan Lingkungan* 1, 36815.
- Sukma, F. (2020). Masalah Menyusui sebagai Determinan Terjadinya Risiko Depresi Postpartum pada Ibu Nifas Normal. 2(3), 121–131.
- Tasripin & Fitriana, 2021. PENGALAMAN IBU MENYUSUI BAYI KEMBAR: SCOPING REVIEW. *Jurnal Ilmu Kesehatan*. Vol. 10 (1).1-7
- Tauho K D, dkk., 2022. Modul Pelatihan Asuhan Laktasi. CV Feniks Muda Sejahtera. Hal 10-12.
- Tika Setiani, & Haryani, S. (2022). Pengelolaan Menyusui Tidak Efektif pada Post Partum Spontan Indikasi Ketuban Pecah Dini. In *Journal of Holistics and Health Science* (Vol. 4, Issue 1, pp. 123–130). <https://doi.org/10.35473/jhhs.v4i1.109>
- Yulianah, S.Y., Safitri, D. E., Maulida, N.R., 2022. Studi Kasus: Kegagalan Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi di Wilayah Puskesmas Banjarsari, Lebak. *Gorontalo Journal Of Nutrition Dietetic*. Vol.2(1), 10-21.

BAB 11

KEBUTUHAN DASAR MASA NIFAS

Annesya Atma Battya, S. Sos., S.Tr.Keb.,M.Tr.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Kebutuhan dasar masa nifas amat penting bagi Ibu yang baru saja melahirkan agar tercukupi sehingga tidak merasa kekurangan baik untuk ibu maupun bayinya. Kebutuhan ini harus terpenuhi, siapa yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ibu nifas? Suami dan keluarga ibu yang harus memberikan semua kebutuhan ibu dapat tercukupi. Secara teori, masa nifas dibutuhkan waktu selama 6-8 minggu untuk mengembalikan seluruh organ tubuh khususnya alat reproduksi Wanita, maka perlu proses dalam pengembalian kesehatan ibu yang baru saja melahirkan. Beberapa kebutuhan dasar ibu nifas diantaranya:

A. Kebutuhan Gizi

Ibu nifas membutuhkan gizi seimbang agar kesehatan ibu dan bayinya lebih optimal. Kualitas gizi yang dibutuhkan ibu nifas untuk menambah jumlah produksi ASI akan meningkat karena bayi membutuhkan nutrisi dan cairan untuk menyehatkan tubuhnya. Menu makanan gizi seimbang yang dibutuhkan ibu nifas harus mengandung sumber energi, sumber pembangun serta sumber pengatur dan pelindung.

1. Sumber Tenaga (Energi)

Ibu nifas membutuhkan tenaga untuk dapat merawat dan menyusui bayinya dengan baik, maka perlu penambahan kalori. Besaran energi yang dibutuhkan ibu adalah 700 kkal/hari. Jika sumber tenaga berkurang maka protein akan dijadikan cadangan untuk memenuhi kebutuhan energi. (Nurjanah,S.N.,Maemunah,A.S.,Badriah,D.L, 2013). Bahan makanan yang termasuk dalam sumber tenaga adalah beras, sagu, jagung, tepung terigu, kentang dan ubi-ubian.

2. Sumber Pembangun (Protein)

Protein sangat dibutuhkan ibu nifas untuk pertumbuhan dan penggantian sel-sel yang rusak atau mati. Besaran protein yang dibutuhkan adalah 20gram/hari. Sumber protein dapat dibagi menjadi 2 yaitu, protein nabati dan protein hewani. Bahan makanan yang termasuk kedalam protein nabati adalah Kacang-kacangan, tahu dan tempe. Sedangkan yang termasuk dalam protein hewani adalah ikan, udang, daging, hati, telur, susu, keju. (Nurjanah,S.N.,Maemunah,A.S.,Badriah,D.L, 2013)

3. Sumber Pengatur dan Pelindung

Ibu nifas juga membutuhkan sumber pengatur dan pelindung yang digunakan untuk melindungi tubuh agar metabolisme dalam tubuh menjadi lancar. Yang

termasuk sumber pengatur dan pelindung adalah mineral, vitamin dan Air. (Nurjanah,S.N.,Maemunah,A.S.,Badriah,D.L, 2013)

- a. Mineral; jenis-jenis mineral yang penting untuk dikonsumsi, zat kapur berfungsi untuk pembentukan tulang, bersumber pada bahan makanan seperti susu, keju, kacang-kacangan, dan sayuran berwarna hijau. Fosfor dan kalsium berfungsi untuk pembentukan kerangka dan gigi anak, bersumber pada susu, keju dan daging. Zat besi berfungsi untuk sirkulasi darah dan sel serta menambah sel darah merah (Hemoglobin) bersumber pada makanan kuning telur, hati, daging, ikan, kacang-kacangan dan sayuran hijau. Yodium berfungsi untuk mencegah kelainan mental dan kekerdilan, bersumber pada minyak ikan, ikan laut, garam beryodium.
- b. Vitamin; Jenis-jenis vitamin yang dibutuhkan ibu nifas adalah Vitamin A, B1-B12, folic acid, vitamin C, D, dan K. Masing-masing vitamin mempunyai fungsi dan kegunaan sendiri, misalkan Vitamin A, berfungsi untuk pembentukan sel, jaringan, gigi dan tulang, perkembangan syaraf penglihatan, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Ibu nifas sangat dianjurkan untuk minum Vitamin A sesuai dosis yaitu berupa kapsul 200.000 IU. Vitamin juga banyak bersumber pada kuning telur,hati, mentega, susu, daging dan sayuran warna hijau. (Nurjanah,S.N.,Maemunah,A.S.,Badriah,D.L, 2013)
- c. Air; Kebutuhan air untuk ibu nifas adalah 3 liter air dalam sehari atau 8 gelas setiap hari. Air penting untuk dikonsumsi oleh ibu nifas, karena didalamnya mengandung molekul-molekul yang dibutuhkan tubuh dalam proses aliran ke jantung.

B. Ambulasi Dini

Ambulasi dini adalah melatih ibu untuk keluar dari tempat tidur dan dapat berjalan agar beraktivitas seperti semula. Aktivitas dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari Gerakan miring ke kanan, kekiri, atau duduk kemudian turun dari tempat tidur akhirnya berjalan. Menurut Dewi, dkk (2011), mengemukakan bahwa mobilisasi atau disebut juga Early Ambulation adalah kemampuan seseorang untuk berjalan bangkit, berdiri dan kembali ke tempat tidurnya dengan kemampuan menggerakkan ekstremitas dalam 24-48 jam postpartum. Mobilisasi dini penting dilakukan untuk mengembalikan otot-otot perut dan panggul kembali normal, dalam melakukan mobilisasi dini ibu akan merasa lebih kuat dan ini menyebabkan otot perutnya menjadi kuat sehingga mengurangi rasa sakit pada punggung. (Supingah, 2017).

Hal-hal yang perlu diperhatikan ibu terkait dengan ambulasi adalah: (Maritalia, 2014)

1. Ibu dapat melakukan gerakan secara perlahan namun bertahap, jika terlambat maka dapat menyebabkan gangguan fungsi organ, aliran darah atau fungsi otot lainnya;
2. Ibu melakukan mobilisasi dengan benar dan tepat sehingga pemulihan lebih cepat;
3. Jangan melakukan mobilisasi secara berlebihan karena dapat meningkatkan beban kerja jantung.

Adapun keuntungan ambulasi dini adalah Ibu nifas yang melakukan mobilisasi dini juga akan merasa lebih sehat dan kuat, dan memiliki kesempatan yang baik untuk mengajari merawat atau memelihara anaknya.

C. Eliminasi

Dalam kamus Bahasa Indonesia, arti dari eliminasi adalah pengeluaran, yang berarti dalam hal ini terkait dengan kesehatan adalah buang air besar maupun kecil. Ibu nifas harus sudah berkemih dalam waktu 6-8 jam, karena jika urine belum keluar maka dapat menghalangi uterus berkontraksi, oleh karena itu kandung kemih harus kosong. Dengan adanya kontraksi, mencegah terjadinya perdarahan postpartum. Namun ada beberapa ibu nifas yang mengalami kesulitan untuk berkemih karena adanya trauma persalinan atau rasa takut akan nyeri jika berkemih maupun buang air besar. (Maritalia, 2014).

Apabila ibu merasa kesulitan untuk buang air kecil maka perlu dilakukan tindakan dengan di rangsang dengan air mengalir, mengompres dengan air hangat diatas simpisis. Namun bila tindakan tersebut tidak berhasil maka lakukan kateterisasi. Ibu nifas perlu diberikan asupan cairan maupun makanan tinggi serat serta ambulasi secara teratur agar mudah untuk buang air kecil atau buang air besar. (Nurjanah,S.N.,Maemunah,A.S.,Badriah,D.L, 2013)

D. Perawatan Diri

Ibu nifas memerlukan perawatan diri setelah melahirkan, sehingga dapat mengurangi sumber infeksi dan meningkatkan perasaan nyaman dan tenang untuk penyembuhan luka perineum. Beberapa hal yang dapat dilakukan ibu dalam perawatan diri yaitu:

1. Mandi
Ibu harus mandi sehari 2 kali agar tubuh ibu nifas bersih dan wangi, mengganti pakaian serta alas tempat tidur dibersihkan dan sering diganti spreinya.
2. Menggosok gigi dan mulut
Ibu perlu sering menggosok gigi, setiap selesai makan pagi atau malam hari sebelum tidur, bisa ditambahkan saat mandi sore hari. Menjaga kebersihan

gigi dan mulut dapat menyebabkan gigi tidak terjadi karies gigi, tidak bau mulut.

3. Merawat Perineum

Merawat luka perineum bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi, memberikan rasa nyaman dan dapat mempercepat penyembuhan luka perineum. Masa nifas selama 40 hari, maka kebersihan vagina atau perineum harus tetap terjaga.

Beberapa alasan perlunya ibu nifas menjaga kebersihan vagina atau perineum: (Maritalia, 2014)

1. Terdapat cairan darah dan lender yang keluar dari vagina selama masa nifas;
2. Letak vagina berdekatan dengan lubang kencing dan anus, kedua saluran ini merupakan saluran pengeluaran yang mengandung mikroorganisme patogen;
3. Adanya luka daerah perineum sehingga bila tidak bersih akan menimbulkan infeksi;
4. Vagina adalah organ tubuh yang dapat dimasuki oleh mikroorganisme yang dapat menjalar ke Rahim.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan vagina pada masa nifas adalah: (Maritalia, 2014)

1. Setiap BAK atau BAB, siram vagina dengan air bersih , basuh dari arah depan ke belakang.
2. Cuci vagina dengan air sabun biasa atau antiseptik, jangan menggunakan cairan lainnya.
3. Jika luka perineum besar, maka upaya yang dilakukan untuk menjaga kebersihan dengan merendam vagina di dalam antiseptik selama 10 menit.
4. Mengganti pembalut setiap selesai membersihkan vagina sehingga mikroorganisme tidak ikut terbawa ke vagina.
5. Keringkan vagina dengan tisu, handuk kecil yang lembut setiap selesai membasuh vagina karena BAK atau BAB.
6. Bila membutuhkan salep antibiotik, maka daapt dioleskan sebelum memakai pembalut baru.

E. Istirahat

Ibu nifas membutuhkan istirahat yang cukup, berkualitas untuk dapat memulihkan keadaan fisiknya. Keluarga baik suami atau orang tua perlu memberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan untuk diri sendiri yaitu beristirahat, agar mempunyai persiapan energi untuk merawat bayinya. (Sulistyawati, 2009). Permasalahan yang timbul kurangnya istirahat pada ibu nifas

yaitu Faktor pertama yaitu gangguan pola tidur akibat merawat kedua anaknya yang masih bayi dan kecil, Faktor kedua yaitu gangguan pola tidur akibat merasa cemas karena ASI nya belum setelah melahirkan sampai hari kedua setelah melahirkan. Ketiga apabila ada masalah yang membuat pasien cemas dan khawatir menganjurkan pasien untuk mencari informasi pada keluarga atau teman-teman (Abdullah, 2017)

Pola tidur ibu nifas akan Kembali normal dalam 2-3 minggu setelah melahirkan, kebutuhan tidur rata-rata orang dewasa sekitar 7-8 jam. Beberapa hal yang dapat berakibat jika ibu nifas kekurangan istirahat: (Maritalia, 2014) (Sulistiyawati, 2009)

1. ASI akan berkurang;
2. Memperlambat proses involusi uterus dan meningkatkan perdarahan;
3. Menyebabkan depresi dan ketidakmampuan dalam merawat bayi dan dirinya sendiri.

Ibu nifas akan kembali pada kegiatan-kegiatan rumah tangga secara perlahan-lahan serta untuk tidur siang atau istirahat selagi kedua anaknya tidur, menganjurkan anak pertamanya untuk tidur dalam satu kamar untuk mempermudah pengawasan, meminta bantuan atau membagi tugas pada suami untuk membantu merawat anak-anaknya (Kumalasari, 2015).

F. Seksual

Penelitian menemukan 20% perempuan yang baru pertama kali melahirkan membutuhkan waktu 6 bulan untuk merasa nyaman secara fisik saat bersenggama, dengan waktu rata-rata sekitar 3 bulan. Peran barunya sebagai orang tua menimbulkan tekanan dan perlu adaptasi. Faktor psikologis, adat istiadat, keseimbangan hormon, adanya luka bekas episiotomy pada ibu postpartum, dan kurangnya informasi tentang seks setelah melahirkan merupakan faktor yang mengakibatkan masalah seksual selama masa nifas (Ayurai, 2009).

Wanita dengan persalinan normal tanpa jahitan perineum, setelah selesai masa nifas dapat kembali menikmati hubungan seksual, namun jika terdapat luka jahitan perineum, membutuhkan waktu lebih lama lagi. Biasanya dalam waktu 4 bulan luka episiotomi benar-benar sembuh dan hubungan seksual bisa dilakukan kembali tanpa adanya nyeri (Sari, 2014). (Ratnaningsih, 2019).

Hubungan seksual yang memuaskan memerlukan suasana hati yang tenang. Jika ibu nifas merasa tidak nyaman atau cemas karena membayangkan jika berhubungan akan merasa nyeri, maka akan menghambat proses perangsangan terhadap produksi cairan pelumas vagina. Perilaku seksual ibu nifas beragam, ada yang merasa bergairah di masa nifas namun ada juga yang merasa tidak bergairah karena kecemasan saat berhubungan dengan suami. Hal tersebut berpengaruh

karena psikologis ibu atau kesiapan ibu dalam menghadapi kehidupan setelah melahirkan. (Maritalia, 2014)

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi hubungan seksual setelah melahirkan:

1. Ibu-ibu yang pertama kali melahirkan merasa bahwa peran seorang ibu sangat berat;
2. Adanya luka episiotomy atau robekan di perineum.
3. Kurangnya informasi tentang seks setelah melahirkan. (Maritalia, 2014)

Bahaya berhubungan seks setelah melahirkan adalah:

1. Mudah terkena infeksi,
Mulut Rahim masih terbuka lebar, berbahaya jika kuman masuk, dan tersedot kedalam rongga vagina kemudian terinfeksi.
2. Sudden death
Mati secara mendadak setelah melakukan hubungan suami istri karena pergerakan teknis berhubungan yang menyebabkan udara masuk kedalam Rahim. (Nurjanah,S.N.,Maemunah,A.S.,Badriah,D.L, 2013)

G. Senam Nifas

Senam nifas adalah senam yang dilakukan ibu melahirkan, berupa gerakan-gerakan tubuh dimana bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan ibu pada masa nifas, serta membantu proses involusi uteri. (Fadhli, 2022).

Kegiatan senam nifas untuk ibu, sangat bermanfaat antara lain mempercepat proses involusi, membantu penyembuhan rahim, perut dan otot pinggul yang mengalami trauma serta mempercepat kembalinya bagian-bagian ke bentuk normal, membantu menormalkan sendi-sendi yang menjadi longgar diakibatkan kehamilan dan persalinan serta mencegah pelemahan lebih lanjut dan menghasilkan manfaat psikologi seperti memberikan rasa enak badan, turunnya berat badan, berkurangnya stress, dan bersantai sehingga mengurangi depresi pasca persalinan. (Fadhli, 2022).

Beberapa Manfaat senam nifas adalah:

1. Membantu penyembuhan Rahim, perut dan otot pinggul serta mempercepat organ-organ Kembali dengan baik;
2. Menormalkan sendi-sendi akibat kehamilan.
3. Lebih santai dan tenang serta menghilangkan depresi pasca persalinan.

(Nurjanah,S.N.,Maemunah,A.S.,Badriah,D.L, 2013)

Senam nifas dilakukan setelah melahirkan, tidak ada kelainan apapun, dan dilakukan setelah >6 jam persalinan. Namun jika tidak melakukan senam nifas maka akan terjadi perlambatan involusi uterus, perdarahan yang abnormal, trombotis vena, timbul varises. (Nurjanah,S.N.,Maemunah,A.S.,Badriah,D.L, 2013)

Bahkan Penurunan tinggi fundus uteri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti paritas, usia dan senam nifas. Dengan melakukan senam nifas penurunan tinggi fundus uteri dapat secara perlahan turun dan akan Kembali seperti semula karena dapat merangsang otot polos berkontraksi dengan lebih baik. Berdasarkan evidence based, bahwa pengaruh senam nifas terhadap penurunan tinggi fundus uteri pada ibu postpartum, terbukti berhasil. (Andriyani, 2013).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Anita Rizky. 2017. Upaya Pemenuhan Kebutuhan Istirahat Tidur Pada Ibu PostPartum. diakses tanggal 6 Desember 2022 melalui website: <http://eprints.ums.ac.id>
- Andriyani, Nurlaila, Pranajaya,R. 2013. Pengaruh Senam Nifas Terhadap Penurunan Tinggi Fundus Uteri Pada Ibu PostPartum. Jurnal Keperawatan, Volume IX, No. 2, Oktober 2013. Diakses tanggal 9 Desember 2022 melalui website: <file:///C:/Users/asus/Downloads/349-886-1-SM.pdf>
- Fadhli, Wendi Muhamad. 2022. Pengaruh Senam Nifas Terhadap Involusi Uterus Pada Ibu PostPartum Hari 1-3 Di RSUD Kabelota. CHMK Midwifery Scientific Journal Volume 5 Nomor 1 Januari 2022; Hal 361-370. Diakses tanggal 8 Desember 2022 melalui website <https://media.neliti.com/media/publications/367513-the-effect-of-public-exercise-on-uternal-e01aae1a.pdf>
- Karyati, Sri. 2016. Jahitan Perineum, Dukungan Suami, Dan Ansietas Seksual Ibu PostPartum. The 3rd Universty Research Colloquium 2016. Diakses tanggal 7 Desember 2022 melalui website: <https://text-id.123dok.com/document/7qv5xp1z-jahitan-perineum-duktungan-suami-dan-ansietas-seksual-ibu-post-partum.html>
- Maritalia, Dewi. 2014. Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Nurjanah, S.N., Maemunah, A.S., Badriah, D.L., 2013. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Ratnaningsih, Esther. 2019. Kualitas Fungsi Seksual Ibu Postpartum dengan Jahitan Perineum diukur dengan Menggunakan Female Sexual Function Index (FSFI). Jurnal SMART Kebidanan, 6 (2), 93-100. Diakses tanggal 7 Desember 2022 melalui website: https://www.researchgate.net/publication/337986670_Kualitas_Fungsi_Seksual_Ibu_Postpartum_Dengan_Jahitan_Perineum_Diukur_Menggunakan_Female_Sexual_Function_Index.
- Sulistyawati, Ari. 2009. Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas. Yogyakarta. Andi Offset.
- Supingah, Arifah Istiqomah. 2017. Pelaksanaan Mobilisasi Dini pada Ibu Nifas. Jurnal Ilmu Kebidanan, Jilid 5, Nomor 2, hlm 124-136. Diakses tanggal 7 Desember 2022 melalui website: <http://jurnalilmukebidanan.akbiduk.ac.id/index.php/jik/article/view/101>.

BAB 12

***SUPPORT SYSTEM* DALAM PROSES MENYUSUI**

Dewi Ayu Ningsih, S.ST, M.Keb, CTM-BT



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. Pendahuluan

Menyusui merupakan proses fisiologis, tidak ada hal yang lebih bernilai dalam kehidupan seorang anak selain memperoleh nutrisi yang berkualitas sejak awal kehidupan. Pemberian ASI (Air Susu Ibu) merupakan nutrisi ideal untuk menunjang kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal. Salah satu upaya untuk meningkatkan status gizi bayi adalah dengan memberikan ASI secara eksklusif (Centers for Disease Control and Prevention, 2013). *World Health Organization* (WHO) merekomendasikan pemberian ASI eksklusif sekurangnya selama 6 bulan pertama kehidupan dan dilanjutkan dengan makanan pendamping sampai usia 2 tahun rekomendasi serupa juga didukung oleh *American Academy of Pediatrics* (AAP), *Academy of Breastfeeding Medicine* demikian pula oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI, 2013).

Proses menyusui merupakan hasil akhir dari perilaku kesehatan seseorang. Perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi salah satunya oleh dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Dukungan sosial adalah suatu keadaan yang bermanfaat bagi individu yang diperoleh dari orang lain yang dapat dipercaya, sehingga seseorang akan tahu bahwa ada orang lain yang memperhatikan, menghargai dan mencintai. aspek dukungan ini juga diperlukan oleh seorang ibu dalam melewati masa menyusui anaknya. *Support system* atau sistem dukungan merupakan suatu hubungan sebagai wujud kepedulian dan perhatian dari sekelompok orang yang mana dapat memberikan motivasi kepada anggota lainnya agar bisa mengerjakan segala sesuatu secara optimal (Andarmoyo, 2012).

Support system ini dapat berupa semua aktivitas yang berasal dari berbagai komunitas, sistem pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, para pekerja, ahli kesehatan masyarakat, organisasi pendukung gerakan menyusui dan individu yang bisa memberikan dukungan terhadap seorang ibu dalam proses menyusui (Centers for Disease Control and Prevention, 2013).

B. Definisi Support System

Support system merupakan hubungan timbal balik yang bersifat saling membantu, simbiosis mutualisme, dan *take and give*. Sifat saling memberi dan menerima tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia *mengingat* sebagai makhluk sosial, manusia sangat bergantung terhadap orang lain baik secara aspek fisik maupun dalam aspek psikologis. *Support system memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan motivasi, meningkatkan ketenangan,*

meningkatkan hormone yang dapat menstimulasi rasa bahagia dalam tubuh yaitu hormone serotonin dan dopamine (Satria, 2021).

Manusia sebagai individu merupakan makhluk sosial dimana setiap aspek kehidupannya dipengaruhi oleh manusia yang lain termasuk dalam berperilaku. Hal ini dikarenakan pada diri manusia terdapat dorongan untuk melakukan interaksi dan kebutuhan sosial (*social need*) terhadap orang lain (Suratman, Munir, & Salamah U, 2013). Dukungan sosial sendiri bermakna sebagai bantuan yang diberikan oleh orang-orang disekitar lingkungan sosial dan dekat dengan subjek baik berupa informasi verbal atau non-verbal, saran, kehadiran dan tingkah laku yang berdampak pada emosional dan atau perilaku seseorang. Dukungan sosial merupakan suatu tindakan dalam bentuk kenyamanan, perhatian, penghargaan atau pertolongan yang diberikan oleh seseorang atau kelompok kepada individu yang membutuhkan (Ningsih, 2019).

C. Dukungan Praktik Asuhan Kebidanan dalam Program Menyusui

Praktik asuhan kebidanan terkait dengan proses menyusui berlangsung selama masa bersalin (fase intrapartum) di rumah sakit dan termasuk praktik yang berkaitan dengan asuhan antenatal, asuhan selama persalinan dan melahirkan, dan asuhan pasca melahirkan. Praktik asuhan kebidanan yang mendukung program menyusui akan memfasilitasi proses menyusui melalui penerapan kebijakan dalam manajemen pelayanan, menyediakan semua staf dengan pendidikan dan pelatihan tentang menyusui, menjaga kontak kulit-ke-kulit antara ibu dan bayi setelah lahir, mendorong sejak dini dalam proses inisiasi menyusui (IMD), mendukung pemberian makan berbasis isyarat, melengkapi dengan susu formula atau air hanya jika diperlukan secara medis, dan memastikan tindak lanjut setelah klien dipulangkan (WHO, 2017).

Penerapan asuhan praktik kebidanan dapat mempengaruhi keberhasilan proses IMD dan pemberian makan bayi selanjutnya perilaku. Menyusui adalah aktivitas yang sangat sensitif dan bergantung terhadap waktu pemberiannya. Pengalaman menyusui pada 1 jam dan hari pertama kehidupan bayi secara signifikan berhubungan dengan proses pemberian makan bayi selanjutnya. Oleh sebab itu, dimulainya proses menyusui harus mendapatkan dukungan penuh sejak bayi masih berada di tempat pelayanan kesehatan baik rumah sakit, puskesmas, maupun praktik bidan mandiri mengingat begitu pentingnya pengalaman menyusui pertama segera setelah bayi lahir bagi kesehatan bayi mendatang (WHO, 2017).

Banyak pengalaman ibu dan bayi baru lahir di rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan lain mempengaruhi keberhasilan menyusui. Sebagian besar kasus, pengalaman ibu ini mencerminkan pelayanan rutin pada fasilitas kesehatan seperti pemberian obat rutin dan prosedur yang diterima ibu selama proses

persalinan dapat mempengaruhi perilaku bayi pada saat lahir, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan bayi untuk menyusui di payudara (Centers for Disease Control and Prevention, 2013)

Bayi baru lahir yang mendapatkan penundaan dalam menerima ASI pertamanya akibat asuhan yang diberikan seperti menimbang, mengukur, dan membersihkan bayi memiliki peluang lebih besar tidak menyusui seperti bayi yang segera mendapatkan asuhan *skin-to-skin* dengan ibu pada 1 jam pertama kehidupannya. Selanjutnya, seorang ibu yang mendapatkan pelayanan *room in* bersama bayi yang baru dilahirkannya akan mendapatkan pengalaman dalam mengenali berbagai isyarat makan dari bayinya sehingga dapat menstimulasi ibu untuk memberikan ASI nya melalui proses menyusui (WHO, 2017).

WHO dan UNICEF mendirikan Rumah Sakit Ramah Bayi (*Baby-Friendly Hospital Initiative Initiative/BFHI*), yang mendukung dan mengakui bahwa rumah sakit dan pusat bersalin serta semua fasilitas kesehatan berkomitmen dalam optimalisasi pada asuhan pemberian makan bayi dengan menerapkan Sepuluh Langkah BFHI untuk mendukung program sukses menyusui. Adapun langkah-langkah praktik yang dapat diterapkan rumah sakit yang terbukti dapat meningkatkan proses menyusui adalah sebagai berikut, (WHO, 2017) (Centers for Disease Control and Prevention, 2013):

1. Memiliki kebijakan tentang program menyusui yang tertulis dan dikomunikasikan secara rutin kepada semua petugas kesehatan.
2. Latih keterampilan semua petugas kesehatan untuk melaksanakan kebijakan ini.
3. Informasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui.
4. Bantu ibu memulai menyusui dalam waktu 1 jam setelah lahir.
5. Tunjukkan pada ibu cara menyusui dan bagaimana mempertahankan laktasi, bahkan jika mereka dipisahkan dari bayi mereka.
6. Tidak memberi bayi baru lahir makanan atau minuman selain ASI, kecuali berdasarkan alasan medis.
7. Menerapkan "*room in*"—izinkan para ibu dan bayi untuk tetap bersama selama 24 jam satu hari.
8. Anjurkan menyusui sesuai permintaan.
9. Jangan berikan dot atau dot buatan untuk menyusui bayi.
10. Membina kelompok pendukung ASI dan merujuk ibu kepada mereka setelah keluar dari rumah sakit atau klinik.

D. Dukungan Pendidikan Bagi Profesional dalam Program Menyusui

Pendidikan profesional merupakan semua program kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap maupun perilaku dari

petugas pemberi layanan kesehatan tentang program menyusui, fisiologi dan manajemen laktasi, ataupun kebutuhan konseling menyusui bagi klien. Petugas kesehatan dalam hal ini yaitu dokter, perawat, bidan, praktisi keperawatan, ahli gizi, konselor menyusui atau petugas lainnya yang bekerja pada area maternal. Petugas kesehatan yang bekerja pada lingkup kesehatan ibu memerlukan pengetahuan dan kemampuan yang luas terkait proses menyusui dan manajemen laktasi. Begitupun dengan petugas kesehatan lainnya yang bekerja dan berinteraksi dengan perempuan usia reproduktif atau bayi perlu memahami proses fisiologi kesehatan ibu dan anak untuk dapat memahami proses menyusui (Amin, Zulkifli, Suriah, Jafar, Maidin, & Abdullah, 2020), (Centers for Disease Control and Prevention, 2013).

Petugas kesehatan memiliki kesempatan untuk mengajak dan menginisiasi keputusan seorang ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya dan melanjutkan untuk menyusui bayinya (Amin, Zulkifli, Suriah, Jafar, Maidin, & Abdullah, 2020). Beberapa provider profesional memiliki pengetahuan yang kurang tentang proses menyusui. Sebagian lainnya, percaya bahwa proses menyusui memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan pemberian susu formula. Program pendidikan bertujuan untuk merubah pengetahuan, kemampuan, sikap dari provider kesehatan sehingga dapat meningkatkan dukungan dalam proses menyusui. Berdasarkan penelitian tentang pengaruh pendidikan petugas kesehatan tentang proses menyusui yang dilakukan pada rumah sakit dengan cakupan menyusui rendah, terbukti dapat meningkatkan persentase klien yang memutuskan untuk menyusui yaitu 59% meningkat menjadi 65% . perbaikan terhadap kurikulum yang diterapkan pada pendidikan dokter spesialis anak terkait program menyusui juga terbukti dapat meningkatkan pengetahuan, praktik, dan tingkat kepercayaan diri pada residen dokter anak. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan terjadi peningkatan pada pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 6 bulan dari 2,3% menjadi 9,0% 29-30 (Centers for Disease Control and Prevention, 2013).

Beberapa program yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan perilaku petugas kesehatan terkait program menyusui adalah,

1. Promosi program menyusui kepada klinik dokter
2. Edukasi program menyusui dikomunitas dokter
3. Penelitian case studi pada kasus menyusui dan laktasi
4. Pelatihan konselor laktasi

E. Dukungan Program Komunitas Ibu Menyusui - Sebaya

Tujuan dukungan sesama ibu menyusui adalah untuk mendorong dan mendukung ibu hamil dan menyusui. Dukungan dalam bentuk ini dapat diberikan

dalam beberapa cara. Metode umum yang paling efektif dalam mendukung program menyusui pada ibu adalah dukungan dari kelompok sesama ibu menyusui dan dukungan dari seorang konselor sebaya. Seorang konselor menyusui yang memberikan dukungan kepada ibu menyusui sudah menjalani pelatihan khusus. Bentuk dukungan yang mereka berikan dapat berupa kegiatan penyusuhan pada kelompok ibu menyusui ataupun konseling satu per satu melalui panggilan telepon atau kunjungan di rumah, klinik, atau rumah sakit. Kontak dapat dilakukan melalui telepon, di rumah, atau dalam pengaturan klinis. Dukungan sesama kelompok ibu menyusui meliputi dukungan emosional, motivasi, pendidikan tentang menyusui, dan membantu memecahkan berbagai masalah yang sedang dialami oleh sesama ibu menyusui (IDAI, 2013).

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang perempuan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka. Lingkungan sosial ini menjadi bagian yang krusial dalam berperan sebagai hambatan atau aspek *support* dalam proses menyusui. Bagi perempuan yang baru saja menjadi seorang ibu, berbagai informasi yang diperoleh dari teman sebaya atau sesama ibu menyusui sangat dominan menjadi perhatiannya. Nasihat dari teman dan keluarga biasanya dikutip sebagai alasan dalam mengambil keputusan tentang pemberian makan bayi. Seorang perempuan yang berperan sebagai konselor menyusui (sebaya) sebaya dapat membantu ibu menyusui seusianya dalam mengatasi hambatan dan permasalahan menyusui selama masa antenatal hingga masa postpartum (Centers for Disease Control and Prevention, 2013).

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam implementasi *peer support* atau dukungan sesama komunitas ibu menyusui (Centers for Disease Control and Prevention, 2013) adalah

1. Dukungan sesama ibu menyusui secara individu
 - a. Menentukan waktu yang tepat dalam upaya pemberian dukungan. Hari dan minggu pertama menyusui merupakan waktu kritis dalam proses menyusui, sehingga dukungan yang diberikan dalam waktu tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi keberhasilan proses menyusui.
 - b. Memperhatikan latar belakang sosiokultural ibu menyusui yang membutuhkan dukungan.
2. Dukungan sesama ibu menyusui secara kelompok
 - a. Menentukan waktu yang tepat dalam proses memberikan dukungan
 - b. Mengadakan pertemuan rutin untuk membahas proses menyusui dan manajemen laktasi
 - c. Mengadakan pelatihan dalam upaya meningkatkan pengetahuan ibu menyusui tentang manajemen laktasi, pemenuhan nutrisi bayi, perkembangannya dan pertumbuhan bayi dan sebagainya

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan untuk menilai ketercapaian program
- e. Pemanfaatan perkembangan teknologi dalam membagikan komunikasi edukasi dan informasi terkait proses menyusui
- f. Optimalisasi peran pasangan dalam mendukung proses menyusui
- g. Optimalisasi peran orang tua dari ibu menyusui dalam upaya mendukung keberhasilan program menyusui.

F. Dukungan Program Menyusui di Tempat Bekerja

Bentuk dukungan bagi ibu menyusui dalam upaya mensukseskan program menyusui di tempat kerja diantaranya berupa jenis tunjangan karyawan dan layanan (Centers for Disease Control and Prevention, 2013). Contohnya adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan perusahaan untuk mendukung ibu menyusui.
2. Menyediakan ruang pribadi khusus (pojok ASI) bagi perempuan untuk menyusui atau memeras ASI.
3. Memungkinkan penjadwalan yang fleksibel untuk mendukung produksi ASI selama bekerja.
4. Memberi ibu pilihan untuk kembali bekerja, seperti teleworking, kerja paruh waktu, atau cuti hamil diperpanjang.
5. Menyediakan penitipan anak di tempat atau di dekatnya.
6. Menyediakan pompa ASI berkualitas tinggi.
7. Membiarkan bayi di tempat kerja.
8. Menawarkan layanan dan dukungan manajemen laktasi profesional.

Bagi ibu menyusui yang aktif bekerja penuh waktu di luar rumah memiliki hubungan yang positif dengan waktu yang lebih singkat dalam durasi menyusui bayinya. Niat ibu menyusui yang bekerja penuh waktu berkaitan dengan rendahnya keinginan ibu untuk menyusui bayinya dan durasi menyusui yang lebih singkat (UNICEF, 2020).

G. Dukungan keluarga dalam proses menyusui

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, yang terdiri dari dua orang/lebih atas ikatan perkawinan, pertalian darah/adopsi/kesepakatan bersama yang tinggal dalam satu atap rumah dibawah asuhan kepala rumah tangga, dimana semuanya saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dan setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing serta memiliki ikatan emosional. Keluarga bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial dari tiap anggota keluarga (Andarmoyo, 2012).

Keluarga memiliki fungsi *supportif* diantaranya adalah: 1) Dukungan informasional (keluarga berfungsi sebagai sebuah kolektor/pencari dan deseminator/penyebarkan informasi tentang dunia). 2) Dukungan penilaian (keluarga bertindak sebagai sebuah penilaian umpan balik, membimbing dan mempengaruhi pemecahan masalah dan sebagai sumber validator identitas anggota keluarganya). 3) Dukungan instrumental (keluarga merupakan sumber pertolongan praktis dan konkrit). 4) sebagai dukungan emosional (keluarga sebagai tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi) (Ningsih, 2019).

Oleh sebab itu, dukungan keluarga dari sekitar ibu menyusui mempunyai peran yang besar terhadap keberhasilan menyusui. Dukungan itu berasal dari lingkungan disekitar ibu selain suami, juga ada keluarga misalnya nenek dan keluarga lain yang sudah mempunyai pengalaman menyusui, peran nenek biasanya yang lebih dominan terhadap ibu. Dukungan suami/keluarga yang bagus akan senantiasa mendukung ibu dalam menumbuhkan sikap yang positif dalam pemberian ASI. Contoh praktis dukungan yang diberikan suami kepada istrinya antara lain mencari informasi tentang manfaat pemberian ASI eksklusif, memberikan masukan kepada ibu untuk makan makanan yang bergisi supaya ASInya lancar, menyediakan fasilitas untuk menyimpan ASI ketika ibu harus bekerja (IDAI, 2013).

Dukungan yang diberikan oleh keluarga secara positif memiliki kaitan dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Bentuk dukungan keluarga dalam keberhasilan menyusui ini dapat berupa mempersiapkan pemenuhan nutrisi ibu menyusui, membantu mengurus bayinya dan anak yang lainnya saat ibu menyusui kembali bekerja, berperan dalam menjaga kebutuhan anak dan bayinya. Dukungan dari keluarga dapat meningkatkan rasa percaya diri ibu menyusui akan kemampuannya dalam memberikan ASI terbaik bagi bayinya (Ratnasari, Paramashanti, & Hadi, 2017).

Terdapat 5 aspek utama dukungan yang dapat diberikan oleh pasangan (Ratnasari, Paramashanti, & Hadi, 2017) yaitu,

1. Dukungan pengetahuan tentang proses menyusui
2. Dukungan sikap yang positif terhadap proses menyusui
3. Dukungan pengambilan keputusan yang tepat dalam proses menyusui
4. Dukungan praktik dalam membantu proses menyusui
5. Dukungan emosional kepada ibu dalam melalui proses menyusui

H. Menyikapi Pemasaran Susu Formula Bayi

Pemantauan terhadap distribusi susu formula bayi dipasaran dapat membantu mengurangi permasalahan dalam proses menyusui bagi ibu yang memutuskan menyusui bayinya. Hubungan negatif antara pemasaran susu

formula dan prevalensi menyusui menjadi data dasar pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan. Kondisi ini menegaskan kembali komitmen berbagai lembaga seperti pemerintah, sistem pelayanan kesehatan, petugas kesehatan, dan produsen serta distributor susu formula terhadap kesuksesan program ASI eksklusif. Lebih khusus menjadi bahan pertimbangan dalam memastikan susu formula bayi dipasarkan dengan cara meminimalkan dampak negatifnya terhadap keberhasilan proses menyusui (Centers for Disease Control and Prevention, 2013).

Bukti menunjukkan bahwa pengaruh praktik pemasaran yang digunakan untuk mempromosikan pemberian susu formula menjadi perhatian khusus karena efek negatif yang tidak lebih menonjol pada ibu menyusui dengan tinggi peluang menghentikan proses menyusui lebih dini. Kasus ini banyak terjadi pada kelompok ibu yang baru pertama kali melahirkan, dan perempuan yang berpendidikan rendah, bukan kulit putih, atau sakit selama periode postpartum (Centers for Disease Control and Prevention, 2013).

Suatu studi membuktikan kelompok ibu menyusui yang mendapatkan sampel susu formula secara gratis memutuskan untuk menghentikan proses pemberian ASI eksklusif lebih dini dibandingkan dengan kelompok ibu menyusui yang tidak mendapatkan sampel susu formula (Centers for Disease Control and Prevention, 2013).

Berikut ini salah satu kebijakan pemerintah di United States yang bisa menjadi gambaran dalam aturan pemasaran susu formula (Centers for Disease Control and Prevention, 2013). Pedoman tersebut mencakup sebagai berikut:

1. Tidak ada iklan pengganti ASI langsung ke publik.
2. Tidak ada sampel gratis untuk ibu.
3. Tidak ada promosi produk kesehatan fasilitas perawatan.
4. Tidak ada perwakilan produk komersial untuk menasihati ibu.
5. Tidak ada hadiah atau sampel pribadi untuk kesehatan pekerja.
6. Tidak ada kata atau gambar yang mengidealkan artifisial menyusui, termasuk gambar bayi diproduksi susu formula.

Pedoman menyatakan bahwa

1. Informasi kepada petugas kesehatan harus ilmiah dan faktual.
2. Semua informasi tentang pemberian makanan buatan, termasuk label produk, harus menjelaskan manfaat ASI dan biaya dan bahaya yang terkait dengan pemberian makanan buatan.
3. Produk yang tidak cocok, seperti susu kental, tidak boleh dipromosikan untuk bayi.
4. Semua produk harus berkualitas tinggi dan memperhitungkan iklim dan kondisi penyimpanan negara tempat mereka akan digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A., Zulkifli, A., Suriah, Jafar, N., Maidin, A., & Abdullah, T. (2020). MIDWIFE SUPPORT IN IMPROVING QUALITY GIVING EXCLUSIVE BREASTFEEDING IN BONTOBANGUN VILLAGE. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol.24, Issue 09, page:1057-1069.
- Andarmoyo, S. (2012). *Keperawatan Keluarga Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2013). *Strategies to Prevent Obesity and Other Chronic Diseases : The CDC Guide to Strategies to Support Breastfeeding Mothers and Babies*. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services.
- IDAI. (2013). *Breastfeeding Family*.
<https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/breastfeeding-family>.
- Ningsih, D. (2019). *Anaisis Hubungan Dukungan Psikososial dengan Keputusan Memilih KB MKJP Di Kampung KB Kota Padang Tahun 2019*. Padang: Universitas Andalas.
- Ratnasari , D., Paramashanti, B., & Hadi, H. (2017). Family support and exclusive breastfeeding among Yogyakarta mothers in employment. *Asia Pac J Clin Nutr* , Vol 26 (Suppl 1) : S31-S35.
- Satria. (2021). *Membangun Support System untuk Diri Sendiri*.
<https://ugm.ac.id/id/berita/21703-membangun-support-system-untuk-diri-sendiri>.
- Suratman, Munir, & Salamah U. (2013). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Malang: Intimedia. Hal. 134-135.
- UNICEF. (2020). *Breastfeeding support in the workplace: A GLOBAL GUIDE FOR EMPLOYERS*. New York, NY 10017, USA: United Nations Children's Fund (UNICEF) .
- WHO. (2017). *Guideline: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services*. Geneva : Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.: World Health Organization.

BAB 13

ANATOMI FISILOGI LAKTASI

Dwie Yunita Baska,SST, M.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 13

ANATOMI FISIOLOGI LAKTASI

Dwie Yunita Baska,SST, M.Keb

Beberapa kalangan masih banyak yang belum mengenal istilah “Laktasi” atau “*Lactation*”. Dikutip dari Akers (2016), *lactation is the process of producing and releasing milk from the mammary glands in your breasts* (Akers, R.M: 2016). Dalam Bahasa yang sederhana, dapat diartikan bahwa laktasi adalah suatu proses produksi dan melepasnya Air Susu Ibu (ASI) dari kelenjar mammae yang ada di dalam payudara wanita. Di negara kita, siapa yang tidak mengenal ASI. Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik dan paling sempurna yang Tuhan anugerahkan kepada seorang ibu untuk bayinya sampai dengan usia 6 bulan (Siti, N.K.:2015). Nutrisi yang terkandung di dalam ASI tidak terdapat pada susu buatan pabrik, seperti susu botol, atau susu formula. Hal itulah yang membuat para ahli lebih menganjurkan pemberian ASI daripada susu formula terhadap bayi. Suatu proses dimana seorang bayi menerima air susu dari payudara ibu merupakan definisi efektif dari kata laktasi atau menyusui.

Perlu diketahui bersama, bahwa ASI tidak langsung keluar begitu saja ketika seorang ibu menyusui anaknya. Akan tetapi, ia melewati sekian tahap proses atau mekanisme alamiah, mulai dari pembentukan kelenjar sampai terciptanya ASI (Siti, N.K.:2015). Pada Bab ini, kita akan mengenal lebih dulu bagaimana bentuk atau struktur anatomi payudara dan bagaimana fungsi organ tersebut mampu berfungsi sebagaimana mestinya sehingga mekanisme laktasi itu terjadi. Secara singkat, *anatomi merupakan* salah satu dasar ilmu kedokteran yang mempelajari ilmu tentang struktur morfologis dari organisme hidup, mencakup tentang berbagai bagian, posisi, serta keterkaitan satu sama lain. Sedangkan *fisiologi adalah* ilmu yang mempelajari faal atau fungsi normal dari tiap-tiap jaringan tubuh, atau sebagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya, yang berfungsi secara normal atau fisiologis. (Dahl, L.:2015, Lestari, S.dkk:2021)

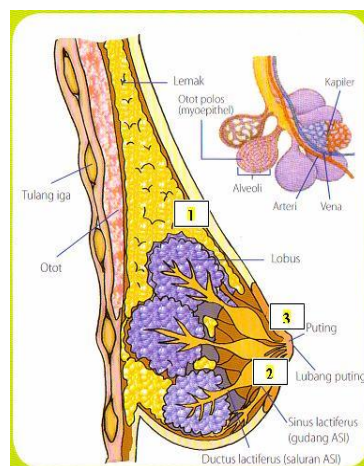
A. Anatomi Fisiologi Payudara

Payudara atau dikenal dengan sebutan mammae (*Glandula Mammae*) merupakan salah satu organ seks asesoris yang dimiliki oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Organ ini terletak pada setiap sisi sternum (kiri kanan) dan meluas setinggi costa ke-2 sampai costa ke-6 bagian axial tubuh manusia, tertanam di atas musculus pectoralis mayor dan dipertahankan oleh ligamentum suspensorium. (Filia, N.A.A,dkk; 2021, Kent, J.C.;2007) Payudara ini menjadi berkembang sangat penting pada wanita saat pubertas, dan sangat sensitive terhadap hormone estrogen. (Annisa, N.;2016) Sedang pada laki-laki biasanya tidak berkembang (rudimenter). Struktur utama pembentuk payudara adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit, dan di atas otot dada, tepatnya pada

hemithorax kiri dan kanan, berbentuk kerucut, dan seringkali berukuran tidak sama. Payudara berfungsi memproduksi dan menyalurkan susu untuk nutrisi neonatus/bayi, segera setelah lahir. (Aprillia,G; 2020, Ashi,R.S & Badiger M.G;2021).

Pada payudara terdapat tiga bagian penyusun utama, yaitu: korpus (bagian yang membesar), areola (bagian yang kehitaman di tengah), dan papilla atau puting/niple (bagian yang menonjol di puncak payudara). (McGlothen,K.&Cleveland, L.M; 2018, Giri Y;2021)

Payudara dewasa beratnya kira-kira 200 gram, yang umumnya lebih besar dari yang kanan, pada waktu hamil payudara semakin membesar mencapai berat $\pm$ 600 gram, dan pada waktu menyusui mencapai $\pm$ 800 gram. (Kamariyah, N;2014, Dahl, L.:2015)



Gambar 15.1 Anatomi Payudara
Sumber: Lawrence R.A & Lawrence R.M.

Secara umum, payudara tersusun atas bagian makroskopis (eksterna) dan bagian mikroskopis (interna) yang menjadi komponen utama penyusun struktur anatomi payudara, serta memiliki peran atau fungsinya masing-masing.(Britton, C,dkk;2007) Telah dirangkum pada tabel berikut ini:

Tabel 15.1
Bagian Struktur Makroskopis dan Mikroskopis penyusun anatomi payudara beserta fungsinya

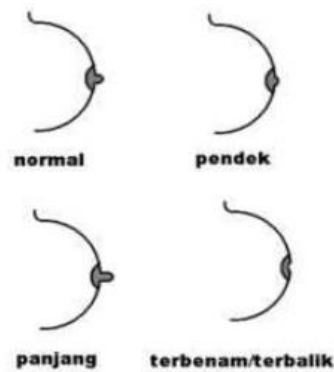
No	Nama Bagian	Keterangan
1	Makroskopis : Korpus (Badan)	: Badan payudara seutuhnya, dan bagian ini akan mengalami proses pembesaran. Korpus terdiri dari <i>Parenkim</i> (ductus, lobus, lobulus,& alveoli) dan <i>Stroma</i> (jaringan penunjang; seperti kelenjar lemak, pembuluh darah, syaraf, limfe/kelenjar getah bening, dan hormonal).
	Mikroskopis terdiri	: Kumpulan beberapa lobulus yang menjadi satu, pada

dari : a. Lobus	tiap payudara terdiri dari 15-20 lobus. Lobus ini dikelilingi jaringan adipose dan dipisahkan oleh ligament suspensorium cooper (berkas jaringan ikat fibrosa). Lobus mayor akan bersubdivisi menjadi 20-20 lobulus.
b. Lobulus	: Kumpulan dari alveolus (10-100 alveolus), dan setiap lobulus yang bercabang akan menjadi ductus.
c. Alveolus	: Unit terkecil yang memproduksi susu. Terdiri dari sel aciner, jaringan lemak, sel plasma, sel otot polos (bila berkontraksi dapat memompa ASI keluar), & pembuluh darah.
d. Ductus	: Saluran kecil penyalur ASI dari lobulus.
e. Ductus Laktiferus	: Gabungan beberapa ductus yang membentuk saluran lebih besar.
2 Makroskopis : Areola	: Bagian kehitaman (area pigmentasi) terletak di tengah mammae, mengelilingi puting susu & berdiameter $\pm 2,5$ cm. Berwarna kegelapan yang disebabkan oleh penipisan dan penimbunan pigmen pada kulit. Perubahan warna akan tergantung pada corak kulit dan adanya kehamilan. Wanita yang berkulit kuning langsung akan berwarna jingga kemerahan, bila corak kulit sawo matang/coklat/kehitaman maka warna areola akan lebih gelap.
(Mikroskopis) Kelenjar Morgagni	Pada aerola terdapat <i>kelenjar Morgagni</i> (kelenjar keringat besar), berfungsi untuk menyekresi cairan yang melembaskan dan melindungi areola sewaktu menyusui.
(Mikroskopis) Sinus laktiferus	: Yaitu saluran dibawah areola yang besar melebar, memusat kedalam puting dan bermuara ke luar.
3 Makroskopis : Papilla atau Puting /nipple	: Bagian yang menonjol pada puncak payudara, dan terletak ditengah-tengah areola. Puting susu memiliki ujung-ujung saraf perasa yang sangat sensitif dan otot polos yang akan berkontraksi bila ada rangsangan. Terdapat lubang-lubang kecil yang menjadi tempat bermuaranya <i>ductus laktiferus</i> dan keluarnya ASI.

Sumber : Dahl, L.:2015, Dewi A;2019, Filia N,dkk;2021)

Bentuk puting ada 4 macam, yang terdiri dari bentuk normal, pendek/datar, Panjang, dan terbenam (*inverted*). (Britton, C;2007) Puting payudara memiliki bagian mikroskopis yang disebut *Tuberkel Montgomeri* di sekitarnya, kelenjar sebacea yang mengalami hipertrofi dan menjadi menonjol saat hamil, mampu menghasilkan pelumas dan memberi perlindungan. (Nariswari.R;2022, McGlothen,K.&Cleveland, L.M; 2018). Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penggunaan sabun dalam jumlah besar dapat meningkatkan risiko kerusakan puting payudara, terutama karena mengakibatkan efek kekeringan dan retak. Kepekaan puting payudara dan daerah di sekitarnya sangat meningkat segera setelah pasca salin.(Kamariyah,N; 2014, Nariswari,R.R;2022). Persiapan laktasi menyebabkan influx impuls saraf

aferen ke hipotalamus yang mengontrol proses laktasi dan perilaku ibu. (Octaviani,N,dkk;2021)



Gambar 15.2 Bentuk puting susu
Sumber: Lawrence R.A & Lawrence R.M.

Pada papilla mammae ini juga sebagian *ductus lactiferous* bersatu dan masuk ke papilla.(Wulandari, P;2018, Sriraman,N.K;2017) Sebelum masuk ke papilla mammae, ductus lactiferous melebar menjadi *sinus lactiferous*, kemudian menyempit lagi dan berjalan sejajar di dalam papilla sebagai *ductus excretorii*. Pada waktu kehamilan, terjadi pertumbuhan duktus-duktus dan ujung duktus-duktus tersebut berkembang menjadi *alveolus*. (Ratnasari, F;2022, Lawrence R;2015)

FISIOLOGI PAYUDARA

Secara harfiah, fisiologi payudara wanita mengalami tiga macam perubahan yang dipengaruhi oleh hormone. *Perubahan pertama*, dimulai sejak masa hidup anak melalui masa pubertas sampai dengan periode menopause. (Marieb,E.& Hoehn, K; 2007, Neville,MC.;1999) Pada masa pubertas, pengaruh hormone estrogen dan progesterone menyebabkan mulai berkembangnya ductus dan timbulnya sinus. *Perubahan kedua*, terjadi sesuai dengan siklus haid/daur menstruasi wanita. Beberapa hari sebelum haid, payudara akan mengalami pembesaran maksimal, tegang, dan terkadang timbul benjolan yang nyeri dan tidak rata (Putri,D.M;2013). Oleh karena itu, pemeriksaan payudara tidak mungkin dilakukan pada masa ini, begitu menstruasi mulai semuanya berkurang (Rahmawati,dkk; 2021, Raharjo; 2014). *Perubahan ketiga*, terjadi pada masa hamil dan menyusui. Saat seorang wanita hamil, volume payudara akan bertambah besar akibat proliferasi dari epitel ductus lobul dan ductus alveolus, sehingga tumbuh duktus-duktus baru. Adanya sekresi prolactin dari aktifitas hipofise anterior memicu terjadinya laktasi, dimana alveolus menghasilkan ASI dan disalurkan ke sinus kemudian dikeluarkan melalui ductus ke puting susu. (Saputri, I.N,dkk;2019, Sari.T dkk;2017)

B. FISIOLOGI LAKTASI

Laktasi (menyusui) merupakan suatu cara atau teknik yang tiada duanya dalam memberikan makanan paling ideal dan sempurna bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sehat, serta mempunyai pengaruh biologis dan kejiwaan antara ibu dan bayi (*bounding attach*). (Rosyida,D.dkk;2022, Ratnasari.F, dkk;2022) Saat kehamilan, kelenjar mammae mencapai perkembangan puncaknya dan berfungsi untuk produksi susu (laktasi) setelah persalinan.(Pramana, C,dkk;2021, Putri ;2014) Proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI inilah yang dinamakan laktasi.

Laktasi mempunyai dua pengertian, yaitu produksi dan pengeluaran ASI, keduanya harus sama baiknya. Pada saat hamil payudara membesar karena pengaruh berbagai hormone, yaitu estrogen, progesterone, dan prolactin. Hormone lain yang berfungsi memperlancar pembentukan ASI (sintesa protein) adalah insulin, kortikosteroid, tiroksin dan lain-lain.(Wirakhmi,I & Purnawan;2021, Marieb,E & Hoehn, K.;2007)

Proses laktasi akan melibatkan unsur hormonal di dalam tubuh manusia. Setelah memasuki usia kehamilan 16 minggu, Wanita hamil sudah mulai memproduksi ASI, tetapi produksi ASI tidak berlanjut karena tertahan oleh kehamilannya. Ketika bayi lahir dan plasenta keluar, hormone yang memengaruhi produksi ASI akan menjadi aktif kembali, apalagi bila tindakan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dilakukan.(Annisa, N;2016) Proses terjadinya pengeluaran ASI dimulai atau dirangsang oleh isapan mulut bayi pada putting payudara ibu. Adanya isapan bayi pada putting payudara akan merangsang kelenjar yang ada di otak ibu untuk memproduksi sejumlah prolactin, yaitu hormone utama yang mengendalikan pengeluaran ASI. Mekanisme pengeluaran ASI ini dikenal dengan *refleks prolactin (pembentukan ASI) dan refleks oksitosin (Let Down Reflect/Refleks aliran)*. (Britton, C,et al;2007, Kent, J.C;2007)

Menurut dr.Widodo Judarwanto yang dikutip oleh Siti Nur Khamzah (2015), ada beberapa mekanisme terjadinya ASI di dalam payudara. Mulai dari proses pembentukan hingga produksi ASI, yang dikenal sebagai *Fase Laktogenesis*. Tahapan-tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

1. *Pertama*, produksi ASI yang dimulai dari minggu ke-12 atau usia kehamilan 3 bulan. Pada tahapan ini, tubuh Wanita memproduksi hormone yang menstimulasi munculnya ASI dalam sistem payudara. Adapun hormon-hormon yang terbentuk antara lain; *Progesteron*, yaitu hormone yang memengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli; *Estrogen*, yaitu hormone yang menstimulasi sistem saluran ASI untuk membesar; *Follicle Stimulating Hormon (FSH)*; *Luteinizing hormone (LH)*; *Prolaktin*, yaitu hormone yang berfungsi mengencangkan otot halus dalam Rahim saat melahirkan dan setelahnya, juga berperan penting untuk mengencangkan otot halus disekitar

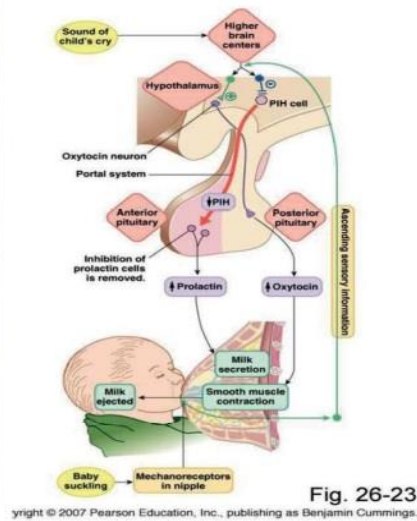
alveoli untuk memeras ASI menuju saluran susu; dan *Human placental lactogen (HPL)* yang berperan dalam pertumbuhan payudara, puting, dan areola sebelum melahirkan. (Saputri,I,dkk;2019, Sriraman; 2017).

2. *Kedua*, pada bulan ke-5 dan ke-6 kehamilan (20-24 minggu), payudara siap memproduksi ASI, namun ASI juga bisa diproduksi tanpa kehamilan (*induced lactation*). (Wulandari, P;2018)
3. *Ketiga, Fase Laktogenesis I*. Fase ini dimulai pada usia akhir kehamilan (*aterm*), payudara memproduksi colostrum yaitu cairan kental yang kekuningan, mengandung sel darah putih, dan antibodi immunoglobulin A (Ig A) yang tinggi daripada ASI sebenarnya, dan tingkat progesterone tinggi. (Wirakhmi,& Purnawan, ; 2021, Rosyida, D;2022).
4. *Keempat, Fase Laktogenesis II*. Saat melahirkan, keluarnya plasenta menyebabkan turunnya tingkat hormone progesterone, estrogen dan HPL secara tiba-tiba, dan meningkatnya hormone prolactin (refleks prolactin dimulai) menyebabkan produksi ASI besar-besaran. (Rahmawati,dkk; 2022)
5. *Kelima, Fase Laktogenesis III*. Sistem kontrol hormone endokrin yang mengatur produksi ASI selama beberapa hari pertama setelah melahirkan sampai dengan produksi ASI mulai stabil, sistem kontrol autokrin dimulai, fase ini dikenal juga sebagai refleks oksitosin (*let down refleks*). (Rosyida, D;2022, Sari T dkk;2017)

Selanjutnya, mekanisme laktasi terjadi melalui peran dua refleks yaitu *refleks prolactin (pembentukan ASI)* dan *refleks oksitosin (Let Down Reflekt/Refleks aliran)* seperti yang dapat diuraikan berikut ini:

1. Refleks Prolaktin (*Pembentukan ASI*)

Ketika bayi menyusu, ujung saraf peraba yang terdapat pada puting payudara ibu mengirimkan sinyal rangsangan ke otak. Rangsangan tersebut oleh serabut afferent dibawa ke *hipotalamus* di dasar otak, lalu memicu *hipofise anterior* untuk beraksi mengeluarkan hormone prolactin yang masuk ke dalam aliran darah menuju kembali ke payudara. (Akers;2016, Britton, C et al;2015). Melalui sirkulasi prolactin memacu sel-sel kelenjar pembuat susu (*alveoli*) untuk bekerja, memproduksi air susu. Dari alveolus ini ASI disalurkan ke dalam saluran kecil (*ductulus*), dimana beberapa saluran kecil bergabung membentuk saluran yang lebih besar (*ductus*). Dibawah areola, saluran yang besar ini mengalami pelebaran yang disebut sinus.(Filia dkk;2021, Giri Y;2021) Akhirnya semua saluran yang besar ini memusat ke dalam puting dan bermuara ke luar. Di dalam dinding alveolus maupun saluran, terdapat otot yang mampu berkontraksi untuk memompa ASI keluar. (Marieb,EN& Hoehn,k; 2007, Lestari, S;2021)



Gambar 15.3. Skema proses stimulasi produksi ASI pada fase lactogenesis II/ refleks prolactin dimulai

Sumber: Pearson Education Inc publishing as Benjamin Cummings.

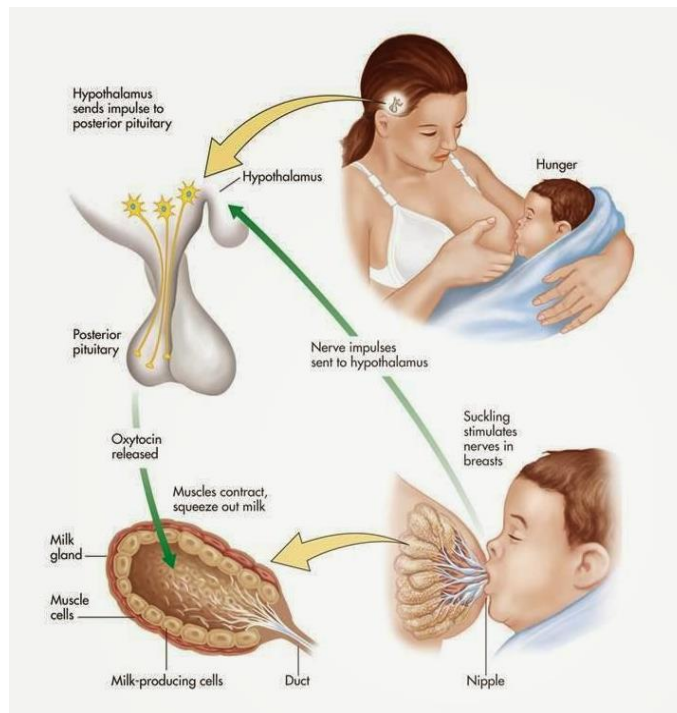
Sel-sel pembuat susu sesungguhnya tidak langsung bekerja Ketika bayi menyusu. Fase ini juga dikenal sebagai Laktogenesis II, proses ini dimulai sekitar 30-40 jam setelah melahirkan. (Dewi, A.; 2019) Sebagian besar hormone prolactin berada dalam darah selama ± 30 menit setelah proses menyusui pertama kali dilakukan. Jadi setelah proses menyusui selesai, barulah sebagian besar hormone prolactin sampai di payudara dan merangsang sel-sel pembuat susu untuk bekerja. Bahkan kebanyakan para ibu baru merasakan payudara penuh sekitar 50-73 jam (2-3 hari) setelah melahirkan.(Filia N dkk;2021, Marieb & Hoen;2007) Artinya, memang produksi ASI sebenarnya tidak langsung terjadi setelah melahirkan, dan hormone ini bekerja untuk produksi susu berikutnya. Jenis cairan pertama yang keluar dan dihisap bayi adalah colostrum. (Dahl, L;2015) Kolostrum mengandung sel darah putih dan antibody yang sangat baik dikonsumsi bayi pada awal kehidupannya, karena dapat membantu melapisi usus bayi yang masih rentan, mencegah kuman masuk ke bayi, dan mencegah alergi makanan. Dalam dua minggu pertama setelah melahirkan, kolostrum pelan-pelan akan hilang dan tergantikan oleh ASI yang sebenarnya. (Aryani, Y;2021, Aprilla, G; 2020)

2. Refleks Oksitosin (*Let Down Refleks/Refleks aliran*)

Rangsangan yang ditimbulkan oleh bayi pada saat menyusui, selain terjadinya pembentukan hormone prolactin oleh hipofise anterior, rangsangan tersebut juga dilanjutkan ke bagian *hipofise posterior (neurohipofise)* untuk mengeluarkan hormone oksitosin.(Nariswari, R; 2022) Melalui aliran darah, hormone ini menuju uterus sehingga menimbulkan kontraksi. Kontraksi dari sel akan memeras air susu yang telah dibuat keluar dari alveoli dan masuk ke sistem

ductus, yang selanjutnya akan mengalir melalui *ductus lactiferous* masuk ke mulut bayi. Hormon oksitosin diproduksi lebih cepat daripada prolactin. Kadang-kadang ASI mengalir hingga keluar Ketika bayi sedang tidak menyusui. Mengalirnya ASI ini disebut *refleks pelepasan ASI (let down refleks)*. (Pramana, C;2021, Neville, M;1999)

Hormon ini berfungsi memacu kontraksi otot polos yang ada di dinding alveolus dan dinding saluran, sehingga ASI terpompa keluar. Makin ibu sering menyusui bayinya, pengkosongan alveolus dan saluran makin baik sehingga kemungkinan terjadinya bendungan ASI makin kecil, dan menyusui semakin lancar. (Pramana,C, dkk; 2021) Saluran ASI yang mengalami bendungan tidak hanya mengganggu proses menyusui, tetapi juga dapat mengakibatkan infeksi. Dengan keluarnya oksitosin, hormon ini juga akan memacu otot Rahim sehingga involusi uterus semakin cepat dan baik. Oleh sebab itu, ibu sering mengeluh perutnya mulas pada hari pertama menyusui, ini adalah mekanisme alamiah yang baik untuk kembalinya Rahim ke bentuk semula. (Rosyida;2022, Sari, T,dkk;2017, Wulandari, P;2018)



Gambar 15.4. Skema proses stimulasi produksi ASI pada refleks oksitosin (*let down refleks*)

Sumber: Pearson Education Inc publishing as Benjamin Cummings.

Produksi hormone oksitosin tidak hanya dipengaruhi oleh rangsangan dari payudara, namun juga dipengaruhi oleh pikiran dan kondisi psikologi ibu/perasaan ibu. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan *let down refleks* adalah melihat bayi, mendengar suara bayi, mencium bayi, dan memiliki pemikiran penuh untuk menyusui bayinya dengan Bahagia. Sedangkan faktor yang dapat

menghambat produksi hormon oksitosin ini adalah stress, seperti keadaan bingung, cemas, pikiran kacau dan takut. (Ratnasari,dkk;2022, Saputri, I. dkk;2019)

Sebuah penelitian berkesimpulan bahwa apabila payudara dikosongkan secara menyeluruh maka akan meningkatkan taraf produksi ASI. (Nariswari, R; 2022) Maka pada tahap ini, apabila ASI banyak dikeluarkan maka payudara akan memproduksi ASI semakin banyak pula. Maka dari itu, produksi ASI sangat dipengaruhi oleh seberapa sering dan baik bayi mengisap, serta seberapa sering payudara dikosongkan. (Siti, N.; 2015) Tanda dan perasaan bahwa refleks oksitosin berjalan baik, adalah:

- a. Ibu mungkin akan merasa ada perasaan memeras dan menggelitik dalam payudara sesaat, sebelum, dan sesudah menyusui.
- b. ASI mengalir dari payudara bila ibu memikirkan bayinya atau mendengar tangis bayi.
- c. ASI menetes pada payudara sebelah ketika bayi mengisap atau menetek.
- d. ASI memancar halus ketika bayi menghentikan menetek di tengah menyusui
- e. Ibu merasakan nyeri kontraksi Rahim saat sedang menyusui, kadang dengan keluar aliran darah saat menyusui dalam minggu-minggu pertama pascasalin.
- f. Isapan dan menelan yang pelan dan dalam oleh bayi, menunjukkan ASI mengalir ke dalam mulutnya. (Dewi, AD;2019, Aprilla, G; 2020, Annisa, N;2016)

DAFTAR PUSTAKA

- Akers, R. M. (2016). *Lactation And The Mammary Gland*. John Wiley & Sons.
- Annisa, N. (2016). *Perbedaan Kadar Prolaktin Dan Produksi Asi Pada Ibu Menyusui Yang Memberikan Asi Langsung Dan Asi Perah* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Aprilla, G. G. (2020). *Studi Kasus Inisiasi Menyusui Dini (Imd)* (Doctoral Dissertation, Thesis. Fkm Universitas Indonesia).
- Aryani, Y., Alyensi, F., & Fathunikmah, F. (2021). Buku Proses Laktasi Dan Teknik Pijat Oksitosin.
- Ashi, R. S., & Badiger, M. G. (2021). Breastfeeding In Infants: A Critical Overview. *International Journal Of Pediatric Nursing*, 7(1), 1-8.
- Britton, C., McCormick, F. M., Renfrew, M. J., Wade, A., & King, S. E. (2007). Support For Breastfeeding Mothers. *Cochrane Database Of Systematic Reviews*, (1).
- Dahl, L. (2015). Anatomy And Physiology Of Breastfeeding. *Clinician's Guide To Breastfeeding*, 17-34.
- Dewi, A. D. C. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Produksi Asi. *Jurnal'aisyiyah Medika*, 4.
- Filia, N. A. A., Gilang, P., Novita, D. P., & Dedes, F. (2021). *Asuhan Kebidanan Pada Ny. S 37 Tahun P3a0 Dengan Bendungan Asi Di Pmb Bidan R Kabupaten Bogor* (Doctoral Dissertation, Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung).
- Giri Yuniari, N. K. (2021). *Manfaat Bimbingan Menyusui Terhadap Pengetahuan Dan Keterampilan Ibu Dalam Menyusui Pada Neonatus Dini* (Doctoral Dissertation, Jurusan Keperawatan 2021).
- Kamariyah, N. (2014). Kondisi Psikologi Mempengaruhi Produksi Asi Ibu Menyusui Di Bps Aski Pakis Sido Kumpul Surabaya. *Journal Of Health Sciences*, 7(1).
- Kent, J. C. (2007). How Breastfeeding Works. *Journal Of Midwifery & Women's Health*, 52(6), 564-570.
- Lawrence R. A & Lawrence R. M. (2015). Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession. Eight Edition. USA: Elsevier
- Lestari, S. S. T., Fatimah, S. S., & Ayuningrum, S. S. (2021). Pijat Oksitosin Laktasi Lancar, Bayi Tumbuh Sehat.
- Marieb, E. N., & Hoehn, K. (2007). The Endocrine System. *Human Anatomy & Physiology*, 603-643.
- McGlothen, K. S., & Cleveland, L. M. (2018). The right to mother's milk: A call for social justice that encourages breastfeeding for women receiving medication-assisted treatment for opioid use disorder. *Journal of Human Lactation*, 34(4), 799-803.

- Nariswari, R. R. (2022). Hubungan Teknik Menyusui, Pemberian Susu Formula, Dan Mp-Asi Dengan Kejadian Gastroesophageal Reflux Pada Bayi Usia 0-6 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Sidomulyo Samarinda. *Jurnal Medika: Karya Ilmiah Kesehatan*, 7(1).
- Neville, M. C. (1999). Physiology Of Lactation. *Clinics In Perinatology*, 26(2), 251-279.
- Octaviani, N. A. (2021). *Hubungan Kecemasan Ibu Dengan Pemberian Asi Eksklusif Di Wilayah Kabupaten Sleman* (Doctoral Dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta).
- Pramana, C., Sirait, L. I., Kumalasari, M. L. F., Supinganto, A., & Hadi, S. P. I. (2021). *Manajemen Laktasi Berbasis Evidence Based Terkini*. Sebatik.
- Putri, D. M. (2013). Motivasi Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi Studi Kasus Di Kalangan Ibu Muda Bekerja.
- Raharjo, B. B. (2014). Profil Ibu Dan Peran Bidan Dalam Praktik Inisiasi Menyusu Dini Dan Asi Eksklusi. *Kemas: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 53-63.
- Rahmawati, N. A., Kep, M., Prayogi, N. B., & Kep, M. (2021). *Asuhan Keperawatan Manajemen Laktasi Dengan Pendekatan Berbasis Bukti: Buku Ajar*. Media Nusa Creative (Mnc Publishing).
- Ratnasari, F., Melinda, R., Septian, R. R., Afifah, R., Agustina, R., Lestari, R. D., ... & Selamita, S. (2022). Perawatan Payudara Dalam Meningkatkan Produksi Asi Pada Ibu Nifas. *Nusantara Hasana Journal*, 1(11), 36-39.
- Rosyida, D. A. C., Latifah, A., & Hidayatunnikmah, N. (2022). Asuhan Kebidanan Pada Nifas.
- Saputri, I. N., Ginting, D. Y., & Zendato, I. C. (2019). Pengaruh Pijat Oksitosin Terhadap Produksi Asi Pada Ibu Postpartum. *Jurnal Kebidanan Kestra (Jkk)*, 2(1), 68-73.
- Sari, T., Mudayati, S., & Lasri, L. (2017). Pengetahuan Tentang Manajemen Laktasi Dan Sikap Ibu Post Partum Dalam Proses Menyusui. *Care: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 3(2), 45-54.
- Siti, N. K. (2015). Segudang Keajaiban Asi Yang Harus Anda Ketahui. *Yogyakarta: Flasbooks*.
- Sriraman, N. K. (2017). The Nuts And Bolts Of Breastfeeding: Anatomy And Physiology Of Lactation. *Current Problems In Pediatric And Adolescent Health Care*, 47(12), 305-310.
- Wirakhmi, I. N., & Purnawan, I. (2021). *Anatomi Fisiologi Dalam Kehamilan*. Penerbit Nem.
- Wulandari, P., Menik, K., & Khusnul, A. (2018). Peningkatan Produksi Asi Ibu Post Partum Melalui Tindakan Pijat Oksitosin. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia [Jiki]*, 2(1), 33-49.

BAB 14

SYSTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

PASCA NIFAS DAN MENYUSUI

Irma Nurma Linda, S. Keb., Bd., M. Keb.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 14

**SYSTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
PASCA NIFAS DAN MENYUSUI**

Irma Nurma Linda, S. Keb., Bd., M. Keb.

A. Pendahuluan

Kematian Maternal dan Neonatal masih menjadi topik global di seluruh negara baik berkembang maupun negara maju. Indonesia angka kematian ibu (AKI) masih cukup tinggi di Negara ASEAN pada tahun 2015 (BPS, 2012). Sekitar 75% kematian langsung akibat dari perdarahan pasca salin, infeksi yang dialami selama pasca salin, tekanan darah tinggi saat kehamilan (preeklampsia atau eklampsia) dan partus lama atau macet, sedangkan akibat dari kematian tidak langsung keterlambatan dalam merujuk menjadi permasalahan. Oleh sebab itu baik penyebab langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan AKI di Indonesia (Indarwati, *et al* 2014).

Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman, pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau hal tersebut tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 5 ayat (2), sedangkan pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan fasilitas menurut jenis pelayanan terdiri dari 2 jenis yaitu Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat. Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua dan ketiga.

Sistem rujukan diperlukan untuk pasien sebagai peserta jaminan kesehatan atau kesehatan social asuransi di penyedia layanan kesehatan (Kemkes, RI 2013). Jaminan Kesehatan Nasional mewujudkan sistem rujukan berjenjang, dimana kesehatan pelayanan dimulai pada kesehatan primer tingkat pertama, seperti pusat kesehatan tingkat pertama (BPJS Kesehatan, 2016).

Upaya kesehatan perseorangan yang terdapat sistem rujukan efektif dalam meningkatkan kesehatan mulai dari pencegahan, pengobatan, pemulihan, dan upaya paliatif dari individu secara menyeluruh, terpadu, dan cara berkelanjutan. Rujukan medis bertujuan untuk memastikan pasien dapat menerima pelayanan yang berkualitas dan memuaskan sesuai indikasi medis (Damayanti, 2019).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan karakteristik rujukan medis, seperti kerjasama antar fasilitas kesehatan, kepatuhan dengan *Standard Operating Procedure* (SOP), sumber daya pendukung yang lengkap termasuk transportasi dan komunikasi, rujukan dengan formulir lengkap, komunikasi antar fasilitas kesehatan rujukan dan penerima rujukan, serta pelaksanaannya rujukan balik (Ratnasari, 2017).

B. Konsep Dasar Rujukan

1. Definisi Rujukan

Rujukan adalah suatu proses seseorang tenaga kesehatan berada di salah satu level system kesehatan, kekurangan sumber daya baik dari obat-obatan, alat ataupun skill dalam manage kondisi seseorang, atau mencari bantuan ke fasilitas yang lebih baik atau berbeda tapi tidak sama atau ke tingkat yang lebih tinggi (Gupta, A.K. *et al* 2017). Rujukan adalah penyerahan tanggung jawab dari satu pelayanan kesehatan ke pelayanan kesehatan yang lain (Susiloningtyas, 2020). Rujukan adalah system yang dinamik, mempunyai input, output serta komponen (Bashar, *et al* 2019).

2. Definisi system pelayanan rujukan

System rujukan adalah suatu system jaringan pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas timbulnya masalah dari suatu kasus atau masalah kesehatan masyarakat, baik secara vertical maupun horisontal, kepada yang lebih kompeten, terjangkau dan dilakukan secara rasional (Susiloningtyas, 2020).

Permen nomor 001 tahun 2012 tentang system rujukan pelayanan kesehatan perorangan. System rujukan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan, rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan pasien.

3. Macam-macam rujukan medis

Rujukan dilakukan secara vetikal dan horizontal. Rujukan vertikal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan serta dapat dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya. Rujukan horizontal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan, apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap (Listyorini, *et al* 2019).

Menurut Permen nomor 001 (2012), Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi dilakukan apabila:

- a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik
- b. Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan ketenagaan.

Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah dilakukan apabila:

- a. Permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya
- b. Kompetensi dan kewenangan pelayanan tingkat pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut
- c. pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang
- d. Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan ketenagaan.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotif*, *preventif*, *kuratif* maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan (Indarwati, *et al* 2014).

4. Tujuan System Rujukan

a. Tujuan umum:

System Rujukan adalah untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelayanan kesehatan secara terpadu (kebidanan komunitas). Tujuan umum rujukan untuk memberikan petunjuk kepada petugas kesehatan tentang pelaksanaan rujukan medis dalam rangka menurunkan IMR dan AMR (IDI,2018).

b. Tujuan khusus sistem rujukan yaitu:

- Meningkatkan kemampuan fasilitas kesehatan dan peningkatannya dalam rangka menangani rujukan kasus resiko tinggi dan gawat darurat yang terkait dengan kematian ibu maternal dan bayi
- Menyeragamkan dan menyederhanakan prosedur rujukan diwilayah kerja.

5. Jenis-Jenis Rujukan:

a) Menurut tata hubungannya, system rujukan terdiri dari rujukan internal dan rujukan eksternal

- 1) Rujukan internal adalah rujukan horizontal yang terjadi antar unit pelayanan di dalam institusi, unit terkait dalam system rujukan internal meliputi BP umum, KIA-KB, poli gigi, laboratorium, gizi, dan sanitasi.
- 2) Rujukan eksternal adalah rujukan yang terjadi antar unit-unit dalam jenjang pelayanan kesehatan, baik horizontal (dari puskesmas rawat jalan

ke Puskesmas rawat inap) maupun vertical (dari Puskesmas ke rumah sakit umum daerah).

b) Menurut lingkup pelayanannya, system rujukan terdiri dari rujukan medik dan rujukan kesehatan.

- a. Rujukan medik Rujukan ini terutama dikaitkan dengan upaya penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan, dengan demikian rujukan medik pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kedokteran (medical service). Sama halnya dengan rujukan kesehatan, rujukan medik ini dibedakan atas tiga macam yakni Kesehatan rujukan penderita, pengetahuan dan bahan-bahan pemeriksaan. Jenis rujukan medik antara lain:

a) *Transfer of patient*

Konsultasi penderita untuk keperluan diagnosis, pengobatan, tindakan operatif dan lain-lain.

b) *Transfer of specimen*

Pengiriman bahan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap.

c) *Transfer of knowledge* atau personal.

Pengiriman tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk meningkatkan mutu layanan setempat.

- b. Rujukan Kesehatan Masyarakat. Rujukan ini terutama dikaitkan dengan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan, dengan demikian rujukan kesehatan pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kesehatan masyarakat (public health service). Rujukan kesehatan dibedakan atas tiga macam yakni rujukan teknologi, sarana, dan operasional. Rujukan kesehatan yaitu hubungan dalam pengiriman, pemeriksaan bahan atau specimen ke fasilitas yang lebih mampu dan lengkap.

6. Prosedur Rujukan Klinis

- a. Melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang medik untuk menentukan diagnosis utama dan diagnosis banding.
- b. Memberikan tindakan stabilitas sesuai kasus *berdasarkan Standart Prosedur Operasional (SPO)*.
- c. Menentukan unit pelayanan tujuan rujukan.
- d. Untuk pasien gawat darurat harus didampingi tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya yang mengetahui kondisi pasien.
- e. Pasien diantar dengan kendaraan ambulans, agar petugas dan kendaraan pengantar tetap menunggu sampai pasien IGD mendapat kepastian pelayanan, apakah akan dirujuk atau ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

- f. Rujukan kasus yang memerlukan standart kompetensi tertentu (sub spesialis) pemberi pelayanan kesehatan tingkat satu (Puskesmas, Dokter Praktik, Bidan Praktik, Klinik) dapat merujuk langsung ke rumah sakit rujukan yang memiliki kompetensi tersebut.

Standar Operasional Prosedur Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2011 tentang *Standar Operasional Prosedur*, SOP adalah serangkaian petunjuk yang tertulis dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas dari pemerintah daerah. Standar opsional prosedur dibuat dalam bentuk: tabel, tertulis dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan, ditulis dengan jelas, rinci, serta benar, memperhatikan standar operasional yang lainnya, dan dapat dipertanggung jawabkan.

7. Syarat rujukan

- a. Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya.
- b. Persetujuan diberikan setelah pasien atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- c. Penjelasan sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Diagnosis, terapi dan tindakan medis yang diperlukan.
 - 2) Alasan dan tujuan dilakukan rujukan.
 - 3) Risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan.
 - 4) Transportasi rujukan.
 - 5) Risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

8. Persiapan rujukan

Perujuk sebelum melakukan rujukan harus:

- a. Melakukan pertolongan pertama atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan.
- b. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat.
- c. Membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan.

9. Kelengkapan surat rujukan

Surat pengantar rujukan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pasien
- b. Hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan)
- c. Diagnosis kerja
- d. Terapi atau tindakan yang telah diberikan
- e. Tujuan rujukan

- f. Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.

10. Manfaat dari system rujukan

Berbagai pihak mendapatkan manfaat dari system rujukan, antara lain:

- a. Pemerintah sebagai penentu kebijakan kesehatan (*policy maker*), manfaat yang akan diperoleh di antaranya, membantu penghematan dana dan memperjelas sistem pelayanan kesehatan.
- b. Masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan akan meringankan biaya pengobatan karena pelayanan yang diperoleh sangat mudah.
- c. Pelayanan kesehatan (*health provider*), mendorong jenjang karier tenaga kesehatan, selain meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan, serta meringankan beban tugas.

11. Jenis pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3 tingkatan

- a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama/FKTP merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua/FKRTL sekunder merupakan pelayanan kesehatan spesialis yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialis.
- c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga/FKRTL tersier merupakan pelayanan kesehatan sub spesialis yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialis.

Sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis, yaitu:

- a. Dimulai dari pelayanan di FKTP
- b. Jika diperlukan pelayanan lanjutan oleh spesialis, maka pasien dapat dirujuk ke FKRTL
- c. Pelayanan kesehatan tingkat kedua di faskes sekunder hanya dapat diberikan atas rujukan dari faskes primer.
- d. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga di faskes tersier hanya dapat diberikan atas rujukan dari faskes sekunder dan faskes primer

Ketentuan pelayanan rujukan berjenjang dapat dikecualikan apabila peserta BPJS Kesehatan dalam kondisi :

- a. Terjadi gawat darurat. Kondisi kegawatdaruratan mengikuti ketentuan yang berlaku
- b. Bencana, Kriteria bencana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
- c. Kekhususan permasalahan kesehatan pasien untuk kasus yang sudah ditegaskan rencana terapinya dan terapi tersebut hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan lanjutan

- d. Pertimbangan geografis
- e. Pertimbangan ketersediaan fasilitas

Rujukan parsial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di Faskes tersebut. Rujukan parsial dapat berupa:

- a. Pengiriman pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang atau tindakan
- b. Pengiriman spesimen untuk pemeriksaan penunjang

12. Material komponen dari system pelayanan rujukan

a. *Man* (Manusia)

Setiap tenaga kesehatan baik di FKTP maupun di FKTL harus lebih meningkatkan kemampuan profesionalismenya:

- *Attitude*
- *Knowledge*
- *Skill*

Yang terlibat dalam elemen ini adalah Institusi Pendidikan, Perhimpunan, dan Asosiasi FASKES/PERSI, RS, BPJS. Harapannya adalah dalam penyusunan regulasi juga tercantum adanya kewajiban Institusi tersebut berperan dalam pembinaan etik dan profesionalisme.

b. *Money* (Uang)

Tenaga kesehatan sebagai pelaksana garda terdepan dari pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagai manusia biasa tentunya juga harus memperhatikan kehidupannya beserta keluarganya, demikianpun untuk meningkatkan kemampuannya atau kompetensinya, semuanya ini memerlukan finansial yang tentunya harus diperhatikan juga.

c. *Machine* (Alat kesehatan atau Logistic farmasi)

Setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya memerlukan alat bantu dalam upaya menegakkan diagnosis. Alat bantu ini berupa alat kesehatan atau laboratorium, radiologi lainnya harus dilengkapi agar mutu dan keselamatan pasien dapat dipertanggung jawabkan dalam pelayanan kesehatan.

d. *Material* atau kelengkapan sarana-prasarana dan penentuan unggulan FKRTL (sistem kelas, regionalisasi)

Pemilik faskes: Pemerintah atau swasta, PERSI. Senantiasa koordinasi dengan lintas sektor baik tingkat pusat maupun daerah Harapannya sarana dan prasarana dapat dilengkapi sehingga dapat bekerja dengan aman dan tenteram, tidak diiringi dengan kecemasan oleh karena sarana dan prasarana yang kurang memadai.

- e. *Method* (management)
 - Pemahaman terhadap tatakelola klinik FKTP – FKRTL.
 - Membuat jejaring pelayanan kesehatan dengan rumah sakit sekitar swasta maupun pemerintah.
 - Perlu verikator tenaga medis.
 - Penyusunan clinical pathway.
- f. Senantiasa ikut terlibat dalam pertemuan-pertemuan untuk penyusunan regulasi Yang terlibat pada elemen ini adalah Organisasi Profesi, Institusi Pendidikan/FK, BPJS, FASKES, PERSI.
- g. Pelaksanaannya adalah berupa seminar, symposium untuk pemberian pemahaman terhadap tatakelola klinik, penyusunan *clinical pathway*, panduan praktis klinik. Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Rujukan Berjenjang, dilakukan oleh:
 - Ka Dinkes Kab/Kota dan organisasi profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama.
 - Ka Dinkes provinsi dan organisasi profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat kedua.
 - Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tertier.

13. Rekomendasi system rujukan

Keberhasilan suatu sistem sangat tergantung oleh adanya alur proses rujukan yang tertata serta adanya komunikasi yang kontinu dan konsisten antar unit yang merujuk dan yang di tuju. Dalam hal system rujukan kesehatan di era JKN yang perlu penataan adalah adanya kesamaan pandang atau sinkronisasi kepaahaman tentang tujuan rujukan, kualitas rujukan dan hubungan mekanisme yang berlangsung intra organisasi (FKTP) dengan kerangka kerja interorganisasi (FKTP), berupa adanya “*care pathway*” antara FKTP dengan FKRTL kontinu dan konsisten dengan cara berikut:

- a. Disarankan FKRTL untuk mengembangkan *Care Pathway* antara puskesmas/FKTP dengan rumah sakit/FKRTL agar terjadi suatu sinkronisasi konsep pelayanan yang berkesinambungan.
- b. Penataan system dengan metode 5 M
- c. Pemerintah menyediakan anggaran kesehatan yang cukup untuk program JKN dengan segera melakukan revisi besar kapitasi dengan revisi tarif INA CBGs dan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi faskes.

- d. Menyediakan sarana dan prasarana dan menjamin tersedianya obat-obatan baik dalam katalog serta penunjang medis (laboratorium, radiologi, dll)
- e. Penerapan sistem remunerasi jasa medis berpedoman pada panduan remunerasi yang disusun oleh IDI.

C. Konsep Dasar Rujukan Kebidanan

1. Definisi rujukan kebidanan

Rujukan kebidanan adalah Sistem rujukan dalam mekanisme pelayanan obstetri yakni pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus atau masalah kebidanan yang timbul baik secara vertikal maupun horizontal. Rujukan vertikal adalah rujukan dan komunikasi antara satu unit ke unit yang telah lengkap. Rujukan horizontal adalah konsultasi dan komunikasi antar unit yang ada dalam satu rumah sakit, misalnya antara bagian kebidanan dan bagian ilmu kesehatan anak (Indarwati, 2014).

2. Tujuan Rujukan kebidanan

Tujuan dari sistem rujukan adalah :

- a. Setiap penderita mendapat perawatan dan pertolongan yang sebaik-baiknya,
- b. Menjalinkan kerja sama dengan cara pengiriman penderita atau bahan laboratorium dari unit yang kurang lengkap ke unit yang lebih lengkap fasilitasnya,
- c. Menjalinkan pelimpahan pengetahuan dan keterampilan (*transfer of knowledge and skill*) melalui pendidikan dan pelatihan antara pusat dan daerah (Indarwati, 2014).

3. Keuntungan dari system rujukan

- a. Pelayanan yang diberikan sedekat mungkin ke tempat pasien, berarti bahwa pertolongan dapat diberikan lebih cepat, murah dan secara psikologis memberi rasa aman pada pasien dan keluarganya,
- b. Penataan yang teratur diharapkan pengetahuan dan keterampilan petugas daerah makin meningkat sehingga makin banyak kasus yang dapat dikelola di daerahnya masing-masing,
- c. Masyarakat desa dapat menikmati tenaga ahli.

4. Persiapan rujukan maternal

Menurut Wignyoastro *et al* (2008) dan WHO (2013) persiapan yang harus dipersiapkan dan diperhatikan dalam melakukan rujukan dapat disingkat menjadi BAKSOKU, meliputi:

- a. B (bidan) : pastikan klien didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegawatdaruratan.

- b. A (alat) : bawa perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan seperti spuit, infus set, tensimeter, dan stetoskop.
- c. K (keluarga) : beritahu keluarga tentang kondisi terakhir ibu (klien) dan alasan mengapa ia dirujuk. Suami dan anggota keluarga yang lain harus menemani ibu (klien) ke tempat rujukan.
- d. S (surat) : beri surat ke tempat rujukan yang berisi identifikasi ibu, alasan rujukan, uraian hasil rujukan, asuhan, atau obat-obat yang telah diterima ibu.
- e. O (obat) : bawa obat-obat esensial diperlukan selama perjalanan merujuk.
- f. K (kendaraan) : siapkan kendaraan yang cukup baik untuk memungkinkan ibu dalam kondisi yang nyaman dan dapat mencapai tempat rujukan dalam waktu yang cepat.
- g. U (uang) : ingatkan keluarga untuk membawa uang dalam jumlah yang cukup untuk membeli dan bahan kesehatan yang diperlukan di tempat rujukan.

5. Hambatan rujukan maternal

Hambatan rujukan akibat tiga terlambat masih menjadi kendala yang sampai saat ini belum bisa diatasi dengan baik. Secara garis besar hambatan rujukan terdiri dari terlambat mengambil keputusan baik oleh pasien maupun oleh tenaga kesehatan itu sendiri. Terlambat mengambil keputusan dipengaruhi oleh beberapa alasan yaitu sosial ekonomi dan budaya, akses menuju fasilitas kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan (Calvelo, J. *et al* 2015).

Ketidakmampuan dalam pembiayaan tidak hanya masalah biaya perawatan di rumah sakit tetapi juga biaya kehidupan rumah sakit seperti biaya transportasi, biaya makan penunggu pasien menjadi pertimbangan saat dilakukan rujukan (Merali, *et al* 2014). Jauhnya tempat rujukan dengan tempat tinggal pasien membuat terlambatnya mengambil keputusan karena masih mencari transportasi yang bisa digunakan ke tempat rujukan. Dalam mengambil keputusan yang cepat terkadang lama mengambil keputusan karena pasien masih melakukan runding dengan keluarga. Suami sebagai pencari nafkah menyebabkan adanya asumsi bahwa suami yang mengambil keputusan dalam menentukan rujukan. Selain ditentukan oleh suami, pengambil keputusan juga dilakukan oleh mertua perempuan oleh karena pengalamannya yang terdahulu ketika mengalami kehamilan dan persalinan (Waiswa P, *et al* 2010).

Terlambat mencapai fasilitas kesehatan secara tepat waktu juga menjadi hambatan rujukan yang kedua. Akses ke fasilitas kesehatan menjadi point utama yang menjadi penyebab terlambatnya mencapai fasilitas rujukan secara tepat waktu. Akses ke fasilitas rujukan dipengaruhi oleh kondisi geografis setempat. Kondisi jalan yang rusak, jarak tempuh dan waktu tempuh sangat

memengaruhi kecepatan mencapai fasilitas rujukan. Jalan di daerah perdesaan terpencil dalam kondisi rusak, bergelombang menyebabkan susah mencapai tempat rujukan. Jika di daerah perdesaan terkendala karena akses jalan yang kurang bagus, berbeda lagi dengan kondisi di daerah perkotaan yang padat lalu lintas. Dari segi jarak dekat dengan fasilitas kesehatan rujukan, tetapi padatnya lalu lintas menyebabkan terlambatnya mencapai fasilitas kesehatan. Kondisi jalan, jarak mempengaruhi waktu tempuh untuk mencapai fasilitas kesehatan. Waktu tempuh terbaik yang harus dicapai untuk kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal adalah 2 jam sehingga pasien mempunyai kemungkinan besar untuk bisa diselamatkan (Munjaja P, *et al* 2012). Kendala transportasi menyebabkan terlambatnya mencapai fasilitas kesehatan. Di daerah terpencil mereka harus jalan kaki mencapai fasilitas kesehatan walaupun jarak antara rumah dengan fasilitas kesehatan tidak terlalu jauh juga menjadi kendala (Give, C. *et al* 2019).

Terlambat yang ketiga adalah terlambat mendapat penanganan di fasilitas kesehatan. Pasien tiba di fasilitas kesehatan rujukan sudah dalam keadaan kritis. Rumitnya administrasi untuk masuk rumah sakit menjadi penyebab terlambat yang ketiga. Kualitas pelayanan fasilitas kesehatan seperti ketersediaan bank darah menjadi kendala rujukan kasus kegawatdaruratan sehingga menyebabkan kematian maternal yang seharusnya bisa dicegah (Merali, *et al* 2014).

Rendahnya kualitas atau kompetensi tenaga kesehatan, double job, komunikasi yang tidak efektif antara pemberi rujukan dengan tempat rujukan menyebabkan terlambatnya rujukan (Nestelita D, 2019). Rendahnya sarana prasarana rumah sakit, ketidakmampuan nakes memahami SOP rujukan menjadi penyebab terlambatnya mendapat penanganan di faskes rujukan. Kurangnya tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan primer untuk memberikan stabilisasi pra rujukan sehingga pasien tiba di rumah sakit dalam kondisi yang kritis (Ose, *et al* 2019).

Komunikasi antara yang melakukan rujukan (fasilitas kesehatan primer) dengan fasilitas kesehatan tempat rujukan (sekunder maupun tersier) tidak hanya dilakukan secara lisan tetapi juga tertulis belum berjalan secara optimal sehingga tidak ada feedback rujukan dari tempat rujukan ke yang memberi rujukan menyebabkan komunikasi tidak berjalan dengan optimal (Schnittger, T.P. *et al* 2018).

D. Masa nifas

1. Definisi masa nifas

Masa nifas (puerperium) adalah masa setelah plasenta lahir hingga alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil dalam waktu kurang lebih 6 minggu (WHO, 2013). Adapun esensial asuhan masa nifas menurut Puji (2018) adalah sebagai berikut:

- Menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik maupun psikologis dimana dalam asuhan pada masa ini peranan keluarga sangat penting, dengan pemberian nutrisi, dukungan psikologi maka kesehatan ibu dan bayi selalu terjaga.
- Melaksanakan skrining yang komprehensif (menyeluruh) dimana bidan harus melakukan manajemen asuhan kebidanan pada ibu masa nifas secara sistematis yaitu mulai pengkajian data subjektif, objektif maupun penunjang.
- Setelah bidan melaksanakan pengkajian data maka bidan harus menganalisa cara tersebut sehingga tujuan asuhan masa nifas dapat mendeteksi masalah yang terjadi pada ibu dan bayi.
- Merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu dan bayinya, yakni setelah masalah ditemukan maka bidan dapat langsung masuk kelangkah berikutnya sehingga tujuan diatas dapat dilaksanakan.
- Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi kepada bayinya dan perawatan bayi sehat memberi pelayanan keluarga berencana.

2. Asuhan kunjungan selama masa nifas

Tabel 16.1 Asuhan

Kunjungan	Waktu	Asuhan
I	6-8 jam post partum	Mencegah perdarahan masa nifas oleh karena atonia uteri.
		Mendeteksi dan perawatan penyebab lain perdarahan serta melakukan rujukan bila perdarahan berlanjut.
		Memberikan konseling pada ibu dan keluarga tentang cara mencegah perdarahan yang disebabkan atonia uteri.
		Pemberian ASI awal.
		Mengajarkan cara memperlambat hubungan antara ibu dan bayi baru lahir.
		Menjaga bayi tetap sehat melalui pencegahan hipotermi.
		Setelah bidan melakukan pertolongan persalinan, maka bidan harus menjaga ibu dan bayi untuk 2 jam pertama setelah kelahiran atau sampai keadaan ibu dan bayi baru lahir dalam keadaan baik.
II	6 hari post partum	Memastikan involusi uterus berjalan dengan normal, uterus berkontraksi dengan baik, tinggi fundus uteri di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal.
		Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi dan perdarahan.
		Memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup.
		Memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi dan cukup cairan.
		Memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar serta tidak ada tanda-tanda kesulitan menyusui.
		Memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir.
III	2 minggu post partum	Asuhan pada 2 minggu post partum sama dengan asuhan yang diberikan pada kunjungan 6 hari post partum.
IV	6 minggu post partum	Menanyakan penyulit-penyulit yang dialami ibu selama masa nifas.
		Memberikan konseling KB secara dini.

Sumber: Kemenkes, RI 2013

3. Asuhan kebidanan Postpartum yang Berpusat pada Ibu (Women Centered Care)

Women centered Care adalah istilah yang digunakan untuk filosofi asuhan kebidanan yang memberi prioritas pada keinginan dan kebutuhan pengguna, dan menekankan pentingnya *informed choice*, kontinuitas perawatan, keterlibatan pengguna, efektivitas klinis, respon dan aksesibilitas. Dalam hal ini bidan difokuskan memberikan dukungan pada wanita dalam upaya memperoleh status yang sama di masyarakat untuk memilih dan memutuskan perawatan kesehatan dirinya (Cunningham, 2012).

Berbagai hasil penelitian menunjukkan pentingnya asuhan yang berorientasi pada wanita dimana mereka punya peran dalam menentukan pilihan sehingga terpenuhi kebutuhannya dan timbul kepuasan ibu. Asuhan kebidanan yang berorientasi pada wanita atau *Women centered Care* amat penting untuk kemajuan praktik kebidanan. Dalam praktik kebidanan, *Women centered Care* dalam asuhan kebidanan nifas dan menyusui adalah sebuah konsep yang menyiratkan hal sebagai berikut.

- a. Asuhan yang berfokus pada kebutuhan wanita yang unik, harapan dan aspirasi wanita tersebut daripada kebutuhan lembaga-lembaga atau profesi yang terlibat.
- b. Memperhatikan hak-hak perempuan untuk menentukan nasib sendiri dalam hal pilihan, kontrol dan kontinuitas asuhan kebidanan nifas dan menyusui.
- c. Meliputi kebutuhan janin, bayi, atau keluarga ibu, orang lain yang signifikan, seperti yang diidentifikasi dan dipercaya atau mendukung oleh ibu tersebut.
- d. Melibatkan peran serta masyarakat, melalui semua tahap mulai dari kehamilan, persalinan, dan setelah kelahiran bayi.
- e. Melibatkan kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya bila diperlukan.
- f. 'Holistik' dalam hal menangani masalah sosial ibu, emosional, fisik, psikologis, kebutuhan spiritual dan budaya.

4. Kegawatdaruratan Masa Nifas dan Menyusui

Rujukan kegawatdaruratan adalah rujukan yang dilakukan sesegera mungkin karena berhubungan dengan kondisi kegawatdaruratan yang mendesak (WHO, 2013).

Pada saat nifas merupakan masa kritis kembalinya seluruh system organ tubuh ibu menuju keadaan sebelum hamil yang diperkirakan 6 minggu, selama proses tersebut banyak terdapat kondisi kegawatdaruratan yang perlu di waspadai oleh bidan dalam memberikan pelayanan mandiri hingga

rujukan. Tidak hanya selama waktu 6 minggu bahkan banyak permasalahan selama waktu menyusui hingga 2 tahun lamanya. Adapun kondisi yang dapat mengakibatkan bidan melakukan rujukan maternal maupun neonatal sebagai berikut:

a. Perdarahan postpartum

Perdarahan postpartum dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.

- I. Perdarahan postpartum primer (*Early Postpartum Hemorrhage*) adalah perdarahan lebih dari 500-600 ml dalam masa 24 jam setelah anak lahir, atau perdarahan dengan volume seberapa pun tetapi terjadi perubahan keadaan umum ibu dan tanda-tanda vital sudah menunjukkan adanya perdarahan. Penyebab utama adalah atonia uteri, retensio placenta, sisa placenta dan robekan jalan lahir. Terbanyak dalam 2 jam pertama.
- II. Perdarahan postpartum sekunder (*Late Postpartum Hemorrhage*) adalah perdarahan dengan konsep pengertian yang sama seperti perdarahan postpartum primer namun terjadi setelah 24 jam postpartum hingga masa nifas selesai. Perdarahan postpartum sekunder yang terjadi setelah 24 jam, biasanya terjadi antara hari ke 5 sampai 15 postpartum. Penyebab utama adalah robekan jalan lahir dan sisa placenta (Prawirohardjo, 2007). Menurut Manuaba (2010), perdarahan postpartum merupakan penyebab penting kematian maternal khususnya di negara berkembang.

Secara garis besar dapat disimpulkan penyebab perdarahan postpartum adalah 4T, yaitu Tonus, Tissue, Trauma dan Trombosis (Cunningham, 2012).

b. Infeksi puerperalis

Beberapa bakteri dapat menyebabkan infeksi setelah persalinan, Infeksi masa nifas masih merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu. Infeksi alat genital merupakan komplikasi masa nifas. Infeksi yang meluas ke saluran urinari, payudara, dan pasca pembedahan merupakan salah satu penyebab terjadinya AKI tinggi. Gejala umum infeksi berupa suhu badan panas, malaise, denyut nadi cepat. Gejala lokal dapat berupa uterus lembek, kemerahan dan rasa nyeri pada payudara atau adanya dysuria (Wahyuningsih, 2018).

c. Subinvolusi

Involusi adalah keadaan uterus mengecil oleh kontraksi rahim dimana berat rahim dari 1000 gram saat setelah bersalin, menjadi 40-60 mg pada 6 minggu kemudian. Bila pengecilan ini kurang baik atau terganggu disebut sub involusi (Mochtar, 2010). Faktor penyebab sub involusi, antara lain: sisa plasenta dalam uterus, endometritis, adanya mioma uteri

(Cunningham, 2012). Pada keadaan sub involusi, pemeriksaan bimanual di temukan uterus lebih besar dan lebih lembek dari seharusnya, fundus masih tinggi, lochea banyak dan berbau, dan tidak jarang terdapat pula perdarahan (Prawirohardjo, 2007). Pengobatan di lakukan dengan memberikan injeksi Methergin setiap hari di tambah dengan Ergometrin per oral. Bila ada sisa plasenta lakukan kuretase. Berikan Antibiotika sebagai pelindung infeksi (WHO, 2013). Bidan mempunyai peran untuk mendeteksi keadaan ini dan mengambil keputusan untuk merujuk pada fasilitas kesehatan rujukan.

d. Suhu tubuh ibu $>38^{\circ}\text{C}$

Dalam beberapa hari setelah melahirkan suhu badan ibu sedikit meningkat antara $37,2^{\circ}\text{C}$ - $37,8^{\circ}\text{C}$ oleh karena reabsorpsi proses perlukaan dalam uterus, proses autolisis, proses iskemic serta mulainya laktasi, dalam hal ini disebut demam reabsorpsi. Hal ini adalah peristiwa fisiologis apabila tidak disertai tanda-tanda infeksi yang lain. Namun apabila terjadi peningkatan melebihi 38°C berturut-turut selama 2 hari kemungkinan terjadi infeksi. Infeksi nifas adalah keadaan yang mencakup semua peradangan alat-alat genitalia dalam masa nifas (Mochtar, 2010). Penanganan umum bila terjadi demam adalah sebagai berikut.

- I. Istirahat baring
- II. Rehidrasi peroral atau infus
- III. Kompres hangat untuk menurunkan suhu
- IV. Jika ada syok, segera berikan pertolongan kegawatdaruratan maternal, sekalipun tidak jelas gejala syok, harus waspada untuk menilai berkala karena kondisi ini dapat memburuk dengan keadaan ibu cepat (Prawirohardjo, 2007).

e. Payudara merah, panas dan terasa sakit

Keadaan ini dapat disebabkan oleh payudara yang tidak disusu secara adekuat, puting susu yang lecet, BH yang terlalu ketat, ibu dengan diet yang kurang baik, kurang istirahat, serta anemia. Keadaan ini juga dapat merupakan tanda dan gejala adanya komplikasi dan penyulit pada proses laktasi, misalnya pembengkakan payudara, bendungan ASI, mastitis dan abses payudara.

f. Demam, muntah, dan rasa sakit waktu berkemih

Pada masa nifas awal sensitifitas kandung kemih terhadap tegangan air kemih di dalam vesika sering menurun akibat trauma persalinan serta analgesia epidural atau spinal. Sensasi peregangan kandung kemih juga mungkin berkurang akibat rasa tidak nyaman, yang ditimbulkan oleh episiotomi yang lebar, laserasi, hematoma dinding vagina.

g. Masalah perkemihan

Pada ibu postpartum terdapat peningkatan kapasitas kandung kemih, pembengkakan dan trauma jaringan sekitar uretra yang terjadi selama proses melahirkan. Hal ini terjadi akibat proses kelahiran dan efek konduksi anestesi yang menghambat fungsi neural pada kandung kemih. Distensi yang berlebihan pada kandung kemih dapat mengakibatkan perdarahan. Pengosongan kandung kemih harus diperhatikan. Kandung kemih biasanya akan pulih dalam waktu 5-7 hari pasca melahirkan sedangkan saluran kemih normal dalam waktu 2-8 minggu tergantung pada keadaan atau status sebelum persalinan, lamanya kala II yang dilalui, besarnya tekanan kepala janin saat lahir.

Dinding kandung kencing memperlihatkan oedema dan hyperemia. Kadang-kadang oedema pada trigonum, menimbulkan abstraksi dari uretra sehingga terjadi retensio urine. Kandung kencing dalam puerperium kurang sensitif dan kapasitasnya bertambah, sehingga kandung kencing penuh atau sesudah kencing masih tertinggal urine residual (normal + 15 cc). Sisa urine dan trauma pada kandung kencing waktu persalinan memudahkan terjadinya infeksi.

Pada masa hamil, terjadi perubahan hormonal yaitu kadar steroid tinggi yang berperan meningkatkan fungsi ginjal. Begitu sebaliknya, pada pasca melahirkan kadar steroid menurun sehingga menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Fungsi ginjal kembali normal dalam waktu satu bulan setelah wanita melahirkan. Urin dalam jumlah yang besar akan dihasilkan dalam waktu 12-36 jam sesudah melahirkan.

Buang air kecil sering sulit selama 24 jam pertama, kemungkinan terdapat spasme sfingter dan edema leher buli-buli sesudah bagian ini mengalami kompresi antara kepala janin dan tulang pubis selama persalinan. Setelah plasenta dilahirkan, kadar hormon estrogen yang bersifat menahan air akan mengalami penurunan yang drastis. Keadaan ini menyebabkan diuresis. Ureter yang berdilatasi akan kembali normal dalam tempo 6 minggu. Bila ibu postpartum tidak dapat berkemih dalam kurun waktu 6 jam pasca persalinan, perlu dilakukan upaya perangsangan secara alamiah agar ibu berkemih, misalnya dengan cara: mendengarkan aliran air, memberikan minum, mengompres dengan air pada daerah suprapubik, dan lain-lain. Bila kemudian tetap tak dapat berkemih dalam waktu lebih dari 6 jam, lakukan kateterisasi dan bila jumlah residu > 200 ml maka kemungkinan ada gangguan proses urinasinya. Maka kateter tetap terpasang dan dibuka 4 jam kemudian, bila volume urine < 200 ml, kateter langsung dibuka dan ibu diharapkan dapat berkemih seperti biasa.

h. Anemia postpartum

Menurut Prawirohardjo (2007), faktor yang mempengaruhi anemia pada masa nifas adalah persalinan dengan perdarahan, ibu hamil dengan anemia, asupan nutrisi yang kurang, serta penyakit virus dan bakteri. Anemia dalam masa nifas sebagian besar merupakan kelanjutan dari anemia yang diderita saat kehamilan, yang menyebabkan banyak keluhan bagi ibu dan mempengaruhi dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam merawat bayi. Pengaruh anemia pada masa nifas adalah terjadinya subvolusi uteri yang dapat menimbulkan perdarahan postpartum, memudahkan infeksi puerperium, pengeluaran ASI berkurang dan mudah terjadi infeksi mammae. Anemia postpartum kemungkinan menjadi salah satu prediktor praktik ASI tidak eksklusif. Pada ibu anemia postpartum pengeluaran ASI berkurang, terjadinya dekompensasi kordis mendadak setelah persalinan dan mudah terjadi infeksi mammae. Pada masa nifas anemia bisa menyebabkan uterus berkontraksi tidak efektif, hal ini dikarenakan darah tidak cukup untuk memberikan oksigen ke rahim.

Penyebab utama anemia pada ibu postpartum adalah kurang memadainya asupan makanan sumber Fe, meningkatnya kebutuhan Fe saat hamil dan menyusui (terkait dengan perubahan fisiologi), dan kehilangan darah saat proses persalinan. Anemia yang disebabkan oleh ketiga faktor itu terjadi secara cepat saat cadangan Fe pada tubuh ibu tidak mencukupi peningkatan kebutuhan Fe. Penatalaksanaan anemia dalam nifas adalah sebagai berikut.

- i. Lakukan pemeriksaan Hb postpartum sebaiknya 3-4 hari setelah bayi lahir, kecuali ada indikasi lain yang memerlukan pemeriksaan Hb yang lebih cepat, misalnya keadaan perdarahan atau patologi tertentu.
 - ii. Anjurkan ibu makan yang mengandung tinggi protein dan zat besi, seperti telur, ikan, dan sayuran.
 - iii. Pada keadaan anemia berlanjut, maka bidan harus melakukan rujukan maupun
 - iv. kolaborasi dengan dokter kemungkinan diperlukan transfusi apabila Hb < 7 gr%.
- i. Preeklampsia atau eklampsia postpartum

Preeklampsia dan eklampsia tidak hanya terjadi pada masa kehamilan, namun pada beberapa kasus preeklampsia/eklampsia dapat berlanjut hingga pada masa postpartum. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa 67% kasus pre-eklampsia terjadi selama masa kehamilan atau sebelum kelahiran. Selebihnya, 33% kasus terjadi setelah proses persalinan dan 79% di antaranya terjadi 48 jam setelah

melahirkan. Risiko terjadi preeklampsia masih cukup tinggi selama hingga 28 hari setelah persalinan. Secara klinis biasanya diawali dengan hipertensi. Preeklampsia pasca persalinan (postpartum preeclampsia) biasanya ditandai dengan gejala hampir sama dengan pre-eklampsia pada masa hamil. Di antaranya, tekanan darah meningkat (hipertensi), pusing dan kejang, penglihatan terganggu (pandangan menjadi kabur), sakit perut, pembengkakan terutama pada kaki, merasa cepat lelah, serta nyeri otot atau persendian.

DAFTAR PUSTAKA

- Armini, L.N,. (2020). Hambatan Rujukan pada Kasus Kegawatdaruratan Maternal. *Seminar Nasional Kebidanan*, 46-53.
<http://jurnal.unw.ac.id/index.php/semnasbidan/article/view/643/469>
- Bashar, A,. Bhattacharya, S,. Tripathi, S,. Sharma, N,. Singh, A,. (2019). Strengthening Primary Health Care Through e-referral System. *J Family Med Prim Care*, 8(4), 1511-1513.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2012). Kemenkes. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Jakarta: BKKBN, Kemenkes, RI.
- BPJS Kesehatan. (2016). Ringkasan Eksekutif Laporan Pengelolaan Program Dan Laporan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2016. Jakarta.
<https://bpjskesehatan.go.id/BPJS/index.php/arsip/detail/951>.
- Calvello, J.E,. Skog, P.A, Tenner, G.A, Lee, A,. Wallis, A.L. (2015). Applying The lessons of Maternal Mortality Reduction to Global Emergency Health. *Bulletin of the World Health Organization*;93:417–23.
- Cunningham, G. Brahm U.P,. Rudi, S,. 2012. Obstetri Williams. Volume 1. McGraw Hill Education (Asia) and EGC Medical Publisher.
- Damayanti, N.S,. (2019). The Implementation of Clinical Procedures In The Vertical Referral System In A Primary Healthcare Center. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 7(1), 73-80.
- Gupta, A.K,. Talati, S,. Bhattacharya, S,. Singh, A. (2017). Health System Strengthening- Focussing on Referrals: An Analysis from India. *JOJ Nurse Health Car*, 2(4):1-3.
- IDI, (2018). Penataan Sistem Pelayanan Kesehatan Rujukan.
<https://dinkes.jatimprov.go.id/userfile/dokumen/Sistem-Pelayanan-Rujukan.pdf>.
- Indarwati,Wahyuni,. (2014). Pelaksanaan Rujukan Persalinan dan Kendala yang Dihadapi. *INFOKES*, 4(1), 1-11.
- KMK No 252. (2015). Asosiasi Fasilitas Kesehatan.
http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No._HK_.02_.02-MENKES-252-2016_ttg_Asosiasi_Fasilitas_Kesehatan_.pdf
- Kementrian Dalam Negeri RI. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten atau Kota. Jakarta: Kemendagri RI.
- Kemenkes RI. (2012). Pedoman Sistem Rujukan Nasional. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2013). Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Listyorini, P.I., Wijananto, D.A., (2019). Sistem Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Jayengan Kota Surakarta. *Infokes*, 9(1), 1-14.
- Manuaba, IGB. (2010). Ilmu Kebidanan dan Kandungan untuk Bidan. Jakarta: EGC.
- Mochtar, R. (2010). Sinopsis obstetri: obstetri fisiologi obstetri patologi. Jakarta: EGC.
- Merali, S.H, Lipsitz, S, Hevelone, N., Gawande, A.A., Lashoher, A.P,.. (2014). Audit-Identified Avoidable Factors in Maternal and Perinatal Deaths in Low Resource Settings: A Systematic Review. *BMC Pregnancy & Childbirth*.;14:280:
- Munjanja, P.S., Magure, T., Kandawasvika, G. (2012). Geographical Access, Transport and Referral Systems. CAB International.
- Nestelita, D., Suryoputro, A., Kusumastuti, W. (2019). Proses System Rujukan dalam Pelayanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal di Puskesmas Sayung 2 Kabupaten Demak. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*. 18(4).
- Ose, I.M. (2019). Analisis Keterbatasan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Pada Pelayanan UGG Puskesmas/PMC; Literatur review. *Journal of Borneo Health*, 109-117.
- Prawirohardjo, S. Wiknjosastro, H. (2007). Ilmu kebidanan, Edisi Keempat. Jakarta: PT Bina Pustaka Yayasan Sarwono Prawirohardjo.
- Pepres No 28 tahun 2016. (2016). Perubahan Ketiga atas Pepres No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40124/perpres-no-28-tahun-2016>
- Permenkes No 001 tahun 2012. (2012). Sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan. <https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/03/13/peraturan-menteri-kesehatan-republik-indonesia-nomor-001-tahun-2012-tentang-sistem-rujukan-pelayanan-kesehatan-perorangan.html>
- Permenkes No 71 tahun 2013. (2013). Pelayanan Kesehatan pada JKN. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129904/permenkes-no-71-tahun-2013>
- Permenkes No 28 tahun 2014. (2014). Pedoman Pelaksanaan JKN. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/117565/permenkes-no-28-tahun-2014>
- Permenkes No 99 tahun 2015. (2015). Pelayanan Kesehatan pada JKN. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/116673/permenkes-no-99-tahun-2015>
- Ratnasari, D. (2017). Analisis Pelaksanaan Sistem Rujukan Berjenjang Bagi Peserta JKN di Puskesmas X Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 5(2), 145–154.
- Susiloningtyas, L., (2010). Sistem Rujukan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Maternal Perinatal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pemenang*, 2(1). 6-16.

- Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf
- Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.
https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/peraturan/09012015_101207_uu_24_11_bpjs.pdf
- Schnittger, T.P., O'Doherty, J., O'Connor, R., O'Regan, A. (2018). Improving quality of referral letters from primary to secondary care: a literature review and discussion paper. *Primary Health Care Research & Development*; 19:211- 222.
- Wahyuningsih, H.W. (2018). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Jakarta: Kemenkes RI.
- Waiswa, P., Kallander, K., Peterson, S., Tomson, G., Pariyo, W.G. Using The Three Delays Model to Understand Why Newborn Babies Die In Eastern Uganda. *Tropical Medicine and International Health*. 2010;15(8):964–72
- Widyana, E.D. (2011). Evaluasi Pelaksanaan Rujukan Ibu Bersalin dengan Komplikasi Persalinan oleh Bidan Desa di Puskesmas Sukorejo Pasuruan, *jurnal penelitian kesehatan Forikes*, 11(4), 241-246.
- Wignyosastro, G., Prayanti, M., Nurani, V (2008) Modul Pelatihan Penyegaran Ketrampilan Klinis Bidan, Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal Serta Kontrasepsi, Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan, Jakarta.
- WHO, 2013. Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan, Jakarta: Kemenkes, UNFPA, POGI, IBI.

BAB 15

**GANGGUAN PSIKOLOGIS PADA POSPARTUM DAN
SCREENING MENGGUNAKAN EDINBURGH
POSTNATAL DEPRESSION SCALE (EPDS)**

Dwi Rahmawati, SST.,M.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 15

**GANGGUAN PSIKOLOGIS PADA POSPARTUM
DAN SCREENING MENGGUNAKAN
EDINBURGH POSTNATAL DEPRESSION SCALE (EPDS)**

Dwi Rahmawati, SST., M.Keb

A. Pengertian

Syndrome baby blues adalah perasaan sedih yang dibawa ibu sejak hamil yang berhubungan dengan kesulitan ibu menerima kehadiran bayinya. Perubahan ini sebenarnya merupakan respon alami dari kelelahan pasca persalinan (Pieter dan Lubis, 2010).

Mansur (2009) juga menyebutkan bahwa *syndrome baby blues* merupakan perasaan sedih yang dialami oleh ibu setelah melahirkan, hal ini berkaitan dengan bayinya. *Postpartum blues* adalah gangguan suasana hati yang berlangsung selama 3-6 hari pasca melahirkan. *Syndrome baby blues* ini sering terjadi dalam 14 hari pertama setelah melahirkan, dan cenderung lebih buruk pada hari ke tiga dan ke empat.

Gangguan *mood postpartum* adalah gangguan suasana hati ibu yang baru melahirkan dan bersifat sementara. Lebih sering terjadi pada anak pertama, berlangsung 1-10 hari, 2 minggu dan dapat menetap menjadi *depresi postpartum* (Posmontier & Waite, 2011)

B. Tanda dan Gejala

Menurut (Wahyuningsih, 2018) kesedihan atau kemurungan setelah melahirkan ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Sedih.
2. Cemas tanpa sebab.
3. Mudah menangis tanpa sebab.
4. Euforia, kadang tertawa.
5. Tidak sabar.
6. Tidak percaya diri.
7. Sensitif.
8. Mudah tersinggung (iritabilitas).
9. Merasa kurang menyayangi bayinya.

C. Penyebab *postpartum blues*

Bobak (2004) beberapa penyebab *postpartum blues* diantaranya :

1. Perubahan Hormon
2. Stress

3. ASI tidak keluar
4. Frustasi karena bayi tidak mau tidur, nangis dan gumoh
5. Kelelahan pasca melahirkan, dan sakitnya akibat operasi
6. Suami yang tidak membantu, tidak mau mengerti perasaan istri maupun persoalan lainnya dengan suami
7. Masalah dengan Orang tua dan Mertua
8. Takut kehilangan bayi
9. Sendirian mengurus bayi, tidak ada yang membantu
10. Takut untuk memulai hubungan suami istri (ML), anak akan terganggu.
11. Bayi sakit (Kuning, dll).
12. Rasa bosan si Ibu.
13. Problem dengan si sulung.

D. Faktor risiko *postpartum blues*

1. Faktor biologis

Faktor-faktor hormonal yang mempengaruhi *postpartum blues* adalah kadar hormon-hormon seperti estrogen, progesterone, prolaktin, kortisol, dan estradiol yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam masa nifas.

Menurut penelitian (Sumarni, 2019) menyatakan bahwa didapatkan hasil kadar estradiol lebih tinggi pada wanita yang mengalami *postpartum blues* dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalaminya.

Kadar progesteron setelah melahirkan yang relatif rendah mempunyai hubungan dengan *postpartum blues*, semakin besar penurunan kadar progesteron setelah persalinan makin besar kecenderungan seorang wanita mengalami *postpartum blues* dalam waktu 10 hari pertama setelah melahirkan. Penurunan kadar estrogen setelah melahirkan berpengaruh terhadap kejadian *postpartum blues* karena estrogen memiliki efek depresi, aktifitas enzim monoamine oksidase nor adrenalin dan serotonin yang berperan dalam perubahan mood dan kejadian depresi (Dalton & Castillo, 2014)

Berkurangnya ketersediaan neurotransmitter monoamin, terutama norepinefrin dan serotonin, dapat menyebabkan depresi. Teori ini diperkuat dengan ditemukannya obat-obat antidepresan seperti trisiklik dan monoamine oksidase inhibitor yang secara singkat dapat meningkatkan monoamine di celah sinap, dimana peningkatan tersebut berkaitan dengan terjadinya perbaikan depresi (Amir, 2005).

a. Serotonin

Nukleus serotonergic berproyeksi dari nucleus rafe dorsalis batang otak ke korteks serebri, hipotalamus, thalamus, ganglia basalis, septum dan hipokampus. Proyeksinya ke tempat-tempat ini mendasari keterlibatannya pada gangguan psikiatrik (Thase, 2005). Serotonin berfungsi sebagai

pengatur tidur, selera makan dan libido. Sistem serotonergic yang berproyeksi ke nucleus suprakiasma hipotalamus berfungsi mengatur siklus sirkadian, misalnya: siklus tidur bangun, temperature tubuh dan fungsi hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA) (Amir, 2005).

b. Norepineprin

Badan sel neuron norepinefrin terletak di locus ceruleus batang otak dan berproyeksi ke korteks serebri, sistem limbic, ganglia basalis, hipotalamus dan thalamus. Aktivasi fungsi locus ceruleus menyebabkan penurunan fungsi vegetative seperti tidur dan makan yang menurun (Thase, 2005); Amir, 2005).

c. Dopamin

Ada empat jalur utama dopamine di otak yaitu: jalur tuberoinfundibular, nigrostriatal, mesolimbic dan mesokorteks. Jalur mesolimbic berperan dalam ekspresi emosional, belajar dan penguatan serta perasaan senang. Penurunan aktivitas dopamine pada jalur mesolimbic dan mesokorteks menyebabkan gangguan kognitif, motorik dan kegembiraan yang berhubungan dengan depresi (Thase, 2005).

2. Faktor demografi

a. Usia

Faktor umur yang terlalu muda untuk hamil akan memicu resiko bagi ibu dan anak dari segi fisik dan psikis baik itu selama kehamilan maupun persalinan (Rusli, 2011). Umur yang terlalu muda untuk melahirkan, sehingga dia memikirkan tanggung jawabnya sebagai ibu untuk mengurus anaknya. Umur ibu sangat mempengaruhi perkembangan bayi mereka.

Umur ibu kurang dari 20 tahun, lebih banyak memiliki dampak psikologi yang merugikan akibat kemungkinan efek jangka panjang pada pendidikan dan karir masa depan, implikasi finansial tentang perawatan anak, kurang pengetahuan tentang mengasuh anak, gangguan psikologis saat ia berada pada tahap pembentukan identitas diri sedangkan usia lebih dari 35 tahun cenderung akan meningkatkan risiko abnormalitas kongenital janin yang disebabkan faktor subfertilitas (Henderson, 2006).

b. Paritas

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *baby blues* adalah paritas ibu. Sebagian besar ibu postpartum yang mengalami stres yaitu ibu primipara dibandingkan ibu multipara. Ibu yang baru pertama melahirkan belum ada pengalaman dalam proses persalinan sehingga kurang persiapan dan manajemen diri. Manajemen diri yang kurang baik bisa saja menimbulkan kelelahan yang tinggi akibat dari rasa sakit setelah melahirkan, pola makan yang tidak sehat, perubahan pola tidur, dan bertambahnya aktivitas rumah tangga (Murtiningsih, 2012).

3. Pengalaman dalam proses kehamilan dan persalinan

Kehamilan yang tidak diharapkan seperti hamil diluar nikah, kehamilan akibat perkosaan, kehamilan yang tidak terencana sehingga wanita tersebut belum siap untuk menjadi ibu. Kesiapan menyambut kehamilan dicerminkan dalam kesiapan dan respon emosionalnya dalam menerima kehamilan.

Seorang wanita memandang kehamilan sebagai suatu hasil alami hubungan perkawinan, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, tergantung dengan keadaan. Sebagian wanita lain menerima kehamilan sebagai kehendak alam dan bahkan pada beberapa wanita termasuk banyak remaja, kehamilan merupakan akibat percobaan seksual tanpa menggunakan kontrasepsi. Awalnya mereka terkejut ketika tahu bahwa dirinya hamil, namun seiring waktu mereka akan menerima kehadiran seorang anak (Bobak, 2004).

4. Faktor psikososial ibu

Latar belakang psikososial ibu yang bersangkutan meliputi:

a. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan dan akses ibu terhadap media masa juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Tingkat pendidikan formal yang tinggi memang dapat membentuk nilai-nilai progresif pada diri seseorang, terutama dalam menerima hal-hal baru, termasuk tentang *postpartum blues*. Tingkat pendidikan inilah yang membantu seorang ibu untuk lebih mudah menangkap dan memahami suatu informasi, sehingga lebih mudah mengadopsi pengetahuan baru khususnya mengenai pentingnya pelayanan masa nifas (Ibrahim, 2012). Dalam penelitian yang dilakukan Asmijati (2015) menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan dan kurangnya informasi dapat berpengaruh terhadap kegagalan pelayanan masa nifas.

Tingkat pendidikan ibu yang rendah dapat mempengaruhi adanya kejadian *postpartum*. Pada ibu yang memiliki pendidikan rendah akan cenderung mempunyai banyak anak dan tehnik dalam perawatan bayi pun kurang baik (Mahmudah, 2010). Sedangkan dalam Rusli, (2011) menyatakan bahwa ibu yang mempunyai pendidikan tinggi akan menghadapi konflik peran dan tekanan sosial antara tuntutan sebagai ibu yang bekerja dan sebagai ibu rumah tangga.

Selain itu hal ini juga dinyatakan oleh penelitian Manurung, (2011) bahwa ibu yang berpendidikan SD/SMP akan berpeluang mengalami *postpartum blues* sebesar empat kali dibanding ibu yang berpendidikan SLTA atau Diploma I dan respon ketahanan terhadap stressor juga dapat mempengaruhi *baby blues syndrome*.

b. Status pekerjaan ibu

Wanita yang bekerja dapat mengalami *postpartum blues* disebabkan adanya konflik peran ganda yang menimbulkan masalah baru bagi wanita tersebut. Anoraga (2008) mengemukakan bahwa wanita pekerja lebih banyak akan kembali pada rutinitas bekerja setelah melahirkan dan cenderung memiliki peran ganda yang menimbulkan gangguan emosional. Sedangkan pernyataan Ambarwati (2009) bahwa ibu-ibu yang hanya bekerja di rumah mengurus anak-anak mereka dapat mengalami keadaan krisis situasi dan mencapai gangguan perasaan */blues* karena rasa lelah dan letih yang mereka rasakan.

c. Status ekonomi keluarga

Faktor ekonomi keluarga serta kurang percaya diri membuat perubahan hormonal yang akan dialami ibu setelah melahirkan mengakibatkan kecemasan yang melahirkan persepsi lebih baik bayi dibunuh dari pada bayinya akan hidup menderita karena ekonomi keluarga yang rendah (Murbiah, 2016).

d. Budaya, keyakinan dan norma

Adanya budaya yang berkembang di keluarga dengan jenis kelamin bayi, mertua atau orang tua sendiri mengharapkan kehadiran bayi laki-laki karena dianggap lebih mudah perawatannya atau lebih banyak mendatangkan berkah tetapi kenyataannya ibu melahirkan bayi perempuan sehingga menimbulkan kekecewaan. Hal ini akan memicu terjadinya *postpartum blues* karena kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan (Marshall, 2004).

5. Dukungan sosial dari lingkungannya

a. Dukungan suami, keluarga, dan teman

Kecukupan dukungan dari lingkungannya (suami, keluarga, dan teman). Apakah suami mendukung kehamilan ini, apakah suami mengerti perasaan istri, apakah suami/keluarga/teman memberikan dukungan fisik dan moral misalnya dengan membantu pekerjaan rumah tangga, membantu mengurus bayi, mendengarkan keluhan ibu.

Dukungan keluarga ini pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat fisik, emosional maupun psikologis yang diberikan kepada ibu yang baru saja melahirkan bayinya. Dukungan sosial adalah kenyamanan, bantuan, atau informasi yang diterima oleh seseorang melalui kontak formal dengan individu atau kelompok (Landy dan Conte, 2007).

b. Dukungan tenaga kesehatan

Faktor-faktor yang meningkatkan pengalaman wanita mengakses dan terlibat dengan perawatan kesehatan mental pada periode

perinatal yaitu memberi kesempatan untuk mengembangkan hubungan saling percaya dengan perawatan kesehatan profesional yang mengakui dan memperkuat peran wanita dalam merawat bayinya tidak menghakimi (Thase, 2005). Informasi yang berkualitas tinggi bagi perempuan, keluarga dan profesional kesehatan, dan penyediaan layanan individual dan pengobatan, juga penting (Thase, 2005).

E. Karakteristik yang mempengaruhi *postpartum blues*

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Llewellyn-Jones (2004), karakteristik wanita yang berisiko mengalami depresi postpartum adalah :

1. Wanita yang mempunyai sejarah pernah mengalami depresi, riwayat depresi mayor atau gangguan psikiatrik lainnya,
2. Wanita yang mempunyai riwayat *dysphoric premenstrual syndrome, anxiety* dan depresi selama hamil,
3. Wanita yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis,
4. Wanita yang jarang berkonsultasi dengan dokter selama masa kehamilannya misalnya kurang komunikasi dan informasi, wanita yang mengalami komplikasi selama kehamilan.

F. Macam-macam gangguan psikologis pada Pospartum

Berikut adalah perbandingan jenis gangguan psikologis pada postpartum:

Tabel 17.1 Perbandingan Jenis Gangguan Postpartum Blues, Depresi Postpartum dan Postpartum Psikosis

	Postpartum Blues	Depresi Postpartum	Psikosis
Insiden	60-80%	10-20%	3-5%
Gejala	labilitas mood, mudah menangis, nafsu makan menurun, gangguan tidur, biasanya terjadi dalam 2 minggu atau kurang.	cemas, rasa kehilangan, sedih, kehilangan harapan (hopelessness), menyalahkan diri sendiri, gangguan percaya diri, kehilangan tenaga, lemah, gangguan nafsu makan (appetite), BB menurun, insomnia, rasa khawatir yang berlebihan, perasaan bersalah dan ada ide bunuh diri.	semua gejala yang ada di depresi postpartum, ditambah gejala: halusinasi, delusi dan agitasi.
Kejadian	1-10 hari setelah melahirkan	1-12 bulan setelah melahirkan	Umumnya terjadi pada bulan pertama setelah melahirkan
Penyebab	Perubahan hormonal dan perubahan / adanya stressor dalam hidup	Ada riwayat depresi, respon hormonal, kurangnya dukungan sosial.	Ada riwayat penyakit mental, ada riwayat keluarga dengan penyakit bipolar. Psychotherapy dan therapy obat.

Dikutip dari : Lynn dan Pierre, 2007: Pillitteri, 2003.

Tabel 17.2 Perbandingan Simptom Gangguan Psikologis Postpartum Berdasarkan Gejala Fisik, Emosional dan Perilaku

Symptom	Baby Blues	Depresi Postpartum	Psikosa
Fisik	Kurang tidur Hilang tenaga Hilang nafsu makan atau nafsu makan berlebih Merasa lelah setelah bangun tidur	Cepat lelah Gangguan tidur selera makan menurun Sakit kepala Sakit dada Jantung berdebar-debar Sesak nafas Mual dan muntah	Menolak makan Tidak mampu menghentikan aktifitas Kebingungan akan kelebihan energi
Emosional	Cemas dan khawatir berlebihan Bingung Mencemaskan kondisi fisik secara berlebihan Tidak percaya diri Sedih Perasaan diabaikan	Mudah tersinggung Perasaan sedih Hilang harapan Merasa tidak berdaya Mood swings Perasaan tidak adekuat sebagai ibu Hilang minat Pemikiran bunuh diri Ingin menyakiti diri sendiri dan orang lain (bayi, diri sendiri dan suami) Perasaan bersalah	Sangat bingung Hilang ingatan Halusinasi
Perilaku	Sering menangis Hiperaktif atau senang berlebihan Terlalu sensitif Perasaan mudah tersinggung Tidak peduli terhadap bayi	Panik Kurang mampu merawat diri sendiri Enggan melakukan aktivitas menyenangkan Motivasi menurun Enggan bersosialisasi Tidak peduli pada bayi Terlalu peduli terhadap perkembangan bayi Sulit mengendalikan perasaan Sulit mengambil keputusan	Curiga Tidak rasional

Sumber : Symptom of Postpartum Illness from Cleveland Clinic and National Mental Health Association (2010)

G. Dampak Postpartum Blues

Menurut Westall & Liamputtong (2011) gangguan mood masa nifas pengaruh pada interaksi bayi dan ibu selama tahun pertama, karena bayi tidak mendapatkan rangsangan cukup. Ibu dapat mengalami gangguan aktifitas sehari-hari, gangguan dalam berhubungan dengan orang lain (keluarga dan teman), risiko penggunaan zat-zat dan dapat terjadi peningkatan kearah *postpartum psychotic depression*. Dampak pada bayi akan lebih sering menangis dalam jangka waktu lama, mengalami masalah tidur dan gangguan makan, kemungkinan mengalami *infanticide*.

Gangguan kecemasan saat ini termasuk gangguan kecemasan umum, gangguan obsesif kompulsif, gangguan panik, fobia sosial, fobia spesifik dan gangguan stress pasca trauma dan sering dilaporkan sebagai hal-hal yang lazim terjadi sebagai gangguan depresi pada periode perinatal (Fairbrother et al., 2015).

Gangguan kecemasan utama yang lazim dan komorbiditas mereka dengan depresi sangat tinggi (Moses-kolko et al., 2013) misalnya tiga bulan setelah melahirkan prevalensi periode untuk setiap gangguan kecemasan dilaporkan sebagai satu dari enam dalam satu studi (Fairbrother et al., 2015), sedangkan lain (Giardinelli et al., 2012) melaporkan prevalensi titik gangguan kecemasan dari satu dari lima pada trimester ketiga kehamilan.

Gangguan kecemasan selama kehamilan mungkin memiliki pengaruh negatif pada hasil obstetri, janin dan perinatal, termasuk gejala kehamilan lebih (mual dan muntah); lebih banyak kunjungan medis; peningkatan konsumsi alkohol atau tembakau atau kebiasaan makan yang tidak sehat; pre eklampsia dan kelahiran prematur; dan postnatal depresi dan gangguan suasana hati (Marc et al., 2011). Tingkat kecemasan tinggi ibu selama kehamilan dikaitkan dengan peningkatan paparan janin untuk kortisol ibu dan risiko hasil perkembangan saraf yang merugikan (Donnell et al., 2012).

Di Australia pada tahun 2012, total kejadian cacat hidup per tahun (DALY) disebabkan depresi perinatal ibu adalah 4.991 pada periode antenatal dan 11.584 pada periode postnatal (PANDA, 2012), yang merupakan beban penyakit yang signifikan dan cenderung diremehkan. biaya langsung (untuk individu, asuransi kesehatan swasta dan pemerintah) terkait dengan depresi pasca melahirkan ibu dan biaya tidak langsung (karena hilangnya produktivitas) sangat tinggi biaya perawatannya. Dampak lainnya yaitu:

a. Pada Ibu

- 1) Menyalahkan kehamilannya
- 2) Sering menangis
- 3) Mudah tersinggung
- 4) Sering terganggu dalam waktu istirahat atau insomnia berat
- 5) Hilang percaya diri mengurus bayi, mersa takut dirinya tidak bisa memberikan asi bahkan takut apabila bayinya meninggal.
- 6) Muncul kecemasan terus-menerus ketika bayi menangis.
- 7) Muncul perasaan malas untuk mengurus bayi
- 8) Mengisolasi diri dari lingkungan masyarakat
- 9) Frustasi hingga berupaya bunuh diri

b. Pada Anak

- 1) Masalah perilaku

Anak-anak dari ibu yang mengalami *baby blues syndrome* lebih memungkinkan memiliki masalah perilaku, termasuk masalah tidur, tantrum, agresi, dan hiperaktif.

2) Perkembangan kognitif terganggu

Anak nantinya mengalami keterlambatan dalam bicara dan berjalan jika dibandingkan dengan anak-anak dari ibu yang tidak depresi. Mereka akan mengalami kesulitan dalam belajar di sekolah.

3) Sulit bersosialisasi

Anak-anak dari ibu yang mengalami *baby blues syndrome* biasanya mengalami kesulitan membangun hubungan dengan orang lain. Mereka sulit berteman atau cenderung bertindak kasar.

4) Masalah emosional

Anak-anak dari ibu yang mengalami *baby blues syndrome* cenderung merasa rendah diri, lebih sering merasa cemas dan takut, lebih pasif, dan kurang independen.

c. Pada Suami

Keharmonisan pada ibu yang mengalami *baby blues syndrome* biasanya akan terganggu ketika suami belum mengetahui apa yang sedang dialami oleh istrinya yaitu *baby blues syndrome*, suami cenderung akan menganggap si ibu tidak becus mengurus anaknya bahkan dalam melakukan hubungan suami istri biasanya mereka merasa takut seperti takut mengganggu bayinya.

H. Penanganan *Postpartum Blues*

Cara mengatasi *postpartum blues* yaitu:

1. Komunikasikan segala permasalahan atau hal lain yang ingin diungkapkan.
2. Bicarakan rasa cemas yang dialami.
3. Bersikap tulus ikhlas dalam menerima aktivitas dan peran baru setelah melahirkan.
4. Bersikap *fleksible* dan tidak terlalu perfeksionis dalam mengurus bayi atau rumah tangga.
5. Belajar tenang dengan menarik nafas panjang dan meditasi.
6. Kebutuhan istirahat harus cukup, tidurlah ketika bayi tidur.
7. Berolahraga ringan.
8. Bergabunglah dengan kelompok ibu-ibu baru.
9. Dukungan tenaga kesehatan.
10. Dukungan suami, keluarga, teman-teman sesama ibu.
11. Konsultasikan pada dokter atau orang yang profesional, agar dapat meminimalkan faktor risiko lainnya dan membantu melakukan pengawasan.

Beberapa penelitian intervensi dapat diberikan untuk mengurangi kejadian perubahan psikologis postpartum ini, diantaranya pendidikan kesehatan mengenai antenatal, proses perawatan bayi di rumah, serta depresi postpartum melalui booklet, proses metode belajar sambil bermain mengenai cara perawatan bayi kepada ibu, serta pentingnya dukungan suami dalam kehamilan hingga perawatan bayi. Selain berbagai intervensi yang telah ditemukan oleh peneliti untuk mengurangi kejadian perubahan psikologis postpartum, pemberian konseling juga penting dilakukan untuk mempersiapkan psikis ibu dalam penerimaan perubahan peran yang akan dialaminya (WHO, 2011).

Faktor-faktor yang meningkatkan pengalaman wanita mengakses dan terlibat dengan perawatan kesehatan mental pada periode perinatal yaitu memberi kesempatan untuk mengembangkan hubungan saling percaya dengan perawatan kesehatan profesional yang mengakui dan memperkuat peran wanita dalam merawat bayinya tidak menghakimi (Megnin-viggars et al., 2015). Informasi yang berkualitas tinggi bagi perempuan, keluarga dan profesional kesehatan, dan penyediaan layanan individual dan pengobatan, juga penting (Megnin-viggars et al., 2015).

Budaya yang tidak membahayakan didasarkan pada hak asasi manusia dasar penghormatan, martabat, pemberdayaan, keselamatan dan otonomi (Phiri et al., 2010). Budaya yang tidak membahayakan merupakan tahap akhir pada keberlanjutan perawatan yang mencakup kesadaran budaya, kepekaan budaya, pengetahuan budaya, menghormati budaya dan kompetensi budaya (CATSINaM, 2014).

Pada ruang lingkup praktik kebidanan yang berkaitan dengan perubahan psikologi, gangguan psikologi (psikopatologi), maka beberapa rekomendasi penting yang perlu dilakukan dalam praktik kebidanan, berdasarkan bukti-bukti yang terbaik (*evidence based*), adalah sebagai berikut:

1. Persiapan yang realistis pada pasangan dan perencanaan kehamilan, persalinan yang baik. Hal ini bertujuan untuk mencapai persalinan yang diharapkan dan mengatasi tantangan dan tuntutan peran sebagai orang tua. Dalam hal ini peran sebagai bidan sangat penting dalam memberikan edukasi dan informasi serta dukungan terhadap perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi.
2. Pada masa antenatal lakukan skrining faktor risiko, misalnya adanya riwayat gangguan jiwa pada diri ibu atau keluarga, riwayat penyalahgunaan obat atau zat adiktif NAPZA, kekerasan dalam rumah tangga, ketidaknyamanan dalam hubungan dengan pasangan (disharmonis), dll.
3. Lakukan deteksi dengan tepat, temukan tanda dan gejala adanya gangguan psikologis (psikopatologi) maupun gangguan jiwa sedini mungkin, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam asuhan kebidanan.

4. Bidan penting untuk memiliki keterampilan dalam mengenali distress emosi yang cukup bermakna sebagai respon terhadap penyimpangan dan kejadian terkait postpartum. Prediksi risiko merupakan aspek penting dalam asuhan kebidanan, karena peningkatan stress selama asuhan postnatal tidak hanya mempengaruhi kesehatan emosi dan psikologis ibu, tetapi juga mempunyai dampak terhadap kesejahteraan bayi.
5. Bidan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan primer harus memberikan asuhan yang efektif, sehingga mampu mengenali, mendeteksi adanya perubahan psikologis dan mampu melakukan penatalaksanaan yang tepat sehingga dapat mencegah adanya psikopatologi dan morbiditas psikologis.
6. Dukungan psikososial pada ibu akan meningkatkan adaptasi dan kenyamanan psikologis ibu postpartum.
7. Untuk mencapai kesejahteraan psikologis, mekanisme koping yang efektif dan penyesuaian emosi yang aman, setiap tahapan harus diselesaikan dengan baik atau dinegosiasikan oleh orang yang bersangkutan agar dapat melangkah ke tahapan selanjutnya dengan efektif.

postmontier & Waite (2011) mengatakan bahwa postpartum blues dapat diatasi oleh ibu dengan teknik perawatan diri yang baik dan menggunakan dukungan sosial. Hal ini meliputi nutrisi yang baik, aktifitas fisik yang teratur dan tidur, mengembangkan *support system*, harapan yang realistis tentang peran sebagai ibu, istirahat, bernafas dalam, menerima dan mengekspresikan perasaan yang *negative*, menumbuhkan perasaan humor, dan menunda perubahan hidup yang besar.

I. **Screening Untuk Depresi dan Gangguan Kecemasan**

Skrining untuk mendeteksi gangguan mood/depresi merupakan acuan pelayanan pascasalin yang rutin dilakukan diluar negeri. Untuk melakukan skrining ini dapat dipergunakan alat bantu berupa *Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS) yang dikembangkan oleh Cox (1987) yaitu kuesioner dengan validitas yang teruji yang dapat mengukur intensitas perubahan suasana depresi selama tujuh hari pasca salin. Pertanyaan – pertanyaan berhubungan dengan labilitas perasaan, kecemasan, perasaan bersalah serta hal yang terdapat pada *postpartum* blues. Kuesioner ini terdiri dari 10 pertanyaan dimana setiap pertanyaan memiliki 4 pilihan jawaban dan harus dipilih satu sesuai dengan gradasi perasaan yang dirasakan ibu pasca salin saat ini. Pertanyaan harus dijawab sendiri oleh pasien dan rata – rata diselesaikan dalam waktu 5 menit. Alat ini telah teruji validitasnya di beberapa Negara seperti Belanda, Swedia, Australia, dan Indonesia. EPDS dapat digunakan dalam minggu pertama pasca salin, bila hasil meragukan dapat diulang lagi 2 minggu kemudian (Jardri et al., 2006).

Sejarah perkembangan EPDS digunakan pada wanita yang tinggal di Edinburgh. Cox tahun 1987 merekomendasikan skor *cut off* 12/13 untuk mendeteksi depresi mayor *postpartum* dengan nilai sensitifitas 86,5, spesifisitas 78 % dan p *Value* prediktif positif 73 %, dengan nilai tingkat kesalahan dilaporkan antara 14-16 % (Andajani, Manderson, & Astbury, 2007). Perbedaan nilai *cut off* akan menghasilkan spesifisitas dan sensitifitas yang berbeda. Penelitian yang dilakukan Edwards *et al* (2015) di Surabaya, Indonesia, Corrigan *et al* (2015); Humayun *et al* (2013) dan Heh *et al* (2004) menggunakan nilai *cut off* 10 dengan nilai sensitifitas 91,75 dan nilai spesifisitas 76,9 % dan perkiraan prediktif positif 46,7 %, dengan titik potong depresi ≥ 10 .

1. Keuntungan EPDS

EPDS digunakan secara luas di berbagai negara untuk alat skrining depresi *postpartum*. Validitas dan reliabilitas sudah teruji secara luas di berbagai Negara. Sensitifitas dan spesifisitas tergantung dari p *Value* yang ditetapkan. Keuntungan lain dari EPDS adalah: sederhana, cepat dikerjakan (membutuhkan waktu 5 – 10 menit) untuk menyelesaikan kuesioner EPDS, mudah dihitung (oleh perawat, bidan dan petugas kesehatan lain), deteksi dini terhadap adanya depresi pasca persalinan, tidak memerlukan biaya, lebih diterima oleh pasien.

2. Cara Penilaian EPDS

a. Pertanyaan 1, 2 dan 4

Mendapatkan nilai 0, 1, 2 atau 3 dengan kotak paling atas mendapatkan nilai 0 dan kotak paling bawah mendapatkan nilai 3.

b. Pertanyaan 3, 5 sampai dengan 10

Merupakan penilaian terbalik, dengan kotak paling atas mendapat nilai 3 dan kotak paling bawah mendapat nilai 0

c. Pertanyaan 10 merupakan pertanyaan yang menunjukkan keinginan bunuh diri.

d. Nilai maksimal 30

e. Kemungkinan depresi bila nilai lebih dari 10

3. Cara Pengisian EPDS

a. Ibu *postpartum* memberikan jawaban mengenai perasaan yang terdekat dengan pertanyaan yang tersedia dalam 7 hari terakhir.

b. Semua pertanyaan dalam kuesioner harus dijawab.

c. Jawaban kuesioner harus berasal dari ibu sendiri, bukan diskusi dengan orang lain.

d. Ibu menyelesaikan kuesioner ini sendiri, kecuali bila mengalami kesulitan dalam memahami bahasa atau tidak bisa membaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, N. (2005). Depresi Aspek Neurologi Diagnosis dan Tatalaksana. Badan Penerbit FKUI.
- Dalton, E., & Castillo, E. (2014). Post partum infections : A review for the. 7(3), 98–102. <https://doi.org/10.1177/1753495X14522784>
- Donnell, K. J. O., Bugge, A., Freeman, L., Khalife, N., Connor, T. G. O., & Glover, V. (2012). Maternal prenatal anxiety and downregulation of placental 11 β -HSD2. *Psychoneuroendocrinology*, 37(6), 818–826. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2011.09.014>
- Fairbrother, N., Janssen, P., Martin, M., Tucker, E., Young, A. H., Tucker, E., & Young, A. H. (2015). Author ' s Accepted Manuscript Perinatal anxiety disorder prevalence and incidence. *Journal of Affective Disorders*. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2015.12.082>
- Giardinelli, L., Innocenti, A., & Benni, L. (2012). Depression and anxiety in perinatal period: prevalence and risk factors in an Italian sample. 21–30. <https://doi.org/10.1007/s00737-011-0249-8>
- Jardri, R., Pelta, J., Maron, M., Thomas, P., Delion, P., Codaccioni, X., & Goudemand, M. (2006). Predictive validation study of the Edinburgh Postnatal Depression Scale in the first week after delivery and risk analysis for postnatal depression. 93, 169–176. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2006.03.009>
- Lynn.,Christine.,E., & Pierre., Cathy., M. (2007). The Taboo of Motherhood: Postpartum Depression. *International Journal for Human Caring*, vol 11, No.2, 22-31
- Mahmudah,Siti.2010.Psikologi Sosial Sebuah Pengantar.Malang:UIN Malang Press
- Mansur, herawati. 2009. Psikologi Ibu & Anak untuk Kebidanan. Jakarta: Salemba Medika
- Marc, I., Toureche, N., Ernst, E., Ed, H., Blanchet, C., Dodin, S., & Mm, N. (2011). Mind-body interventions during pregnancy for preventing or treating women ' s anxiety (Review). 11.
- Marshall, Fiona; Fransiska; Lilian Juwono; Surya Satyanegara; coping with postnatal depression. (2004). Mengatasi depresi pasca - melahirkan / Fiona Marshall ; alih bahasa, Fransiska, Lilian Juwono ; editor, Surya Satyanegara. Jakarta
- Megnin-viggars, O., Symington, I., Howard, L. M., Pilling, S., & Howard, L. M. (2015). Experience of care for mental health problems in the antenatal or postnatal period for women in the UK : a systematic review and meta-synthesis of qualitative research. 745–759. <https://doi.org/10.1007/s00737-015-0548-6>

- Moses-kolko, E. L., Famy, C. S., & Hanusa, B. H. (2013). Onset Timing, Thoughts of Self-harm, and Diagnoses in Postpartum Women With Screen-Positive Depression Findings. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2013.87>
- Murtiningsih, Afin. 2012. Mengenal Baby Blues dan Pencegahannya. Jakarta: Dunia Sehat.
- Phiri, J., Nursing, H., Midwifery, H., Wh, M. N., Bonner, A., & Nurs, B. (2010). Cultural safety and its importance for Australian midwifery practice. *Collegian*, 17(3), 105–111. <https://doi.org/10.1016/j.colegn.2009.11.001>
- Pieter H.Z & Lubis N. L. 2010. Pengantar Psikologi Untuk Kebidanan. Rapha Publishing. Medan.
- Pillitteri A. (2003). *Maternal and Child Health Nursing: Care of The Childbearing Family*. 4th ed. Lippincott. Philadelphia
- Posmontier, B., & Waite, R. (2011). Social Energy Exchange Theory for Postpartum Depression. <https://doi.org/10.1177/1043659610387156>
- Sumarni. (2019). asuhan kebidanan post partum (FADJRIAH O). CV. CAHAYA BINTANG CEMERLANG.
- Thase, M. E. (2005). Bipolar Depression : Issues in Diagnosis and Treatment. 257–271. <https://doi.org/10.1080/10673220500326425>
- Wahyuningsih. (2018). asuhan kebidanan nifas dan menyusui.

KUESIONER *EDINBURGH POSTNATAL DEPRESSION SCALE* (EPDS)

Sebagaimana kehamilan atau proses persalinan yang baru saja di alami, kami ingin mengetahui bagaimana perasaan anda saat ini. Mohon memilih dan memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang paling mendekati keadaan perasaan anda **DALAM 7 HARI TERAKHIR**, bukan hanya perasaan anda hari ini saja. Dibawah ini adalah contoh pertanyaan yang telah disertai oleh jawabannya: Contoh : Saya merasa bahagia:

- a. Ya, setiap saat
- b. Ya, hampir setiap saat**
- c. Tidak, tidak terlalu sering
- d. Tidak pernah sama sekali

Ibu menjawab B arti jawaban tersebut adalah “saya merasa bahagia di hampir setiap saat dalam satu minggu terakhir ini. Mohon dilengkapi pertanyaan lain dibawah ini dengan cara yang sama seperti contoh diatas.

- 1. Saya mampu tertawa dan merasakan hal – hal yang menyenangkan
 - a. Sebanyak yang saya bisa
 - b. Tidak terlalu banyak
 - c. Tidak banyak
 - d. Tidak sama sekali
- 2. Saya melihat segala sesuatunya kedepan sangat menyenangkan
 - a. Sebanyak sebelumnya
 - b. Agak sedikit kurang dibandingkan dengan sebelumnya
 - c. Kurang dibandingkan dengan sebelumnya
 - d. Tidak pernah sama sekali
- 3. Saya menyalahkan diri saya sendiri saat sesuatu terjadi tidak sebagaimana mestinya
 - a. Ya, setiap saat
 - b. Ya, kadang – kadang
 - c. Tidak terlalu sering
 - d. Tidak pernah sama sekali
- 4. Saya merasa cemas atau kuatir tanpa alasan yang jelas
 - a. Tidak pernah sama sekali
 - b. Jarang-jarang
 - c. Ya, kadang-kadang
 - d. Ya, sering sekali

5. Saya merasa takut atau panik tanpa alasan yang jelas
 - a. Ya, cukup sering
 - b. Ya, kadang-kadang
 - c. Tidak terlalu sering
 - d. Tidak pernah sama sekali
6. Segala sesuatunya terasa sulit dikerjakan
 - a. Ya, hampir setiap saat saya tidak mampu menanganinya
 - b. Ya, kadang-kadang saya tidak mampu menanganinya seperti biasa
 - c. Tidak terlalu, sebagian besar berhasil saya tangani
 - d. Tidak pernah, saya mampu mengerjakan segala sesuatu dengan baik
7. Saya merasa tidak bahagia sehingga mengalami kesulitan untuk tidur
 - a. Ya, setiap saat
 - b. Ya, kadang-kadang
 - c. Tidak terlalu sering
 - d. Tidak pernah sama sekali
8. Saya merasa sedih dan merasa diri saya menyedihkan
 - a. Ya, setiap saat
 - b. Ya, cukup sering
 - c. Disaat tertentu saja
 - d. Tidak pernah sama sekali
9. Saya merasa tidak bahagia sehingga menyebabkan saya menangis
 - a. Ya, setiap saat
 - b. Ya, cukup sering
 - c. Disaat tertentu saja
 - d. Tidak pernah sama sekali
10. Muncul pikiran untuk menyakiti diri saya sendiri
 - a. Ya, cukup sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang sekali
 - d. Tidak pernah sama sekali

SELF REPORTING QUESTIONNAIRE

Petunjuk: Berilah tanda centang (V) pada salah satu jawaban “YA” atau “TIDAK” yang menggambarkan tentang kondisi anda.

Apakah dalam 1 (satu) bulan terakhir anda mempunyai keluhan di bawah ini?

No	Pertanyaan	YA	TIDAK
1	Apakah anda sering menderita sakit kepala?		
2	Apakah nafsu makan anda kurang?		
3	Apakah tidur anda tidak nyenyak/terganggu?		
4	Apakah anda mudah ketakutan?		
5	Apakah tangan anda gemetar?		
6	Apakah anda merasa gugup, tegang, atau cemas?		
7	Apakah pencernaan anda terganggu/buruk?		
8	Apakah anda sulit untuk berfikir jernih?		
9	Apakah anda merasa tidak bahagia?		
10	Apakah anda lebih sering menangis dari biasanya?		
11	Apakah anda merasa sulit menikmati kegiatan anda sehari-hari?		
12	Apakah anda merasa sulit untuk membuat keputusan?		
13	Apakah pekerjaan anda terganggu?		
14	Apakah anda tidak mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup?		
15	Apakah anda kehilangan minat pada berbagai hal?		
16	Apakah anda merasa orang tak berguna?		
17	Apakah anda mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup anda?		
18	Apakah anda merasa kelelahan sepanjang waktu?		
19	Apakah anda mengalami rasa tidak enak di perut?		
20	Apakah anda mudah lelah?		

BAB 16

PARENTING SELF-EFFICACY PADA IBU NIFAS

Rini Mustikasari Kurnia Pratama, S.Si.T., M.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. Parenting Self-Efficacy

Parenting merupakan suatu proses yang kompleks, sedangkan *self-efficacy* mengacu pada keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam melakukan suatu perilaku. *Parenting self-efficacy* disingkat sebagai (PSE). PSE merupakan keyakinan orang tua terhadap kemampuan dirinya dalam menjalankan peran sebagai orang tua atau memberikan pengaruh positif sehingga memberikan pengaruh terhadap perilaku anaknya (Nurbaiti et al., 2021). PSE akan mempengaruhi anak dikemudian hari dalam menghadapi masalah, misalnya individu dengan tingkat PSE tinggi akan mampu melewati tahapan-tahapan perkembangan dengan baik tanpa adanya stress bahkan depresi. Tingkat *parenting self-efficacy* yang baik akan mendapatkan responsivitas terhadap kebutuhan anak, keterikatan dalam interaksi langsung dengan orang tua, serta beberapa persepsi tentang masalah perilaku pada anak (Leahy-Warren & McCarthy, 2011).

Parenting self-efficacy tinggi ditemukan pada ibu yang cenderung memiliki anak dengan tingkat emosional lebih rendah dan lebih ramah, berpendidikan lebih baik, memiliki pendapatan keluarga lebih tinggi dan lebih berpengalaman dalam hal pengasuhan anak. Tingkat *parenting self-efficacy* yang rendah berkaitan dengan kecenderungan orang tua untuk fokus pada kesulitan-kesulitan dalam hubungan, pengaruh negative, perasaan ketidakmampuan dalam berperan sebagai orang tua, *autonomic arousal* yang tinggi, dan cenderung menghukum anak. *Parenting self-efficacy* sangat penting untuk dimiliki oleh orang tua untuk dapat memberikan pengasuhan yang positif (Salonen et al., 2009).

Keyakinan orang tua pada efikasi diri mereka sendiri telah dihubungkan dengan focus yang lebih besar pada perencanaan, yang pada gilirannya menyebabkan tingkat kepuasan orang tua yang lebih tinggi dan kesejahteraan afektif yang lebih besar. Orang tua dengan keyakinan *self-efficacy* yang lebih kuat cenderung merencanakan tindakan saat merawat anak. Orang tua dengan PSE rendah mungkin memiliki akses terbatas ke strategi regulasi kognitif yang efektif untuk menyesuaikan respons emosional mereka. PSE dipengaruhi secara negative oleh stress ibu, kecemasan, depresi pascapersalinan, kelelahan, kepuasan pengasuhan, dan kompetensi dalam peran pengasuhan (Botha et al., 2020).

Self-efficacy ibu postpartum sangat penting untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ibu dalam melakukan perawatan bayi baru lahir secara efektif. *Self-efficacy* memengaruhi penilaian, usaha, ketahanan, pilihan hidup, dan

ketekunan ibu dalam beradaptasi menjadi orang tua. Proses menjalankan peran sebagai orang tua melibatkan hubungan dengan bayi dan pengembangan keterampilan dalam tugas pengasuhan anak. *Parenting self-efficacy* sangat berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak yang optimal. Ibu dengan *parenting self-efficacy* tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan tugas sebagai orang tua, lebih responsif setiap terdapat isyarat dan kebutuhan bayi, serta memiliki hubungan interaksi yang lebih baik dengan anak. Keadaan ini akan meningkatkan tanggung jawab ibu dalam merawat anak dan menurunkan kejadian kekerasan pada anak (Botha et al., 2020; Oktafia et al., 2022).

Parenting self-efficacy mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan ibu. *Parenting self-efficacy* yang tinggi akan menurunkan risiko terjadinya stress, depresi postpartum, dan kecemasan ibu. *Parenting self-efficacy* berhubungan positif dengan kesejahteraan orang tua, kepuasan perkawinan dan fungsi keluarga, serta kepuasan peran menjadi orang tua. Sebaliknya, *parenting self-efficacy* yang rendah dapat menimbulkan konflik perkawinan, kurang memiliki waktu santai dan menyenangkan dengan anak, dan mengalami kesulitan yang tinggi dalam melakukan tugas pengasuhan bayi. *Parenting self-efficacy* juga menjadi predictor dalam praktik pengasuhan bayi dan berhubungan erat dengan perkembangan anak. Pengkajian *parenting self-efficacy* pada periode awal postpartum dalam mengidentifikasi ibu atau kelompok yang berisiko serta menentukan intervensi yang tepat dalam membantu menyelesaikan masalah ibu (Nurbaiti et al., 2021; Oktafia et al., 2022).

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Parenting Self-Efficacy*

Parenting self-efficacy dapat dibangun dan ditingkatkan melalui beberapa komponen sumber informasi sebagai berikut (Botha et al., 2020):

1. *Enactive Mastery Experience* (pengalaman dalam penguasaan tindakan)

Komponen ini berhubungan dengan pengalaman keberhasilan dan kegagalan dalam melakukan suatu tugas tertentu. Pengalaman masa lalu ibu sangat berpengaruh terhadap *self-efficacy*nya, baik kegagalan maupun keberhasilan dalam merawat anaknya akan mempengaruhi kepercayaan diri dan meningkatkan *self-efficacy* dalam mencari solusi saat menghadapi kesulitan dalam merawat anak selanjutnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mendapatkan bahwa ibu primipara memiliki skor *parenting self-efficacy* lebih rendah dibandingkan ibu multipara atau grandemultipara.

2. *Vicarious Experience* (pengalaman pemodelan/kinerja orang lain)

Keberhasilan ibu dalam menguasai suatu tindakan akan mempengaruhi *self-efficacy*nya. Persepsi *self-efficacy* ibu akan meningkat ketika melihat ibu lain berhasil melakukan tugas tertentu, namun sebaliknya kegagalan ibu lain

juga dapat menurunkan *self-efficacy* ibu. Keberhasilan orang lain biasanya akan memberikan motivasi pada ibu untuk berhasil terutama apabila melakukan model atau tindakan yang sama. Semakin ibu memiliki kesamaan model atau tindakan maka akan semakin besar pengaruh keberhasilan atau kegagalan model terhadap *self-efficacy*. Perbedaan model atau tindakan juga tidak akan berpengaruh terhadap *self-efficacy* ibu.

3. *Persuasion Verbal*

Persuasi verbal sebagai upaya untuk meyakinkan ibu dalam kemampuannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Persuasi dapat diberikan dapat melalui informasi dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan setiap ibu. Informasi dan dukungan dari tenaga kesehatan serta suami maupun keluarga selama periode postpartum akan mempengaruhi keyakinan ibu terhadap kemampuannya dalam menjalankan perannya sebagai orang tua. Ibu yang diberi persuasi akan memiliki motivasi dan kemauan yang lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak diberi persuasi untuk menyelesaikan perannya sebagai orang tua.

4. *Physiological and Affective State*

Disebut juga sebagai kondisi emosi dan fisik. Keadaan cemas dan stress dapat mengancam kemampuan diri seorang ibu dalam menyelesaikan perannya sebagai orang tua. Penurunan fungsi fisik akan menghasilkan kinerja yang buruk. Kelemahan dan kelelahan setelah melahirkan dapat mempengaruhi *parenting self-efficacy* ibu postpartum. Hasil akhir asuhan kebidanan pada ibu nifas dan menyusui ditujukan untuk pemulihan dan peningkatan fungsi fisik, serta memberikan kesejahteraan psikologis ibu sehingga ibu mampu beradaptasi selama periode postpartum dan menjalankan peran sebagai orang tua dengan baik. Adanya *parenting self-efficacy* yang tinggi berhubungan negative dengan kejadian gejala depresi konsep diri yang tidak baik.

Kecemasan selama masa nifas dapat dianggap sebagai faktor yang mengkhawatirkan karena secara negative mengganggu ikatan afektif antara ibu dan bayi, mengurangi kemampuan ibu untuk mengatasi transformasi yang melekat pada periode postpartum, dengan kemungkinan memburuk selama pertumbuhan bayi. Ibu yang menunjukkan gejala kecemasan memiliki kompleksitas yang lebih besar untuk memahami emosinya dan akan mengganggu pemberian pengasuhan kepada bayinya (Melo et al., 2021).

Terdapat tiga dimensi berdasarkan pembentukan *self-efficacy* antara lain (Botha et al., 2020):

1. Dimensi Tingkat Kesulitan (*Magnitude*)

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kesulitan tugas, keyakinan ibu terhadap kemampuannya dalam menjalankan tugas pada tingkat kesulitan tertentu. Ketika ibu dihadapkan pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai

orang tua, ibu akan memilih mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya dan menghindari tugas yang menurutnya di luar batas kemampuan. Tingkat kesulitan dapat dibagi menjadi tingkat keterampilan yaitu tingkatan pada keyakinan ibu terhadap keterampilan yang ibu miliki untuk menyelesaikan tugas sebaik-baiknya; tingkat usaha yaitu tingkatan pada keyakinan ibu terhadap kemampuan mengarahkan usaha yang maksimal untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik; tingkat ketepatan yaitu tingkatan pada keyakinan ibu terhadap kemampuan menyelesaikan tugas dengan tepat; tingkat produktivitas yaitu tingkatan pada keyakinan ibu terhadap kemampuan akan menghasilkan sesuatu; dan tingkat cara menghadapi ancaman yaitu tingkatan pada keyakinan ibu terhadap kemampuan dalam menghadapi setiap hambatan yang datang.

2. Dimensi Tingkat Keyakinan (*Generality*)

Dimensi *generality* merupakan keyakinan ibu dalam melakukan tugas tertentu berdasarkan kemampuan menguasai keterampilan baik yang bersifat khusus/spesifik maupun umum. Keyakinan diri yang tinggi akan meningkatkan kemampuan ibu untuk melakukan tugas lebih banyak dan pada cakupan bidang yang lebih luas. *Self-efficacy* yang tinggi akan memotivasi ibu mampu melakukan tugas-tugas sebagai orang tua dari yang bersifat umum seperti memandikan bayi, menyusui bayi, menjaga kehangatan bayi, dll, sampai tugas yang bersifat khusus seperti merespon bayi saat merasa haus atau lapar. Dimensi tingkat keyakinan ini terdiri dari keyakinan bahwa ibu mampu untuk melakukan tugas-tugas lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan aktivitas dengan tugas yang mampu dikerjakannya (derajat kesamaan aktivitas), serta keyakinan bahwa dalam menyelesaikan tugas ibu harus memiliki modalitas ekspresi meliputi kognitif, afektif, dan behavior (modalitas ekspresi).

3. Dimensi Tingkat Kekuatan (*Strength*)

Dimensi ini melihat dari ketahanan ibu dalam melakukan tugasnya. Ibu yang memiliki keyakinan tinggi akan tekun dan gigih dalam menjalankan perannya meskipun terdapat hambatan dan kesulitan. *Self-efficacy* yang tinggi memberikan kemampuan pada ibu dalam menghadapi setiap hambatan atau masalah yang ditemui selama periode postpartum.

Parenting self-efficacy seorang ibu dipengaruhi oleh banyak faktor, tergantung dari jenis tugas yang harus ibu selesaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi *parenting self-efficacy* sebagai berikut (Nurbaiti et al., 2021) :

1. Usia Ibu

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa usia ibu berhubungan dengan *parenting self-efficacy*. Pada umumnya *self-efficacy* yang tinggi pada usia ibu 40—65 tahun. Pada usia ini dapat disebut sebagai tahap usia keberhasilan karena memiliki pengaruh yang maksimal, mampu membimbing dan menilai

diri sendiri. Ibu yang berusia lebih tua memiliki skor *parenting self-efficacy* lebih tinggi dibandingkan ibu dengan usia muda.

2. Paritas

Pada faktor paritas dihubungkan dengan pengalaman mengasuh dan merawat anak sebelumnya. Ibu primipara tidak memiliki pengalaman dalam merawat anak sebelumnya sehingga memiliki *parenting self-efficacy* yang lebih rendah dibandingkan ibu dengan multipara. Pengalaman masa lalu sangat mempengaruhi *self-efficacy* ibu.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan ibu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa berhubungan dengan *parenting self-efficacy*. Tingkat pendidikan umumnya akan mempengaruhi kemampuan ibu dalam menerima dan mengolah informasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang ibu akan semakin tinggi pula *parenting self-efficacy* yang dimilikinya.

4. Dukungan

Dukungan suami, keluarga dan dukungan sosial lainnya yang adekuat akan memberikan keyakinan ibu untuk melakukan tugas asuhan pada bayinya dengan baik. Ibu yang mendapatkan *rooming-in* dan didampingi oleh suami selama persalinan dan nifas memiliki *parenting self-efficacy* lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang tidak dilakukan *rooming-in* dan tanpa pendampingan persalinan oleh suami.

5. Status Kesehatan Anak

Status kesehatan anak berhubungan dengan tingkat kesulitan dalam melakukan perawatan yang diberikan. Ibu dengan bayi yang terganggu kesehatannya atau cacat akan menyebabkan *parenting self-efficacy* rendah. Beberapa ibu akan meminta bantuan kepada tenaga kesehatan dalam perawatan bayinya. Keadaan ini akan menghambat pembentukan *parenting self-efficacy*.

C. *Parenting Self-Efficacy* Pada Ibu Nifas

Bidan berperan sebagai educator dan model yang memfasilitasi individu meningkatkan kemampuan beradaptasi dan melakukan aktivitas fisik. Ibu primipara diberikan intervensi edukasi postpartum untuk meningkatkan *self-efficacy* dalam perawatan bayi dan menyusui. Pendampingan ibu postpartum dilakukan selama di rumah sakit, klinik, atau puskesmas tempat persalinan kemudian dilanjutkan dengan melakukan kunjungan rumah (*home care*) atau kunjungan nifas ke fasilitas kesehatan untuk memantau proses involusi uteri (Germeroth et al., 2019).

Dalam meningkatkan *parenting self-efficacy*, bidan perlu menyediakan informasi terkait tugas-tugas dalam membina hubungan baik antara ibu dan bayi

selama periode postpartum dengan merespon setiap isyarat dan pemenuhan kebutuhan bayi, serta memantau tumbuh kembangnya. Beberapa pokok bahasan dalam disampaikan yang berkaitan dengan perawatan dan pengasuhan bayi seperti karakteristik perilaku bayi, pola kativitas/tidur bayi, kebutuhan nutrisi, perawatan dasar bayi seperti merawat tali pusat, menjaga *personal hygiene*, menggendong bayi, menenangkan bayi serta melakukan stimulasi tumbuh kembang bayi (Rachmawati et al., 2021).

Peningkatan *parenting self-efficacy* dapat dikembangkan melalui intervensi edukasi postpartum untuk meningkatkan *self-efficacy* seperti pada proses menyusui. Intervensi lain dengan diskusi kelompok dan pemberian *booklet* untuk menilai efektivitas *parenting self-efficacy* (Pramudianti, 2017). Dukungan dan informasi tentang tugas pengasuhan bayi baru lahir juga dapat digunakan sebagai intervensi yang disediakan dalam bentuk *database* yang nantinya dapat diakses oleh ibu via internet. Tersedianya forum diskusi dapat menjadi alat komunikasi secara online dengan penyedia layanan. Ibu juga diberi kesempatan untuk bertanya seputar keluhan-keluhan atau hambatan yang dihadapi selama pengasuhan pada periode postpartum (Leahy-Warren & McCarthy, 2011).

Edukasi postpartum bertujuan untuk membantu ibu beradaptasi terhadap peran barunya sebagai ibu dan proses belajar untuk merawat bayinya, serta mengidentifikasi masalah kesehatan yang umum terjadi. Kurangnya pengalaman ibu primipara menjadi penyebab *self-efficacy* tidak berhasil atau gagal. Hal ini dapat menjadi penyebab menurunnya kepercayaan diri ibu melakukan tugas perawatan bayi secara mandiri. Peran bidan dituntut dalam kondisi ini, dengan memberikan perhatian lebih khususnya pada ibu primipara (Pramudianti, 2017). Fokus perawatan postpartum menempatkan ibu sebagai individu yang sehat, memiliki kemampuan dan kepercayaan diri, membutuhkan dukungan baik dari tenaga kesehatan maupun suami dan keluarganya untuk melakukan aktivitas secara mandiri (Wittkowski et al., 2017).

Kesiapan belajar dan keadaan emosional ibu yang stabil juga menjadi faktor penentu keberhasilan intervensi peningkatan *parenting self-efficacy*. Kualitas interaksi dan dukungan sosial bidan secara langsung dapat mempengaruhi *self-efficacy* ibu. Interaksi yang telah terbina dengan baik memiliki sisi positif antara bidan dan ibu sehingga ibu akan menjadikan bidan sebagai *role model* yang layak untuk ditiru dan diikuti apa yang menjadi nasihat atau sarannya. Intervensi lain yang dapat digunakan dalam peningkatan *parenting self-efficacy* adalah dengan metode redemonstrasi. Metode ini bermanfaat dalam menurunkan kecemasan dan kekhawatiran ibu terhadap kesalahan yang mungkin terjadi. Redemonstrasi juga terbukti efektif untuk melihat dan menilai keterampilan ibu dalam melakukan tindakan perawatan bayi baru lahir. Metode demonstrasi dan redemonstrasi menyebabkan peningkatan kepuasan ibu terhadap edukasi yang diberikan

sehingga peningkatan *parenting self-efficacy* ibu meningkat (Botha et al., 2020; Salonen et al., 2009).

D. Instrumen *Parenting Self-Efficacy*

Parenting self-efficacy biasanya dinilai melalui pengukuran laporan diri yang tepat mengingat bahwa *parenting self-efficacy* mencerminkan kepercayaan atau penilaian orang tua atas kemampuannya untuk berhasil melakukan tugas pengasuhan yang diberikan. Laporan diri tersebut menilai empat domain yaitu; *self-efficacy* umum atau sifat, spesifik/khusus domain, domain umum, dan domain khusus (Leahy-Warren & McCarthy, 2011).

Langkah-langkah menilai dari *self-efficacy* umum dengan menilai secara keseluruhan dalam peran pengasuhan dan item tidak terikat dengan tugas pengasuhan khusus, contohnya : Apakah yang saya lakukan memiliki pengaruh kecil terhadap perilaku anak saya”. *Parenting self-efficacy* spesifik/ khusus menilai keyakinan orang tua dalam kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas tertentu dari peran pengasuhan anak pada usia tertentu, contohnya: Seberapa baik Anda membuat bayi Anda bersenang-senang dengan Anda?”. Spesifik domain memiliki item yang seluruhnya spesifik seperti spesifik dalam tugas, spesifik usia, spesifik situasi, dll (Wittkowski et al., 2017).

Parenting Self-Efficacy Scale (PSES) merupakan skala yang digunakan untuk menilai keyakinan orang tua terhadap kemampuan dalam pengasuhan anak (Salonen et al., 2009).

Aspek Kognitif

1. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini dalam memilih makanan yang baik untuk bayi
2. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini dalam merencanakan perawatan dan menjaga *personal hygiene* bayi
3. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini tentang cara mengganti pakaian bayi
4. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini tentang pola aktivitas/tidur bayi
5. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini tentang perkembangan normal bayi
6. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini tentang cara merangsang perkembangan bayi
7. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini tentang lingkungan yang aman untuk bayi
8. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini dalam mengenal setiap isyarat bayi

9. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini tentang cara menghibur dan menenangkan bayi
10. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengalaman ibu saat ini yang mendukung dalam mengambil suatu keputusan perawatan bayi
11. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini kemana mencari bantuan atau dukungan Ketika bayi memiliki masalah

Aspek Afektif

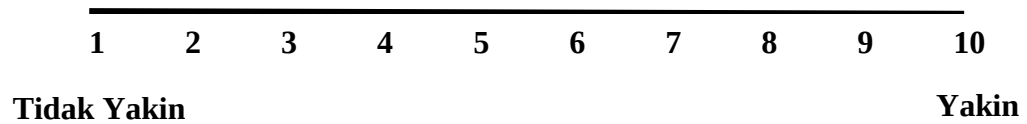
1. Bagaimana keyakinan ibu saat ini dalam kemampuan mengenali tanda-tanda bayi lapar
2. Bagaimana keyakinan ibu saat ini dalam kemampuan merespon setiap tangisan bayi
3. Bagaimana keyakinan ibu saat ini dalam kemampuan merespon setiap kondisi bayi
4. Bagaimana keyakinan ibu saat ini dalam kemampuan merespon setiap isyarat bayi dan perilaku yang tidak bisa
5. Bagaimana keyakinan ibu saat ini dalam kemampuan merespon setiap penampilan yang ditunjukkan bayi
6. Bagaimana keyakinan ibu saat ini dalam kemampuan memberikan rangsangan pada bayi
7. Bagaimana keyakinan ibu saat ini dalam kemampuan memberikan kesenangan atau hiburan pada bayi

Aspek Keterampilan

1. Bagaimana keyakinan terhadap kemampuan ibu saat ini menjaga dan memelihara bayi dengan baik
2. Bagaimana keyakinan terhadap kemampuan ibu saat ini melakukan semua aktivitas perawatan dasar pada bayi
3. Bagaimana keyakinan terhadap kemampuan ibu saat ini menidurkan bayi dengan nyaman
4. Bagaimana keyakinan terhadap kemampuan ibu saat ini menilai setiap kondisi yang ditunjukkan bayi
5. Bagaimana keyakinan terhadap kemampuan ibu saat ini terhadap kemampuan ibu melakukan perawatan bayi dengan aman
6. Bagaimana keyakinan terhadap kemampuan ibu saat ini untuk menghibur dan menenangkan bayi
7. Bagaimana keyakinan terhadap kemampuan ibu saat ini dalam menyayangi bayi dengan sepenuh hati
8. Bagaimana pengetahuan terhadap kemampuan ibu saat ini untuk memberikan rangsangan untuk perkembangan bayi

9. Bagaimana keyakinan terhadap kemampuan ibu saat ini untuk melakukan seluruh perawatan bayi

Pertanyaan di atas dengan jawaban rentang angka sesuai dengan keyakinan sebagai berikut :



DAFTAR PUSTAKA

- Botha, E., Helminen, M., Kaunonen, M., Lubbe, W., & Joronen, K. (2020). Mothers' parenting self-efficacy, satisfaction and perceptions of their infants during the first days postpartum. *Midwifery*, 88, 102760. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102760>
- Germeroth, L. J., Wang, Z., Emery, R. L., Cheng, Y., & Levine, M. D. (2019). The Role of Self-Efficacy and Motivation in Postpartum Sustained Smoking Abstinence. *Women's Health Issues*, 29(3), 259–266. <https://doi.org/10.1016/j.whi.2019.03.006>
- Leahy-Warren, P., & McCarthy, G. (2011). Maternal parental self-efficacy in the postpartum period. *Midwifery*, 27(6), 802–810. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2010.07.008>
- Melo, L. C. de O., Bonelli, M. C. P., Lima, R. V. A., Gomes-Sponholz, F. A., & Monteiro, J. C. D. S. (2021). Anxiety and its influence on maternal breastfeeding self-efficacy. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 29, e3485. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.5104.3485>
- Nurbaiti, F. N., Herniyatun, & Astutiningrum, D. (2021). Hubungan Karakteristik Personal Terhadap Parenting Self Efficacy Pada Ibu Post Partum Di Rs Pku Muhammadiyah Gombong. *University Research Colloqium*, 251–263, 251–263.
- Oktafia, R., Rahmayanti, R., Maghpira, D. A., & Indriastuti, N. A. (2022). Psychosocial Condition and Parenting Self-Efficacy Among Postpartum Mothers. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7, 241–246. <https://doi.org/10.30604/jika.v7iS2.1435>
- Pramudianti, D. N. (2017). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Parenting Self-Efficacy Pada Periode Awal Postpartum Di Bidan Praktik Mandiri (Bpm) Gunarti , Banjarbaru. *Jurnal Of Midwifery & Reproduction*, 1(1), 15–20. <https://journal.umbjm.ac.id/index.php/midwiferyandreproduction/article/view/86%0Ahttps://journal.umbjm.ac.id/index.php/midwiferyandreproduction/article/download/86/44>
- Rachmawati, D., Marcelina, L. A., & Permatasari, I. (2021). Hubungan Dukungan Sosial Dengan Self-Efficacy Ibu Postpartum. *Jkep*, 6(2), 160–172. <https://doi.org/10.32668/jkep.v6i2.761>
- Salonen, A. H., Kaunonen, M., Åstedt-Kurki, P., Järvenpää, A. L., Isoaho, H., & Tarkka, M. T. (2009). Parenting self-efficacy after childbirth. *Journal of Advanced Nursing*, 65(11), 2324–2336. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05113.x>
- Wittkowski, A., Garrett, C., Calam, R., & Weisberg, D. (2017). Self-Report Measures of Parental Self-Efficacy: A Systematic Review of the Current Literature. *Journal of Child and Family Studies*, 26(11), 2960–2978. <https://doi.org/10.1007/s10826-017-0830-5>

PROFIL PENULIS



Andri Tri Kusumaningrum, S.SiT.,Bd.,M.Kes

Penulis lahir di Surabaya. Penulis adalah alumni dari Akademi Siti Khodijah Sepanjang (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo) lulus pendidikan D3 Kebidanan tahun 2006. Tahun 2007, penulis melanjutkan kuliah D4 Kebidanan di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran. Tahun 2010, menyelesaikan S2 di Universitas Sebelas Maret. Tahun 2023 lulus pendidikan profesi bidan dan saat ini menempuh study lanjut S3 di Universitas Negeri Semarang. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Lamongan Prodi D3 Kebidanan, dengan jabatan Lektor.

Beberapa mata kuliah yang pernah diampu penulis diantaranya Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, Asuhan Kegawatan Maternal Neonatal, Komunikasi dalam Kebidanan, Ketrampilan Klinik Praktik Kebidanan. Sebagai Koordinator Mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui sejak 2010-sekarang. Selain mengajar, penulis juga aktif mengikuti seminar dan pelatihan terkini dalam 5 tahun terakhir diantaranya: Pelatihan Item Development, Item Review & Item Bank Administrator, workshop klinik akreditasi, Pelatihan OSCE Metode Objective Structured Clinical Examination, Workshop Penyusunan Kurikulum OBE MBKM, Workshop Penyusunan Buku Ajar dan Modul Praktikum, Pelatihan Midwifery Update. Dalam pengembangan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat mendapat hibah baik dari LLDIKTI VII dan Hibah Riset Muhammadiyah. Beberapa publikasi karya ilmiah yang dihasilkan penulis dalam 5 tahun terakhir diantaranya: 1. Efektifitas Kombinasi Stimulasi Oksitosin dan Endorfin Massage Terhadap Kejadian Bendungan ASI, 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Menyusui Pada Masa Pandemi Covid-19. 3. Pembentukan dan Pelatihan KP-ASI Melalui Kader Aisyiyah untuk Mewujudkan Desa Bebas Stunting. Penulis juga aktif dalam organisasi persyarikatan Muhammadiyah. Penulis dapat dihubungi melalui email: andri.trikusumaningrum17@gmail.com

PROFIL PENULIS



Yayah Rokayah, SKM., M. Kes., Lahir di Lebak Banten, 04 April 1970. Menyelesaikan Pendidikan Diploma III Kebidanan di Poltekkes Bandung pada tahun 2002. Selanjutnya menyelesaikan Pendidikan SI Kesmas di Universitas Respati Indonesia pada tahun 2004 dan menyelesaikan Pendidikan S2 Kespro di Universitas Dipenogoro Semarang pada tahun 2013. Saat ini penulis bekerja menjadi Dosen di Jurusan Kebidanan Rangkasbitung Poltekkes Kemenkes Banten. Penulis sangat berharap agar pembaca mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas. Dengan harapan pada saat bekerja bisa menjadi tenaga kesehatan (bidan) yang Kompeten

Ni Wayan Manik Parwati, S.Si.T.,M.Keb. Penulis adalah seorang bidan kelahiran Denpasar, 9 Mei 1982 yang telah menyelesaikan Pendidikan D3 Kebidanan tahun 2003 di Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar. Tahun 2004, penulis melanjutkan kuliah D4 Kebidanan di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran. Tahun 2015, penulis menyelesaikan Magister Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Penulis juga aktif mengikuti pelatihan-pelatihan non formal seperti Pijat Bayi, Mom and Baby SPA, Hypnobirthing dan Yoga Prenatal.

Penulis aktif sebagai dosen di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali (ITEKES Bali) sejak tahun 2005. Selain sebagai dosen, penulis juga mengelola Denias Mom dan Baby Spa. Penulis menunjukkan ketertarikan di bidang Nifas dan menyusui sejak pertama kali bergabung menjadi dosen di ITEKES Bali, hingga saat ini penulis masih dipercaya menjadi Koordinator Bidang Nifas Program Studi Kebidanan. Berbagai penelitian di bidang nifas dan menyusui telah dipublikasikan. Penulis juga telah membuat modul praktikum nifas dan buku panduan pijat oksitosin pada ibu menyusui. Keseriusan penulis dalam melaksanakan kewajiban Tridarma Perguruan Tinggi telah mengantarkan penulis menjadi dosen terbaik kedua LLDIKTI wilayah VIII tahun 2019.

Email Penulis: manikparwati82@gmail.com

PROFIL PENULIS

Fatmawati, SST., M.Keb. Penulis adalah seorang bidan kelahiran Surabaya dan menyelesaikan Pendidikan bidan di tahun 2001. Penulis melanjutkan pendidikan DIV Bidan Pendidik di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2003 dan menyelesaikan pendidikan Magister Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2015. Pengalaman pekerjaan sebagai Tenaga Pendidik mulai tahun 2001– sekarang, dan Owner Praktik Mandiri Bidan pada tahun 2003– sekarang.

Saat ini penulis adalah Dosen tetap Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Universitas Brawijaya Malang dan menjabat sebagai Ketua Program Studi PS Pendidikan Profesi Bidan Universitas Brawijaya, penulis juga merupakan Auditor di Universitas Brawijaya, dan Asesor LamPTKes. Penulis memiliki kepakaran dibidang Kebidanan. Penulis juga aktif sebagai Pengurus IBI Cabang Kota Surabaya dan Fasilitator Bidan Delima. Dengan semangat dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan mewujudkan karir sebagai dosen yang profesional, penulis pun melaksanakan Tri dharma Perguruan tinggi dalam proses pembelajaran, peneliti maupun pengabdian kepada masyarakat dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian telah dilakukan dan dipublikasi baik level nasional maupun internasional. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan sumbangsih untuk pendidikan bidan dan kontribusi bagi bangsa serta aktif mengikuti pelatihan-pelatihan non formal seperti Kegawat daruratan, Pijat Bayi, Mom and Baby SPA, Hypnobirthing dan Yoga Prenatal, dan Manajemen Laktasi. Email Penulis: fatmawati@ub.ac.id

PROFIL PENULIS



Psiari Kusuma Wardani, S.ST, M.Kes, lahir di Pringsewu pada tanggal 16 Januari 1990. Penulis telah menyelesaikan pendidikan formal di SD Fransiskus Pringsewu lulus tahun 2002, SMP Xaverius Pringsewu lulus tahun 2005 dan SMA Negeri I Pringsewu lulus tahun 2008. Penulis menyelesaikan jenjang Pendidikan DIII Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang lulus tahun 2011, Diploma IV Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang lulus tahun 2013, dan S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Mitra Indonesia Lampung lulus tahun 2016. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen Prodi DIII Kebidanan di Universitas Aisyah Pringsewu sejak tahun 2016 dan sebagai direktur Klinik Cahaya Sehat Kemiling Bandar Lampung sejak tahun 2020. Penulis pernah mendapatkan hibah Ristekdikti dengan judul penelitian “Gambaran Penggunaan Herbal Pelancar ASI (*Galactagogue*) Pada Ibu Menyusui di Desa Wonosari Kabupaten Pringsewu Tahun 2019” dan mendapatkan hibah pengabdian masyarakat dari Ristekdikti dengan judul “Strategi Pengembangan Produk, Manajemen Keuangan dan Pemasaran Online untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Ibu-Ibu Kelompok Konveksi Rumahan di RT 03, RW 03 Pekon Podosari Pringsewu Lampung Tahun 2021”. Penulis telah mengikuti berbagai pelatihan non formal seperti Pelatihan dan Telaah Soal Uji Kompetensi Nasional Studi Tenaga Kesehatan tahun 2019, Pelatihan Perseptor Mentor tahun 2019, Pelatihan *Mom and Baby Spa* Tahun 2021, Pelatihan *Midwife Emergency Course* tahun 2021, dan Pelatihan Persalinan D’Maryam tahun 2023.



Tutik Iswanti, SST., M. Keb., Lahir di Sragen Jawa Tengah, 13 Agustus 1983. Menyelesaikan Pendidikan DIII Kebidanan di Akbid Pemda Kendal pada tahun 2004. Selanjutnya menyelesaikan Pendidikan D-IV Bidan Pendidik di Politeknik Karya Husada Jakarta pada tahun 2010 dan menyelesaikan Pendidikan S2 Kebidanan di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta pada tahun 2017. Saat ini penulis menjadi Dosen di Jurusan Kebidanan Rangkasbitung Poltekkes Kemenkes Banten. Penulis berharap agar pembaca memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas agar bisa menjadi Bidan yang Kompeten.

PROFIL PENULIS



Heni Nurakilah, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.

Lahir di Kota Tasikmalaya pada tanggal 28 Oktober 1993. Telah menyelesaikan studi Diploma III Kebidanan di STIKes Respati Tasikmalaya pada tahun 2015, lulus studi Sarjana Terapan Kebidanan di Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada Cirebon pada tahun 2016, dan pada tahun 2019 telah lulus studi Magister Terapan Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada Bandung. Saat ini tercatat menjadi Dosen Tetap di Prodi D-3 Kebidanan

Universitas Bhakti Kencana PSDKU Tasikmalaya. Berikut beberapa buku yang pernah ia tulis yaitu: Buku Sukses UKOM D3 bidan, Buku Ajar Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra-Sekolah, Buku Referensi Terapi Komplementer sebagai Alternatif Mengurangi Kecemasan Saat Persalinan Meningkatkan Produksi ASI dan Kelancaran Pengeluaran ASI, Buku Evidence Based Soal Kasus Kebidanan Komunitas II. Selain itu ia aktif menjadi pengajar dalam bimbingan Uji Kompetensi Bidan

Selain mengajar penulis juga aktif dalam pengembangan penelitian dan pengabdian Masyarakat. Berikut beberapa publikasi yang telah dihasilkan dalam 5 tahun terakhir: Perbandingan Pengaruh Penggunaan Warm Bra Care dan Kompres Hangat terhadap Kelancaran Pengeluaran ASI pada Ibu 3-4 Pospartum di Puskesmas Tomo Kabupaten Sumedang. Perbedaan Pola Asuh Demokratis dan Otoriter terhadap Kemandirian Anak Tunagrahita di SLB Yayasan "B" Kota Tasikmalaya. Penatalaksanaan Nyeri Punggung Pada Ibu Hamil Trimester III dengan Metode Konesio Tapping berdasarkan Srandar Profesi Bidan. Efektivitas Terapi Kompres Lidah Buaya (Aloe Vera) terhadap Kelancaran Pengeluaran ASI Pada Ibu 2-3 Hari Post Partum di Wilayah Kerja Puskesmas Karanganyar Kota Tasikmalaya. The Effect of Parenting Styles Using Authoritarian Methods on the Independence of 7 Year Old Children During the Covid 19 Pandemic. Penatalaksanaan Anemia Pada Ibu Nifas Melalui Terapi Pemberian Buah Naga di Wilayah Kerja Puskesmas Karanganyar. Efektivitas Menggendong dengan Metode M-Save dan J-Save terhadap Kualitas Tidur Bayi Usia 2-6 Bulan.

Email Penulis: heni.nurakilah@bku.ac.id

PROFIL PENULIS



Rizka Fatmawati, S.SiT., M.Kes

Lahir di Klaten, pada 14 September 1988. Ia tercatat sebagai lulusan D III Kebidanan di STIKES Muhammadiyah Klaten pada tahun 2009 dan melanjutkan pendidikannya ke D IV Bidan Pendidik di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran Semarang lulus tahun 2010 serta pada tahun 2013 Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 Magister Kedokteran Keluarga dengan minat utama Pendidikan Profesi Kesehatan di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis saat ini baru menyelesaikan S2 Kebidanan di salah satu perguruan tinggi swasta di jogja.

Penulis merupakan Dosen di Institut Teknologi dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta dari tahun 2011 sampai sekarang, sebelumnya penulis juga pernah bekeja di salah satu Perguruan Tinggi swasta di daerah Cilacap. Penulis bukanlah orang baru di dunia pendidikan. Ia sering melakukan penelitian, pengabdian masyarakat serta menulis buku untuk menunjang pembelajaran. Pada Tahun 2018 -2019 lalu, Rizka berhasil meraih Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) dari Kementrian Pendidikan dan Mampu menghasilkan beberapa buku dan jurnal publikasi ilmiah. Beberapa buku yang dihasilkan dalam 5 tahun terakhir yaitu Buku ajar manajemen haid opada remaja, Perawatan pola tidur ibu nifas dengan boreh, Sukses UKOM D3 Kebidanan, Asuhan Kebidanan Masa Nifas. Selain itu penulis juga mengembangkan Enterpreneur dengan mengikuti Pelatihan Mom and Baby Spa dari IHCA.



Henny Sulistyawati, SST., M.Kes

Penulis adalah seorang bidan kelahiran Jombang Jawa Timur, lahir pada tanggal 17 Mei 1987 dan telah menyelesaikan pendidikan DIV Bidan Pendidik di Universitas Kadiri Kota Kediri lulus pada tahun 2009 kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Sebelas Maret Solo lulus tahun 2012.

Penulis mulai aktif mengajar sebagai Dosen Kebidanan pada tahun 2009 di ITSkes Insan Cendekia Medika Jombang sampai sekarang.

Penulis juga aktif membuat buku ajar, modul ataupun monograf yang ber ISBN dan aktif melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang hasil akhirnya di Publikasi di Jurnal Nasional dan Internasional.

Email Penulis: henny.gadang@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ismiati, SST., M.Keb. lahir di Taken-Aken, Desa Lekor, kec. Janapria. Lombok Tengah pada tanggal 05 Juni 1994. Penulis menyelesaikan pendidikan D III Kebidanan di STIKES Qamarul Huda Badaruddin Bagu tahun 2012-2015. Kemudian melanjutkan pendidikan D IV/SI pada perguruan tinggi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) tahun 2017-2018. Serta melanjutkan S2 kebidanan tahun 2018-2020 di UNISA. Sejak tahun 2021 hingga saat ini penulis aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya. Dan saat ini penulis tergabung dalam TIM penyusunan buku Optimal.



Annesya Atma Battya, S.Sos., S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.

Lahir di Kota Lumajang pada tanggal 14 Desember 1977. Telah menyelesaikan studi Ilmu Administrasi Niaga di Universitas Brawijaya Malang tahun 2000, Diploma III Kebidanan di Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada pada tahun 2015, lulus studi Sarjana Terapan Kebidanan di Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada Cirebon pada tahun 2016, dan pada tahun 2019 telah lulus studi Magister Terapan Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada Bandung. Saat ini tercatat menjadi Dosen Tetap di Prodi D-3 Kebidanan dan

menjabat sebagai Wakil Direktur III Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama di Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada. Penulis juga sebagai praktisi kebidanan komplementer sejak tahun 2016 hingga sekarang. Berikut beberapa buku yang pernah di tulis yaitu: Buku Evidence Based Soal Kasus Kebidanan Komunitas II.

Selain mengajar penulis juga aktif dalam pengembangan penelitian dan pengabdian Masyarakat. Berikut beberapa publikasi yang telah dihasilkan dalam 5 tahun terakhir: Perbedaan Penggunaan Baby Massage Kit Dan Pijat Konvensional Terhadap Perkembangan Motorik Kasar Dan Relaksasi Bayi Usia 6– 12 Bulan, Perbedaan Lama Lepas Tali Pusat antara Perawatan Tali Pusat Menggunakan Kasa Steril dengan Perawatan Terbuka pada Neonatus, Pengaruh Kompres Hangat terhadap Penurunan Nyeri Payudara pada Ibu Nifas, Perbandingan Penggunaan Skincare yang Mengandung Niacinamide dan Vitamin C pada Ibu Hamil Trimester 2-3 dengan Melasma Gravidarum Face, Hubungan Pola Hidup Sehat Ibu Hamil Dengan Kejadian Preeklamsi Di Puskesmas Cilimus Kabupaten Kuningan, Hubungan Antara Umur Dan Paritas Dengan Kejadian Plasenta Previa Pada Ibu Bersalin Di Rsud Arjawinangun Kabupaten Cirebon Tahun 2022, The Relation Of Way Of Giving Milk With Regurgitation Incident On Neonatus In The Perinatologi Room RSD Gunung Jati Cirebon City.

Email Penulis: abattya@gmail.com

PROFIL PENULIS

Dewi Ayu Ningsih, S.ST, M.Keb, CTM-BT

Penulis lahir di Kalibening, 30 Januari 1989. Penulis adalah alumni dari Program Studi S2 Ilmu Kebidanan Universitas Andalas tahun 2019. Penulis merupakan dosen pengajar pada Program Studi D3 Kebidanan – STIKes Panca Bahkati, Bandar Lampung. Beberapa mata kuliah yang pernah diampu penulis diantaranya Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, Dokumentasi Kebidanan, Entrepreneurship Kebidanan, Kebidanan Komunitas, Metodologi Penelitian, Praktik Klinik Kebidanan, dan Praktik Klinik Komunitas. Penulis juga pernah bekerja sebagai Bidan Pelaksana di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Restu Bunda, Bandar Lampung.

Selain mengajar, penulis juga aktif dalam pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa publikasi karya ilmiah yang dihasilkan penulis dalam 5 tahun terakhir diantaranya: 1. *Awarding Support Becomes a Dominant Factor in the Election of Family Planning in the Long-Term Contraception Method in Kampung KB*, 2. Hubungan Pengetahuan Tentang Kanker Payudara Dengan Perilaku Sadari (Periksa Payudara Sendiri), 3. Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan KB MKJP, 4. Penyuluhan tanda bahaya kehamilan pada kelas ibu hamil di puskesmas Kota Karang, 5. Kajian Determinan yang Berhubungan dengan Status Gizi Kurang pada Balita



Irma Nurma Linda, S. Keb., Bd., M.Keb.

Riwayat Pendidikan:

- Menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) pada tahun 2012-2016 di Universitas Airlangga Surabaya, dilanjutkan dengan Pendidikan Profesi lulus tahun 2017 di Universitas Airlangga Surabaya.
- Penulis melanjutkan Pendidikan Magister Kebidanan (S2) pada tahun 2019-2021 di Ilmu Kebidanan, Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

Saat ini, penulis aktif mengajar di Universitas Pendidikan Ganesha sebagai Dosen Kebidanan. Penulis juga aktif dalam penerbitan dan Publikasi Ilmiah.

Penulis dapat dihubungi melalui Email: irmanurmalinda@gmail.com

Pesan untuk para pembaca: *“jadilah orang cerdas secara akal dan moral, yang dapat memberi impact positive disekitarnya”*

PROFIL PENULIS



Dwie Yunita Baska, S.ST, M.Keb

Penulis lahir di Bengkulu, 23 Juni 1988. Penulis adalah alumni dari Program Studi S2 Magister Kebidanan Universitas Padjadjaran Tahun 2018. Penulis merupakan dosen pengajar pada Program Studi Pendidikan Profesi Bidan dan Program Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Beberapa mata kuliah yang pernah diampu penulis diantaranya Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Anatomi dan Fisiologi Manusia, Asuhan Kebidanan pada Ibu dan Anak Rentan, Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan (KDPK) I, Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan II (Pemeriksaan Fisik Ibu dan Anak), Evidence Based dalam Praktik Kebidanan, KB dan Pelayanan Kontrasepsi, dan Patofisiologi Kasus Kebidanan. Sebelum berprofesi sebagai Dosen, Penulis sudah menjadi ASN yang bekerja di Instansi Pemerintah Prov. Bengkulu sejak 2009 dan ditempatkan di beberapa unit kerja seperti Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Prov. Bengkulu, UPTD Akbid Provinsi Bengkulu, dan sebagai Bidan Pelaksana di RSUD M. Yunus Provinsi Bengkulu.

Selain mengajar, penulis juga aktif dalam pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa publikasi karya ilmiah yang dihasilkan penulis dalam 3 tahun terakhir diantaranya: *The Effect of Health Education with Flashcard Media on Improvement of Knowledge and Reduction of Anxiety Degree in Adolescents Primigravida* (2020), Pengaruh Pendidikan Kesehatan dengan Media Video Terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil Tentang Asi Eksklusif di Puskesmas Pagar Jati (2022), *The Empowering of Alert Husbands in Maternal's Class to Increasing Knowledge and Skills of Labor Pain Management Techniques* (2023), *The Establishment of Youth Posyandu to Increase Adolescent's Productivity* (2023), *Effect of The Safe Delivery App (SDA) by Blended Learning on Midwives' Knowledge* (2023), *Intervention of Kusuma Milk-Shake Drink on Cervical Dilatation and Duration of Labor: Experience from Bengkulu, Indonesia* (2023), Kelas Ibu Hamil Meningkatkan Partisipasi Suami/Keluarga dalam Pendampingan Persalinan (2023), Pendampingan Kelompok Jarestiput Dalam Pencegahan Risiko Tinggi Pada Ibu Hamil (2023), dan pernah menjadi salah satu Dosen Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh PT NFC, Optimal.

PROFIL PENULIS



Dwi Rahmawati, S.ST., M.Keb

Penulis adalah seorang bidan kelahiran Denpasar, lahir di Rokan Hulu, 27 Agustus 1989 dan telah menyelesaikan Pendidikan DIII Kebidanan tahun 2011 di Poltekkes Bhakti Mulia Sukoharjo. Penulis melanjutkan kuliah DIV Kebidanan di Universitas Kader Bangsa Palembang Tahun 2015. Tahun 2019, penulis menyelesaikan Magister Kebidanan di Universitas 'Asyiyah Yogyakarta. Penulis juga aktif mengikuti pelatihan-pelatihan non formal seperti Pijat Bayi, Mom and Baby SPA, Public Speaking. Penulis aktif sebagai dosen di Universitas Adiwangsa Jambi (UNAJA) sejak tahun 2019. Selain sebagai dosen, penulis juga mengelola Klinik Mizan Medika. Penulis Mengampu mata kuliah salah satunya Asuhan Kebidanan Nifas. Berbagai penelitian di bidang Kebidanan telah dipublikasikan. Email Penulis: dwirahmawati.jmb@gmail.com



Rini Mustikasari Kurnia Pratama, S.Si.T., M.Keb

Lahir di Sarolangun, tanggal 17 Maret 1990. Telah menyelesaikan studi pada DIII Kebidanan STIKes A. Yani Yogyakarta (sekarang Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta) tahun 2010, lulus DIV Kebidanan STIKes Ngudi Waluyo Ungaran (sekarang Universitas Ngudi Waluyo) tahun 2011, lulus S2 Ilmu Kebidanan di Universitas Andalas tahun 2017. Pernah menjadi dosen tetap Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan menjabat sebagai Wakil Ketua I STIKes Keluarga Bunda Jambi. Saat ini bekerja sebagai dosen DIII Kebidanan Universitas Bengkulu. Pernah mendapatkan Hibah Penelitian Kemdikbudristek dengan skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) sebanyak 2 kali sebagai ketua dan 1 kali sebagai anggota, dan skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT) sebanyak 1 kali sebagai ketua. Saat ini masih menjadi sekretaris dalam kepengurusan IBI Ranting Di Provinsi Jambi dan sebagai pengurus daerah perkumpulan Relawan Jurnal Indonesia (RJI) Jambi. Pernah menjadi narasumber di beberapa kesempatan baik seminar maupun kuliah pakar yang berkaitan dengan ilmu kebidanan, menjadi pengajar dalam bimbingan belajar uji kompetensi bidan serta telah menerbitkan Buku "Sukses Ukom Profesi Bidan", Buku Ajar "Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui" sebagai penulis pertama, Buku Referensi "Terapi Komplementer Sebagai Alternatif Mengurangi Kecemasan Saat Persalinan, Meningkatkan Produksi ASI dan Kelancaran Pengeluaran ASI", Buku Ajar "Asuhan Kebidanan Bayi dan Balita-S1 Kebidanan", serta beberapa buku yang sedang dalam proses penerbitan.

SINOPSIS

Buku Asuhan Kebidanan Nifas & Menyusui ini merupakan bahan ajar yang ditujukan bagi mahasiswa kebidanan sesuai dengan kompetensi pada Kurikulum Program Diploma Kebidanan yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasarkan atas konsep, sikap, dan keterampilan.

Buku ini menjelaskan tentang asuhan masa nifas yang membahas konsep dasar masa nifas, perubahan masa nifas, asuhan masa nifas terfokus, dan deteksi dini serta penatalaksanaannya. Menyusui merupakan bagian dalam masa nifas yang dibahas pada buku ini, yang dimulai dari pembahasan tentang kebijakan pemerintah dalam pemberian ASI, anatomi dan fisiologi payudara, ASI sebagai makanan utama bayi, IMD, cara pemberian ASI.

Buku ini memiliki keunggulan dalam hal penyajian ilustrasi dan gambar berwarna yang akan membantu visualisasi topik yang dibahas akan memudahkan dan meningkatkan pemahaman bagi pembacanya. Dengan demikian, tepatlah untuk dikatakan bahwa buku ini merupakan referensi ideal bagi pembelajaran mahasiswa. Penulisan isi buku ini disusun dalam tata kalimat dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga masyarakat awam pun dapat menjadikan buku ini sebagai pedoman pada masa nifas dan menyusui. Sekilas tentang penulis buku ini disusun oleh tim penulis yang merupakan para pengajar yang berasal dari berbagai institusi Pendidikan kebidanan di Indonesia.

Buku Asuhan Kebidanan Nifas & Menyusui ini merupakan bahan ajar yang ditujukan bagi mahasiswa kebidanan sesuai dengan kompetensi pada Kurikulum Program Diploma Kebidanan yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasarkan atas konsep, sikap, dan keterampilan.

Buku ini menjelaskan tentang asuhan masa nifas yang membahas konsep dasar masa nifas, perubahan masa nifas, asuhan masa nifas terfokus, dan deteksi dini serta penatalaksanaannya. Menyusui merupakan bagian dalam masa nifas yang dibahas pada buku ini, yang dimulai dari pembahasan tentang kebijakan pemerintah dalam pemberian ASI, anatomi dan fisiologi payudara, ASI sebagai makanan utama bayi, IMD, cara pemberian ASI.

Buku ini memiliki keunggulan dalam hal penyajian ilustrasi dan gambar berwarna yang akan membantu visualisasi topik yang dibahas akan memudahkan dan meningkatkan pemahaman bagi pembacanya. Dengan demikian, tepatlah untuk dikatakan bahwa buku ini merupakan referensi ideal bagi pembelajaran mahasiswa. Penulisan isi buku ini disusun dalam tata kalimat dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga masyarakat awam pun dapat menjadikan buku ini sebagai pedoman pada masa nifas dan menyusui. Sekilas tentang penulis buku ini disusun oleh tim penulis yang merupakan para pengajar yang berasal dari berbagai institusi Pendidikan kebidanan di Indonesia.

ISBN 978-623-88564-9-7



Anggota IKAPI
No. 624/DKI/2022

Penerbit :

PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919